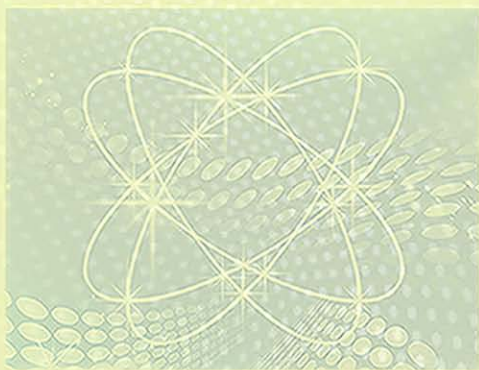


妇科病外治验案

主 编 汤 宇



人民军医出版社



中医外治验案丛书

妇科病外治验案

FUKEBING WAIZHI YAN'AN

主 编 汤 宇

副主编 谢雅莉 刘 颖

编 委 (以姓氏笔画为序)

刘 颖 汤 宇 许晓波

孙晓宇 李 宇 谢亚莉

 人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

妇科病外治验案 / 汤宇主编. — 北京: 人民军医出版社, 2008.7
(中医外治验案丛书)

ISBN 978-7-5091-1940-2

I. 妇… II. 汤… III. 妇科病—中医治疗法: 外治法—
医案—汇编 IV. R271.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 095718 号

策划编辑: 张伏震 文字编辑: 李香玉 责任审读: 周晓洲

出 版 人: 齐学进

出版发行: 人民军医出版社

经销: 新华书店

通信地址: 北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编: 100036

质量反馈电话: (010) 51927270; (010) 51927283

邮购电话: (010) 51927252

策划编辑电话: (010) 51927300-8725

网址: www.pmmp.com.cn

印刷: 京南印刷厂 装订: 桃园装订有限公司

开本: 850mm×1168mm 1/32

印张: 7.75 字数: 187 千字

版、印次: 2008 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 0001~4000

定价: 24.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书, 凡有缺、倒、脱、页者, 本社负责调换



内 容 提 要

本书为《中医外治验案丛书》的妇科病外治验案分册，系统地总结了近年来治疗痛经、闭经、功能性子宫出血、盆腔炎、不孕症、乳腺增生、前阴病等疾病的中医外治法，精选了大量名家的医案、医论、治疗及经验心得等。本书所述治法实用、通俗易懂、疗效确实，适合中医从业人员参考，也可供患者及家属阅读。



前 言

中医外治法广义来说是指除内服药物治疗以外的一切治疗方法，是我国劳动人民和古代医家在长期与疾病作斗争的过程中总结出来的一套独特的行之有效的治疗方法，与内服药物治疗有同等重要的地位，而且在某些方面优于内治法。中医外治法作用迅速，操作简便，易学易用，使用安全，为广大患者所接受。近年来，由于药源性疾病的日益增多，中草药和非药物疗法已经受到国内外医界的重视。国际上提倡的“自然疗法”，就包含了运用天然药物治疗疾病的各种方法，我国的中医药外治法尤引人瞩目。

“中医外治验案丛书”包括《妇科病外治验案》《关节炎外治验案》《颈肩腰腿痛外治验案》《皮肤病外治验案》《中风外治验案》5个分册。书中所举验案，均选自现代名医家的医案及专业期刊。所选择验案本着易于操作、疗效确定、讲解详细的原则。在内容编排上，以西医病名为纲，简述各病的发病机制，主要介绍不同的外治医案、医论。因为书中所选外治方法，在临床上曾大量应用，大家已熟知，书中就没有再详

细介绍具体的操作方法及原理。

本丛书在编写时本着继承名老中医经验，传播中医外治方法的宗旨，所介绍的治疗方法都是通过临床实践证明疗效确切或前人用之有效且有文献依据的，并具有容易掌握、应用简便、取材方便、不受设备条件限制、疗效稳妥可靠、适宜于临床应用等优点。

各位中医爱好者在应用本书所载的方法时，一定要在专业医师的指导下进行，以防发生意外。当然，由于水平所限，书中谬误、不当之处，敬请原案作者和读者批评指正。

本书所引用的临床病例资料，均来自国内期刊公开发表的文献，谨此向所有作者致以衷心的感谢。

编 者

2008 年 3 月



目 录

第1章 痛经	(1)
第一节 概述	(1)
一、病因与病机	(1)
二、临床表现与临床分型	(3)
三、诊断与鉴别诊断	(3)
第二节 辨证论治	(5)
一、名家医案、医论	(5)
孙六合	(5)
陆瘦燕	(6)
华廷龄	(6)
朱汝功	(6)
钟梅泉	(7)
张涛清	(9)
田从豁	(10)
刘保延	(11)
二、中药外治法	(11)
取嚏法治痛经	(11)
红藤汤灌肠治疗子宫内膜异位症痛经	(12)
吴茱萸白药膏敷神阙穴治疗痛经	(13)



穴位外敷痛经膏药治疗原发性痛经.....	(14)
熨敷神阙穴治疗痛经.....	(15)
敷脐疗法治痛经 1.....	(15)
敷脐疗法治痛经 2.....	(16)
痛经贴外敷关元穴治疗痛经.....	(17)
艾香药袋敷脐治疗痛经.....	(18)
中药外敷治疗痛经 1.....	(19)
中药外敷治疗痛经 2.....	(20)
中药外敷治疗痛经 3.....	(21)
痛经散穴位贴敷治疗原发性痛经.....	(22)
痛经宁敷脐治疗痛经.....	(23)
少腹逐瘀汤外用治疗痛经.....	(24)
三、针灸疗法	(25)
针刺治疗痛经 1	(25)
针刺治疗痛经 2	(26)
针刺治疗痛经 3	(26)
针灸治疗痛经 1	(28)
针灸治疗痛经 2	(29)
针刺曲骨治疗痛经.....	(30)
针刺承山穴治疗痛经.....	(31)
针刺阿是穴治疗痛经.....	(32)
针刺次髎穴治疗痛经.....	(32)
针刺膝眼穴治疗痛经.....	(33)
针刺治疗虚寒性痛经.....	(34)
针刺十七椎下治疗痛经.....	(34)
针刺治疗血瘀型原发性痛经.....	(35)
速刺内关、公孙治疗痛经.....	(36)



针灸承浆、大椎治疗痛经	(37)
针刺三阴交、次髎治痛经	(38)
针刺承山、三阴交治疗痛经	(39)
针刺关元、三阴交治疗痛经	(40)
针刺三阴交治疗原发性痛经	(41)
针刺中冲、三阴交治疗痛经	(41)
三阴交温针治疗原发性痛经	(42)
三阴交透刺悬钟穴治疗痛经	(43)
三阴交穴配合神阙穴治疗痛经	(44)
针刺膝眼、三阴交穴治疗痛经	(45)
针灸气海、天枢、三阴交治疗原发性痛经.....	(46)
针灸配合耳穴治疗原发性痛经	(47)
针药并用治疗痛经	(49)
针刺配合中药导入治疗痛经	(50)
埋针治疗原发性痛经	(51)
穴位埋线治疗痛经	(52)
芒针结合穴位注射治疗痛经	(53)
火针治疗痛经	(54)
温针治疗痛经 1	(56)
温针治疗痛经 2	(56)
关元温针灸治疗痛经	(57)
电针加温针灸治疗痛经	(58)
针刺足三里、三阴交治疗痛经	(59)
一穴多针法治疗原发性痛经	(60)
针灸按摩治疗原发性痛经	(61)
刺血加拔罐治疗痛经	(62)
穴位注射治疗痛经	(62)



注射液封闭治疗痛经.....	(63)
艾条灸治疗痛经 1.....	(64)
艾条灸治疗痛经 2.....	(65)
艾灸关元治痛经	(66)
灸法治疗原发性痛经.....	(66)
隔姜灸治疗痛经 1.....	(67)
隔姜灸治疗原发性痛经 2.....	(68)
发泡疗法治疗原发性痛经.....	(69)
壮医药线点灸合中药外敷治疗原发性痛经.....	(70)
针灸配合耳穴贴压治疗痛经.....	(71)
四、耳穴疗法	(72)
耳穴压丸配合按摩治疗原发性痛经.....	(72)
耳轮水针治疗痛经.....	(73)
耳穴皮内埋针法治疗痛经.....	(74)
耳穴贴压治疗痛经 1.....	(75)
耳穴贴压治疗痛经 2.....	(76)
耳穴贴压治疗痛经 3.....	(77)
耳穴贴压治疗痛经 4.....	(78)
耳针子宫穴治疗痛经.....	(78)
耳体针配合治疗痛经.....	(79)
耳穴贴压配合中药治疗痛经.....	(80)
耳针配合针灸治疗痛经.....	(81)
五、推拿疗法	(82)
全息蜂疗治疗痛经.....	(82)
手法激穴治疗痛经.....	(83)
推拿点穴治疗痛经.....	(84)
一指禅手法治疗痛经.....	(84)
经穴按摩并封闭治疗痛经.....	(86)



推按第二掌骨侧下腹穴区治疗痛经	(87)
六、简方疗法	(88)
熨热方	(88)
芎归散	(88)
乳没散	(88)
按摩方	(88)
梅花针方	(88)
灯火灸方	(89)
推拿点穴方	(89)
二草调经方	(89)
青盐热熨法	(89)
香桂敷贴法	(89)
第2章 闭经	(91)
第一节 概述	(91)
一、病因病机	(91)
二、临床表现	(93)
三、诊断与鉴别诊断	(94)
第二节 辨证论治	(95)
一、名家医案、医论	(95)
李志明	(95)
张善忱	(96)
朱汝功	(97)
郑魁山	(98)
钟梅泉	(99)
二、针灸疗法	(100)
针灸治疗闭经	(100)
针刺三阴交治疗闭经	(101)



针刺艾灸治疗继发性闭经.....	(102)
针灸配合中药治疗闭经.....	(103)
中药配合耳穴电针治疗肾虚闭经.....	(104)
针灸按摩治疗继发性闭经.....	(106)
针刺治疗肥胖妇女闭经.....	(106)
耳贴治疗功能性闭经.....	(107)
三、简方疗法	(108)
方 1	(108)
方 2	(108)
方 3	(109)
方 4	(109)
方 5	(109)
方 6	(109)
第 3 章 功能性子宫出血.....	(110)
第一节 概述	(110)
一、病因病机	(110)
二、临床表现	(112)
三、诊断与鉴别诊断.....	(113)
第二节 辨证论治	(114)
一、名家医案、医论.....	(114)
王松荣	(114)
叶心清	(115)
黎文献	(115)
张善忱	(116)
郑魁山	(117)
李世珍	(117)
钟梅泉	(118)
黄宗勗	(119)



二、针灸疗法	(120)
针刺隐白、复溜、关元治疗崩漏	(120)
针灸隐白治疗崩漏	(121)
针灸治疗脾肾阳虚型崩漏	(122)
针刺治疗崩漏	(123)
三、简方疗法	(124)
方 1	(124)
方 2	(124)
方 3	(124)
方 4	(124)
方 5	(124)
方 6	(124)
方 7	(125)
方 8	(125)
第 4 章 盆腔炎	(126)
第一节 概述	(126)
一、病因病机	(127)
二、临床表现	(128)
三、辅助检查	(129)
四、诊断与鉴别诊断	(130)
第二节 辨证论治	(131)
一、名家医案、医论	(131)
郑魁山	(131)
钟梅泉	(132)
邱茂良	(132)
田从豁	(136)
二、中药外治疗法	(136)
妇炎散外敷治疗慢性盆腔炎	(136)



肠安散外敷治疗慢性盆腔炎.....	(137)
丹香合剂治疗慢性盆腔炎.....	(138)
复方仙鹤草膏治疗慢性盆腔炎.....	(139)
归芎延桃饮灌肠治疗慢性盆腔炎.....	(139)
红酱解毒汤灌肠治疗慢性盆腔炎.....	(140)
慢盆汤内服灌肠治疗慢性盆腔炎.....	(141)
如意金黄散治疗慢性盆腔炎.....	(142)
三、简方疗法	(143)
方 1	(143)
方 2	(143)
第 5 章 不孕症	(144)
第一节 概述	(144)
一、病因病机	(144)
二、临床表现	(147)
三、诊断与鉴别诊断.....	(148)
第二节 辨证论治	(149)
一、名家医案、医论.....	(149)
朱汝功	(149)
郑魁山	(151)
二、中药外治疗法	(152)
中药外敷微波并用治疗慢性附件炎并发不孕症.....	(152)
中药灌肠辅助输卵管通液治疗继发性不孕.....	(153)
中药外敷法治疗输卵管阻塞不孕症.....	(154)
中药外熨加通液术治疗慢性输卵管炎不孕.....	(154)
三、针灸疗法	(156)
育肾汤配合针灸治疗不孕症.....	(156)
针刺推拿法治疗痛经伴不孕.....	(157)
针刺卵巢穴治疗卵子滞留症.....	(158)



针灸配合耳穴贴压治疗不孕症	(159)
针灸治疗卵巢早衰不孕症	(160)
针灸治疗输卵管炎性不孕	(161)
针灸治疗女性不孕症 1	(162)
针灸治疗女性不孕症 2	(163)
针药结合治疗输卵管梗阻性不孕	(164)
针药并举治疗输卵管阻塞性不孕	(165)
温针灸治疗痛经不孕	(166)
耳压配合中药治疗子宫内膜异位症痛经	(167)
腹丛刺为主治疗慢性附件炎并发不孕症	(168)
四、简方疗法	(169)
方 1	(169)
方 2	(170)
方 3	(170)
第 6 章 乳腺增生	(171)
第一节 概述	(171)
一、病因病机	(171)
二、临床表现	(172)
三、诊断与鉴别诊断	(172)
第二节 辨证论治	(173)
一、名家医案、医论	(173)
郭诚杰	(173)
贺普仁	(175)
田从豁	(176)
焦顺发	(177)
二、中药外治疗法	(177)
消癖散结膏治疗乳腺增生	(177)
消核散阴膏治疗乳腺增生	(178)



八味狼毒散治疗乳腺增生	(179)
自制乳消散外敷治疗乳腺增生	(180)
自制乳癖贴治疗乳腺增生	(181)
中药垫外敷治疗乳腺增生	(182)
痛消散外敷治疗乳腺增生症	(183)
乳癖消膏外敷治疗乳腺增生	(183)
乳癖散外敷治疗乳腺增生	(184)
乳结消膏贴敷治疗乳腺增生病	(185)
三、针灸疗法	(186)
背俞穴拔罐治疗乳腺增生	(186)
耳穴贴压治疗乳腺腺病	(187)
膏药外贴配合手法治疗乳腺增生	(188)
刮痧拔罐治疗乳腺增生	(189)
火针围刺治疗乳腺增生	(190)
温针灸鱼际穴治疗乳腺增生	(191)
针刺治疗乳腺增生 1	(192)
针刺治疗乳腺增生 2	(193)
针刺配合耳压法治疗乳腺增生症	(194)
针挑治疗乳腺增生	(195)
针刺背俞穴治疗乳腺囊性增生病	(196)
循经推拿手法治疗乳腺增生病	(197)
第 7 章 前阴疾病	(199)
第一节 概述	(200)
一、阴道炎	(200)
二、外阴瘙痒	(200)
三、外阴白斑	(200)
第二节 辨证论治	(201)
一、中药外治疗法	(201)



黄柏油外用治疗阴道炎	(201)
二黄子洗液治疗阴道炎	(202)
复方百部洗剂治疗阴道炎	(202)
复方苦参散治疗阴道炎	(203)
自拟止痒汤外洗治疗阴道炎	(204)
复方硝矾洗剂治疗阴道炎	(204)
苦参蛇冰汤熏洗治疗阴道炎	(205)
苦柏液外洗治疗老年性阴道炎	(206)
清热解毒汤外洗治疗细菌性阴道炎	(207)
自拟六味汤熏洗坐浴治疗真菌性阴道炎	(207)
解毒止痒汤治疗滴虫阴道炎	(208)
蛇凤汤外洗治疗滴虫阴道炎	(209)
蛇床苦参煎外洗治疗滴虫阴道炎	(210)
蛇白汤熏洗治疗女性阴部瘙痒	(210)
熏洗方治疗女性阴部瘙痒	(211)
自拟土茯苓苦参汤治疗女性阴部瘙痒	(212)
龙蛇苦参汤治疗女性阴部瘙痒	(213)
止痒消白液治疗女性阴部瘙痒	(213)
蛇黄苦参汤治疗女性阴部瘙痒	(214)
外阴瘙痒洗剂治疗女性阴部瘙痒	(215)
苦参汤治疗女性阴部瘙痒 1	(216)
苦参汤治疗女性阴部瘙痒 2	(217)
中药止痒液治疗女性阴部瘙痒	(217)
中药外洗治疗外阴瘙痒	(218)
荆防洗剂治疗外阴白斑	(219)
坤痒宁治疗外阴白斑	(219)
苦参汤治疗外阴白斑	(220)



二、针灸疗法	(220)
芒针疗法治疗外阴瘙痒症.....	(220)
耳穴贴压法治疗外阴瘙痒症.....	(221)
毫针针刺加火针点刺治疗外阴白斑.....	(222)
针刺配合火针治疗外阴白斑.....	(223)
电针治疗外阴白斑.....	(224)
三、简方疗法	(225)
方 1	(225)
方 2	(225)
方 3	(225)
方 4	(225)
方 5	(226)
方 6	(226)
方 7	(226)
方 8	(226)
方 9	(226)
方 10	(226)
方 11	(227)
方 12	(227)
方 13	(227)
方 14	(227)
方 15	(227)
方 16	(227)
方 17	(228)
方 18	(228)

第 1 章 痛 经

第 1 节概述』

凡在经期或经期前后发生明显的腹部疼痛或腰部酸痛等不适，甚至剧痛难忍，常可伴有面色苍白，冷汗淋漓，手足冰凉，恶心呕吐等症，以致影响生活和工作的称为痛经。痛经通常分原发性痛经和继发性痛经两种。原发性痛经多见于未婚、未孕妇女，妇科检查未发现明显器质性病变者；继发性痛经则为生殖器官有器质性病变者，如盆腔炎、子宫内膜异位症、子宫肌瘤等。本病中医又称“月经来腹痛”“经行腹痛”“经期腹痛”“经痛”等。

一、病因与病机

痛经的发生与冲任、胞宫的周期性生理变化密切相关。主要病机在于邪气内伏或精血素亏，更值经期产后冲任二脉气血的生理变化急骤，导致胞宫的气血运行不畅，“不通则痛”；或胞宫失于濡养，“不荣则痛”。其所以随月经周期发作，是与经期前后特殊的生理环境变化有关。胞宫平时藏精气而不泻，血海由空虚到满盈，变化缓慢，气血平和，致病因素不会影响冲任胞宫。经前、经期血海由满盈到溢泻，以通为顺，若冲任胞宫阻滞则痛。经血



下泻必耗气耗血，冲任胞宫失养则不荣而痛。痛经的发生，其病位在冲任、胞宫，变化在气血，表现在经前、经期、经后。

1. 气滞血瘀 平素抑郁，或愤怒伤肝，肝气不疏，气滞血瘀；或经期产后，余血内留，蓄而成瘀，血瘀气滞，加之经前经期气血下注冲任，胞脉气血更加壅滞，致使经血不能畅行而发生痛经。

2. 寒凝胞中 经期冒雨、涉水、游泳，寒邪外袭；或过食寒凉生冷，内伤于寒，凝滞气血；或素禀阳虚，寒从内生，寒凝经脉，影响冲任胞宫气血运行，经行涩滞，“不通则痛”。

3. 湿热下注 素有湿热内蕴，正气虚馁之时，流注冲任，阻滞气血；或经期、产后（包括堕胎、小产）调摄不当，感受湿热之邪，邪留冲任、胞宫，胞脉受阻，“不通则痛”。

4. 气血虚弱 素体虚弱，气血不足；或大病久病，耗伤气血；或脾胃虚弱，化源不足，气虚血少。经行血海更虚，不能充养冲任胞脉，以致“不荣则痛”。

5. 肝肾虚损 先天禀赋不足，肝肾本虚；或多产房劳，损及肝肾，精亏血少，而经行之时，阴血下泻，气血更虚，冲任胞脉失于濡养，因而发为痛经。

西医认为痛经由子宫收缩异常，子宫缺血、缺氧；性激素周期性变化和子宫峡部神经丛的刺激等因素所致。

临床所指痛经，主要是原发性痛经，继发性痛经多归入其相应的疾病中。原发性痛经的病因目前尚不十分明了，可能与内分泌因素（前列腺素含量增高等，子宫过度收缩，导致子宫缺血、缺氧）、子宫因素（子宫发育不良、子宫位置异常、宫颈管狭窄、膜样痛经等）、遗传因素、精神神经性因素（紧张、恐惧、对疼痛极为敏感等）有关。继发性痛经病久，生殖器官充血水肿，影响血运，均符合中医学气血运行不畅，不通则痛的认识。

现代医学研究证明血瘀型痛经主要为盆腔血流动力学改变，血循环量减少，血管阻力增强，两侧血流量供应不等有关；甲皱



微循环也有一定变化,管袢长度、袢周状态、及变异流速都有所改变。血液流变学观察到红细胞电泳时间延长,红细胞表面电荷下降或丧失,致使细胞间易于聚集。细胞聚集力增加可导致血流减慢,末梢循环发生障碍,是瘀血型痛经的病理基础。

二、临床表现与临床分型

(一) 临床表现

1. 下腹部疼痛是痛经的主要症状,痛经多发生在经前或经期 1~2d,可呈阵发性痉挛性或胀痛伴下坠感,拒按或喜按,疼痛持续数小时至 2~3d 不等,随后逐渐减轻至消失,严重者可放射到腰骶、外阴、肛门等部位,或伴有恶心、呕吐、腹泻,坐卧不宁,严重时面色苍白、冷汗淋漓,甚至发生晕厥而急诊就医。也有少数于经血将净或经净后 1~2d 觉腹痛或腰腹痛者。

2. 原发性痛经在青少年时期常见,痛经多在初潮后 6~12 个月发病。妇科检查功能性痛经者,多无明显病变,部分患者可有子宫体极度屈曲,宫颈口狭窄;子宫内膜异位症,多有痛性结节,子宫粘连,活动受限,或伴有卵巢囊肿;子宫腺肌病的子宫多呈均匀性增大,局部有压痛;慢性盆腔炎者有盆腔炎的征象。

(二) 临床分型

痛经按是否由器质性病变引起而主要分为两种类型。

1. 原发性痛经 痛经不伴明显的盆腔器质性疾病,亦即功能性痛经。

2. 继发性痛经 因盆腔器质性疾病导致的痛经,常见的有盆腔炎、子宫内膜异位症、子宫发育不良、子宫过于前屈或后倾、子宫颈狭窄等。

三、诊断与鉴别诊断

(一) 诊断要点

1. 原发性痛经 主要在于排除继发性痛经的可能。应详细



询问病史，注意疼痛开始的时间、类型及特征。根据：①初潮后1~2年发病；②以小腹疼痛为主，呈坠胀痛或绞痛，可放射至腰骶部、外阴、肛门等，疼痛多在出现月经血或在此之前几个小时开始痛，疼痛持续时间可为48~72h，经期加重，可持续数小时至1~2d，程度因人而异；③妇科双合诊或肛诊阴性。可得出原发性痛经之诊断。

2. 继发性痛经 ①反复盆腔炎症发作史、月经周期不规则、月经过多、放置宫腔节育器、不育等病史有助于继发性痛经之诊断。②通过双合诊及三合诊，可发现一些导致痛经之病因，如子宫畸形、子宫肌瘤、卵巢肿瘤、盆腔炎块等。肛诊扪得子宫骶骨韧带结节状增厚，对早期诊断子宫内膜异位症尤为重要。

（二）鉴别诊断

原发性痛经应与异位妊娠、先兆流产、子宫肌瘤和子宫内膜异位症鉴别。

1. 异位妊娠 异位妊娠多有停经史和早孕反应，妊娠试验阳性；妇科检查时，宫颈有抬举痛，腹腔内出血较多时，子宫有漂浮感；B超盆腔扫描常可见子宫腔以外，有孕囊或包块存在；后穹窿穿刺或腹腔穿刺阳性；内出血严重时，患者有休克，血红蛋白下降。痛经虽可出现剧烈的小腹痛，但无上述妊娠征象。

2. 先兆流产 胎动不安有停经史和早孕反应，妊娠试验阳性；有少量阴道出血和轻微小腹疼痛的同时，可伴有腰酸和小腹下坠感；妇科检查子宫体增大如停经月份，变软；盆腔B超扫描可见宫腔内有孕囊和胚芽或见胎心搏动。痛经无停经史和妊娠反应，妇科检查及盆腔B超扫描也无妊娠征象。

3. 子宫肌瘤 以月经改变为主要症状，如月经周期缩短，经量增多，经期延长，甚或持续性不规则流血，下腹坠胀，腰背酸痛，白带多，以及因压迫邻近器官可出现尿频、尿急、便秘、里急后重、肾盂积水等，严重时合并不孕、贫血；妇科检查、超声检查可发现子宫肌瘤体征。



4. 子宫内膜异位症 痛经特点虽然随月经周期而发，经净症状逐渐消失，但呈进行性加重，多发生在 30~40 岁的妇女；妇科检查于子宫直肠陷凹及子宫骶骨韧带处可扪及单个或多个触痛性硬结或包块，月经期其结节稍增大，直接活体组织检查或腹腔镜检查能得以证实。

第2节 辨证论治

一、名家医案、医论

孙六合

李某，女，32岁，1989年1月24日就诊。述4年前因与家人生气开始行经腹痛，中西药疗效欠佳。现症：腹痛难忍，大汗淋漓，呻吟不止，月经量少，色暗有块，心烦易怒，伴乳房及胁肋部胀痛。查：神清语明，痛苦面容，弯腰护腹，舌质暗，有瘀斑，脉沉弦。证属气滞血瘀，治宜行气活血，通络止痛。穴取环中上、太冲、三阴交。环中上斜刺，求针感达小腹、会阴部；针三阴交平补平泻法，以针感上传至小腹、会阴效佳；太冲针刺得气后运针，使针感传之少腹部，即时痛止。以后每月月经来潮前5d用同法治疗1个疗程，连续治疗3个月，痛经未再复发。

按：本例肝郁气滞，瘀阻胞宫，太冲乃肝经原穴、冲脉之支别处，肝经“环阴器，抵小腹”，针之可疏肝解郁，理气活血，调理冲任；三阴交乃足三阴经的交会穴，三阴经从足走腹，针此穴可调脾胃，益肝肾；而环中上穴“气至病所”，疏通局部经气，调理冲任，在二辅助穴相助之下共奏舒肝解郁，调理冲任，通络止痛之功。

尤艳利. 河南中医; 2004; 24(11)



陆瘦燕

吴某，女，29岁。经前少腹疼痛，经行紫黑，胸肋刺痛，脉之关尺俱涩，此乃肝失条达，气郁血瘀而致，拟疏肝理气。处方：期门（双），归来（双），急脉（双），曲骨，三阴交（双）。

按：痛经之症，原因甚多，朱丹溪曾有“将行作痛者，气之滞也；行后作痛者，气血虚也”的论述。盖妇女善病肝郁，木失条畅，则气易滞，气滞则必血瘀作痛。本例患者，脉来涩滞，是气结之象，胸肋刺痛，是肝失条达之征，经行紫黑，是气滞血瘀而致。陆老师审症求因，为泻期门、急脉，以疏厥阴之气；曲骨是任脉、足厥阴之会，亦有疏肝而利冲任之功，施用盘法以和少腹之气；泻三阴交，统调肝、脾、肾三经，佐以归来，统是妇科调经的经验要穴。故治之痛减而愈。

《江南名医医案精选·陆瘦燕医案医话选》

华延龄

李某某，女，15岁，1965年9月23日急诊。昨夜月经来临，量少色暗，少腹隐痛。今晨起少腹剧痛，喜热喜按，痛苦面容，其色晄白，四肢欠温，畏寒。脉弦细带紧，苔薄白。证系阴寒凝滞冲任，治拟温壮督阳，以消冲任阴寒，取从阳治阴之理。处方：哑门、风府、下脑户、风池（双）。温针灸七壮。即时收效，腹痛缓解，四肢转温。

按：患者阳气虚微，阴寒内盛，寒凝血滞胞宫，经水难以畅流。施以银温针灸，温壮督阳，疏通冲任，消阴寒，散凝滞，气血调和，其病自愈矣。

《华延龄医案》

朱汝功

郁某，19岁，初诊1966年1月5日。每次经临，少腹疼痛



难忍6年。13岁初次行经少腹微感疼痛，以后每次经来（一般月经延期）少腹胀痛，痛势逐年增加，经色紫黯，有瘀块。近3年来左乳发现一结块（如梅核大），经来前1d，少腹胀痛，乳下结块亦痛，经净时腹痛、结块痛均消。昨月经期未至，腹痛又作，来诊时侧身倦卧，胸闷纳呆，四肢酸痛，有低热（37.6℃），脉细数尺弱，舌苔薄腻尖红。肝郁则气滞，故乳房结块肿胀，气滞则血瘀，不通而痛，故经前少腹疼痛，经色紫黯而有瘀块，拟行气通经、活血止痛为治。处方：①取穴三阴交（双）、血海（双）平针法，得气后，三阴交捻转1~2min，留针15min。②关元平针法，得气后不留针。二诊：1月6日。昨天针后，少腹疼痛已止，今天低热亦退，尚感四肢酸软，守上方加减。处方：①取穴三阴交（双）、太冲（双）、合谷（双）、手三里（双）、足三里（双）。②手法：平针法，得气后留针15min。月经干净后，按上方又针治2次，诸恙消失。

《陆瘦燕、朱汝功针灸学术经验选》

钟梅泉

贺某，女，18岁，未婚，1966年1月15日初诊。每当月经来潮，少腹痛，腰疼痛，持续3~4d，服止痛片无效，常需卧床休息数天，月经后症状消失，历时已18个月。14岁初潮，24~26/4~5d，量中等，白带较多，性情急躁易怒，胃纳尚佳，二便如常。昨日来潮，下腹仍痛来就诊。检查：一般情况尚可，脸色黄白欠华。胸椎_{7~10}两侧有条索、腰椎₂至骶椎_{1~2}两侧有条索和泡状软性物。脉细稍弦，苔薄中腻。证属肝郁气滞，冲任失调而致痛经，拟以疏肝理气，化瘀止痛为治。根据病证，当即采用梅花针重刺腰部、三阴交和期门。针刺毕，下腹痛即消失。随后加骶部、下腹部、小腿内侧、带脉区、中脘、大椎，连续治疗7次，停诊休息，时隔28d后，月经来潮，疼痛消失，量中等，历时6d净。再拟以胸椎_{7~10}两侧，重点叩打腰骶部、下腹部、三阴交、关元，



调理治疗 5 次停诊。以后追踪观察 20 个月，疗效稳固。

魏某，女，34 岁，已婚，1986 年 10 月 4 日初诊。月经来潮，下腹疼痛，腰酸，头晕，神乏已 21 年。10 年来痛经症状加重，每次来经均要卧床休息数天。经几家医院诊治均未见效。13 岁初潮，25~26/7~8d，量中等，质稀，色发紫，白带较多，胃纳欠佳，大便时稀、性急心烦。检查：脸色苍白无华，胸椎_{5~12}两侧有条索并有压痛，腰椎两侧可摸到泡状软性物，骶嵴部有结节。脉沉细，苔薄质淡。证属久病体虚，气血虚弱，胞脉失养。拟以补益气血，调理止痛为治。根据病证，采用梅花针叩打腰骶部、腹部、腹股沟区、带脉区、阳性物处、大椎。经治疗 10 次后，月经来潮，下腹痛减轻，没有卧床休息，照常工作。经治疗 21 次后，月经来潮，只有轻微下腹痛，无头晕。再拟以胸椎_{5~12}两侧、下腹部、带脉区、中脘、关元、期门，重点叩打腰、骶部，巩固调理 1 疗程后停诊。随访观察 9 个月，经期正常，亦无痛经。

按：采用梅花针治疗痛经，标本缓急结合，疗效显著。所治病例辨证为例（1）肝郁气滞，冲任失调型痛经；例（2）辨证为气血虚弱，胞脉失养型痛经。发作时均采用梅花针重刺腰部、三阴交和期门治其标，下腹痛随即消失。后加骶部、下腹部、小腿内侧、带脉区、中脘、大椎治其本，后痛经未作。再以胸椎_{7~10}两侧、重点叩打腰骶部、下腹部、三阴交、关元调理治疗，疗效巩固。钟氏治疗过程中注重探找阳性反应物，针对阳性反应物所在区域进行重点治疗，两证型均在腰部和骶部有阳性反应物，不同的是肝气郁结证型阳性反应物在胸椎_{7~10}两侧，气血虚弱的阳性反应物在胸椎_{5~12}两侧有条索并有压痛，这与肝、胆俞在胸_{9~10}节段，脾胃俞在胸椎_{11~12}节段非常吻合，可见脏腑疾病必然会在相应的背俞穴有所反应。两病例同时取用大椎穴，可见刺激督脉大椎从可温补阳气，达到气帅血行的目的。

《中国梅花针》



张涛清

王某，女，20岁，未婚。自诉：每逢月经来潮前2~3d，心烦易怒，两乳房胀痛，小腹剧痛，两大腿根部疼痛如劈，严重时辗转呻吟，冷汗淋漓，直至月经后3~4d疼痛方逐渐减轻，行经量少，经色紫红夹有血块，经行不畅，每次经期卧床不起6~7d，曾经多方治疗未效，请求针灸治疗。查：小腹胀痛拒按，舌质有瘀点，脉弦紧。诊断为痛经，辨为气滞血瘀。取穴：中极、次髂、十七椎下、太冲、合谷、三阴交。手法：合谷（补）、三阴交（泻），其余穴进针得气后行平补平泻手法，留针30min，疼痛即解除。次日又针1次，嘱下次月经来潮前2~3d再针治1次。患者按约定时间又针刺2次，痛经治愈，5年后相遇，疗效稳定，再未复发。

安某，女，20岁，未婚。自诉：每经行前小腹剧痛如绞，痛2d后经行，色紫黑如豆汁，有血块，伴有腰痛，乏力，纳谷不馨，经妇科检查，诊断为痛经。历经中西药物治疗未效，求针灸治疗。查：小腹冷痛，手足不温，苔白腻，脉沉紧。诊断为痛经，辨为寒湿凝滞。取穴：中极、次髂、十七椎下、地机、足三里。手法：进针得气后，行平补平泻手法，留针30min，间歇期行针2~3次。起针后用艾条温和灸3~5min。针灸1次痛止病愈。嘱下次月经来潮前2~3d再针治1次。患者按约定时间，又针刺2次。痛经治愈，再未复发。

按：针灸治疗痛经，有镇痛通经之效，疗效比较理想。原发性痛经在临床上常有针到病除之效。对继发性痛经，应查明继发于何种原因而痛经，应审证求因。张氏所治病例（1）辨证为气滞血瘀型痛经，例（2）辨证为寒湿凝滞型痛经，治疗均以中极、次髂、十七椎为主穴，配三阴交、足三里、气海、关元、曲骨、天枢、腹结、肾俞、次髂、中髂、合谷等穴及痛区。针刺后艾卷温和灸而愈。张氏认为针灸治疗痛经尽量在月经来潮或来潮前1~2d腰酸胀痛时，在下次月经来潮时或来潮前再针灸1~2次，



以巩固疗效。所用十七椎为经外奇穴，位于腰部，当后正中线上，第5腰椎棘突下。

《张涛清针灸治验选》

田从豁

梁某，女性。34岁，已婚，初诊日期1998年5月4日。主因“经期腹痛20余年，加重6年”来诊，患者13岁月经初潮，经期第1天腹痛，睡眠后可以缓解。25岁结婚，婚后2年未孕，因有痛经史，即前往北京市各大医院就诊。1991年、1992年先后2次于北大医院行宫腔镜检查，发现子宫均匀增大，此后腹痛加剧。1995年于协和医院诊为“子宫腺肌病”。并行子宫楔形切除术，手术过程顺利，术后行GNRH（促性腺激素激动剂）注射治疗，每月1针，持续使用6个月，停药100d后月经来潮，经期腹痛未减反剧。就诊时患者主诉：经期头1~3d剧烈腹痛，以右侧少腹为甚，疼痛呈拘紧感，喜温拒按，伴恶心，欲吐，腰骶酸痛，经血中有明显血块，色紫暗，量少，经期头1~3d不能上班，重时4~5d不能工作，常口服芬必得止痛。曾经中药、按摩等疗法治疗，均未取得明显疗效。因从英特网得到田从豁教授的有关经验介绍，故抱着试试看的心里前来就诊，患者13岁初期，月经周期40d左右，每次行8d，末次月经1998年3月28日。诊断：中医为痛经（寒凝瘀血）；西医为子宫腺肌病术后。初诊于针刺中极、子宫、血海、三阴交、足三里，留针30min，并加神灯于小腹部熏烤。第二诊，即5月6日，患者诉有轻微头晕、心慌，取穴加百会毫针刺。第三诊，即5月8日，患者诉月经来潮，觉少腹疼痛较治疗前明显好转，自服1片去痛片后照常上班。第四诊，5月11日，月经第4天，腹痛基本缓解。患者诉本次经期疼痛明显减轻。前3d仅服1片止痛片疼痛即可缓解，可坚持日常工作，未出现过恶心、呕吐等症状。治疗在原方的基础上加肾俞、命门、白环俞，并加隔姜灸关元。此后患者坚持治疗3周，



每周治疗3次，至6月5日，月经再潮，此次月经期未出现剧烈腹痛，仅觉腰腹不适，小腹部喜温恶寒伴轻微头晕，周身乏力，因经期腹痛明显缓解能够坚持日常工作，故停止治疗。患者腹痛剧烈，拒按，当属实证。疼痛伴拘紧感，并且喜温恶寒，从病邪的属性上看属寒。另经血中有血块，经血色暗，提示还有瘀象，纵观其病证当属寒凝血瘀，冲任不调。因此治疗应温经散寒、活血化瘀为主。方中选中极、子宫两穴调理冲任气血；血海、足三里、三阴交调理全身气血；红外线烤灯及隔姜灸是温经散寒的一种措施。疼痛缓解后加肾俞、命门、白环俞用以补肾调理先天之本，这从中体现出田老倡导的“急则治其标，缓则治其本”的学术思想。

《当代中医名家丛书·田从豁临床经验》

刘保延

祝某，女，27岁。痛经5年余。患者于5年前因生气后开始出现痛经，且症状逐渐加重，曾经多方治疗，病情时好时坏。现症：经行腹痛，为绞痛，不能自持，痛甚则晕厥，月经量较少，色黑，夹有血块，下腹及腰骶有空坠感，喜暖怕凉，伴有头晕，头痛，乳房胀痛，善太息，舌淡红苔白微腻，脉弦滑。辨证：痛经，气滞血瘀，寒湿凝滞。治疗毫针火针并用。毫针取穴：列缺、内关、公孙、太冲、三阴交、血海。火针选用中号火针速刺中极、关元、次髂。治疗1次后腹痛即消失，连治1疗程，以后每于经前治疗5次，连续治疗3个月，诸症消失，临床治愈。

《火针》

二、中药外治疗法

取嚏法治疗痛经

【药物组成】 皂莢3份，冰片1份。



【操作方法】 上药共研极细粉末装瓶备用。凡遇痛经患者使用时，取药末少许置患者手帕或掌中，令其捂鼻呼吸，顷刻患者张口收腹，喷嚏频作，继而周身微汗，精神振奋，每日 1~2 次，一般患者 1~3 次痛经可除，1 个月经周期为 1 疗程。

【功效主治】 通经止痛。

【经验心得】 痛经是行经时少腹疼痛，伴随月经周期而发的疾病。中医学认为本病的发生多因气滞、血瘀、寒凝或血虚所致，痛在经前经期属实，痛在经后多属虚。其病机是气血运行不畅，脱宫经血流通受阻所致。根据“痛则不通”的要旨，采用皂莢、冰片辛香之性，开窍通络而取嚏，有效而迅速的鼓动中气，增强内脏的压力和功能，起到宣畅气机的作用。喷嚏一出周身气通，阴阳调和，故能因势利导，治疗痛经。但因喷嚏有耗气之弊，气血虚弱患者慎用。此方法简单方便，可供同道借鉴。

治验：江某，女，20 岁。自诉初潮至今 5 年余，每逢经前腹痛欲绝，久服中西药物，疗效欠佳。今日值经期，弯腰护腹，痛哭流涕，手足不温，胸乳发胀。查舌淡苔薄，脉象弦滑，诊为气滞型痛经。取药末少许令其嗅之，随即喷嚏大作，入厕经行，疼痛顿止。其母索药少许，后适经期如法用之，3 个月来告，其女病除。

【方剂出处】 李德浩，等．取嚏法治疗痛经．中医外治杂志，1997；（2）：41

红藤汤灌肠治疗子宫内膜异位症痛经

【药物组成】 红藤 15g，败酱草 15g，三棱 15g，莪术 15g，赤芍 15g，桃仁 15g，丹参 10g，桂枝 10g，延胡索 15g，香附 10g。

【操作方法】 上药浓煎 100ml，保留灌肠，每日 1 次，10d 为 1 个疗程，经期停用，连续用 3 个疗程。

【功效主治】 活血化瘀，理气止痛。

【经验心得】 中医认为瘀血是子宫内异症的根本病机，异位



的子宫内膜周期性出血，经血瘀积于卵巢形成囊肿，“离经之血”，也即瘀血。血瘀少腹，使冲任受阻，胞脉不通，不通则痛，故出现经期疼痛症状。瘀血日久，新血不生，正气必虚，如选用内服攻伐之药，必伤正气。治疗当以活血化瘀、理气止痛为要。

现代药理研究证实，活血化瘀中药有改善血流动力学，改善血液流变学和抗血栓形成，抑制炎症和组织异常增生，镇痛及免疫调节功能。作者选用中药保留灌肠，一可避免虚虚之戒，二可使药物直达病所，通过黏膜渗透入盆腔，以改善盆腔子宫的血液循环，促进局部组织瘀血消散，促进炎症粘连包块吸收，是内异症痛经的治疗机制。

【方剂出处】 梁月琴，等．中药灌肠治疗子宫内膜异位症痛经 72 例．中国中医药科技，2004；11（4）：252

吴茱萸白药膏敷神阙穴治疗痛经

【药物组成】 生吴茱萸粉 2 份，云南白药 1 份，陈醋若干。

【操作方法】 上药用陈醋调和成面团状即为吴茱萸白药膏。治疗时每次取药膏如蚕豆大纳神阙穴，外用伤湿膏固定，从就诊当天及月经期前 6d 开始，至月经来潮后第 6d 止，每日 1 换，连续治疗 3 个月经周期为 1 个疗程。对肝郁湿热证患者，每次取六神丸 1 粒研碎和入药膏中同敷。因云南白药及伤湿膏均为孕妇忌用品，故已婚妇女做此治疗前需排外妊娠，治疗过程中需避孕。

【功效主治】 调理冲任，通调三焦，益气健脾。

【经验心得】 仲景治冲任虚寒兼瘀血证主以温经汤，温补冲任，养血行瘀，扶正祛邪。此方现代仍是治疗痛经等症的有效方剂。但汤药煎服殊为不便，作者遵吴师机“外治之理即内治之理，外治之药亦即内治之药，所异者法耳”的理论，仿温经汤意，取温经汤主药吴茱萸，以温经散寒，疏肝解郁，行气止痛，温肾暖胃，配活血散瘀、止血消炎及能治妇科一切血证的云南白药，敷于任脉之神阙穴，具有调理冲任、通调三焦、益气健脾之功。药



与穴合，使冲任得温，瘀血得行，肝郁得解，邪祛正复，痛经可愈。如属肝郁湿热证者，加入六神丸以清热、解毒、消炎，又能制吴茱萸之热性，寒温并用，相济以立功。

【方剂出处】 兰迪翔，等. 吴茱萸白药膏敷神阙穴治疗痛经，江西中医学院学报，1997；9（4）：17

穴位外敷痛经膏药治疗原发性痛经

【穴位选择】 神阙、三阴交。

【药物组成】 生川乌头、生草乌头、花椒、马钱子各 15g，生大黄、红藤、乌药、小茴香、香附各 10g，三七、当归、红花、桃仁各 6g。

【操作方法】 上药加麻油 1 500g，浸泡 7d，文火炼制，以油滴水成珠为度，过滤去渣，加入铅丹 700g，制成膏药，每张重约 1g，使用时膏药中心可加冰片少许，贴附于上穴，2d1 换，连用 3 个月经周期。

【功效主治】 镇痛缓急，理气活血。

【经验心得】 痛经膏药中生川乌头、生草乌头、花椒、马钱子均具有很强的镇痛作用；乌药、小茴香、木香、香附理气调经；三七、当归、川芎、桃仁、红花活血行瘀；大黄、红藤清热散结。全方共收镇痛缓急、理气活血之效。神阙内通脏腑经络；三阴交乃足三阴经交会穴，为调理痛经之要穴。膏药性缓，加少量冰片芳香透达以取其速，故收效甚佳。

治验：王某，24 岁，已婚。痛经 3 年余，曾用中西药物治疗效果不佳。每次经前 3~4d 小腹疼痛难忍，伴腰骶酸楚疼痛，经量少，经色紫黯有块，块下痛减，舌质紫、有瘀点，脉沉弦。证属气滞血，经行不畅。予痛经膏药外敷神阙、三阴交，20min 后小腹疼痛即止。连用 3 个月经周期，痛经消失，随访 6 个月未见复发。

【方剂出处】 范红. 穴位外敷痛经膏药治疗原发性痛经 160



例. 河北中医, 1999; 21 (6): 371

熨敷神阙穴治疗痛经

【药物组成】大葱 1 500g, 红萝卜 500g, 生姜 20g, 白酒 50g。

【操作方法】将大葱切段, 红萝卜、生姜切片, 放锅内炒至半熟, 喷上白酒, 散发蒸汽, 而后分成 2 份, 一份留锅内保温备用, 另一份用布包裹熨脐(神阙穴), 凉后再换锅内一份, 如此交替敷熨至脐以下出汗为止(一般 4h 以上)。此疗法在经期前 3~5d 内应用, 敷熨时用毛巾或被遮盖脐部以下, 上半身不用遮盖以避免上半身出汗过多。

【功效主治】温经活络止痛。

【经验心得】采用大葱、红萝卜、姜, 可散寒、除湿、祛瘀、温通阳气而止痛, 白酒助其药性。脐为神阙穴, 属任脉, 任脉为阴脉之海, 主任胞胎, 与督脉相表里, 总司人体诸经百脉, 同时脐又为冲脉运行之所, 冲脉也为经脉之海, 所以脐与百脉相通。又因奇经八脉纵横上下、沟通内外、联络全身之络, 药敷该穴, 药性可迅速到达病所而发挥药理作用, 起到温经通络止痛之目的, 故起效迅捷。

【方剂出处】张崇芬, 等. 熨敷神阙穴治疗痛经 62 例. 中国针灸, 2001; 21 (3): 134

敷脐疗法治痛经 1

【药物组成】气滞血瘀型: 乳香、没药各 10g, 白芍、当归、吴茱萸各 50g。寒凝血瘀型: 肉桂、吴茱萸、小茴香、赤芍各 20g, 温姜、桃仁各 10g。

【操作方法】把药研为细末, 加 30% 白酒和少许凡士林调为膏糊状。于经前 3d 敷脐部, 经至敷关元穴, 胶布固定。敷药前先以酒精棉球擦净脐孔, 每日换药 1 次, 经净取下。痛甚者同时用热水袋温敷, 连续 3 个月经周期为 1 个疗程。



【功效主治】 行气通经，化瘀止痛。

【经验心得】 原发性痛经在中医辨证中属气滞血瘀或寒凝血瘀者居多。气滞则血液运行不畅，瘀滞冲任，不通则痛；寒主收引，寒凝胞宫，使气机阻滞血行不畅而经行腹痛。总之，不论是气滞血瘀还是寒凝血瘀，其主要病机都是不通则痛，其治法无论是行气通经还是温经通脉，都离不开“通则不痛”这一准绳。敷脐法属于中医外治法的范畴，现代医学研究表明，脐在胚胎发育过程中，为腹壁最后闭合处，其表面角质层最薄，屏障作用较差，脐下无脂肪组织，皮肤与筋膜、腹膜直接相通，含有丰富的血管，渗透性强、吸收快，极有利于药物的穿透吸收。故药物敷脐可以弥散穿透入血液循环，产生全身效应，达到治疗目的。

【方剂出处】 谭学锋. 中医敷脐法治疗原发性痛经. 江西中医药, 2004; 35 (236): 33

敷脐疗法治痛经 2

【药物组成】 肉桂、红花、炮姜、桃仁、细辛、川芎、吴茱萸、延胡索、天仙子、制川乌、冰片。

【随症加减】 血热瘀结型去肉桂、吴茱萸、炮姜，加黄柏。

【治疗方法】 上药粉碎过 100 目筛，装瓶密封备用。经前 3d，取药粉 3g 加黄酒调敷，外敷神阙穴，胶布固定，隔日换药 1 次，用至经行 3d 为止。3 个月为 1 疗程。另外，疼痛时，取上述药粉 0.5g 吹入一侧鼻孔，吹药时嘱患者屏气，以防药粉误入气管，引起呛咳。

【功效主治】 活血温通镇痛。

【经验心得】 中医认为痛经以寒凝胞宫，气血不畅为多。寒主收引，寒凝胞宫，气血郁滞，不通则痛。方中肉桂、炮姜、细辛、川乌宣导血脉，散寒止痛，温补肾阳，红花、桃仁、川芎活血调经，破血行瘀；延胡索、天仙子行气解痉止痛；冰片既能止痛，又香窜善走，能引药深入病处。全方共奏活血温通镇痛之功



效。神阙穴为五脏六腑和十二经脉出入之门。脐部敷药可通过经脉使药力直达胞宫，疏通经脉气血，瘀去痛自止。脐部表皮角质层最薄，脐下无脂肪，皮肤与筋膜腹膜直接相连，脐周围血管丰富，利于药物吸收，扶正祛邪，调整阴阳，疏通经络，调理气血，补虚泻实，整体调节胞宫的功能，使趋于正常，而达到治病治本的目的，这是本法能根治痛经的机制所在。

鼻黏膜毛细血管丰富，鼻腔给药取效时间快，几乎可与静脉给药相当，给药量少，可连续多次给药，无消化道及肝脏首关效应，与神阙敷药起到相辅相成的作用。

【方剂出处】 王梅. 中药外治单纯性痛经疗效观察. 中医外治杂志, 1997; (3): 36

痛经贴外敷关元穴治疗痛经

【穴位选择】 香附、蒲黄、五灵脂、丁香、肉桂、乌药、细辛、延胡索、川芎、红花。

【操作方法】 将上述药研成细末，用黄酒将其调匀成稀糊状，均匀地裱糊于两层医用透气胶带之间。待其晾干后剪切成 $2\text{cm} \times 2\text{cm}$ ，粘贴于 $2\text{cm} \times 4\text{cm}$ 医用胶布的中间部位。再用 $2\text{cm} \times 4\text{cm}$ 医用塑料薄膜覆盖，并将薄膜中间剪开，制作成创可贴式样，厚 0.15cm ，密封以备。治疗时让患者仰卧，用乙醇棉球在患者关元穴区进行无菌操作后，将痛经贴贴敷其上，同时根据关元穴局部皮肤情况，如皮肤出现充血者第3天即可取下，如无皮肤充血者可连续贴敷4~6d取下，每月1贴，于每次痛经出现前2~4d进行贴敷，连续治疗3个月。

【功效主治】 疏通经络，调理气血。

【经验心得】 任脉起于胞宫，具有“主胞胎”的作用。《难经·二十九难》曰：“任之为病，其内苦急”；《脉经·平奇经八脉病》云：“苦少腹绕脐，下引横骨，阴中切痛。”关元穴为任脉经穴，并与冲脉相通，《素问·举痛论》曰：“冲脉起于关元”，内



通胞宫；《类经图翼》称此穴为“女子畜血之处”，位于脐下三寸，又称“丹田”。有调理冲任、温通胞脉的作用。

痛经贴所选中药具有行气活血、化瘀止痛之效，能通调冲任气血；兼有芳香走窜之性，加之黄酒，可促进药物透皮吸收。其中香附调经止痛，其挥发油能缓解子宫平滑肌紧张；蒲黄、五灵脂行瘀散结，是中药镇痛良方，能缓解平滑肌痉挛；丁桂散常用于传统外治疗法，具有温经散寒、活血通脉作用，血得温则行，其中桂皮油是透皮吸收促进剂；乌药、延胡索含挥发油能行气止痛；细辛挥发油具有明显镇痛作用，皮肤给药可降低毒性；川芎、红花活血化瘀止痛。痛经贴治疗痛经，给药途径独特，其发挥穴位与中药的双重效应，避免了药物的毒性和不良反应，通过穴位皮下组织的储库效应，长时间激发经气，达到疏通经络、调理气血的作用。方法简便，疗效确切，为患者自行治疗提供方便。

治验：周某，22岁，未婚。月经前小腹部剧烈疼痛5年。初次月经在15岁。5年前因高考精神高度紧张，出现痛经，以后每次月经前2~3d均出现小腹部剧烈疼痛，伴有腰骶部酸胀疼痛，胸部胀闷不舒，月经周期常紊乱，量少，有血块呈紫黯色，血块下后疼痛明显减轻。舌质紫黯苔薄白，脉弦细，证属气滞血瘀。治以行气活血止痛。用痛经贴治疗3个月，疼痛消失。随访半年未复发。

【方剂出处】 陈卫华，等.痛经贴外敷关元穴治疗痛经 188例. 安徽中医学院学报，2002；21（3）：38

艾香药袋敷脐治疗痛经

【药物组成】 艾叶 10份，公丁香、乳香、没药、五灵脂、青盐各 1份。

【操作方法】 先将艾叶研成艾绒，其他药物共研细末，然后与艾绒充分混合均匀备用。用白棉布做成直径 15~20cm 的圆形袋，取上药 20g 装入袋内，用手将袋内药末摊成薄饼状压实封口，



用带子将药袋系于脐部，每个月经周期换药袋1次，连续敷用3个月经周期为1疗程，敷药期间停用一切其他治疗痛经的药物。

【功效主治】 温经通脉，活血化瘀。

【经验心得】 病例均为未婚少女，其中14~18岁者居多，生理上具有肾气初盛，天癸始至，冲任之通盛尚未稳定的特点，病理上以虚、寒、瘀互见者居多。《本草纲目》曰：“……丹田气弱，脐腹冷疼者，以艾叶入布袋兜其脐腹，妙不可言。”故方中以艾叶为主温阳、调经、通脉；辅以公丁香、乳香、没药、五灵脂行气活血；青盐引药入下焦，敷于脐部通过神阙、丹田等穴位的吸收，经络的传递，调整脏腑的功能，共奏温经通脉、活血化瘀之功。本法具有简便易行，疗效可靠，无副作用等优点。

治验：王某，女，16岁。自诉从14岁月经初潮起，每逢经期即小腹疼痛难忍，伴有腹部凉感，经期常须卧床休息，服止痛药，影响日常生活及学习，曾服“当归丸”等中成药治疗无效。给予艾香药袋敷脐，敷用1个月经周期后痛经即明显减轻，继续敷至3个周期后，月经来潮后腹疼及腹部凉感完全消失，随访半年未复发。

【方剂出处】 王宝礼. 艾香药袋敷脐治疗少女痛经40例. 中医外治杂志, 1997; (5): 19

中药外敷治疗痛经1

【药物组成】 延胡索20g，红花10g，食盐50g。

【操作方法】 先把延胡索、红花两味研成粗末，炒至药物发黄，用麻油调成糊状，外敷于脐部，用纱布覆盖其上固定。另外，将食盐炒热，放于一布袋内，外敷脐部，每日3~5次。注意生活规律、经期保温；注意经期卫生，避免剧烈运动及劳累；忌食生冷，加强营养，消除紧张情绪。

【功效主治】 活血通经，祛瘀止痛。

【经验心得】 痛经的发生往往与情志有关，另外生活起居不



慎或六淫为害也有不同的影响。其病机为经期前后受致病因素的影响，导致冲任瘀阻或寒凝经脉，致气血运行不畅，胞宫经血流受阻，以致不通则痛，或冲任、胞宫失于濡养，不荣则痛。治以活血化瘀、温经止痛。方中延胡索疏经通络、行气活血止痛；红花辛温，活血通经、祛瘀止痛，治疗经闭，癥瘕、瘀血作痛；食盐炒热外敷脐部，产生热效应，有利于药物有效成分的渗透和吸收，引药入里。诸药合用，共奏疗效。本方法简单实用疗效好，不妨一试。

治验：杜某，女，18岁，未婚。自诉行经时小腹坠痛，经量不多，色黯，有凝血块，脉沉弦，舌质暗红有瘀点，正值经期，故用上述方法治疗，连用3个周期，痛经消失，随访2年未见复发。

【方剂出处】王会明，等．中药外敷治疗痛经57例．中医外治杂志，2002；11（5）：4

中药外敷治疗痛经2

【药物组成】肉桂、延胡索、乳香、没药、土鳖虫、乌药各30g。

【操作方法】上药焙干后研细末备用，每次取20g，用黄酒调成糊状。外敷关元穴，上覆1层油纸或塑料薄膜，再用胶布固定，每天用特定电磁波治疗器（TDP）照射10~20min。每日换药1次，每个月经周期自经前3d开始，连用5d至经潮第2天，连续治疗3个月经周期为1疗程。

【功效主治】温阳散寒，活血化瘀，调经止痛。

【经验心得】痛经虽有寒热虚实之分，但原发性痛经大多以寒凝血瘀证型为主，尤其是重度痛经患者。正如《诸病源候论》所说：“妇女月水来腹痛者，由劳伤气血，以致体虚，受风冷之气客于胞络，损伤冲任之脉。”病变部位在冲任，导致胞宫排经血行不畅而致疼痛，局部病变引起全身反应，根据“不通则痛”的病机及“欲其通之，必须温之”的治则，立温冲任，化瘀止痛



法，自拟外敷通经止痛方治疗之。方中肉桂温壮阳气，寒得温则散，瘀得温则化，血得温则行，故为主药，延胡索、乳香、没药、土鳖虫散瘀行气止痛，破血中之瘀；乌药温通散寒、行气止痛；黄酒温通血脉，以助药力。全方共奏温阳散寒、活血化瘀、调经止痛之效。

治验：赵某，女，17岁，2002年3月16日初诊。14岁初潮后因冒雨涉水而痛经，曾在本村和乡医院治疗，效果不佳。2001年入校后每次来月经疼痛难忍，靠吃止痛药来控制。由于痛经的困扰，加之长期服用止痛药导致胃肠功能紊乱，而致体形消瘦，精神不佳。诊断为重度痛经，用通经止痛方外敷关元穴，连续治疗3个月经周期后痊愈。现在该学生在医院实习，2003年12月10日电话随访未发生痛经。

【方剂出处】 刘卫平. 中药外敷治疗寒凝血瘀型原发性痛经45例疗效观察. 中医外治杂志, 2004; 13(4): 4

中药外敷治疗痛经3

【药物组成】 取附子、吴茱萸、红花、细辛、冰片按5:4:3:2:1比例混合研末，过100目筛，装瓶备用。再取紫草500g研成极细末，倒入烧沸的1000g麻油中，凉后装瓶备用。用前临时将药粉加紫草油调成糊状。

【治疗方法】 在每次月经来潮前3~4d开始直至经净，于每天临睡前将关元穴区用酒精或碘伏消毒，将调好的中药糊涂抹在关元穴区，厚度约1mm，面积约6cm×6cm，以塑料纸覆盖。然后取2000g食盐（最好是粗盐）炒热，装入缝好的毛巾袋中，在关元穴区滚熨约1h。最后用收腹带或纱布带缠扎腰腹部，固定关元穴区外敷的药糊，防止其污染被褥，次晨取下，用温水清洗干净腹部即可。每月治疗约10d，部分患者可延长达20d，3个月后观察疗效。

【经验心得】 痛经一证虽有情志所伤，起居不慎及六淫为害



等不同病因，但其总病机是冲任瘀阻或寒凝经脉，使气血运行不畅所致，或因素体不足，胞宫失于濡养引起。其病位在冲任、胞宫，变化在气血，故其治疗原则以调理冲任气血为主。笔者选用任脉之关元穴，其位置正对胞宫，具有补气养血作用，并用附子、吴茱萸、细辛等辛热之品温阳散寒，红花活血散瘀，配有有渗透作用的冰片外敷，起到温经散寒、行气活血的作用；用紫草油调敷可加强其活血补血之作用。另用盐熨是取盐之咸味并其温热之性带诸药入肾，达到温肾养血、温补下元的作用。本法对痛经一证，不论虚实均能顾及，冲任得调，经脉畅通，胞宫得养，而疼痛消失。

治验：黄某，18岁，2002年11月25日初诊。自诉15岁月经来潮时，每月经前1d始，至经净后5d，小腹疼痛难忍连及腰骶，同时伴有头痛、恶心、经来量多且有血块。曾经口服中西药物治疗而不效。改用上法治疗第1个月即感疼痛大减，继续治疗，至第3个月月经来潮时疼痛完全消失。观察半年未再复发。

【方剂出处】 王光明，等．中药外敷配合盐熨治疗痛经 60例．中国民间疗法，2004；12（8）：18

痛经散穴位贴敷治疗原发性痛经

【药物组成】 肉桂、细辛、吴茱萸、苍术、威灵仙、白鲜皮各30g，延胡索、香附、乳香、没药各15g，白芷、川芎各10g。
取穴：神阙、中极、次髎（双）、地机（双）。

【治疗方法】 上药共研极细面，装瓶备用。临用时取药末（每穴3g），陈醋调膏，摊于4cm×5cm塑料薄膜或敷料上，贴于上述穴位，胶布固定。2d1次，连用3个月经周期。

【功效主治】 调理冲任，通经止痛。

【经验心得】 膻穴为经络气血流注之处，本方配伍目的为通调冲任，行气化瘀止痛。神阙属任脉，与督脉、冲脉“同源三岐”，且奇经纵横，串于十二经脉之间，故神阙穴贴敷药物，可通经达



络而贯注全身，调整脏腑功能而起到治疗作用。中极亦属任脉经穴，可通调冲任脉气；地机为脾经郄穴，能疏调脾经经气而止痛；次髎为治疗痛经的有效经验穴。上述诸穴合用，有调理冲任、通经止痛作用。药物施于腧穴，可发挥腧穴、药物的双重治疗作用。

【方剂出处】 张治华，等．痛经散穴位贴敷治疗原发性痛经 60 例．河南中医，2000；20（3）：61

痛经宁敷脐治疗痛经

【药物组成】 丁香 10g，肉桂 10g，延胡索 10g，冰片 10g，干姜 10g，高良姜 10g，郁金 10g，五灵脂 10g，蒲黄 10g。上药烘干研细末，装瓶备用。

【治疗方法】 于经前 3d，以上药 5g 左右，用黄酒或用藿香正气水调匀，制成直径 2cm 之药饼，敷于脐部，然后用麝香追风膏贴牢。部分对胶布过敏者，可用纱布条固定。每 24h 换贴 1 次。如果患者冷痛明显，可在敷药后再以热熨（即用净沙炒热装布袋置脐上，注意勿烫伤皮肤），或隔药灸（即以药艾条点燃后置脐上悬灸）。每次 20min 左右，以患者觉舒适为度，连续治疗到经净后 3d 结束。

【功效主治】 行气散寒、祛湿、化瘀止痛。

【经验心得】 痛经之症其病位在胞宫，气滞血瘀，不通则痛，临床以寒湿凝滞为多，故方中用郁金、蒲黄、五灵脂、延胡索等行气活血；丁香、肉桂、高良姜等散寒；以藿香正气水散寒除湿；冰片性微寒，于温热药中，可取其止痛之效。诸药合用可奏行气散寒、祛湿、化瘀止痛之效。

神阙穴位于脐部，坐镇于腹部中央，为五脏门户。现代研究表明：脐的表皮角质层最薄，屏障作用较差，脐下无脂肪组织、皮肤和筋膜，腹膜直接相连，脐周血管丰富，故敏感性高，渗透性强。药物敷脐能使药物分子易透过脐部皮肤进入细胞间质，弥



散入血而达全身发挥药物治疗作用，再加之热敷，使药物性能更活跃，尽快发挥作用。

【方剂出处】 陈金梅．痛经宁敷脐治疗痛经．江苏中医，1998；19（11）：34

少腹逐瘀汤外用治疗痛经

【药物组成】 炒小茴香 15g，肉桂 30g，炒干姜 30g，提取挥发油，延胡索 30g 醇提，醇液挥醇、浓缩，当归 90g，川芎 30g，肉桂 30g，赤芍 60g，水煎煮、浓缩、超速离心浓缩液。混合所有浓缩液，加入基质、促渗剂，混匀制成黑褐色膏状物。

【治疗方法】 清洁脐中及关元穴处，取制成的黑褐色膏状物 10g，分别置于两张 4cm×4cm 大小胶布中心，各贴敷脐中及关元穴。每于月经前 5d 开始，每日 1 次，连续 5 次。3 个月经周期为 1 疗程。

【功效主治】 调理气血。

【经验心得】 小茴香、干姜、肉桂温经散寒，通达下焦；延胡索利气散瘀，消肿定痛；蒲黄活血祛瘀，散结止痛，生用重在活血祛瘀；当归、川芎乃阴中之阳药、血中之气药，配合赤芍用以活血行气，散滞调经。全方温经散寒，活血祛瘀止痛。任脉起于胞宫，主一身之阴经，为阴脉之海，凡精、血、津、液均属任脉所司。脐中即神阙，为任脉要穴，温阳行气，调中止痛。关元为任脉和足三阴经的交会穴，为强壮穴，温阳固脱，补虚益损，行气止痛。将以上药物制成透皮吸收剂贴敷神阙、关元，用量小、使用方便、安全，不影响肝肾及胃肠道功能，减少了口服、注射给药的危险性。因此，少腹逐瘀汤方外用治疗气滞血瘀型痛经是一种具有较好疗效的给药方式，该方法经济、简便、有效、无痛苦、无明显副作用，具有很好的临床疗效和推广价值。

【方剂出处】 朱兵，等．少腹逐瘀汤外用治疗痛经的体会．河南中医，2001；21（2）：53



三、针灸疗法

针刺治疗痛经 1

【穴位选择】 阴交，水道，中极，足三里，三阴交。

【操作方法】 患者仰卧位，放松腹肌，常规消毒后自脐部神阙穴下，一横指处取主穴阴交穴，均采用直刺法，刺入 0.8~1 寸，依身体灵活掌握，留针 30min。月经来潮疼痛时进行治疗，治疗 3 次为 1 个疗程，连续治疗 3 个月经周期。

【功效主治】 通调冲任。

【经验心得】 中医学认为，痛经的主要机制是气血运行不畅所致。针刺以阴交穴为主穴，因位于神阙下 1 寸，为任脉之中，是“阴经之海”，具有调节全身阴经经气的作用，是人体气机运转的重要枢纽。配中极、三阴交穴，补阴中之气、聚足三阴之经气，足三里加强养血活血之功，给机体以良性刺激，迅速改善功能状态，降低平滑肌收缩，促进局部组织和机体的新陈代谢，收到了标本同治的效果。

针刺治疗痛经不但可避免药物治疗带来的副作用，而且取穴少、针感强、时间快、止痛效果显著，绝大多数患者 10min 内疼痛可明显减轻或消失。另外此疗法操作简单，治疗方便，花钱少，效果佳。对于炎症感染、子宫先天性畸形等因素所致的痛经，则要配合其他方式治疗。

治验：女，18 岁。从月经初潮起，每次月经小腹冷痛，连及腰骶部，经量少色暗，得热痛减，便溏，口服索米痛片、延胡索止痛片、肌注安痛定后仍痛不止。舌苔白腻，脉沉紧。医院妇科检查子宫、附件无异常，诊断为痛经，中医认为寒湿凝滞。经针刺治疗 1 次，疼痛大减，1 个疗程后诸症消失。为防复发，嘱其下月行经时仍来治疗，连续 2 个疗程，随访 2 年，未见复发。

【方剂出处】 孙宝莲，等。针刺治疗痛经 56 例。宁夏医学



杂志, 1999; 21 (7): 437

针刺治疗痛经 2

【穴位选择】 血瘀气滞型：中极、血海、三阴交、太冲；寒湿凝滞型：关元、中脘、气海；气血两亏型：命门、关元、气海、足三里。

【操作方法】 患者取平卧或坐位，针刺局部酒精消毒，采用毫针刺，对准所取穴位，垂直快速进针皮下，然后按以下各穴不同的方向，向上或向下进针。平刺进针达 1.5 寸。留针 30min。每日 2 次，1 周为 1 疗程，连续治疗 2 个疗程。然后在下 1 个月月经来潮的前 1 周再针刺 1 疗程，以期巩固疗效。各穴平刺进针的方向：中极向下、血海（双）向上、三阴交（双）向上，太冲（双）向上，关元向下，气海向下，命门向下，足三里（双）向上；刺激量：均取轻微酸麻胀针感为依据，同时亦可以针对症状改善情况来确定得气与否。一般以针时疼痛消失者为得气好；针时疼痛减轻或针时疼痛不明显或缓解者为得气较好，针时针后疼痛均无改善者为未得气。

【功效主治】 通经止痛。

【经验心得】 针对各型进行辨证选穴，针刺皮下采用不同方位治疗痛经，疗效好，是由于经络运行气血的生理作用及辨证施治的结果。痛经之因多见虚与寒，故采用轻微刺激以温补之，并适当留针以利于疗效，操作时垂直进针，直达皮下，方可平刺，以取疗效。

【方剂出处】 方悦箴，等。针刺皮下治疗妇女痛经 38 例临床观察。针灸临床杂志，1999; 15 (4): 26

针刺治疗痛经 3

【穴位选择】 子宫、大赫、关元透中极、地机、至阴、次髎。加减：寒湿凝滞加水道；肝郁气滞加支沟、阳陵泉或外关、丘墟；



肝肾亏虚加肝俞、肾俞、太溪、照海；气血虚弱加百会、阳池、中脘、足三里。

【操作方法】 每次月经中期开始，每日1次，7~10d为1个疗程。针刺前嘱患者排空小便。子宫穴、大赫穴向下斜刺，使针感传至会阴部。关元透中极，针刺时从关元穴进针透向中极，局部酸胀为度。次髂穴操作时采用俯卧位，于第二骶后孔中刺入5cm，捻转1~2min，使小腹部及会阴部发热或重胀为度。百会穴用迎随补泻或隔姜灸法。其他穴均用平补平泻法。地机、至阴隔日加灸1次，每次每穴20min。

【功效主治】 补中益气，调经止痛。

【经验心得】 子宫穴配大赫穴均善治妇科病，子宫穴为奇穴，有调整子宫功能之用。而大赫穴为肾经穴位，下当子宫位置，根据“腧穴所在，主治所及”的原则，对子宫诸疾，特别是肾虚，元气不足者多有良效。关于腹部穴的针刺角度，运用李志道老师的经验，认为凡是腹部的腧穴均宜呈70°向下斜刺为好。若直刺，尤其是向上斜刺，往往会出现腹胀之弊。关于百会、阳池、中脘、足三里：百会的位置最高，为阳气所居。阳池为三焦原穴，原气通过三焦布散于全身。十二原穴均与原气关系密切，故阳池穴与原穴的关系尤为密切。中脘为胃募腑会，胃为水谷之海，脾胃为后天之本，故本穴补中益气的效果尤佳。有鉴于此，日本学者曾把百会、阳池、中脘作为补中益气和补益原气的固定处方。考虑到足三里为补中益气之中坚，故又加入足三里，将以上4个穴作为补中益气的基本处方。该方不仅用于痛经的气虚证，凡是中气不足或中气下陷者均可用本方予以加减，诸如胃下垂、子宫下垂、肾下垂、少气懒言、神疲乏力、虚喘、眩晕等可收到满意效果。地机是脾经郄穴，能通调气血；至阴为膀胱经井穴，胞脉系于肾，肾与膀胱相表里，泻膀胱经的井穴，可治胞宫的病，实验证明至阴可以调整宫缩治痛经效果较好，次髂穴能调整局部气血，三穴组合疗效更为显著。



治验：刘某，女，22岁，未婚。痛经6年余，每次经期腹部胀痛连及两胁伴经行不畅，月经色暗，有血块，正值行经第1天，疼痛难忍，大汗淋漓，苔薄白，脉沉弦。诊断：肝郁气滞型痛经。治则：疏肝解郁，调经止痛。治疗：按上述肝郁气滞型针灸并用，当时痛止，连续治疗2个疗程完全恢复正常，随访半年未复发。

【方剂出处】李庆玉. 针灸治疗痛经60例临床观察. 天津师大学报, 1999; 19(1): 61

针灸治疗痛经1

【穴位选择】气滞血瘀：活血化瘀、通经止痛取气海、关元、三阴交、太冲。寒湿凝滞：温经散寒祛湿，通经止痛，取关元、水道、地机、三阴交、肾俞、次髎。气血两虚：益气养血，调补冲任。取气海、足三里、膈俞。肝肾亏损：补益肝肾，取命门、肾俞、关元、肝俞、太溪。

【操作方法】患者取卧位，针刺部位以75%酒精常规消毒，采用32号不锈钢1次性毫针，对准所选的穴位，垂直快速进针，然后按照以下各穴不同的方向，进针1.5寸，留针30min，每日1次，每疗程10d。各穴位进针的方向：中极向下，三阴交向上，血海向上，肾俞向下，命门向下，关元向下。针刺手法以平补平泻为主。

【功效主治】行气止痛。

【经验心得】痛经中医学认为与情志、外邪、体虚等因素有关，情志不舒，肝郁气滞，郁久化火，血运受阻，冲任脉运行不畅，经血滞于胞宫，不通则痛；寒湿之邪，伤于下焦，客于胞宫，经血凝滞，运行不畅而痛；禀赋不足或久病或孕育过多，肾精亏损，气血亏虚，经行之后血海空虚等导致胞脉失养，出现疼痛。凡经前经初痛，则为气血凝滞，多为实证，凡经后经行末期痛者，则为气血虚弱，肝肾不足，多为虚证，此病病变部位在下焦，涉及肝、脾、肾、冲脉、任脉，故辨证分型选穴，采取皮下针刺的



方法治疗痛经疗效较好，此外，针灸对原发性痛经不仅有镇痛作用，还能改善全身状况，调整内分泌，故采用针灸治疗痛经优于其他治疗方法。

治验：姜某某，24岁。自述行经腹痛6年，经中西药治疗疗效不佳，每遇行经则腹痛难忍，甚至休克，不能上班，月经量少不畅，夹有紫红血块，畏寒喜温，腰酸乏力，面色苍白，苔薄白，脉沉细，证属冲任气滞，胞宫寒凝，治以温经散寒，行气活血止痛。取关元、足三里、三阴交，行平补平泻法，得气后施以温针，30min后疼痛缓解，嘱患者在月经来潮前7~10d开始治疗，每月治疗1疗程，连续治疗3个疗程，随访未见复发。

【方剂出处】赵虹. 针灸治疗痛经42例疗效分析. 针灸临床杂志, 2004; 20(12): 27

针灸治疗痛经2

【穴位选择】三阴交（双）、足三里（双）、内关（双）、中脘、关元、中极、气海。

【操作方法】从上穴中每次选4~5个穴，随证加减。患者仰卧位，局部常规消毒后取30号1.5寸毫针，针刺得气后用艾条温和灸，每次20min，其间行针3次，灸至皮肤红晕略有灼痛感。每日1次，7次为1个疗程。最佳治疗时间为月经前3~4d。

【功效主治】疏通经络，理气止痛。

【经验心得】痛经多见于青年妇女。针灸治疗本病的机制主要是疏通经络，行气活血，调冲任。三阴交穴为肝脾肾三经之交会，功能调理气血；足三里为阳明经多气多血之穴，配中脘补益胃气，以资气血生化之源，胞脉得养，冲任自调；关元、中极、气海为任脉穴，通于胞宫，可调理冲任，乃治腹痛月经失调之常用要穴；内关穴为八脉交会之一，有治疗胸腹满痛，理气止痛，止呕，宁心安神之功效，诸穴合用共奏疏通经络，理气止痛，调补肝肾，温养冲任，行气活血之功，从而使本病告愈。



治验：陈某，女性，19岁。患者诉14岁月经初潮至今，每次行经期均出现下腹部持续性疼痛，兼有恶心欲呕，腰部酸胀，出冷汗，手足欠温等症状，需用止痛药物。诊见面色苍白，痛苦表情，下腹剧痛，月经量少，色暗红有瘀块，舌质暗苔薄白，脉弦细。辨证属肝肾不足，气滞血瘀。治宜补肝肾，调冲任，通行气，活血止痛。治疗取关元、中极、三阴交（双）、足三里（双），针刺得气后，加艾条温和灸，留针20min，行针3次。经治疗7次后下次月经期腹痛及其他诸症基本消失。继用上法治疗1个疗程而愈，随访至今未复发。

【方剂出处】 陈桂民，等．针灸治疗痛经66例．中国民间疗法，2000；8（11）：13

针刺曲骨治疗痛经

【穴位选择】 主穴：曲骨。配穴：气海、合谷、三阴交、关元、血海、足三里

【操作方法】 嘱患者小便后，取仰卧位。选定穴位，曲骨穴，即耻骨联合上缘中点。常规消毒后，取1.5~2寸消毒针具1枚。左手拇指按在腧穴位置的旁边，右手持针紧靠左手指甲面将针直刺入腧穴1~1.5寸，待疼痛缓解后，再针刺配穴。

【功效主治】 通经活血，祛瘀止痛。

【经验心得】 曲骨穴在临床较为少用，治泌尿、生殖系统疾患，属任脉与足厥阴经交会穴。任脉起于胞宫，主一身之阴。凡精、血、津、液等阴液都属任脉总司。为人体妊养之本。任脉通盛，月经得以畅流。谓之“通则不痛，不通则痛”之理。

治验：张某，19岁，14岁月经来潮。平素喜食生冷。每以经前或经时小腹胀痛难忍，号哭翻滚。经色紫黑有块。热敷痛减。平时靠服西药止痛。来诊时正值经前。小腹胀痛难忍，胸闷恶心，需抱进诊室。诊之面色发青，苔滑脉沉紧，此属寒湿凝滞型痛经。治当温经散寒，健脾燥湿。处方：针曲骨，针约2min即缓解，



留针加艾灸 30min。针配穴，三阴交双（泻）合谷双（补）气海（补）每日 1 次，7d 1 个疗程。下次经前小腹仍有疼痛。但症轻痛缓。再依法治疗 3 个疗程，症状基本消失。随访半年未见复发。

【方剂出处】 扬兰卿. 针灸治疗痛经 42 例疗效观察. 针灸临床杂志, 1998; 14 (7): 13

针刺承山穴治疗痛经

【穴位选择】 双侧承山。

【操作方法】 痛经时患者俯卧，取双下肢承山穴常规消毒后，用 1.5~2 寸 30 号毫针呈 45° 由内向上斜刺，进针 1~1.5 寸，并快速提插捻转，使局部产生麻胀感，行针 1~2min 后留针 15~30min，并每隔 5min 提插捻转次，以加强针感。每日 1 次，1 个月经周期针 5d 为 1 个疗程。

【功效主治】 调理气机，活血化瘀，调补冲任。

【经验心得】 承山穴属太阳膀胱经穴，主治脱肛、腰腿痛等症。子宫位于直肠、膀胱中间，且承山穴介于经穴昆仑、合穴委中之正中，兼行 2 穴之功能。针刺时针尖近达地机，又具地机穴作用。地机穴是治疗痛经有效穴位之一，故承山穴有一穴多用之功能，具有调理气机、活血化瘀、调补冲任作用，是治疗痛经的有效穴位。

现代医学研究也显示针刺治疗痛症能使血清内 β -内啡肽含量明显升高，而 β -内啡肽为体内镇痛物质，具有强大镇痛作用，这可能也是承山穴治疗痛经的作用机制之一。针刺承山穴治疗痛经疗效显著，特别是治疗原发性痛经，疗效尤为明显。但对继发性痛经疗效仍不满意，这可能与继发痛经合并器质性病变有关。在 3 例无效病例中，有 1 例因为痛经严重而住院，手术证实为子宫内膜异位。

【方剂出处】 吴海根，等. 针刺承山穴治疗痛经 187 例疗效观察. 江西中医药, 2000; 31 (5): 41



针刺阿是穴治疗痛经

【穴位选择】 阿是穴：在血海穴上方找压痛点，有疼痛或酸胀感之点。

【操作方法】 取穴时，请患者取仰卧位或坐位，两腿自然下垂，术者以左手拇指尖按在阿是穴上，右手持针垂直刺入（选用2~3寸毫针），运针30min至数分钟，留针15~20min。对疼痛停止又再发者，可行再次针刺。针刺过程中疼痛无减轻者，应及时停止，并尽快明确痛经原因，对症治疗。

【功效主治】 疏通经气。

【经验心得】 以压痛点为穴是中医针灸学的传统取穴法，源于《内经》“以痛为腧”的理论。“痛则不通”“通则不痛”，针刺阿是穴可以疏通经气，故能止痛。针刺阿是穴对功能性痛经尤其适应，对器质性痛经疗效欠佳。应用此法治疗时，患者除有针感外，无其他不良反应，这一点优于应用镇痛药。

【方剂出处】 李云华，等．针刺阿是穴治疗痛经．青海医药杂志，2004；34（9）：39

针刺次髎穴治疗痛经

【穴位选择】 次髎。加减：气滞血瘀加地机、太冲、气海；寒湿凝滞加中极、归来，气血虚弱加肾俞、关元、足三里。

【操作方法】 患者俯卧，选用3~4寸毫针刺入次髎穴，进针深度为3~3.5寸，针感向小腹部放射，得气后行盘针法或接G—6850治疗机，疼痛停止后，留针15~20min，然后使患者仰卧，针刺其他穴位。配穴遵照“虚则补之，实则泻之”的原则，地机、太冲、气海用提插捻转泻法，中极、归来施用先补后泻的手法或配温和灸，肾俞、关元、足三里施以补法，留针30min，每日1次，5次为1疗程。

【功效主治】 活血行气，祛瘀止痛。



【经验心得】 本法以针刺次髎穴为主治疗，该穴位于骶部，局部有第二骶神经通过，深刺可触及盆腔神经丛，故可调节盆腔脏器的功能，解除子宫平滑肌的痉挛。并通过刺激使体内脑腓肽的含量升高，提高痛阈，而达到止痛效果。然后结合辨证选穴，以补其不足，泻其有余来调节脏腑之功能，达到最佳的治疗效果。

治验：王某，女，17岁。痛经2年，每值经前1d，开始小腹胀痛，痛势剧烈，难以忍受，常在床上翻滚、呻吟、经色紫暗，夹有血块，血块排出后痛稍减，舌质暗有瘀点，苔黄白相间，脉沉弦，证属气滞血瘀型痛经。治以活血行气，祛瘀止痛，选用次髎穴，刺入3.5寸，施用盘针法，痛稍缓解，留针15min再行盘针法痛止；然后选用地机、太冲、气海用泻法，留针30min。为巩固疗效，连治3次而愈，1年后随诊未复发。

【方剂出处】 苏永立，等．针刺次髎穴治疗痛经．河南中医，2002；22（4）：51

针刺膝眼穴治疗痛经

【穴位选择】 内外膝眼穴。

【操作方法】 患者仰卧位，施术膝关节屈曲90°，穴位常规消毒，选用28号3.5寸长毫针，于内外膝眼穴垂直进针约3寸，行提插捻转补法，中等强度刺激，针感达到要求后出针，每日1次，3次为1个疗程，每疗程以痛经发作当天开始，治疗连续3个月经周期。

【功效主治】 疏肝理气。

【经验心得】 痛经是妇女正值经期或行经前后出现以周期性疼痛为主的一类病症。中医认为痛经与肝、肾、冲、任等经脉相关，肝肾不足，胞脉失养，导致气机不畅，瘀阻胞中而得，治宜温补肝肾，行气导滞。内外膝眼穴治疗痛经系作者在临床为一痛经患者治疗膝关节炎时偶尔所得。《灵枢·杂病》云：“肾有疾，其气藏于两膕。”内外膝眼长针深刺，针尖已达到两膕窝，从而



疏导了肾气，因肝肾同源之理，肾气舒畅则肝气也得以运化，使宗筋得舒，疼痛乃消。另外作者发现在非痛经期针此二穴无预防作用，且痛经时针膻窝之穴委中疗效不如膝眼。

【方剂出处】 胡朝伟，等．针刺膝眼穴治疗痛经 60 例．中国针灸，2001；21（11）：670

针刺治疗虚寒性痛经

【穴位选择】 子宫，三阴交，合谷。加减：血中夹块者加血海；胁痛乳胀者加太冲、期门；形寒肢冷者加肾俞、命门；月经过多者加阴陵泉。

【操作方法】 子宫穴：前阴抽动感；合谷、三阴交：用 1.5 寸 30 号毫针直刺，进针 1 寸左右，待得气后，平补平泻方法提插捻转数次，留针 15～20min，辅以远红外线适宜温度理疗。经前 3～5d 治疗，每日 1 次，3d 为 1 疗程。连续 3 个月的经前治疗。

【功效主治】 补气和血，通经止痛。

【经验心得】 虚寒性痛经主要是由于寒凝、气滞血瘀、气血不荣所致。气为血之帅，气行则血行，通则不痛。子宫穴为胞宫的主要穴位，针刺该穴促使任脉经气疏通，气血宣畅，气机调达；三阴交是足太阴经穴，主血分，为肝脾肾三经之交会，针刺该穴能健脾助运，养血柔肝，滋阴益肾；合谷为手阳明经穴，阳明经多气多血。合谷配三阴交起到补气和血、通经止痛之效。腹部远红外线理疗，使局部的毛细血管扩张，从而对盆腔脏器产生了热效应，解除紧张，减少子宫收缩，针灸并施，两法合用，使气血通畅，疼痛消失。

【方剂出处】 武兴建．针刺加远红外线治疗虚寒性痛经 28 例．安徽中医临床杂志，2000；12（5）：419

针刺十七椎下治疗痛经

【穴位选择】 主穴：十七椎下（第 5 腰椎棘突下）；配穴：



足三里（双侧），三阴交（双侧）。

【操作方法】 嘱患者俯卧位，腹部垫枕头，消毒局部皮肤，于第5腰椎下指压取穴后，取2.5寸毫针直刺穴位，徐徐捻转进针，刺入约1.5寸，以有强烈针感为度，留针15min。足三里、三阴交取1.5寸毫针，直刺1寸深，得气后留针15min。痛经发作时治疗，可起到迅速止痛的效果。周期治疗，选择治疗时间为经前5d开始针刺，经后连续针刺3d，每日1次，实证用泻法，虚证用补法。一般2~3个疗程，病可痊愈。

【功效主治】 调经止痛。

【经验心得】 本病由诸多因素影响而致冲任瘀阻或寒凝经脉，使气血运行不畅，胞宫血流受阻，血脉失养，以至于“不通则痛”“不荣则痛”。十七椎下，位在督脉。督脉为阳，任脉为阴。而痛经属阴阳不和、气滞血瘀。取十七椎下近胞宫部位，从阳到阴，以调和阴阳，疏通气血而达到止痛目的。针灸玉龙歌云“肚腹三里留”，故取足三里。任主胞宫，三阴交穴，系足厥阴肝经、足太阴脾经、足少阴肾经交会之处，足之三阴循行足内侧至腹部，故取三阴交，以调整血海、胞宫的气血功能而达到止痛的目的。

治验：丁某，女，17岁，患痛经已2年，月经量少伴有血块，块下痛减。本次发病为月经第1天，就诊时面容痛苦，右下腹部胀痛难忍，舌边有瘀斑，脉沉涩，证属冲任瘀阻，经本法治疗后，疼痛迅速消失，又经周期治疗2次，痊愈未复发。

【方剂出处】 姚红. 针刺治疗痛经32例观察. 中医函授通讯, 2000; 19(3): 53

针刺治疗血瘀型原发性痛经

【穴位选择】 双侧关元俞。加减：寒凝血瘀配以三阴交、足三里；气滞血瘀配以太冲、足三里等穴。

【操作方法】 用28号3寸针刺入关元俞2寸左右，得气后，



捻转提插 1min，然后出针。针后加拔火罐，留罐 10min。配穴平补平泻，留针 20min，每隔 5min 行针 1 次。在每个月经周期前 5~7d 开始施治，每日治疗 1 次，至每次月经来潮为止，连续治疗 3 个月经周期为 1 个疗程。

【功效主治】 温通经脉，活血化瘀。

【经验心得】 血瘀型痛经的主要病机是寒凝气滞、冲任气血运行不畅导致血瘀胞宫而作痛，故以温经通络、活血化瘀为治疗原则。选取双侧关元俞，针刺后加拔火罐以达温通经脉、活血化瘀之效。取关元俞既能调理肾与胞宫，又能疏通局部经气，以温通之法，有益火之源、振奋阳气而祛寒邪之意，为治疗痛经的经验效穴。再者，取双侧关元俞可以通过针刺的提插捻转来直接刺激骶丛神经和自主神经系统，调节子宫平滑肌的自律性和收缩性，缓解痉挛而即时止痛。另外，根据寒凝血瘀和气滞血瘀成因之不同，分别辨证配以足三阴经之会的三阴交，以达健脾运湿、益肾助阳、疏肝调血之功，共奏宣散寒湿、通瘀理血之效。足三里为阳明胃经之合穴，阳明经多气多血，配之有扶正缓急、活血止痛的作用。

【方剂出处】 任路，等．针刺关元俞加罐治疗血瘀型原发性痛经临床研究．中国中医药信息杂志，2001；8（3）：72

速刺内关、公孙治疗痛经

【穴位选择】 内关（双侧）、公孙（双侧）。

【操作方法】 患者平卧，取双侧内关、公孙穴快速进针，行泻法（强刺激），不留针。

【功效主治】 行气活血，解痉止痛。

【经验心得】 公孙穴为足太阴之络，联系足阳明胃经通于冲脉，冲脉起于胞中循腹至胸中而散。内关为手厥阴之络，联系手少阳三焦经，通于阴维脉，阴维脉起于与各阴经交会之处，与足三阴经、任脉相维系因此选用两穴则可调理冲任，解痉止痛，行



气活血从而达到“通则不痛”的目的。

治验：患者，女，20岁。自述经期适至，少腹疼痛难忍。诊见患者痛苦面容，双手按腹，查脉沉而迟。此乃胞宫寒凝气滞，经行未畅，气血不和之故。即取内关、公孙穴速刺。1次后疼痛缓解，休息片刻疼痛全消。

【方剂出处】 李秀明. 针刺治疗痛经 50 例. 上海针灸杂志, 2004; 23 (8): 43

针灸承浆、大椎治疗痛经

【穴位选择】 承浆，大椎。

【操作方法】 承浆向下斜刺 5 分，待有酸麻、胀重针感后，快速提插捻转约 0.5min，留针 30min，每隔 10min 提插捻转 1 次。大椎将针向深部缓慢刺 3 分深，使针感向背部下方传导。如属寒凝血瘀或虚寒痛经，再加温针 2 壮。上述治疗在月经来前 3d 开始到月经停止为 1 个疗程，每日针刺 1 次，共针治 3 个疗程。

【功效主治】 振奋阳气，滋养胞宫。

【经验心得】 痛经病位主要在胞宫，但与冲任督相互资助密切相关。因冲任督三脉同源三歧，均起于胞中，任脉主一身之阴脉，起胞中，行于腹部正中与足三阴经交会，主一身之阴，为阴脉之海。而月经为阴血所化生，任脉之阴血滋养胞宫，与冲脉相互资助，才能保证女子正常的月经来潮，正如《素问·上古天真》曰：“任脉通……月事以时下。”故任脉受病，胞宫失养，则易发生疼痛。故选任脉之承浆穴，可以调冲任，补阴血不足；大椎穴乃诸阴之会，总帅一身之阳，有调整全身阳气，推动气血运行的作用。二穴合用，有振奋阳气、滋养胞宫之功，使胞宫内气血运行通畅，冲任和调，故无疼痛之虑。

治验：王某，女，24岁。自诉痛经 1 年，曾用中西药治疗不显，每次月经来前 1d，少腹绞痛难忍，俯卧屈膝，双手按腹，舌



苔白，脉沉而迟。此乃寒凝气滞之痛经，用上法治疗 1 次后痛减，共针 3 个疗程而愈，随访 1 年未复发。

【方剂出处】 孙文华. 针灸治疗痛经 120 例观察. 新疆中医药, 2000; 18 (3): 34

针刺三阴交、次髎治痛经

【穴位选择】 主穴：三阴交、次髎。配穴：寒湿凝滞取中极、水道、地机。肝郁气滞取气海、太冲、内关。气血虚寒取血海、肾俞、足三里。

【操作方法】 主穴操作：患者取俯卧位，以 3.5 寸毫针刺入次髎穴，进针 2~3 寸，行针得气后针感向小腹及股内侧传导。取三阴交穴使针尖向上斜刺，进针 0.8~1 寸，行针催气使针感上传并与次髎穴之感传相呼应为佳。实证用泻法，虚证用补法，虚实不明显用平补平泻法。配穴操作：因部位而异进针，得气后随证补泻。寒湿凝滞型先补后泻，肝郁气滞型针用泻法，气血虚寒型针用补法。留针 20min，每隔 5min 行针 1 次。自经前 5d 开始治疗，每日 1 次，至行经第 2 天结束。

【功效主治】 缓急止痛。

【经验心得】 原发性痛经由于其发病年龄特点在大学生中较为常见，随着身体发育逐渐成熟，正值肾气初盛而冲任日臻充盈阶段。多因月事来时失于调护而感受寒湿，胞脉凝滞，气血运行不畅；或为七情所伤，肝郁气滞，冲任瘀阻；或因先天禀赋不足，精血亏少，气血虚寒，使胞脉失于温煦濡养发为痛经。本证疼痛为标，寒湿、气滞、虚损所致冲任失调为本。治宜缓急止痛治其标，通调冲任顾其本。主穴次髎、三阴交为治疗痛经的经验效穴，深刺次髎可通过盆腔神经丛的调节以解除子宫平滑肌痉挛。三阴交为足三阴经交会穴，有调三阴经经气活血通经之效。辨证配穴以祛邪扶正，补虚泻实来消除病因，并于经前调理，使冲任调畅，胞宫得以濡养，以达到治疗痛经的目的。



【方剂出处】 郭之平，等．针刺防治原发性痛经 39 例．陕西中医，2003；24（12）：1120

针刺承山、三阴交治疗痛经

【穴位选择】 承山（双侧）、三阴交（双侧）。

【操作方法】 选用 30 号 3.5 寸长的毫针，按常规消毒，先针双侧承山穴，后针双侧三阴交。得气后留针 30min。于经前 5d 连续针至经行第 2 天为 1 个疗程，一般连续治疗 3~5 个疗程。进针后根据辨证虚实施行补泻手法：经前或经期腹痛拒按，伴乳胀痛，量少色紫暗，有血块，脉细沉紧，多属气血瘀滞或寒湿凝滞之实证，进针后承山穴行泻法，三阴交行补法；若寒湿偏重，经行腹痛，得温则缓，可配合艾灸三阴交穴；经期或经后小腹空痛、喜按，经行量少质稀，舌淡脉细，则属气血两亏或肝肾亏虚，进针后承山、三阴交均行补法。

【功效主治】 行气化瘀，调补冲任。

【经验心得】 痛经之发生主要是冲任不调，多因肝肾不足，任冲二脉气血运行不畅，致成“不通则痛”。三阴交是肝、脾、肾三条阴经之交会穴，该穴能调补肝肾，疏肝理气，调经止痛。承山穴乃足太阳膀胱经穴，取治痛经乃民间经验选穴，其具体机制未见记载，有待进一步研究。

治验：王某，女，21 岁。诉 18 岁时因经前淋雨而致腹痛至今，每月经行前即出现小腹部持续性坠胀痛，服中药、止痛剂等治疗，疼痛曾一度缓解。刻下为经行第 1 天，经行量少色紫暗，小腹坠胀疼痛剧烈，面色苍白，出冷汗，腰酸痛，恶心呕吐，舌质暗红脉细弦，证属气滞血瘀。治宜行气化瘀，调补冲任。治疗取穴承山、三阴交。承山穴行泻法，三阴交行补法。针刺 3 个疗程，随访 6 个月未复发。

【方剂出处】 朱志义．针刺承山三阴交治疗痛经 36 例．四川中医，2002；20（8）：78



针刺关元、三阴交治疗痛经

【穴位选择】 关元、三阴交（双侧）。

【操作方法】 穴位常规消毒后，选用 30 号 1.5 寸毫针快速刺入皮肤，直刺 1~1.2 寸，施以提插捻转得气后，留针候气。每隔 10min 加强刺激 1 次，留针 30min。起针后在关元穴上，置以约 2.5cm×3cm×0.3cm 上刺数个小孔的鲜姜片，鲜姜片上置底面直径约 1cm 的圆锥形艾炷（约 1.5g）连续灸 3 壮，如患者在施灸过程中觉局部有热痛感，可将姜片连同艾炷向上略提起稍停放下再灸。使腹部有温热感，局部皮肤潮红为度。在月经前 1 周开始治疗，针刺每日 1 次，隔姜灸每日 1 次，经至时停止治疗，共治疗 3 个月经周期。

【功效主治】 行气活血，温通经脉，补益肝肾，调和气血。

【经验心得】 中医学认为原发性痛经多由情志所伤，六淫为害，导致冲任气血不畅或冲任气血虚损以至“不通而痛”或“不荣而痛”。临床治疗当以行气活血、温通经脉、补益肝肾、调和气血为法。关元为足三阴与任脉交会穴，三阴交为脾经穴，又是足三阴交会穴，针刺可疏通经脉、调和气血、行瘀止痛，加之关元隔姜灸可温经通络、祛湿逐寒，二法配合，相得益彰，从而达到通经止痛的功效。

治验：王某某，女，19 岁，1995 年 4 月初诊。自述痛经史 3 年，月经初潮有冒雨涉水史。曾服中西药治疗，效果不佳。现每遇经期则小腹经痛难忍，得热则舒，经量少，色暗挟块。伴形寒肢冷，乏力，便溏。经妇科检查排除器质性病变，舌质淡红苔白，脉细沉，诊断为原发性痛经。中医辨证属寒湿凝滞型痛经。患者就诊当时恰为月经前 1 周左右，即用上法治疗 5d。经至停止治疗。当月小腹疼痛明显减轻，量稍增，经血转红，块减少，大便正常，连续治疗 3 个月经周期告愈，随访半年无复发。

【方剂出处】 熊秀蓉，等。针灸治疗原发性痛经 68 例临床



观察. 福建中医学院学报, 2001; 11 (3): 33

针刺三阴交治疗原发性痛经

【穴位选择】 三阴交（双侧）。加减：实证加血海、太冲；虚证加关元。

【操作方法】 于月经前 5d 开始针刺治疗，每日 1 次，每次 30min 共针 5 次。手法以平补平泻为主，中强刺激为宜。3 个月经周期为 1 个疗程。

【功效主治】 疏肝理气，活血化瘀。

【经验心得】 痛经是临床上常见的妇科疾病，中医学谓之经行腹痛。历代医家对本病的因、机、证、治多有述著，且积累了丰富的经验。中医认为本病的病因主要是感受寒邪、情志不畅、体质虚弱导致冲任瘀阻或胞宫失养，“不通则痛，不荣则痛”。三阴交兼通肝、脾、肾三经，广泛运用于女子经带诸证。针三阴交，既能疏肝理气，活血化瘀，使气机调畅，瘀血得出，“通则不痛”，又能益气养血，调补肝肾，“荣则不痛”。

治验：赵某，31 岁。自诉痛经 3 年，每于行经第 1 天小腹冷痛即作，痛势剧烈，影响正常生活及工作。经血量多，色偏暗，中夹血块，舌淡，脉弦涩。证属寒凝血瘀。取三阴交、血海、太冲穴针刺，每日 1 次。经治 1 个月经周期后，行经时疼痛明显减轻。3 个疗程后，疼痛未再发作。随访半年未复发。

【方剂出处】 孙舟红. 针刺治疗原发性痛经 59 例. 国医论坛, 2000; 15 (4): 34

针刺中冲、三阴交治疗痛经

【穴位选择】 中冲（双侧）、三阴交（双侧）。

【操作方法】 穴位常规消毒，中冲穴用 0.5 寸毫针刺入 0.1 寸，三阴交穴用 1.5 寸毫针直刺 0.5~1 寸。实证患者行泻法，虚证患者采用补法，并可选用配穴关元、足三里。留针 20min，中



间行针 2 次。每日针刺 1 次，5 次为 1 疗程。在月经前 2~3d 或经期疼痛发作时治疗，连续治疗 2~3 个月经周期。

【功效主治】 补脾益气，行气止痛。

【经验心得】 痛经多因行经期间情志、受寒、潮湿等因素的影响，使经血凝滞不通，经行受阻；或由于脾胃虚弱、冲任血虚，导致血海空虚，胞脉失养而痛。主要病机为气血运行不畅，宜行气活血、通络止痛。中冲穴为手厥阴心包经井穴，能行气活血；三阴交穴属足太阴脾经，为肝脾肾三阴经交会穴，能调气行血，治肝脾肾三阴经之疾患。二穴相配调理心肝脾之功能，气血充足胞宫得养，益气通脉，冲任自调而痛止。配穴关元为足三阴经与任脉交会穴，可调冲任、暖胞宫；足三里有补脾胃而益气血生化之源之效。气血充足，冲任调血，经血通畅，则疼痛自止。

【方剂出处】 余芳，等。针刺中冲三阴交治疗痛经 46 例临床观察。针灸临床杂志，2004；20（11）：16

三阴交温针治疗原发性痛经

【穴位选择】 三阴交。加减：太冲、中极、阳陵泉、命门、水道、地机、阴陵泉、行间、百会、气海、足三里、肝俞、肾俞、气冲。

【操作方法】 主穴施行泻法，反复强烈提插捻转，以至局部产生酸、麻、重、胀感，并沿下肢内侧向上传至会阴、小腹部为宜，局部有温热感更佳，得气后留针 10min。寒湿凝滞型肾俞、水道、地机、中极针用平补平泻；肝肾亏虚型肝俞、肾俞、气冲针用补法；气血虚弱型百会、气海、足三里针用补法；气滞血瘀型中极、太冲、阳陵泉针用泻法。皆施行温针疗法，即用艾条 1.5~2cm 插入针柄上，从下部点燃开始施灸，直到艾绒燃尽冷却、疼痛缓解后起针，在每次行经前 3~5d 针治，每日 1 次，针至来经次日，连续针刺 3 个月经周期。

【功效主治】 调理气机。



【经验心得】 取穴以足三阴经脉交会穴三阴交，经脉经穴气海、中极为主，旨在通过温补足三阴经气，暖胞脉，调冲任，蒸动气化，宣通涩滞，调理气机，以帅血行而达通经止痛之目的。配地机、水道健脾利湿，选太冲解郁行气，取足三里、肝俞、肾俞以益精血，养肝肾，培补脾胃中气，通调冲任气血。诸法结合，其效彰著。实证者加灸法，取其温通之力，俾经脉通，血下行，其痛自止。然此症之治，实则行气调气为主，活血为次，欲通经调气，以手法控制传感至为重要，果能气至病所，其效验立见。

治验：王某，女，21岁。自诉月经将至，腰腹痛剧，小腹胀坠1d。患者月经16岁初潮，期量色质尚正常，后因经期大怒，其后则每于行经前即腰痛、腹痛、小腹胀坠。经行开始血量少，色紫暗有块，待血块下后则痛减，有时胸胁胀痛。此次行经，非同往常，疼痛剧烈，无奈前来求治。检查：搀入诊室，弯腰抚腹，呻吟不止，表情痛苦，面色苍白，头面冷汗，小腹拒按。舌质紫暗且有瘀点，脉沉涩。诊为痛经，属气滞血瘀型。治疗宜行气活血，祛瘀止痛。当即取太冲、中极、三阴交、阴陵泉，进针后三阴交针感沿下肢内侧传至会阴部，并有温热感，均行泻法，辅之灸法。患者自觉疼痛立即减轻，10min后痛止出针，患者面带笑容。随嘱其下次月经前稍有不适时，即来针治。如此经过几次治疗，即告痊愈。随访3个月经周期，未见复发。

【方剂出处】 张有圣. 温针治疗原发性痛经 48 例. 安徽中医临床杂志, 2000; 12 (3): 235

三阴交透刺悬钟穴治疗痛经

【穴位选择】 三阴交、悬钟。伴随症状严重者加内关穴。

【操作方法】 选用 30 号 3.5 寸长的毫针，常规消毒后，从三阴交透刺悬钟穴，行捻转泻法，得气后留针 30min，1 个周期为 1 个疗程。

【功效主治】 健脾、疏肝、益肾。



【经验心得】 痛经发生的主要机制，是冲任二脉气血运行不畅所致。治疗时以疏通经络为治则，选用三阴交透刺悬钟穴治疗，因三阴交为足三阴经之会，具有健脾疏肝益肾，调理人体阴血的作用，悬钟为足少阳胆经之络穴，是八会穴之一，为“髓之会”，具有强腰壮肾的作用，髓又能生血，取三阴穴透刺悬钟穴，可使经脉的气血疏通，调和冲任，故能获效。

治验：赵某，女，18岁。诉15岁月经初潮至今，每次行经期间均出现下腹部持续性疼痛，经常服用“去痛片”或注射“止痛针”，就诊时乃为经期第2天。症见：月经量少，色暗红，夹有瘀块，下腹部剧痛，恶心欲呕，腰部酸胀，头冒冷汗，面色苍白，手足欠温，舌质暗，脉弦细。辨证属痛经（肝肾不足，气滞血瘀）。治宜补肝肾，调冲任，通经行气，活血止痛。治疗：取三阴交穴透悬钟穴，按上述方法进行操作，行针后患者诉疼痛减轻，出针后痛经症状基本消失，第2天再行上法治疗1次后痊愈。随访1年痛经未见复发。

【方剂出处】 郑建宇. 三阴交透刺悬钟穴治疗痛经 56例. 新中医, 1997; 29(5): 25

三阴交穴配合神阙穴治疗痛经

【穴位选择】 三阴交（双侧），神阙。

【操作方法】 患者仰卧位，选用直径0.3mm，长度40mm毫针，穴位常规消毒后，将毫针快速刺入皮下，得气后使针尖沿经向上，让针感沿足太阴经脉上行至少腹部，用平补平泻手法。留针30min，留针期间每隔10min行针1次。在针刺留针的同时，在神阙穴用自制的艾灸筒艾灸30min，使腹部产生温热感。

【功效主治】 疏肝理气，调气行血。

【经验心得】 痛经中医学称之“经行腹痛”，是由于情志不舒，郁怒伤肝或外受寒湿后，寒湿凝滞，气血运行不畅，气滞则血瘀，经行不畅，冲任受阻，“不通则痛”而致。三阴交为肝、



脾、肾三经交会穴，针刺之能疏肝理气，调气行血，健脾益气，养血调经；神阙穴居脐中，为任脉经穴，艾灸之能温中散寒止痛，温暖胞脉，调畅冲任。针灸结合，相得益彰，疏肝理气，行气活血，调经止痛。肝气疏泄，情志畅达，冲任调畅，气血流通，经血得下，“通则不痛”。

治验：王某，女，27岁，未婚。主诉：痛经2年余，每于行经前1~3d小腹胀痛，痛势剧烈，得热则缓，遇寒加剧，经血量少，色紫黑有块，血块排除，疼痛减轻，脉弦紧，舌淡苔薄白，证属寒凝气滞型。用针刺三阴交穴配合艾灸神阙穴治疗5d后，行经时疼痛明显减轻，精神爽快，下个月经期继续治疗5d后疼痛未再发作，随访1年未复发。

【方剂出处】 杨晋红. 针刺三阴交穴配合艾灸神阙穴治疗痛经56例. 针灸临床杂志, 2003; 19(3): 40

针刺膝眼、三阴交治疗痛经

【穴位选择】 膝眼、三阴交。

【操作方法】 令患者取高矮适宜的端坐位，屈膝90°，双下肢放松，取4寸长银针3根，用碘酒消毒，酒精脱碘后，任选一下肢的双膝眼穴、三阴交穴进针。实热证采用泻法：重捻进针，捻转提插以有酸、麻、胀为度，然后用于快速捻转、轻提重插，捻转幅度大于180°，患者能忍受为度。虚寒证采用补法：用力轻，徐缓捻转进针，得气为度，然后徐缓间断捻针，捻转幅度在90°左右，待患者疼痛逐渐减轻后缓缓提插出针，一般只需1~3min，不留针。

【功效主治】 调气行血，祛寒止痛。

【经验心得】 本病实证采用泻法，以泻其有余。虚证采用补法，以补其不足。膝眼穴为常用奇穴，有温通胞宫、理气活血、助阳祛寒止痛的作用；三阴交穴能调气行血，能治肝脾肾三阴经之疾患。二穴相配调理三脏功能，气血充足胞宫得养，益气通脉



冲任自调而痛止。但还应了解月经生理、消除恐惧、焦虑及精神负担。进行体育锻炼，增强体质。注意生活规律，劳逸结合，适当营养及充足睡眠。经期避免剧烈运动，过度劳累。如果症状过于严重，针刺无效或效果不明显，疼痛影响了工作与生活者，则应服用适宜药物治疗。

【方剂出处】徐兴荣. 针刺膝眼三阴交穴治疗痛经 48 例疗效观察. 甘肃中医, 1999; 12 (6): 42

针灸气海、天枢、三阴交治疗原发性痛经

【穴位选择】气海、天枢、三阴交。

【操作方法】取仰卧位，下肢屈曲。气海用 3 寸长毫针先直刺 1.5~2 寸，上下徐徐提插 3~5 次后，再将针提至皮下，向中极方向透刺 2~2.5 寸，按上法上下徐徐提插 3~5 次，待有强烈沉胀感后留针 20~30min；天枢针 1.5~2 寸，刮针手法，留针时间同气海；三阴交针 1.0~1.5 寸，提插捻转手法，持续行针至腹痛减轻或消失后留针，与上两穴同时起针。同时嘱助手手持点燃之艾条，灸烧气海穴上下部位，每次灸烤 30min。于经行腹痛或经期前后下腹部疼痛时进行，每日 1 次，3 次为 1 疗程。

【功效主治】温宫散寒，调补肝肾，通经祛瘀，理气止痛。

【经验心得】《巢氏病源》云：“妇人月水来腹痛者，由内伤气血，以致体虚，风冷客于胞络，损伤冲任之脉。”《丹溪心法》云：“临行时腰腹疼痛，乃是郁滞，有瘀血。”而气海为气之海，呼吸之根，藏精之所，为下焦之要穴，针之可益脏真，回生气，温下元，振肾阳，天枢乃大肠之募穴，能分理水谷糟粕，清导一切滞浊，与气海相配，取气海振下焦之阳，取天枢调理肠胃之气，以利运化；加之三阴交为肝、脾、肾、三径之交会穴，取之以调理三脏，调和冲任，疏通经脉，三穴同取，针灸并施，共奏温宫散寒，调补肝肾，通经祛瘀，理气止痛之功，从而使冲任调和，气血通畅，月经畅通，痛经乃消。



治验：王某，女，20岁，未婚。经期少腹痛5~6年，近半年来逐月加重，经量少，遇热痛缓，遇冷痛著，常须服用镇痛药物，曾经妇科检查及B超检查无异常发现。来诊时诉：诊前1d月经来潮，少腹冷痛，经少色暗有血块，晨起时腹痛剧烈，伴有头痛、腰痛乏力、食欲不振等。遂诊断为原发性痛经，予上法针灸3min后痛缓，留针、灸烤30min后痛止；并于其后2d，每日1次上法针灸，少腹冷痛未作。又嘱其于每次月经来潮时按上法针灸，每日3次。共治疗3个月后，痛经未再发作。

【方剂出处】 马向明. 针灸治疗原发性痛经 65 例. 针灸临床杂志, 1998; 14 (11): 18

针灸配合耳穴治疗原发性痛经

【穴位选择】 主穴：中极、三阴交（双侧）、地机（双侧），配穴：挟血块者加血海（双侧）。耳穴区的子宫、卵巢、交感、内分泌、肝、肾、脾等反应点。足部的肾、输尿管、膀胱、生殖腺、阴道、子宫、卵巢、下腹部、下身淋巴结腹股沟等反射区。加减：湿邪重者加阴陵泉（双侧）；肝郁者加太冲（双侧）；气血虚弱者加足三里（双侧）；肝肾虚损者加关元。

【治疗方法】 先嘱患者排尽小便，用1.5寸30号毫针直刺进针，缓慢进至1寸左右，待得气后用平补平泻方法提插捻转数次，留针15~20min。其间，除太冲外，以上诸穴均用温针灸2壮。操作次数：经期每日1次，非经期每周2~3次。

耳穴治疗：先用75%酒精棉球将一侧耳郭擦净，再用一小探棒在上述耳穴区探出最敏感点后，用事先贴好王不留行子或小磁珠的0.6cm×0.6cm的胶布，对准最敏感点贴压上，垂直用力按压至有酸胀、疼痛感，每次每穴按压30~60次，务求每次按压都有酸胀或疼痛感。配合足部按摩：患者双足先在热水中洗净擦干，涂抹少许冬青油或脲素霜后，开始对操作部位按上述顺序依次按摩，之后再重复按摩一遍肾、输尿管、膀胱。其中肾反射区



用握足扣指法，输尿管、膀胱、生殖腺反射区用单示指扣拳法，阴道、卵巢反射区用单示指刮压法，子宫、下腹部反射区用双拇指和掌法，下身淋巴结反射区用拇食指扣拳法，腹股沟反射区用单拇指指腹施压法。肾、输尿管、膀胱等每个反射区按摩 1.5min，其余每个反射区按摩 1min。先左足后右足，术毕患者需饮 300~500ml 温开水。不分经期非经期，每日 1 次。

【功效主治】 温经散寒，活血止痛。

【经验心得】 温针灸具有辨证施治、标本兼治的特点，在行经期疼痛发作的急性期，根据“急则治其标”的原则，温针灸能通过温经通络而达到止痛的目的；在非经期的缓解期，则通过进一步的辨证治疗，“治病必求其本”。耳穴埋子能起到迅速解痉止痛的作用，在痛经发作的时候即刻按压就有明显的缓解疼痛的效果，也适用于惧怕针刺的患者。足部按摩简便易行，不需借助任何工具，可教患者在家中自行操作，也可用在发病时，医生不在场的情况下。3 种疗法各具特色，若单独运用，一般 1 个月经周期即可见效，数个周期后疼痛能大大减轻；若 3 种疗法联合运用，则效果更为明显，疗程也可缩短。

治验：吴某，女，18 岁。原本月经正常，唯经期稍长，6~7d 方净。为能缩短经期，多参加训练及比赛，听信他人之言，开始在经期大量服用冷饮。后经期逐渐缩至 3~4d，然痛经亦开始出现并加重。每次行经如临大敌，少腹疼痛剧烈，蜷卧于床，腹上置一热水袋，则疼痛稍减，服止痛药数次，强能忍受。妇科检查无明显异常。此次月经将行，遂来我处求医。诉及经量少，色黯，挟有紫黑血块，块出经将止疼痛亦止。苔薄舌质偏黯有瘀点，脉弦细。辨为寒凝胞中，伴有血瘀。治拟温经散寒，佐以活血之法。体针取穴中极、三阴交、地机、血海，用温针灸，耳穴埋子、足部按摩也依上述之法行之。至此次月经，疼痛程度及频率都有所改善。原法续进不间断，至下次行经，疼痛已大大减轻。再教其足部按摩之法，让其自行操作，第 3 次来潮时已基本上不觉疼



痛，血块也少了许多。嘱其坚持按摩，6个月后随访，经量、经期一如常人，亦无疼痛之感。

【方剂出处】张斌渊. 针灸为主治疗原发性痛经. 针灸临床杂志, 1998; 14 (4): 9

针药并用治疗痛经

【穴位选择】气滞血瘀型：中极、血海、三阴交；寒湿凝滞型：命门、关元、气海；气血两虚型：足三里、关元、气海；肝肾亏损型：肾俞、关元、太冲。

【随症加减】配合当归四逆汤加减：当归、芍药、桃仁、杜仲、补骨脂各 12g，桂枝、吴茱萸、枳壳、蒲黄（布包）、五灵脂各 10g，路路通 6g，鸡血藤 6g 还可加适当理气药，如香附之类，以助诸药共奏益血逐寒之功。共服 5 剂后，在此方基础上加三七粉 6g。

【操作方法】患者取平卧或坐位，针刺部位以 75% 酒精常规消毒，采用 30 号不锈钢毫针，对准所选的穴位，垂直快速进针，然后按照以下各次不同的方向，进针 1.5 寸，留针 30min。每日 1 次，每疗程 6d，连续 2 个疗程。在下 1 个月月经来潮前 6d 再针 1 疗程，以巩固疗效。各穴位进针的方向：中极向下，三阴交（双）向上，血海（双）向上，肾俞（双）向下，命门向下，关元向下，足三里（双）向上，太冲（双）向上。按提、捻、转的手法进行，均取轻微刺激，直至酸麻胀针感为止，以症状改善的情况来确定是否得气，针后疼痛症状均无明显改善者为未得气。

【功效主治】疏经活络，祛瘀止痛。

【经验心得】痛经与遗传、精神等因素有密切的关系。中医认为气血不充、情志不畅、肝郁气滞、经期或产后感受寒湿所致。凡经后痛，则气血虚弱；经前痛，则为气血凝滞。作者认为：属寒湿凝滞，经络不通，古人曰：“通者不痛，痛者不通。”作者按辨证分型选穴，采取皮下针刺的方法治疗痛经，疗效较好。由



于经络运行气血的生理作用及辨证施治的结果。痛经多见于虚寒，故采取轻微刺激以温补，适当留针有利于疗效的提高。

【方剂出处】 胡华珍，等。针药并用治疗痛经 60 例。针灸临床杂志，2004；20（1）：23

针刺配合中药导入治疗痛经

【穴位选择】 主穴：中极、地机、三阴交。配穴：寒湿凝滞型配水道、阴陵泉、丰隆；肝郁气滞型配太冲、气海、阳陵泉，肝肾亏损型配肝俞、肾俞、太溪；气血虚弱型配足三里、关元；湿热下注型配阴陵泉、合谷。中药导入液：当归、川芎、红花、桃仁、乳香、没药、透骨草、穿山甲、山楂、肉桂、桂枝、制附子、木香、厚朴、柴胡、车前子、泽泻煎汁取液备用。

【操作方法】 首先依据患者症状，辨证分型治疗前患者排空小便，取仰卧位，按上述取穴选定穴位后，局部皮肤以 75% 酒精常规消毒，小腹部穴位（中极、关元、气海、水道）取 1.5 寸毫针垂直进针 0.5~1 寸，局部得气后，除肝肾亏损型、气血虚弱型用平补平泻手法外，其他型均用泻法，强度以患者能忍受为度。远端取穴，常规操作，肝肾亏损型、气血虚弱型用补法，其他三型用泻法。上述诸穴每次均留针 30min 起针，其间施术 3 次。

配合中药导入：患者每次针刺治疗结束后，用中药离子导入机，以关元穴为中心垫正级（自制中药棉垫 15cm×20cm 大小吸沾中药液后，敷在小腹部），腰部命门穴为中心垫负极，开机后，刺激强度及温度调节均以患者能忍受为度，连续导入 30min，结束治疗。患者每次月经前 5d 开始治疗，连续 10d 为 1 疗程。

【功效主治】 通经行气，活血逐瘀。

【经验心得】 痛经的主要病理机制是气血运行不畅，无论何种证型都具有这个共性。因此主穴的选择适应于各型。中极乃足三阴经与任脉之交会穴，又是募穴，位居少腹，刺之自有通畅局部气血、通经止痛之效。地机乃脾经之郄穴，通经止痛之力较强。



三阴交通调三阴，行经止痛。各型之配穴，辨证而选，针对性强，加之补泻手法运用之恰当，治疗时间又在经期之前后，诸穴共舞，可获良效。此外，针刺期间有月经提前或经量增多现象，属逐瘀邪出，气血通畅之转机，不影响治疗。中药液其性偏于通经行气、活血逐瘀、温阳止痛，通过导入直接作用于局部，加之导入期间的电脉热效应，更增加了功效。综上所述，针刺配合中药导入治疗痛经，疗效显著，疗程短，有推广价值。

治验：李某，32岁，1996年9月初诊。自诉2年来，经前小腹冷痛，遇寒加重，得温则减。此次月经来潮半日，因持续性少腹疼痛难忍1h而就诊。经水少色黯，时有小血块，腹痛拒按，苔薄白，脉沉紧。辨证属寒湿凝滞型痛经，随按上述方法治疗，1次后疼痛减轻经量增加，3次后疼痛大减，1疗程后小腹疼痛消失。第2疗程于月经来潮前5d开始治疗，其间未发生小腹疼痛，以后终止治疗，随访6个月未复发。

【方剂出处】王素芳. 针刺配合中药导入治疗痛经100例. 针灸临床杂志，2001；17（3）：7

埋针治疗原发性痛经

【穴位选择】次髎穴（双侧）。加减：气滞血瘀型配太冲（双侧）、血海（双侧）；寒湿凝滞型配中极、地机（双侧）；肝郁湿热型配太冲（双侧）、三阴交（双侧）；气血亏虚型配足三里（双侧）、气海。

【操作方法】双侧次髎穴经常规消毒后，取规格为0.26mm×15mm的图钉型皮内针，用镊子夹住环型针柄，刺入穴内使环状针柄平整地留在皮肤上，用20mm×20mm小块胶布固定、留针。气滞血瘀型配穴施以毫针刺泻法；寒湿凝滞型配穴施以毫针刺泻法，加灸；肝郁湿热型配穴施以毫针刺泻法；气血亏虚型配穴施以毫针刺补法。加灸疗程：治疗一般于月经来潮1周前开始进行。3个月经周期为1疗程。注意事项：天气凉爽时，每次可留针3d，



热天一般留针 1~2d。留针期间，患者每天可自行按压埋针处 1~2 次，每次按压 1min。起针休息 1d 后重复治疗 1~2 次，月经期不做治疗。皮肤过敏者不宜使用此法。

【功效主治】 调经理气，行血散瘀。

【经验心得】 次髎穴属足太阳膀胱经，为八髎穴之一。膀胱经“抵腰中，入循膂，络肾，属膀胱……”（《灵枢·经脉》）。督脉分支“别绕臀至少阴，与巨阳（足太阳）中络者合少阴上股内后廉，贯脊属肾……”（《素问·骨空论》）。次髎穴位于腰骶部，与肾、督脉关系密切。督脉与任脉、冲脉同起于胞中，一脉三岐；肾主藏精。因此，次髎穴可强腰壮肾，调补冲任，调经理气，行血散瘀，是治疗妇科疾病的效穴。临床上采用皮内针疗法，给予次髎穴较持久的刺激，加之根据中医辨证，有针对性地配伍相应穴位，治疗痛经取得了比较好的效果。

治验：于某，24 岁，未婚。经行腹痛 1 年。患者平素性格内向，抑郁寡欢，每次月经来潮前及经期腹痛，月经量少，色黯，有血块，伴有乳房胀痛，曾服中药治疗，症有好转，但经期仍有腹痛，故来针灸治疗。查：舌红边有瘀点，苔薄，脉弦。诊为痛经（气滞血瘀型）。经针刺治疗 3 个疗程后，经期腹痛及乳房胀痛消失，随访 3 个月未复发。

【方剂出处】 徐立，等。次髎穴埋针为主治疗原发性痛经 45 例。四川中医，2003；21（4）：79

穴位埋线治疗痛经

【穴位选择】 关元、中极、肾俞、三阴交、血海穴等。

【治疗方法】 16 号针头、长 5 号针头各 1 个。4 号羊肠线数段（各长约 1cm。患者采用仰卧位。取关元、中极穴严格消毒局麻后，用装有 4 号羊肠线的 16 号无菌针头，从中极穴透向关元穴，再用长 5 号针头将线送入穴下。三阴交、血海穴直刺埋入，然后采用俯卧位，取双侧肾俞透命门穴将线埋入，方法同上，完



备后用创可贴外敷即可。一般在月经前 3~7d 治疗最佳，每月治疗 1 次，多数患者 1~3 次即愈。

【功效主治】 行气活血，温通经络。

【经验心得】 痛经一症属气滞血瘀，寒凝胞中；气血虚弱，肝肾不足所致。其病机一般以胞宫气血不畅，“不通即痛”而概括。临床上常以行气活血，温通经络为治法。关元、中极穴为任脉经穴，两穴能调理冲任、温通胞脉，关元又为强壮要穴之一，能壮全身之阳气。冲任调和，经血则按时而行。肾俞穴为肾之背俞穴，能滋补肾精以治其本，再配以三阴交、血海穴，三阴交为足三阴经之交会穴，以调补三阴经气并和营活血通经，使补益之中兼有通滞之效。穴位埋线对原发性痛经有良好的治疗效果，对继发性痛经也能起到镇痛、改善症状的作用。当痛经发作时，可用针刺操作，宜用泻法，并适当久留针，可留针 30~60min，一旦获效，可在主要穴位上进行埋线，穴位埋线可通过羊肠线在穴内的长时间刺激作用，以加强疏通经络，调和气血，温经止痛的作用。治疗本病应注意选择治疗时机，若能在月经前 1 周即开始治疗，常可提高疗效、防患于未然。

【方剂出处】 张惠民. 穴位埋线治疗痛经 34 例. 河南中医, 2002; 22 (4): 40

芒针结合穴位注射治疗痛经

【穴位选择】 中极、子宫（双侧）、次髂（双侧）、地机（双侧）。

【操作方法】 于月经来潮前 3~7d 开始。针刺前嘱患者排空尿液。取中极、次髂、子宫芒针均垂直进针，刺入 3~4 寸，针感向下腹部及会阴部放射。地机穴刺入 3 寸，针感向大腿内侧及下腹部放射。每日 1 次，针刺至月经来潮。配合穴位注射：经血出现后，用 0.5% 利多卡因 3ml、山莨菪碱注射液 10mg 混合液，在双侧地机、子宫穴进行穴位注射，每穴注入药液 1ml，每日 1 次，



连续 3d。用上述方法治疗，每月 1 次，连续应用 3 个月经周期。

【功效主治】 调经止痛。

【经验心得】 原发性痛经主要是由于子宫痉挛性收缩，引起子宫肌组织缺血，刺激子宫自主神经疼痛，继而发生痛经。并且原发性痛经多见于青春期少女，排卵后子宫内膜增厚，由于未曾生育，增厚的子宫内膜不易通过宫颈口，“不通则痛”。子宫颈及阴道的痛感神经由交感和副交感神经纤维经过骶神经 S_{2-4} 传向中枢的，而次髂正经过 S_{2-4} 神经分布上，刺之使痛阈增加，并能通过神经的传递起到解痉止痛作用。中极、子宫可利下焦，益肾气。芒针刺法可直达病所，减少子宫收缩，使局部血液循环得以改善。地机为脾经郄穴，可调血通经止痛。利多卡因、山莨菪碱穴位注射能解除子宫痉挛性收缩，使宫颈口松弛，子宫血流通畅，达到“通则不痛”之目的。

治验：患者，女，18 岁。13 岁月经初潮，每次经血出现后均见小腹坠胀疼痛，痛势较剧，并伴呕吐、腹泻，持续 3~4d。经量中等，经色紫暗夹有血块，月经周期规则。曾用西药止痛消炎等治疗，未见明显好转。现经期将至，脉沉涩而弦，舌质尚润伴紫，苔薄白。经上述方法治疗 3 个月经周期，痛经及呕吐、腹泻等症状消失。随访 1 年未见复发。

【方剂出处】 周英．芒针结合穴位注射治疗痛经 30 例．上海针灸杂志，2003；22（2）：9

火针治疗痛经

【穴位选择】 主穴为关元、次髂（双侧）、十七椎。

【随症加减】 寒湿凝滞：中极、三阴交、地机、肾俞。气滞血瘀：气海、太冲、三阴交。气血虚弱：肾俞、命门、足三里、加灸中脘。肝肾不足：肝俞、肾俞、血海、足三里。

【操作方法】 火针长 2 寸，粗 0.8mm。用止血钳夹住若干个被 95% 酒精浸泡过的棉球，点燃后针尖在火焰上 1cm 处加热约



5s, 以针体前 3cm 处, 呈鲜红为度, 将针快速地刺入穴位, 快速出针, 全过程在 1s 内完成。腹部关元穴针刺深度为 3cm, 次髎穴深度为 1.5cm, 十七椎深度为 0.5cm, 配穴背俞穴针刺深度为 1.5cm, 其他配穴均以毫针施术。足三里、命门、气海用提插捻转补法, 三阴交、太冲、中极、地机、血海用泻法, 留针 15~20min。月经前 3~5d 开始治疗, 连续治疗 10d 为 1 个疗程, 共治疗 3 个周期。

【功效主治】 温经散寒, 祛瘀止痛。

【经验心得】 方中关元穴是任脉经穴, 为女子蓄血之处, 可通调冲任脉气, 通经行血, 也是任脉与足三阴经交会穴, 故可温补肝肾, 益精调经。次髎穴为足太阳膀胱经穴, 与肾经相表里, 位居腰骶具有清利湿热, 理气调经之用。但取穴要准确, 深度以 2~3 寸为宜。十七椎又名腰孔, 首见于《千金翼方》, 从经络循行上看, 十七椎虽为经外奇穴, 但穴居督脉, 与督脉关系密切。由于督脉总督一身之阳, 为“阳脉之海”, 具有调节全身诸阳经经气之功能, 故取之可通调诸阳, 通而不痛。从解剖部位上看, 十七椎下有第 5 腰神经分布, 与其他神经形成盆丛, 组成子宫阴道丛等次级丛, 分布于生殖器, 故针刺十七椎治疗痛经可调节子宫收缩, 解除子宫痉挛性收缩, 而达到止痛目的。

治验: 胡某, 女, 20 岁。病史诉自月经初潮起每次月经前 3~4d 开始小腹疼痛, 连及腰骶部, 得热痛减, 按之痛甚, 经量少色黯黑有血块, 形寒肢冷, 便溏。经妇科诊断为痛经, 多方治疗无明显疗效, 近几个月来每次月经来潮前小腹剧痛不能坚持上班, 今日小腹疼痛始作, 精神不振, 预计行经尚有 3d, 舌苔白腻, 脉沉紧。B 超检查子宫附件无异常。中医辨证为胞宫寒湿凝滞, 血行不畅所致。治以温经散寒除湿止痛, 调和冲任, 取穴中极、关元、次髎、十七椎, 肾俞、脾俞用火针, 配以毫针刺三阴交、水道、归来、地机用泻法, 当即疼痛缓解, 连续治疗 3d 后, 行经, 未见腹痛。继续治疗 1 周, 直至月经停止, 第 2 个月行经前及行



经期末见疼痛，随观 1 年，未见复发。

【方剂出处】刘玲玲. 火针治疗妇女痛经 50 例临床观察. 针灸临床杂志, 2001; 17 (2): 32

温针治疗痛经 1

【穴位选择】寒湿凝滞型取关元、足三里、三阴交，针用平补平泻之法；肝肾亏损型取关元、气海、三阴交、足三里，针用补法。

【操作方法】按分型针刺上穴，得气后皆施温针治疗，即用艾条 1.5~2cm 插入针柄上，从下部点燃开始施灸。直到艾绒燃尽冷却，疼痛缓解以后起针。

【功效主治】温经散寒，缓急止痛。

【经验心得】痛经是指妇女经期或行经前后出现的周期性小腹疼痛。中医学认为痛经与肝、肾、冲、任等经脉有关，主要由于经期受寒湿之邪所致，或者由于肝肾不足，胞脉失养。其病机在于气血运行不畅。取关元、三阴交意在调理冲、任与肝肾，关元为足三阴、任脉之会，有益精血，补肝肾，调冲任的作用；三阴交穴为足太阴脾经腧穴，又为足三阴经交会穴，具有调补肝肾，疏肝理气，活血化瘀之效。温针刺之可使气机调畅，瘀血得出，“通则不痛”。再根据证型不同，配气海、足三里以补虚，补益气血，调理经气。

【方剂出处】李晔. 温针治疗原发性痛经 130 例. 上海针灸杂志, 1998; 17 (3): 16

温针治疗痛经 2

【穴位选择】气海，关元，子宫穴（双侧）。

【操作方法】嘱患者排空小便，腹部常规消毒后，术者用 1.5~3 寸的毫针针刺患者气海、关元、双侧子宫穴，深度因患者胖瘦而定。待出现酸胀感后，取四段 1 寸长的艾条，用牙签扎孔



后，套在针柄上，针孔处垫4块纸板，以防烫伤。从艾条下端点燃艾条，至艾条灰烬完全熄灭后起针，每次持续大约30min。月经前1~2d或行经疼痛时针刺均可，针刺后疼痛不减者，次日再针，直至完全止痛。每个月行经前或行经期疼痛者继续下1个疗程。患者行经期间注意情志愉悦，避免受凉，不吃生冷饮食，多吃蔬菜，保持大便通畅。

【功效主治】 温经散寒，调气行血。

【经验心得】 选取气海、关元、子宫穴（双侧），乃因气海，关元为任脉经穴，通于胞宫。针刺气海，能补气调气行血，调理冲任；针刺关元，有益精血、补肝肾、养冲任之功。双侧子宫穴为经外奇穴，为女子蓄血之处，针刺子宫穴，能活血调经。加之艾灸能温经散寒、活血通络，故而针灸并用，双重刺激穴位，可达温经散寒、调气行血、补养冲任的目的，使胞中经血得以畅通，痛经因而缓解。

治验： 张某，女，25岁，已婚未孕。自诉每次月经来潮前1d开始小腹疼痛，痛连腰骶部，得热痛减，按之痛甚，经血量少色黯有血块。诊为痛经。此次痛经症状如前，舌淡伴有瘀点，脉沉涩。辨为寒凝血瘀。经上法治疗后，疼痛有所缓解，续治3d后疼痛消失。但此后月经来潮前1~2d，腹部仍然疼痛。续以温针灸治疗5个月经周期，疼痛缓解。随访半年未见复发，后怀孕生子。

【方剂出处】 严桂芳. 温针灸治疗痛经160例. 湖北中医杂志, 2002; 24(10): 51

关元温针灸治疗痛经

【穴位选择】 关元。

【操作方法】 嘱患者仰卧，放松调息，以毫针直刺关元穴，得气后，在针上插以长2cm左右的艾条点燃。艾条下端和皮肤间隔以中间带小孔的硬纸壳，以防灰烬落下烫伤皮肤。30min后艾



条已燃尽，除去灰烬后起针。每次经前 3~5d 开始治疗，每日 1 次，每个月经周期治疗 10 次。治疗 3 个月经周期。

【功效主治】 温经散寒，活血祛瘀。

【经验心得】 痛经是指妇女正值经期或行经前后发生的小腹疼痛，或痛引腰骶。中医学认为其病机为气血亏虚，寒凝经脉，冲任瘀阻，气血运行不畅，胞宫经血流通受碍，以致“不通则痛”；或冲任、胞宫失于濡养，不荣而痛。关元穴属于任脉，古医家认为是“丹田”部位，针之可调理冲任、培肾固本、大补元气。温针灸是在针刺得气的基础上，在针柄上挂以艾条施灸的方法，可使热力通过针身传入经络，适用于一切虚寒的病证。采用温针灸关元穴，患者可体会到温热感沿针扩散至整个下腹部，气至病所，收到温经散寒、培补冲任、疏通经络、活血祛瘀之疗效，故可奏效。此疗法取穴精少，操作简便，刺激温和，疗效显著，故临床患者易接受，值得推广。

【方剂出处】 王松梅，等. 温针灸治疗痛经 40 例. 河北中医，2002；24（12）：927

电针加温针灸治疗痛经

【穴位选择】 关元、中极、三阴交、足三里。

【操作方法】 上 4 穴常规消毒后进针，关元与一侧的三阴交为 1 组电极，中极与另一侧的足三里为 1 组电极，使用上海产 G-6805 型治疗仪，频率及强度结合病情，以患者耐受为度，同时用艾条灸针柄，使患者有穴内温热和循经传导之感（灸时要注意保护皮肤，防止烫伤）。每次治疗 40min，每日 1~2 次，经前或痛经发作时进针治疗，每个月经周期连续治疗 5~7d 为 1 个疗程。

【功效主治】 化瘀通经，调经止痛。

【经验心得】 痛经由气血运行不畅所致，气滞血瘀、寒凝气滞、气血不足、肝肾亏损等均可导致经行不畅而发为痛经。治当调冲任，养气血，化瘀通经，调经止痛。关元穴益精血，补肝肾，



养冲任；中极可调理气血，通调冲任；三阴交可调理三阴经的气血，为痛经的远道取穴；足三里补脾胃，益气血生化之源。温针灸简便易行，不但能温通经脉，调经止痛，又能增强机体抗病能力和免疫功能，改善微循环。电针可加强刺激，增强镇痛效果，提高疗效。针灸并用，冲任得调，气血得养，血瘀得化，寒滞得能，经调而痛止。电针加温针灸是治疗各型痛经的好方法。

治验：李某某，17岁。自月经初潮即现痛经，至今2年余，每于经前及经期腰腹剧痛，涉及下肢酸痛不适，伴有恶心呕吐，不能进食，经量少色紫有块，少腹凉坠，得热则舒，曾多次治疗无效，行电针加温针灸治疗1次痛止，1疗程后病愈，随访1年未复发。

【方剂出处】丰玉红，等. 电针加温针灸治疗痛经100例. 针灸临床杂志，2003；19（3）：28

针刺足三里、三阴交治疗痛经

【穴位选择】足三里（双侧）、三阴交。

【操作方法】每次月经周期前3d，针刺双侧足三里、三阴交，强刺激15min，每日1次，连续3d，3个月为1个疗程。

【功效主治】疏肝理气，调经行血。

【经验心得】痛经一病，主要机制，是气血运行不畅。治疗原则，根据“通则不痛”的原理，通调气血。脾胃乃气血生化之源，气血不畅，当调脾胃之经。足三里，是足阳明胃经之合穴，用泻法可调理气机，气行则血行，使气血运行趋于正常。

据报道，针刺人和家兔的足三里，可使裂解素和调理素明显增加，白细胞吞噬指数上升，增强其免疫能力。三阴交，是足太阴脾经之穴，是足三阴经交会之处，是治疗妇科疾病的主穴。强刺激此穴，不仅通畅足太阴脾经，使气血运行有序；还调顺足厥阴肝经，使气血畅行无阻；更利达足少阴肾经，使气血顺至胞宫，月经正常，腹痛必消，痛经根除。



治验：张某，女，22岁。诉经期腹痛6年，加重2d。病史：6年前，因经期游泳致腹部疼痛，以后每次月经都复发，并且逐月加重。2d前，因月经来潮腹痛复呈，且伴有头晕目眩、不能起床，泛恶呕吐，吐物为胃内容物和胆汁，四肢厥冷，全身无力，遂来诊。四诊：面色萎黄、精神萎靡、表情痛苦、语声低怯、舌暗苔白、脉弦紧无力。用上方治疗1次后，疼痛减轻，继治3d，上症悉消。第2个月，该患者担心复发再次来诊，又治3d，月经来潮时，腹痛隐隐，无头晕，轻微恶心未吐。第3个月，再治3d，经期无腹痛、不恶心，月经正常。追访1年，痛经未再复发。

【方剂出处】王淑敏。针刺治疗痛经68例。中华实用中西医结合杂志，2004；4（17）：1018

一穴多针法治疗原发性痛经

【穴位选择】主穴：中极；配穴：足三里。

【操作方法】患者仰卧，穴位局部常规消毒，选用0.35mm×75mm毫针，先快速刺入主穴，提插用泻法，针感向阴部放射为佳。再在穴位周围斜刺、平刺5~6针，留针30min，主穴用艾灸10壮。捻针，提插用补法刺配穴。在月经来潮前3d开始治疗，每日1次，3次为1个疗程。每个月经周期治疗1个疗程，连续3个疗程。

【功效主治】温经散寒，活血通络。

【经验心得】痛经临床上分实虚两类。实证多由行经期受寒饮冷，以致血因寒而凝滞，瘀血停滞胞中，经行受阻，不通而痛，或因七情郁结，气滞经行不畅而致。虚证每因体质虚弱，或大病、久病之后，气血不足，以致血海空虚，胞脉失养所致。临床上以实证多见。其治则以温通经络，行气活血为大法。中极属任脉与足三阴交会穴，可通调冲任脉气，位于少腹部并具有补益气血，理气调经而止痛之功效。足三里为足阳明胃经经穴，针刺该穴，可补脾益胃以滋气血生化之源，行气止痛，而且该穴乃强壮之穴，



能增强人体免疫力，两穴合用，远近相配，相互协调，可收较强的止痛之功效。一穴多针法，可疏通各经络，加强局部血液循环，促进新陈代谢。此法具有活血通经，活络化瘀之功效，温针灸更增强温经散寒，活血通络之作用。

【方剂出处】袁明泽. 一穴多针法治疗原发性痛经 36 例. 上海针灸杂志, 2001; 20 (5): 44

针灸按摩治疗原发性痛经

【穴位选择】足三里、三阴交、关元、气海、中极。

【操作方法】局部常规消毒，取毫针直刺，用平补平泻法，一般留针 10min，症状较重者可留针 15min，宜在经前 14d 开始治疗，每日 1 次，至月经来潮为 1 个疗程。按摩的方法主要是教患者自己完成。具体做法是：患者取坐位，双手卡腰，大拇指向后，双拇指对称放于脊柱旁约 1.5 寸，其他四指并拢，小指与髌骨同高，双拇指揉压腰部，边揉边向下移动，直到骶骨处，重复此动作约 10min，力量要由轻到重。然后再取仰卧位，用大拇指在脐下揉压，边揉边向下移动，直到耻骨上方，时间约 10min，手法同上。自我按摩宜在每日睡前进行，每月为 1 个疗程，经期停用。

【功效主治】调和气血，和络止痛。

【经验心得】痛经是妇女的一种常见病，甚者剧痛难忍，常可伴面色苍白，冷汗淋漓，泛恶呕吐等。本病多因气血不畅所致，经期情志不畅，起居不慎或六淫为害等不同病因而引起。多由冲任瘀阻或寒凝经脉，使胞宫经血流通受阻，冲任、胞宫失于濡养，不荣而痛，多见于未婚女子。其基本治疗原则是调和气血，和络止痛。针灸可以疏通经络中壅滞的气血，协调虚实，使气滞血瘀的病理变化恢复正常，从而起到积极的治疗作用。作者采用针灸配合自我按摩，自我按摩的目的是加强针刺的作用，尽快改善冲、任经脉中凝滞的气血，改善胞宫的血液循环，促使患者疼痛消失，



功能恢复正常。本治疗方法简便宜行，容易操作，且治愈率高，治疗期间应忌食辛辣生冷，避免劳累受凉，注意经期卫生，控制情绪。患者一般针灸 1 个疗程后，自我按摩巩固 1 个疗程即可痊愈。

【方剂出处】 殷红才. 针灸按摩治疗原发性痛经. 医药论坛杂志, 2003; 24 (8): 56

刺血加拔罐治疗痛经

【穴位选择】 次髎、关元。

【操作方法】 次髎用三棱针挑刺后拔罐 10min，令其出血 2~5ml。关元穴向下斜刺 1.5~2 寸，使针感达少腹及阴部为宜。实证用毫针泻法，虚证用补法，留针 20min。于每次月经来潮前 3~5d 开始治疗，每日 1 次，至开始行经为止，每 1 个月经周期为 1 个疗程。

【功效主治】 通经止痛，调理冲任。

【经验心得】 次髎为膀胱经穴，位于骶部，临近盆腔，为治疗痛经的经验有效穴。关元属任脉穴，可调理冲任之气，又为足三阴交会穴，疏肝健脾补肾，二穴合用，达到通经止痛的功效。刺血拔罐可调畅气血，通经止痛从而收到较好的疗效。

【方剂出处】 王玉国. 刺血加拔罐治疗痛经 55 例. 中国针灸, 2000; (5): 292

穴位注射治疗痛经

【穴位选择】 关元、三阴交、次髎。

【随症加减】 气滞血瘀加血海、天枢。寒湿凝滞加地机、外陵。气血虚弱加足三里、气海。

【操作方法】 每次取同侧穴位及任脉穴，用 5.5 号针头 3ml 针管，每穴注入 5% 当归注射液 1.5ml，痛甚者加 1ml 普鲁卡因。行经前 7d 开始治疗，每日 1 次，7 次为 1 个疗程，治疗 3 个疗程。



【功效主治】 散寒除湿，温经理气，益气补血，化瘀止痛。

【经验心得】 痛经是妇科临床常见疾病之一，其发病机制主要是在这个期间受到致病因素的影响，导致冲任瘀阻或寒凝经脉，使气血运行不畅，胞宫经血流通受阻，以致“不通则痛”或冲任、胞宫失于濡养，“不荣而痛”。

当归具有补血、活血、止痛之功效，通过刺激三阴交、关元、次髎等穴位达到散寒除湿，温经理气，益气补血，化瘀止痛作用。再配合当归活血补血，又善止痛之功，故能在治疗痛经中起到很好的作用。

治验：张某某，18岁。痛经4年余，每次经前3d左右出现小腹胀痛，经量少，经色紫黯有块，直至月经来后5~7d才痛止。初诊时为月经来潮第2天，小腹胀痛难忍，大汗淋漓，见舌有瘀点，脉弦。诊断：痛经，气滞血瘀型。按上法施治，治疗3次后疼痛消失，次月月经来潮前7d给上法治疗7次后，月经来潮时，再无痛经，至今未复发。

【方剂出处】 陈育德，等．穴位注射治疗痛经40例．针灸临床杂志，2004；20（12）：36

注射液封闭治疗痛经

【穴位选择】 三阴交（双侧）。

【操作方法】 经前2~3d，在双侧三阴交穴注射当归注射液4ml，每穴注射2ml，每日1次。月经来潮时再注射2~3d。平时根据气滞、血瘀、胞宫虚寒等不同病情，对症给予逍遥丸、四制香附丸、艾附暖宫丸等服用。

【功效主治】 疏肝理气，健脾补虚，。

【经验心得】 痛经分为原发痛经与继发痛经，主要为气血运行不畅。与肝气不疏，脾虚不运，肾阳不足有密切的关系。三阴交穴是肝、脾、肾三条阴经的交会穴，该穴既能疏肝理气，健脾补虚，又可调经止痛。配合当归注射液之补血活血，调经止痛之



效力，使经络激发不滞，血脉疏通不阻，致“通则不痛”而达到治疗痛经之目的。

治验：金某，18岁，1994年初诊。痛经2年，面色欠华，心悸，疲倦，纳呆，便溏。月经量少，色淡，来潮即腹痛绵绵，少腹部疼痛较剧，喜按。舌质淡，脉细弱。用当归注射液经前在三阴交穴封闭治疗2次，行经时再封闭2次。行经期未出现痛经。嘱每日服用归脾丸，每日2次，每次1丸。半年后随访，身体健壮，未见复发。

【方剂出处】王峙峰，等．当归注射液三阴交穴封闭治疗痛经25例．新中医，1997；（5）：28

艾条灸治疗痛经1

【穴位选择】地机、至阴、中极、子宫、大杼。

【随症加减】肝郁气滞加太冲；气血亏虚加足三里、三阴交；寒邪凝滞加关元。

【操作方法】每穴用艾条灸疗10min。为了缩短治疗时间，采用双艾条左右同时灸。于两月经周期之间开始，每日1次，至月经来潮为止。

【经验心得】至阴穴的作用：现有教材均未论及至阴穴治疗痛经。均记载至阴穴有矫正胎位不正的作用。有报道本穴可治疗胎位不正，从中体会到本穴对子宫有作用，故将其列为治疗痛经的首选穴，有时仅针刺至阴一穴即可有明显的止痛效果。子宫穴的位置：唐·孙思邈《备急千金要方》云：“夹玉泉相去三寸。”玉泉即中极穴，现针灸学教材均指中极穴旁开3寸为子宫穴。从《备急千金要方》中许多类似的语句中可证“夹玉泉相去三寸”之语是指中极穴旁开1.5寸，两子宫穴之间为3寸，与中极穴相平。据经验，每遇诸多妇科病，都用中极穴旁开1.5寸为一点，旁开3寸为一点，左右共用4个点，取古今之两个观点。地机穴的作用：地机与三阴交均属脾经。现临床中多用三阴交为治疗痛



经及其他妇科病的首选穴，临床确实有效。但据家父多年临床筛选，证明对于痛经而言，地机的作用优于三阴交。地机为脾经郄穴，郄穴常用于治疗急性病。大杼穴的作用：《灵枢·海论》篇说：“冲脉者，为十二经之海，其腧在于大杼。”另外，妇科的生理功能与冲任二脉的关系十分密切，即所谓冲为血海，任主胞胎。大杼穴虽然在肩背部，属于膀胱经，但因与冲脉有着特定的联系，故此穴当为治疗包括痛经在内的多种妇科病的必用之穴。

治验：张某，女，17岁。12岁月经初潮，14岁以前月经周期不准，14岁以后周期正常。但每于月经来潮前5~6d即感胸胁、乳房、小腹胀满疼痛。月经来潮后小腹疼痛加剧。常因此不能上课。舌边尖红，苔薄黄，脉弦。诊断：痛经（肝郁气滞型）。治疗方法：按上述基本方加太冲。经1个月经周期的治疗，症状即有好转，经3个月经周期的治疗，痛经基本消失，虽略有不适，已不影响上课。

【方剂出处】 李文君. 艾条灸法自疗治痛经. 天津中医, 2002; 19 (3): 34

艾条灸治疗痛经2

【穴位选择】 关元、归来、交信、气海、血海、三阴交、至阴、命门等（最佳穴位为归来、交信）。选穴顺序为先阴后阳，先上后下。行经期仍疼痛者加灸命门、血海、三阴交、至阴穴。

【操作方法】 于经期前3~5d开始施灸，每日1~2次，操作时以2根艾条同时进行，每次灸15min，灸至月经来潮，此为1个疗程，治疗3个疗程。

【功效主治】 温经散寒，活血止痛。

【经验心得】 痛经为妇科最常见的自觉症状之一，在青少年女学生中发病率尤其高，且多为原发性痛经。中医学认为：痛经



是由于“七情”的影响，导致气血瘀滞，经血不畅，即“不通则痛”。艾条灸是通过刺激穴位激发经络的功能而起作用的，因此对于改善机体的血液循环，温经散寒活血，通痹止痛具有独特的功效；且操作简单、方便易行、经济实惠、疗效明显，特别是对于原发性痛经的疗效更是显著，安全而无副作用。

【方剂出处】 张筠，等．艾条灸治疗痛经 169 例．江西中医药，2004；（8）：62

艾灸关元治痛经

【穴位选择】 关元。

【操作方法】 月经来潮前 3~5d 开始，每日灸关元穴 15~20min，至月经来潮时为止。视痛经好转情况可连续灸 2~3 个周期，痛经愈后再灸 1 个周期巩固之。

【功效主治】 暖宫散寒，温经止痛。

【经验心得】 关元穴位近胞宫，是治疗痛经的常用穴，以艾条温灸，可暖宫散寒，温经止痛，故收效满意。此法简便易行，疗效满意，值得临床推广应用。

【方剂出处】 武翠萍，等．艾灸关元治痛经 12 例．中国民间疗法，2001；9（12）：18

灸法治疗原发性痛经

【穴位选择】 气滞血瘀型取关元、太冲（双侧）、三阴交（双侧）；气血虚弱型取三阴交（双侧）、气海、关元、腰阳关。

【操作方法】 术者手持艾条点燃，令其点燃的烟雾直接熏灸于所取暴露的穴位，着火点离穴位皮肤 1~2cm，施温和灸法，以患者能够耐受为度，待其感到局部灼热，见局部皮肤潮红，再灸其他穴位，每个穴位累计灸 5min 左右，一般患者每日施灸 1 次，疼痛严重者每日可施灸 2 次，治疗期间患者停用其他一切用药。

【功效主治】 温经散寒，消瘀散结。



【经验心得】 中医认为，妇人痛经多因血不通调，或因经期内伤冷食，或坐卧湿地，冷气客于胞宫、冲任脉络，故经血为寒湿所凝，经行不畅则疼痛；或因忧思气结或肝郁气滞，使冲任受阻逆行，不通则痛；或因禀赋不足，肝肾虚弱，冲任不固而疼痛。灸疗具有温经散寒、温通经络、回阳固脱、消瘀散结、补虚理气的功效。现代研究证明，艾条燃烧时，中心温度可达几百度不等，能产生包括红外线在内的特殊的热信息。通过人体穴位对热信息的传递，可振奋经气，对人体的经络系统并通过经络对脏腑起着特殊的调节作用。

【方剂出处】 王桂珠，等．灸法治疗原发性痛经 120 例．中国民间疗法，1999；（8）：12

隔姜灸治疗痛经 1

【穴位选择】 以任、督脉、足少阴和足阳明经穴为主。取穴神阙、命门、关元、足三里、三阴交、肾俞。耳穴取子宫、卵巢、内分泌、交感、神门、皮质下、肾、屏间。

【操作方法】 嘱患者仰卧位，术者立于一侧，每次选 4 个穴，用厚 3mm 左右生姜 1 片，中间用针刺十余个孔放在穴位上，术者点燃艾条置姜片上方燃灸，手法用温和灸，一般灸 30min，每日 1 次。治疗时间最好为经前 7d，连续治疗 3 个经期，若不见效，停止治疗。辅助治疗用耳穴贴压法，每次取 6 个穴，两耳交替使用。每日按压 4 次，每次以耳郭发热为佳，隔日换 1 次。

【功效主治】 温通经络，祛寒止痛。

【经验心得】 痛经多见于青年妇女，本组病例属中医学虚证范畴，多由素体气血不足，冲任亏损，血海胞宫空虚，胞脉失养。隔姜灸具有温经通络，激发阳气，驱散寒邪，以调和营卫，振奋脏腑之气化功能以促进气血通畅，“通则不痛”。辅以耳穴贴压法，以调节大脑皮质的兴奋和抑制的功能，有调节血管舒缩功能，能缓和平滑肌痉挛，对内脏有较强的镇痛作用，并有较好的促进



代偿功能。

治验：孙某，女，18岁。主诉：月经期腰腹酸痛，伴有恶心，头昏，嗜睡1d，于14岁月经初潮，每月经期，均有腰酸腹痛，但经期尚准，血量不多，色红，口不干，二便正常，曾服中成药、西药未收效。查：神志清楚，体质较瘦，舌淡苔白，心肺正常，肝脾未触及，腹平软，无明显压痛，血常规（一），尿常规（一），脉紧，诊为痛经。治疗同上，治疗1次疼痛大减能够正常读书学习，经3个经期巩固治疗痊愈。随访1年未复发。

【方剂出处】朴光华，等。隔姜灸为主治疗痛经34例。针灸临床杂志，1997；13（1）：38

隔姜灸治疗原发性痛经2

【穴位选择】神阙、关元。

【操作方法】将纯净干燥精细食盐填于神阙穴中，使之与脐平，上置备制好的新鲜姜片（直径大约3cm，厚约0.3cm，中间刺数孔）和大艾炷点燃施灸，当艾炷燃尽后，易炷再燃，直至规定壮数。然后再将制备好的新鲜姜片放在关元穴处，上置大艾炷点燃施灸，当艾炷燃尽后，易炷再燃，直至规定壮数。在施灸过程中若患者感觉灼热疼痛不能忍受时，可用镊子上下移动姜片，切勿烫伤。根据痛经的轻重程度规定壮数，轻度灸4壮，中度灸6壮，重度灸8壮。共治疗3个疗程（月经周期），第1个疗程于疼痛时开始治疗，每日1次，直至痛止；第2~3个疗程于月经前3d开始治疗，每日1次，治疗到痛止为1个疗程。若经第1个疗程治疗后不再疼痛属于巩固治疗，第2~3个疗程于月经前3d开始治疗，每日1次，7d为1个疗程。

【功效主治】温经散寒，逐瘀止痛。

【经验心得】方中神阙、关元为任脉腧穴，具有温阳补肾、培元固本、通调冲任的功效。加之艾灸不仅增强了二穴的作用，又可温经散寒活血祛瘀，从而达到通经止痛的目的。



治验：张某，女，17岁，2003年3月初诊。主诉行经腹痛3年。患者于月经初潮时有冒雨涉水史，以后每逢经期小腹疼痛，有时痛剧难忍，喜温畏寒，月经量少，色暗有块。经妇科检查排除器质性病变，诊断为原发性痛经。曾服中西药物治疗，效果不佳，故欲求针灸治疗。此次又因着凉而诸症加重，伴恶心呕吐，面色苍白，形寒肢冷，舌淡红，苔白，脉沉紧。中医辨证：寒湿凝滞型痛经。取神阙穴隔盐灸，关元穴隔姜灸，用大艾炷各穴灸8壮，灸后即效，疼痛消失，为巩固疗效，按上述治疗方法，又连续治疗2个月经周期而告痊愈。随访3个月未见复发。

【方剂出处】孙立虹，等．隔物灸治疗原发性痛经42例疗效观察．河北中医药学报，2004；19（3）：37

发泡疗法治疗原发性痛经

【药物组成】斑蝥、白芥子各20g。

【操作方法】上药研末和匀，以50%二甲基亚砷调成软膏状，取麦粒大小状软膏，置于2cm×3cm大小的胶布中心，贴于中极或关元穴（二穴交替使用），3h后揭去药膏，稍后即可出现约0.5~1cm大小的水泡，2~3d后干瘪结痂，一般不留瘢痕。每于月经前5d贴第1次，月经始行或觉小腹痛时贴第2次，3个月为1疗程。另外在发泡过程中，要注意局部清洁，避免摩擦。

【功效主治】疏经通络止痛。

【经验心得】根据中医“通则不痛、不通则痛”的原理，治疗当以疏经通络止痛为主。取关元、中极既是任脉之经穴，又为足三阴与任脉之会穴，通于胞宫，用斑蝥、白芥子性温发泡，刺激经穴，能调理冲任之经气，温通胞脉，调气行血。气调血行，通则不痛，故获效满意。

治验：张某，女，24岁，未婚。痛经8年，始于16岁初潮，经期周期35~40d/4~5d。每于经前数日或行经时小腹冷痛，喜温喜按，畏冷肢楚，甚则出冷汗，面色苍白，经量多、色紫暗、



夹血块，行经 2d 后小腹疼痛减缓。现月经期将至，小腹始痛，舌苔薄、衬紫气，脉细弦，脉症合参，当属寒凝血瘀所致，治当温经散寒、活血止痛。即用发泡膏外贴于关元穴，于月经始行贴第 2 次于中极穴。经第 3 次治疗后疼痛消失，半年后随访未见复发。

【方剂出处】 施振东，等。发泡疗法治疗原发性痛经 38 例临床观察。江苏中医药，2002；23（12）：29

壮医药线点灸合中药外敷治疗原发性痛经

【穴位选择】 气海、中极、承山、三阴交。伴呕吐加灸内关、足三里等穴。

【药物组成】 川芎、艾叶、乳香、没药、当归、赤芍、香附、延胡索、白芍、细辛等。

【操作方法】 采用壮医药线 2 号线（一般直径为 0.7mm）。患者取坐位或卧位。医者用右手拇指、示指持药线一端，露出线头 1~2cm，在酒精灯上点燃线端，并迅速熄去火焰，将带火星的线头直接点按于穴位上，一按火灭即起为 1 壮。一般每穴 1 壮，灸处可有轻微灼热感，灸后局部有灼热或痛感，勿搔抓。选择经前 1 周开始治疗，每日 1 次，经至时停止治疗，共治疗 3 个月经周期。配合中药外敷，上药共研成末，加入凡士林中煮沸，搅拌调成膏状备用。每次取 100~200g 加温后外敷于腹部，每日 2 次，每次 3~4h 以上。可于经前 3d 开始治疗，月经干净后停用，连续治疗 3 个月经周期。

【功效主治】 活血化瘀，暖宫散寒。

【经验心得】 气海穴、中极穴为任脉要穴，气海穴更是任脉与三阴经交会穴。中医认为任脉起于胞中，主一身之阴，为妊养之本而主胞胎；任脉之气通，才能促使胞宫有行经、胎孕等生理功能。气海有理气、益气的作用，三阴交为足三阴经之交会穴，可调血行血，承山为治痛经经验穴。而药线点灸以局部的温热刺激通过经络传导，调整气血使之归于平衡，具有止痛、活血化瘀、



温煦经络等功效；合用以川芎、艾叶、乳香、没药、当归、赤芍、香附、延胡索、白芍、细辛等制成的药膏热敷下腹部，加强活血化瘀，暖宫散寒，调经止痛功效，使胞宫、冲任气血畅通，使经行腹痛消失。现代医学研究发现，原发性痛经的重要因素是子宫内膜和血内前裂腺素（PGT2A）含量增高引起。国内有学者认为，乳香、没药、延胡索等药所以能止痛，是有不同程度降低前列腺素的作用。针灸刺激三阴交能起到调整子宫内膜和血中前列腺素的作用。故药线点灸合中药外敷治疗原发性痛经疗效明显。

【方剂出处】 卢英翔. 壮医药线点灸合中药外敷治疗原发性痛经 37 例. 广西中医学院学报, 2004; 7 (4): 23

针灸配合耳穴贴压治疗痛经

【穴位选择】 主穴：上髎、次髎、中髎。加减：寒湿凝滞型加地机；肝郁气滞型加太冲；肝肾亏损型加关元。耳穴：寒湿凝滞型取子宫、内分泌、皮质下、卵巢、交感、神门；气滞血瘀型取子宫、交感、皮质下、卵巢、脾、肝；气血两亏型取子宫、肾、肝、内分泌、交感、神门、心。

【操作方法】 患者取俯卧位，艾条剪成 2cm 左右的艾段，用 28 号或 30 号 2 寸毫针快速进针使针感传至小腹或前阴为佳，针留在适当深度，将艾段插在针尾上点燃，连灸 2 炷，留针 30min。每日治疗 1 次，7 次为 1 个疗程，月经周期开始即行治疗。耳穴操作：将王不留行子置于 0.5cm×0.5cm 的正方形胶布上，令患者取坐位，耳郭用酒精棉球消毒后，将胶布贴压在所取穴位上，用拇、示指对压耳穴，手法由轻到重按压，使之产生酸、麻、胀、痛感。嘱患者每日自行按压 4~5 次，每次 3~5min，隔日换 1 次，双耳交替贴压。亦可同时贴压双侧，经前 1 周开始耳穴贴压，15d 为 1 个疗程。

【功效主治】 健脾利湿，调血通经。

【经验心得】 痛经临床以青年妇女多见，其原因是由于经期



感寒、过食寒冷食物、寒邪蕴于胞宫，或气血运行不畅，胞宫经血疏通受阻，而导致“不通则痛”或冲任胞宫失于濡养，“不荣则痛”。治疗总以理气行血为主，重点突出一个“通”字。若因于滞者，则行而通之，因于虚者，则补而通之。作者取穴以上髎、次髎、中髎为主穴，可健脾利湿、调血通经。地机为脾经之穴，可止痛，调经血；太冲穴，可疏肝解郁，调理气血；关元为足三阴、任脉之会，有益精血，补肝肾，养冲任的作用。再结合艾灸温补下焦，散寒除湿，相互配合，相辅相成，功效卓著。通过耳穴贴压可起到疏通经络，运行气血，调和脏腑，以恢复组织器官的生理功能，提高机体的抵抗力以达到止痛目的。子宫穴为相应部位取穴，以调气血、滋养胞脉；神门穴调节精神止痛；交感调整自主神经功能；肾穴补益肾气，调节冲任；卵巢调节垂体前叶功能。诸穴相配共奏调理气血而止痛之功效。实践验证，病程较短者效果为佳。

【方剂出处】张振宇. 针灸配合耳穴贴压治疗痛经 40 例. 河南中医, 2003; 23 (4): 51

四、耳穴疗法

耳穴压丸配合按摩治疗原发性痛经

【穴位选择】主穴：内生殖器、卵巢、内分泌、交感、神门穴。配穴：气滞血瘀型配肝，耳尖、耳背静脉点刺放血；寒湿凝滞型配脾、三焦加温灸（即用艾条温灸整个耳郭令其明显发红，并有灼热感即可，每次 3min）。

【操作方法】用麝香追风膏（过敏者用肤疾宁贴膏）剪成 4mm×4mm 大小，其中央放一粒王不留行子，敷贴双耳相应穴位，每日按压 2~3 次，每次每穴按压 30 下，隔日换贴。配合按摩：施术者指揉中极、关元、气海穴各 2min，频率 60 / min，掌摩腹部 2min，每日 2 次。



【功效主治】 温通经脉，调和气血。

【经验心得】 痛经属中医“经来腹痛”或“行经腹痛”范畴。原发性痛经又称功能性痛经，常见于未婚妇女，多属实证。引起原发性痛经的原因大多为外感风寒，内伤七情，导致冲任瘀阻或寒凝经脉，使气血运行不畅，胞宫经血流通受碍，以致“不通则痛”。现代医学认为，导致原发性痛经的原因，与精神因素引起的自主神经功能失调、子宫发育不良、内分泌紊乱、物理刺激等原因导致子宫痉挛性收缩有关。治疗采取实证以疏为通，根据全息对应原理，取相应部位之穴位为首选穴，如内生殖器、卵巢穴。交感、神门穴为解痉止痛要穴。根据现代医学理论，内分泌穴可以调节人体内分泌功能，对气滞血瘀型加肝穴疏肝理气，气行则血行，耳尖、耳背静脉点刺出血以泻之；寒湿凝滞型加脾、三焦穴健脾除湿，温灸以温之。按摩中极、关元、气海及腹部以温通经脉，调和气血，使气血畅通，诸穴共同作用，以达止痛之目的。

治验：袁某，20岁，未婚。每于行经前及行经期腰腹坠胀、疼痛较剧，经量多，色暗、有血块，经行不畅，且血块排出则疼痛缓解，脉沉弦，舌淡尖红边有瘀点，苔薄微黄，就诊时正值经期，上述症状俱存，要求止痛，遂采用按摩中极、关元、气海穴各2min，掌摩腹部2min，耳尖、耳背静脉点刺放血各3~4滴，耳压取穴：内生殖器、内分泌、神门、交感、卵巢、肝，每穴按压30下，疼痛当即缓解，嘱隔日换贴1次，下次行经前1周前来治疗至行经完毕，连续3个周期，患者行经疼痛消失。

【方剂出处】 朱锦波. 耳穴压丸配合按摩治疗原发性痛经. 中医外治杂志, 2001; 10(2): 38

耳轮水针治疗痛经

【穴位选择】 耳轮（单）。



【操作方法】 患者取坐位，常规消毒其一侧耳轮，用一次性注射器抽取 0.1%利多卡因 1ml，由耳尖处沿皮下缓慢注入 1ml，注射完毕，取少许消毒药棉敷于针眼处，以防注射液外渗。月经来潮当日或经期小腹痛发作时予以治疗，每日 1 次，两耳交替治疗，至痛经症状完全缓解。继续治疗 3 个月经周期为 1 个疗程。一般治疗后 2~15min 见效，多数患者经治疗 1~2 次即可缓解当月痛经症状。

【功效主治】 调经止痛。

【经验心得】 耳轮水针为著名针灸专家，安徽省中医学院周楣声老师所创，可用治各种痛症，尤其对急性、痉挛性痛症效尤显，并对某些癌症疼痛亦有一定的镇痛作用。

治验：周某，女，16 岁。经行腹痛（重度）2 年。14 岁月经初潮，每次经潮当日小腹痛剧，伴呕吐、畏寒肢冷，甚则晕厥，月经第 2 天渐缓，经量偏少（每次月经期用卫生巾 10 片左右），色紫暗。本次月经今日来潮，量少、色褐，小腹坠痛难忍，纳呆呕恶，面色苍白，四肢厥冷，由家人背负而来。体检：腹平软，无包块，无压痛，测血压正常，查血常规无异常。确诊为原发性痛经。即予耳轮水针治疗，5min 后小腹痛止，未再发作。此后，每月经潮当日治疗 1 次，逐月痛减，连治 3 个月经周期告愈，随访 1 年未复发。

【方剂出处】 卞宜心. 耳轮水针治疗痛经 40 例. 中医外治杂志, 2001; 10 (5): 39

耳穴皮内埋针法治疗痛经

【穴位选择】 交感、神门、子宫、皮质下。加减：气滞加肝，血虚加脾，寒凝加肾，瘀血加盆腔，瘀热加卵巢。

【操作方法】 经期腹痛第 1 天开始，7d 为 1 疗程，一般连续治疗 6 个疗程。先用 75%酒精常规消毒耳郭，左手固定耳郭，右手将特制的皮内针刺入耳穴后，再用胶布固定，并嘱患者每日 4



次按压埋针，以增强疗效。两耳郭可轮换埋针。

【功效主治】 解痉止痛。

【经验心得】 痛经是妇科常见病之一，子宫过度收缩是原发性痛经的关键。其发病有情志所伤、起居不慎或六淫为害等不同病因，并与素体及经期、经期前后特殊的生理环境有关。耳穴交感能调节自主神经功能紊乱，解除内脏血管平滑肌痉挛；神门能平肝熄风、镇惊安神止痛；子宫主理月经不调，具有消除盆腔炎症之功；皮质下是大脑皮质的反应区，能调节内分泌系统，增强人体的免疫功能，有解痉抗炎消痛作用。依据辨证，选用配穴，诸穴相配，标本兼治。

【方剂出处】 夏效云，等. 耳穴皮内埋针法治疗原发性痛经 108 例. 中医外治杂志，2000；9（3）：46

耳穴贴压治疗痛经 1

【穴位选择】 寒湿凝滞型：子宫、内分泌、皮质下、交感、神门；气滞血瘀型：子宫、交感、皮质下、卵巢、肝、脾；气血两亏型：子宫、肝、肾、内分泌、交感、神门、心等穴。

【操作方法】 取王不留行子 1 粒，置于 0.5cm×0.5cm 的正方形胶布上，让患者取坐位，先用 75% 酒精棉球消毒耳郭，待干后，应用耳穴诊断仪探取所用穴位，然后将置有王不留行子的胶布对准穴位贴压固定，并嘱患者每日按压 3~5 次，每次 1~3min，至耳郭有发热感为宜，重者贴压双侧，2d 更换 1 次，3 次为 1 个疗程。

【功效主治】 理气行血，疏通经络。

【经验心得】 关于痛经的记载，最早见于《金匱要略·妇人杂病脉证并治》篇。临床以青年妇女多见，其主要原因是由于经期感寒，过食寒冷，寒邪蕴于胞宫，再者是气血运行不畅，胞宫经血流通受阻，而导致“不通则痛”，或冲任、胞宫失于濡养，“不荣则痛”。治疗总以理气行血为主，重点突出一个“通”字。



若因于滞者，则行而通之，因于虚者则补而通之。通过耳穴贴压起到疏通经络、运行气血、调和脏腑以恢复组织器官的生理功能，提高机体的抵抗力，以达到止痛目的，实践证明，年龄小者及病程较短者效果为最佳。

子宫为相应部位取穴，以调气血，滋养胞脉；神门穴调节精神止痛；交感调整自主神经功能；肾穴补益肾气，调节冲任，行气血而止痛，心主血脉，脾统血，脾生血；卵巢调节垂体前叶功能。诸穴相配共奏调理气血，调和冲任功能，正气复，邪气除，病自愈。

治验：王某，18岁。主诉月经周期错后10d，经期腹痛难忍，每次必注射止痛针或口服延胡索止痛片，病假休息治疗。热敷即轻，月经量少，质稀色黑，舌淡苔白，脉沉紧。诊断：痛经（寒湿凝滞型），治疗同时贴压双侧穴位，经过1个疗程治疗，痛经缓解，效果明显，又经过1个疗程治疗，诸症消失，随访2年未复发。

【方剂出处】房师勤. 耳穴贴压治疗痛经600例. 中医外治杂志, 2001; 10(5): 40

耳穴贴压治疗痛经2

【穴位选择】主穴：子宫（即耳穴国际化标准方案之内生殖器穴）、肾、内分泌、交感、皮质下。加减：气滞血瘀型加肝、神门；寒湿凝滞型加脾、胃；湿热瘀滞型加三焦、腹。

【操作方法】于月经前1周左右开始将王不留行子用胶布固定贴压在所选的经过常规消毒的一侧耳穴上，手压耳穴，以患者有明显的痛、胀、灼热感为宜。嘱患者每日自行按压3~5次，每次按压5~10min。2~3d贴压对侧耳穴，经净或经净后数日停止贴压。

【功效主治】调气行血，祛瘀止痛。

【经验心得】临床观察痛经以30岁左右未婚女子为多。女



子多禀性柔弱，易因七情所伤导致肝气郁滞，气机不畅，气滞而致血瘀，故对气滞血瘀型痛经加用了肝和神门两穴。脾主统血，运化水湿，健脾则有利于寒湿的消除，故对寒湿凝滞型痛经加用脾、胃两穴；湿热瘀滞型加用三焦、腹，一是从部位考虑，二是因三焦有通调水道、分清别浊的功能。

用耳穴贴压刺激法治疗痛经，能使经脉调和，气血流通，冲任、胞宫得养而痛经蠲除。王不留行性走而不守，能入冲任血分，耳穴贴压则有助于痛经的缓解。耳穴贴压具有简便易行，患者易接受等优点，值得推广。

【方剂出处】 梁雪雯. 耳穴贴压法治疗痛经 70 例. 上海中医药杂志, 1998; (11): 20

耳穴贴压治疗痛经 3

【穴位选择】 子宫、内分泌、缘中。加减：气滞血瘀型加肝、脾、内分泌；寒湿凝滞型加肾、脾；气血亏虚型配脾、胃、小肠；疼痛剧者加神门、皮质下；经血不畅者加交感；恶心呕吐、腿软无力者加脾、胃；心烦不安加心、神门。

【操作方法】 耳穴局部用酒精消毒后，将王不留行子用胶布压贴在穴位上，嘱患者每日按压 3~4 次，两耳交替，以耳穴发热发痛为度。于经前 1 周开始治疗，至月经干净为 1 个疗程。

【功效主治】 调理冲任，行气活血，疏通经络。

【经验心得】 耳压法是在耳针的基础上发展起来的。根据人体整体观念，选择一组对月经有特异调节作用的穴位做耳压治疗，可以达到调理冲任、行气活血、疏通经络的功效。耳压法的即时止痛效果较好；疗效与患者年龄大小、病程长短有一定关系，年龄小病程短的见效快疗效好，反之则见效慢、疗效差。耳压治疗必须给所贴穴位以足够的刺激量同时，要解除情绪紧张，注意经期卫生避免感受风寒和过食生冷食物。



【方剂出处】潘蕾. 耳压法治疗痛经 48 例. 宁波医学, 2000; 12 (6): 286

耳穴贴压治疗痛经 4

【穴位选择】耳部子宫、内分泌、交感、皮质下、卵巢、肝、肾、三焦、胃、脾穴。

【操作方法】先用王不留行子粘于胶布上做好贴压子片，并剪成每片黏附有 1 粒王不留行的耳压板，再将耳朵皮肤消毒，用镊子夹取耳压板一粒粒固定于耳穴上，用拇指和示指对压耳穴，手法由轻至重，使之产生酸、麻、胀痛感，每次 3~6min。尔后嘱患者每日自行按压 6~7 次，于经前 3~7d 进行治疗，左右耳朵交替贴压。

【功效主治】疏肝解郁，调畅气机。

【经验心得】中医认为，本病的主要病机是气血运行不畅，多因寒湿凝滞、肝郁气滞、肝肾亏损所致。肝藏血、主疏泄，调畅气机；肾主胞宫；脾主运化统血，为气血生化之源；三焦总司全身气机。故取耳部肝、肾、脾、三焦之穴，以调畅气机、调和气血。现代医学认为痛经主要为子宫过度前倾和后倾、子宫内膜增厚、盆腔炎、子宫内膜异位所引起，故取子宫、交感、卵巢、皮质下、内分泌诸耳穴，以调节内分泌，调节子宫功能。此法简便易行，疗效可靠，且无副作用。

【方剂出处】尹军勤. 耳穴贴压治疗痛经 31 例. 湖南中医药导报, 2001; 7 (5): 233

耳针子宫穴治疗痛经

【穴位选择】子宫穴（双侧）。

【操作方法】患者取坐位，常规消毒穴处皮肤，选用 28 号 1 寸毫针，针尖对准子宫穴，进针 0.2~0.3cm 左右，两侧同时进行，采用泻法捻转 2min，隔 10min 后再捻转 1 次，每次留针 20min，



3次为1个疗程。针刺过程中停用其他药物治疗，连续治疗2~3个疗程。

【功效主治】 疏通经络，调理气血

【经验心得】 痛经临床上分为二种，一种是原发性（亦称功能性痛经），一种是继发性。中医学认为其发病机制是“痛则不通”，临床治则在于使其“通则不痛”。采用针刺耳郭子宫穴，能刺激神经系统，对机体功能进行调整，具有疏通经络，调理气血之功用。其止痛效果明显，患者乐于接受，为解除妇女痛经疾苦无疑是一条捷径。

治验：宋某，32岁。主诉：月经过多、疼痛2年。每至经行辄小腹疼痛，痛引腰骶，伴见头昏目眩，四肢乏力，不能坚持上班，经中西医多方求治罔效，遂来愚处求针灸治疗。经用上述方法针刺3次后，疼痛若失，随访1年未见复发。

【方剂出处】 王万祖. 耳针治疗痛经 164 例. 中国针灸, 2000; (5): 311

耳体针配合治疗痛经

【穴位选择】 取穴子宫、内分泌，体穴取关元、三阴交。

【操作方法】 常规消毒后，选0.5~1.5寸毫针，耳穴进针0.2~0.3寸，体穴进针1~1.2寸，针刺出现酸胀感后，行捻转泻法，留针30min，每10min行针1次，每日1次，5次1疗程，行经前1d开始治疗，经期不停针。

【功效主治】 疏经通络，行气活血。

【经验心得】 针刺耳穴子宫、内分泌能刺激神经系统，调整脏腑经络；针刺体穴关元、三阴交可通调冲任脉气，使气血畅通下行，耳体针配合可加强疏经通络、行气活血的作用，以达快捷通经止痛之目的。

【方剂出处】 黄庆友. 耳体针配合治疗痛经. 中国针灸, 2002; 22 (2): 108



耳穴贴压配合中药治疗痛经

【穴位选择】 子宫、神门、内分泌。加减：气滞血瘀型加肝、卵巢；寒凝胞中加皮质下、脾；湿热下注加会阴、腹穴；气血虚弱型加脾、阳谷；肝肾虚损型加肝、肾。

【药物选择】 气滞血瘀型以行气活血、祛瘀止痛为主，膈下逐瘀汤；寒凝胞中型以温经散寒、祛瘀止痛为主，温经汤加减；湿热下注型以清热除湿、化瘀止痛为主，清热调血汤加减；气血虚弱型以益气补血止痛为主，圣愈汤加减；肝肾虚损型以益肾养肝止痛为主，调肝汤加减。自月经来潮前 1 周开始服用，每日 1 剂，水煎，分早、晚 2 次服用至月经干净为止。

【操作方法】 于月经来潮前 1 周将王不留行子按辨证贴压于上述耳穴，嘱其每日按压耳穴 3~5 次，每次 5~10min，使耳郭有灼热感。每 3d 换贴 1 次，左右耳交替使用，5 次为 1 个疗程。至下个月经周期开始第 2 疗程。

【功效主治】 疏理肝气，活血化瘀。

【经验心得】 痛经为青少年女性中的常见病。现代医学认为痛经常与生殖器局部病变、内分泌、神经、精神因素等有关。中医学则认为痛经与肝、肾、冲、任等经脉有关。其主要病机在于气血运行不畅，胞宫经血流通受碍，故临床上用耳穴贴压法，取子宫、卵巢相应部位以调理气血，滋养胞宫；内分泌以调整内分泌；皮质下为止痛要穴，并可调整神经中枢；交感以调整自主神经及止痛；神门镇静安神、消炎止痛；少腹属肝，取肝以解少腹痛，且能疏理肝气、活血化瘀；取肾以补肾气，调冲任，行气血而止痛。同时配以中药辨证施治，随症加减，以调理冲任气血。因此，耳穴贴压与中药配合从根本上调整了人体阴阳气血的平衡，达到了标本兼治的目的。

治验：翟某，女，17 岁。病史：痛经病史 4 年，加重半年。



每逢月经前 2~3d 或月经期小腹胀痛，拒按，伴胸胁乳房胀痛，经行不畅、量少、色紫黯有块，痛剧时影响睡眠和饮食、坐卧不宁，多次服用妇科十味片、当归丸效果不显。现月经将至，腹部稍有隐痛，查其舌质黯边有瘀点、苔薄白，脉弦细。中医辨证为气滞血瘀之痛经，给予耳穴子宫、神门、内分泌、肝、卵巢贴压，并同时服用中药膈下逐瘀汤加川楝子 10g，柴胡 6g。治疗 1 个月经周期后，疼痛大减，伴随症状亦减轻。连续治疗 3 个月经周期诸症亦消失，为防复发，嘱其每次行经前 1 周仍来治疗，继续治疗 3 个月经周期，随访半年，未见复发。

【方剂出处】刘佳彬. 耳穴贴压配合中药治疗痛经 30 例. 中国针灸, 1999; (11): 690

耳针配合针灸治疗痛经

【穴位选择】耳穴：子宫；内分泌、神门、卵巢、肾、肝、内分泌。体穴：上髂、次髂、中髂。加减：寒湿凝滞型加地机，肝郁气滞型加太冲、肝肾亏损型加关元。

【操作方法】取棉球耳郭常规消毒，再将王不留行子（生），用胶布固定贴压在所选定的穴位上，用手挤压药子使贴压处有明显的灼热、痛、胀感为宜。嘱患者每日自行按压所贴穴 4~6 次，每次按压 5~7min，2d 后如法交替贴压对侧耳穴以 1 个月经周期为 1 个疗程。配合针刺，重症患者在月经来潮前 2 周开始治疗，轻症者在来潮前 1 周开始治疗，一般月经期不针刺。患者取适当体位，穴位常规消毒后用 30 号毫针针刺以上诸穴，针感传至小腹或前阴为佳，留针 40min，每日治疗 1 次。

【功效主治】疏肝解郁，调理气血。

【经验心得】现代医学认为，痛经与子宫发育不良，子宫位置前屈或后倾，子宫内膜病变或盆腔炎等有关，中医学则认为痛经与肝、肾、冲、任等经脉有关，其病机在于气血运行不畅，耳穴贴压治疗痛经目的是通过刺激耳部穴位，联络全身经脉和相关



的脏腑，达到使经脉调和、气血流通，冲任胞宫得以濡养。再配合针刺，以上髀、次髀、中髀为主穴，可健脾利湿调血通经，地机为脾经之郄穴，可止痛，调经血、太冲是肝经原穴可疏肝解郁，调理气血；关元为足三阴任脉之会，有益精血，补肝肾、养冲任的作用，以上诸穴相配，相辅相成，因此取得良好疗效。

【方剂出处】 王勤. 耳针治疗痛经 20 例. 针灸临床杂志, 2000; 16 (2): 39

五、推拿疗法

全息蜂疗治疗痛经

【穴位选择】 第二掌骨侧下腹穴。

【操作方法】 采取全息穴位与蜂刺相结合方法，活蜂皮试阴性者，取第二掌骨侧下腹穴，先毫针刺，用泻法，留针 30min，然后活蜂 1~2 只螫刺。

【功效主治】 疏肝解郁，理气活血。

【经验心得】 痛经原因诸多，精神因素、内分泌失调、子宫发育欠佳、宫口稍小等而致子宫呈不规则痉挛收缩，中医认为肝气郁结、气血双亏、寒滞经脉所致。运用山东大学张颖清教授“全息生物学”理论，取第二掌骨侧下腹病理反应点予以针刺、蜂螫，通过体液神经的调节，使相应的患病器官或部位得到修复和调整而愈。

治验：吴某，女学生，未婚，月经初潮，羞于启齿，精神紧张，家长带来就诊，腹痛剧烈，呕吐、四肢厥冷，经询问病史、检查确诊为痛经，予以第二掌骨侧针刺下腹穴，留针 30min，活蜂 1 只螫刺，1 次愈。

【方剂出处】 彭丽. 全息蜂疗治疗痛经的探讨. 养蜂科技, 1999; (1): 33



手法激穴治疗痛经

【穴位选择】 中脘、气海、中极、天枢、命门、左阳池。

【操作方法】 用拇指揉压中脘、气海、中极穴各 2min，然后用医用艾条灸中脘、天枢、气海、命门、左阳池各 5min（气海可灸至 10min），每日 1 次，此法在行经前 7d 进行，7d 为 1 个疗程，每 1 个月经周期为 1 疗程，一般 1~3 个疗程便可奏效。

【功效主治】 温经活血，调经止痛。

【经验心得】 中医学认为痛经的发生可能与七情六淫有关。现代医学认为与患者自身素质及特殊生理状况有关。以腹部症状为主者与子宫前倾有关，以腰骶症状为主者与子宫后倾有关，乳胀可能与输卵管状况有关。宫位不正是痛经主要原因之一。用任脉的中脘、中极可醒脾健胃，所以有明显祛恶心、止呕吐之功效；气海为腹部纳气之根本，能助全身百脉通畅，“通则不痛”，气海公认有很强的解痉止痛的作用，天枢为足阳明胃经募穴，揉压此穴可使子宫振奋，输卵管扩张；命门是督脉重要穴位之一，艾灸可活跃腰骶骨盆血循环，增大血供、濡养下焦百脉；阳池为调节三焦之要穴，有纠正子宫倾斜之妙用；诸穴合用，共奏活血化瘀，解痉止痛，端正子宫，增强胃肠壁蠕动，止吐镇静，强壮肌体之功效。此法收效快，患者乐意接受，值得推广。

治验：唐某，女，21 岁。诉患痛经史 5 年，月经规律，每于经前期及行经期少腹剧痛，伴有恶心、出冷汗。常服用止痛片或注射止痛针以缓解痛苦，妇科检查无异常，患者心理压力很重，惧怕月经，笔者先亲自以手法激穴一遍，然后用笔在患者身上标出穴位，嘱其母照此法施治 1 周。于当月 15 日来诊，喜告本次月经疼痛全无，赞叹奇迹，嘱患者在气海，左阳池施手法 1 周以固效。随访数年无复发。



【方剂出处】 王恩福. 手法激穴治疗痛经 52 例. 中医外治杂志, 1998; 7 (5): 18

推拿点穴治疗痛经

【穴位选择】 气海、关元、膻中、太冲、中极、三阴交、血海、膈俞、肝俞、肾俞、命门、八髋穴。

【操作方法】 患者取仰卧位，医者站于患者一侧，用掌推法、掌揉法、掌摩擦小腹法、多指提拿法，拇指点揉气海、关元、膻中、太冲、中极等穴，掌推搓下肢内侧足三阴经，拇指点揉三阴交、血海。患者俯卧位，医者站于患者一侧，用掌直推、掌揉、搓擦腰骶部，至透热为度。点揉膈俞、肝俞、肾俞、命门、八髋穴，根据病情的不同证候，施术加减法，7d 为 1 疗程，每日 1 次，每次约 20min。

【功效主治】 行气活血，祛瘀止痛。

【经验心得】 治疗痛经要以行气活血、祛瘀止痛为主。掌推揉腹法、掌推揉腰骶部、点揉气海、关元、血海、三阴交、肾俞、命门、八髋穴，具有舒筋活络、缓解痉挛、开通闭塞之功。寒食凝滞型加掌摩擦小腹法、搓擦腰骶部至透热为宜，可起到祛风散寒、温中止痛之功效。气血凝滞型加掌推搓下肢内侧足三阴经，点揉膻中、太冲、肝俞、膈俞穴，具有宽胸、舒肝理气、开通闭塞、行气活血之功。

【方剂出处】 祁彦华. 推拿点穴治疗痛经. 现代中西医结合杂志, 2001; 10 (20): 1973

一指禅手法治疗痛经

【穴位选择】 气海、关元、章门、期门、血海、三阴交、脾俞、膈俞、肝俞、胆俞。

【操作方法】 首先，患者仰卧位，医者站于右侧，用一指禅



推任脉，从阴交至中极往返5次，重点推气海、关元穴，然后用掌摩法摩于小腹部顺时针方向6~8min，再用振法于小腹部，使小腹得气感至上腹，下行至会阴部，点按章门、期门、血海、三阴交，以酸胀为度。接着，嘱患者俯卧位，用一指禅推脊柱膀胱经第一侧线，重点按脾俞、膈俞、肝俞、胆俞，每穴0.5~1min，然后用擦法擦其两侧膀胱经与督脉，透热为度，重点擦腰骶部及八髎穴。最后患者取坐位，作者站于右侧，斜擦两胁，从后向前斜擦，以微热为宜。手法治疗是在月经来潮前1周开始，隔日1次。一般每月做3次。治疗3个月为1个疗程。

【功效主治】 疏肝理气止痛。

【经验心得】 气滞血瘀型痛经是由于素有抑郁，情志不畅，肝郁气滞，气机不利，经血运行不畅，凝滞于胞中而引起的。其主要病机是气滞血瘀，气血运行不畅，不通则痛。采用一指禅推拿手法结合辨证取穴，可起到行气活血的作用。如两胁为足厥阴肝经循行路线，斜擦两胁可疏肝解郁，章门、期门、太冲、行间为足厥阴肝经经穴，按揉上述穴位可疏肝理气止痛，擦督脉助阳气，推揉任脉气海、关元，可益气，调理冲脉任脉，点揉血海、三阴交两穴，健脾生血调经。气机畅，瘀血去，则痛经止。

治验：张某某，女，18岁，未婚。主诉：经来腹痛半年余，近来加重。15岁月经初潮。半年前，患者由于心情不畅，继而出现经前小腹疼痛，痛引至腰骶，甚至剧痛难忍，经色紫黯夹有血块，胸胁乳房胀痛，拒按。平时喜叹息。患者当时因少腹胀痛难忍经妇科介绍做手法治疗。末次月经为2000年7月19日。患者自诉曾做过子宫、输卵管B超及白带化验，均正常。舌紫黯有瘀点，脉弦，证属气滞血瘀。治拟理气化瘀止痛，取任脉及足厥阴肝经、足太阴脾经为主。取气海、关元、太冲、期门、章门、血海、三阴交、肝俞、膈俞、八髎穴等。采用一指禅推法、摩法等。具体操作按照上述治疗方法进行。从8月12日到18日，隔日推拿1次，8月19日痛经症状明显减轻。治疗期间未服止痛药物。



同时嘱生活要有规律，心情舒畅。连续治疗 3 个月后，痛经完全消失，随访 1 年未复发。

【方剂出处】 诸国庆．一指禅手法治疗痛经 30 例．浙江中医杂志，2002；（9）：379

经穴按摩并封闭治疗痛经

【穴位选择】 百会、肩井、合谷、足三里、三阴交（双侧）。

【随症加减】 气血两虚者配关元，气滞血瘀者配太冲、血海。

【操作方法】 用揉、按、点、摩手法施术于上述穴位，虚证用补法，实证用泻法，每穴操作 5～7min。按摩完毕后皮肤常规消毒，用 2ml 注射器和 6 号针头吸取当归注射液 2ml 刺入双侧足三里穴 1.5～2cm，患者产生针感，抽吸无回血后缓慢注入药液，每穴 1ml。每次月经来潮前 10～12d 开始治疗，隔日 1 次，5 次为 1 疗程。3 个疗程后评定疗效。

【功效主治】 通气活血，调经止痛。

【经验心得】 中医学认为本病是由于各种原因导致经络气血不通，“不通则痛”。临床治疗的关键是使其“通则不痛”。百会为“诸阳之会”，肩井是手足少阳、阳维交会穴，三阴交为足三阴经的交会穴，手法刺激此 3 穴可宣通全身经络气血，再辅以合谷、足三里等穴，疗效更佳。中药当归既能补血活血，又善止痛，为妇科调经之要药，穴位封闭更能发挥其作用。经穴按摩和封闭相结合止痛效果明显，且妇女易接受。

治验：孙某，29 岁。主诉：月经有血块且多，小腹胀痛 3 年，痛引腰骶，同时伴有头晕目眩、四肢乏力，影响正常生活和工作，经中西医多方求治无效，遂来寻求按摩、针灸治疗。脉弦，舌质暗。证属冲任气滞，胞宫瘀阻。治以通经行气，活血止痛。穴位按摩采用强刺激泻法，以达行气活血而止痛，再配合穴位封闭。1 个疗程后，诸症消失，随访 1 年未复发。



【方剂出处】朱宏锦,等.经穴按摩并封闭治疗痛经 40 例.四川中医, 2004; 22 (10): 94

推按第二掌骨侧下腹穴区治疗痛经

【穴位选择】下腹穴(据穴位全息律,第二掌骨远端起点头穴和近端起点足穴连线的中点是胃穴,胃穴与足穴连线分为 6 等份,从足穴起中间 5 个分点的第 2 个分点即是下腹穴)。

【操作方法】患者手如松握鸡卵状,肌肉自然放松,虎口朝上,示指尖与拇指尖相距约 3cm,按压第二掌骨侧下腹穴区,寻找压痛点,有胀痛感为得气。得气后用一指禅法,沿第二掌骨侧向足穴方向推,用力以患者能承受为宜,频率为 120 / min,每侧手推按 5min,双手交替,共 10min,每日 2 次。或腹痛发作时,随时推按至腹痛消失,每个月经周期推按自腹痛开始至腹痛消失后 1d,连续 3 个月经周期。

【功效主治】调经止痛。

【经验心得】全息生物学认为,第二掌骨节肢是整体的缩影或胚胎,包含着全部整体各部位的病理生理信息,所以将第二掌骨节这样的单位称之为全息胚。全息胚部位与整体的对应部位之间生物学特性相似程度较大。推按第二掌骨侧的下腹穴区,造成这一部位的损伤,通过神经将要修复损伤的信息传到神经中枢,并通过神经中枢的中介而传到全身,激发出能够修复损伤的泛作用,这种泛作用是修复损伤特定的生化物质组合,在修复推按部位损伤的同时,也修复了与之生物学特性相似程度较大的病灶子宫。人体第二掌骨裸露在袖口之外,取穴方便,推按下腹穴区治疗痛经见效快,有效率高,简单易学,经济实惠,经常推按,可增加远期疗效。

【方剂出处】李海燕.推按第二掌骨侧下腹穴区治疗痛经 100 例.辽宁中医杂志, 1999; 26 (1): 34



六、简方疗法

熨热方

组成：葱白 250g，麸皮 100g，食盐 100g，吴茱萸 75g。上药加适量白酒，入锅炒热，分装数袋，乘热同时熨敷脐下及两足心 30min。药袋冷则更换。每日 2 次。直至腹痛消失。

效用：温经、散寒、止痛。用于痛经。

芎归散

组成：川芎、当归各等量。以上 2 味共研细末，每取 10g 炒热，趁热熨脐部。

效用：活血调经止痛。用于痛经。

乳没散

组成：乳香、没药各 15g。将上药混合研为细末，备用。于月经前取药 5g，调黄酒制成饼如五分硬币大稍厚，贴在患者脐孔上，外用胶布固定，每天换药 1 次。

效用：理气活血止痛。用于治妇女痛经，经前、经后或来潮时腹痛均可。

按摩方

操作：在气海、关元穴各加麝香风湿油 2~3 滴，然后按摩 3~5min，患者感到小腹发热且内传，腹痛即止。

效用：通经活血，镇痛。用于经行腹痛。

梅花针方

部位：取腰、骶部及下腹部，带脉区，亦可取小腿内侧。重点叩打腰、骶部，腹股沟，关元、气海、期门、三阴交。中度或



重度刺激，于每次月经来潮前1周左右开始治疗。每日治疗1次，7次为1疗程。

效用：用于痛经。

灯火灸方

操作：中极、归来、承山、气海、次髎。采用明灯火爆灸法，每日施灸1次，每穴灸1壮，直至疼痛消失。

效用：通调冲任，疏肝理气，行瘀止痛。用于实证痛经。

推拿点穴方

操作：主穴：地机、梁丘、中都、水泉、血海。配穴：肾俞、次髎、关元、气海、三阴交、足三里。以足三阴经与冲任督带脉入手，以泻和用点、揉、擦、抖、拿等，每次在行经前3d始连续推拿5次，3个月共治疗15次。

效用：用于痛经。

二草调经方

组成：益母草 60g，夏枯草 30g。以上2味共捣烂炒热，趁热贴敷于神阙穴、关元穴。

效用：活血调经，清肝解郁。用于肝郁血热、瘀阻冲任所致之痛经。

青盐热熨法

组成：青盐 150g。将盐炒热，用布包好温熨小腹，待不烫皮肤时，包扎于小腹上。

效用：温经、散寒、止痛。用于痛经。

香桂敷贴法

组成：丁香、肉桂、延胡索、木香各等份。上药共研末，



过 100 目筛，和匀，瓶贮备用。月经将行或疼痛发作时，用药末 2g 置胶布上，外贴关元穴，若疼痛不止，加贴双侧三阴交，隔日换药。

效用：温经散寒，行气活血，止痛。用于寒气凝滞、气滞血瘀所致之痛经者。

第2章 闭经

第1节 概述

闭经是妇产科临床的一种常见症状，表现为无月经或月经停止。习惯上将闭经按出现的时间分为原发性闭经与继发性闭经。原发性闭经是指女性年满16岁，虽有第二性征，而月经未来潮，或年满14岁未出现第二性征也无月经。继发性闭经是指按原有月经周期计算停经3个周期以上或正常月经建立后月经停止6个月。青春前期、妊娠期、哺乳期、绝经过渡期及绝经后期出现的月经不来潮均不属于病理性闭经。

一、病因病机

（一）中医认识

中医学认为，闭经的病因可根据虚实而分为两大类，虚者多为精、气、血的不足，实者多为气郁、血瘀、痰阻、湿滞、寒凝等。其发病机制，虚者是因精血不足，血海空虚，无血可下；实者是因脉道阻塞，气血不通，经血不得下行。

1. 肾精不足 禀赋不足，肾气未盛，精气未充，精不生血，冲任失于充养，血海不得盈满，经血不能应期而潮，这是先天之



因。后天则因于早婚早育，多产堕胎，房事不节，或久病不愈，连累及肾，肾不生精，则源断流枯，胞宫无血可下而致经闭。故《医学正传》说：“月经全借肾水施化，肾水既乏，则经血日以干涸。”

2. 气血亏虚 气血生化不足、流失有余也是闭经的重要成因因素。素体脾虚、化源不足，或忧思过度、伤及心脾，或数度失血，或大病久病，或虫积耗血，阴血不足在于先，经闭不行随其后。故《兰室秘藏·妇人门》说：“妇人脾胃久虚，或形羸气血俱衰，而致经水断绝不行。”

3. 气滞血瘀 忧郁恼怒，情志不畅，肝失条达，不能疏泄，则气滞不行，血因成瘀，瘀阻冲任，胞脉壅塞，经水阻隔，不得下行，致成闭经。故《万氏女科·经闭不行》说：“忧愁思虑，恼怒怨恨，气郁血滞而经不行。”

4. 痰湿阻滞 多见于丰腴之体。肥胖之人，阳气内虚，运化失常，痰湿内停，下注冲任，胞脉壅塞，闭而不行，亦成闭经。故《女科切要》说：“肥白妇人，经闭而不通者，必是湿痰与脂膜壅塞之故也。”《女科经纶·月经门》也说：“经不行者，非无血也，为痰所碍而不行也。”

5. 寒凝经脉 肾阳素虚，寒从内生，或经期、产后感受寒邪，或饮食不慎，内伤生冷，寒滞血凝，阻于冲任，胞脉不利，经闭不行。

（二）西医认识

1. 子宫性闭经 原发性闭经多由先天性阴道或子宫内膜缺如，或子宫发育不良引起；继发性闭经多由过度的刮宫或严重的感染等造成内膜损伤或粘连，以及哺乳时间过长使子宫内膜萎缩等引起。

2. 卵巢性闭经 原发性闭经多由先天性卵巢缺如或性腺发育不良引起；继发闭经可因卵巢功能早衰、手术切除、放射治疗后以及卵巢男性化肿瘤等引起。卵巢发育不全或功能缺陷，使卵



巢分泌的激素水平低下或缺乏周期性变化而发生闭经。

3. 垂体性闭经 常见于席汉氏综合征和垂体肿瘤患者。前者多由于产后大出血伴休克、严重的产后感染或弥漫性血管内凝血，引起垂体前叶缺血坏死，造成垂体功能不全，多种激素分泌减少而导致闭经；后者由于肿瘤生长于垂体，机械性压迫分泌细胞，使促性腺激素分泌减少而导致闭经。

4. 下丘脑性闭经

(1) 精神性闭经：精神紧张等刺激，使下丘脑分泌促肾上腺皮质激素释放因子亢进，引起下丘脑-垂体-卵巢功能失调，导致闭经，常见于年青妇女。

(2) 神经性厌食：患者为了苗条体型而强迫节食，引起下丘脑分泌异常，下丘脑促性腺激素释放激素浓度降至青春期前水平，致使性腺激素水平低下而发生闭经。

(3) 药物性闭经：长期应用抗精神病药物、避孕药物以及利血平、灭吐灵等，使下丘脑促性腺激素释放激素分泌不足，或卵泡刺激素、黄体生成素对下丘脑促性腺激素释放激素反应迟钝而引起闭经。

(4) 其他内分泌腺异常闭经：肾上腺、甲状腺及胰腺等功能紊乱时也可影响月经，如肾上腺皮质功能亢进或减退、甲状腺功能亢进或减退以及糖尿病等，都能通过丘脑下部影响垂体功能而引起闭经。

二、临床表现

闭经的临床表现除月经停止以外，常因病因不同而有不同的临床表现，如先天性卵巢缺如或性腺发育不良所致的闭经，患者身材矮小、蹼颈、肘关节外翻、智力低下、后发际低及第二性征不发育；多囊卵巢引起的闭经，表现为不孕、多毛、肥胖；产后大出血引起的垂体性闭经（席汉综合征）可见无乳、性欲减退、毛发脱落、第二性征衰退、性器官萎缩、消瘦、消化不良、畏寒、



乏力、基础代谢率低；甲状腺功能亢进所致的闭经，可见心悸、多汗、畏热、性情急躁、食欲亢进、体重下降、乏力、颈部变粗、眼球突出等。

三、诊断与鉴别诊断

（一）诊断

询问病史要区分原发性闭经与继发性闭经。对原发性闭经患者，应详细询问其家族史，生长发育史及年幼时是否患过结核等严重影响其发育的疾病。对继发性闭经者应了解初潮年龄、闭经期限、闭经前有无诱因、诊治情况，是否服过避孕药，曾否用过内分泌治疗及对各种治疗的反应，生育、生活和工作情况等。

体格检查：包括全身检查、妇科检查等，以排除全身性疾病、生殖道器质性病变如处女膜闭锁、阴道畸形等。

根据病史、症状体征和以下辅助检查结果，可对闭经作出诊断。

1. 子宫性闭经

（1）基础体温呈双相型，连续阴道涂片或宫颈黏液检查结果均表示有排卵。

（2）人工周期1周内无撤药性出血。

（3）行诊断性刮宫时取不出子宫内膜或发现宫腔有粘连。

2. 卵巢性闭经

（1）基础体温呈单相型，阴道涂片或宫颈黏液提示无排卵及雌激素水平低落。

（2）人工周期后有撤药性出血。

（3）尿、血清促卵泡生成素（FSH）水平升高，及黄体生成素（LH）水平也高于正常。

（4）血清雌二醇降低。

3. 垂体性闭经

（1）基础体温呈单相型，阴道涂片及宫颈黏液提示雌激素水



平降低。

(2) 血清雌二醇降低。

(3) 人工周期后有撤药性出血。

(4) 血、尿的 FSH 及 LH 水平低下，肌注黄体生成素释放激素后仍低下。

(5) 蝶鞍摄片或 CT 检查能发现较大垂体肿瘤。

4. 丘脑下部性闭经

(1) 血、尿的 FSH 及 LH 水平低下，在肌注黄体生成素释放激素后能升高。

(2) 阴道涂片、宫颈黏液检查提示雌激素水平低落。

(3) 血清雌二醇降低。

(4) 人工周期后有撤退性出血。

(二) 鉴别诊断

病理性闭经需与生理性闭经作鉴别：

1. 早孕 往往是突然停经，或伴有晨起呕恶、嗜睡、倦怠、厌食、择食等早孕反应，子宫体增大与停经月份相符合，尿妊娠试验阳性，超声检查可见孕囊或胎心搏动。

2. 哺乳期闭经 产后哺乳，月经不来潮，尿妊娠试验阴性，子宫大小正常。

3. 更年期闭经 进入更年期，月经先紊乱，渐至月经停闭，尿妊娠试验阴性，可伴有更年期综合征。

第2节 辨证论治

一、名家医案、医论

李志明

王某某，女，31岁，于1965年8月3日初诊。自诉：3个月



未来月经，经常腰痛，腰痛最近加重，伴腰胀，饮食不好，大便稀，每日2~3次，晨起如厕，睡眠佳。既往月经正常。于18岁月经初潮，量中等，无痛经史，已婚。查：发育及营养中等，舌苔白薄，脉象沉细而弱，子宫发育正常，妊娠试验阴性，心肺正常，肝脾未触及，弯腰活动受限，腰部无压痛点，血压13.3/8kPa。诊为闭经，证属阴血不足型。治以健脾养心，通经活血。针刺中脘、天枢、合谷、三阴交、气海，用热补手法，热胀感传到阴部，加灸2壮。第二诊，饮食增加，有恶心，吐酸水，腰仍痛，月经未来，苔、脉同上，取穴同上，加刺肝俞、脾俞、肾俞后月经未来；经第3次针灸后，月经来潮，量正常，无痛经。

《现代针灸医案选》

张善忱

耿某，女，20岁。自诉：平素身体尚健，15岁月经初潮后，月经多后延至45d左右，每次行经时多腹痛，腹胀，全身乏力，或感少腹胀痛，经量尚可，经色暗红有块，每次经期腹痛多服止痛药控制，否则不能坚持工作，但有时镇痛效果亦不甚显著，至今月经已76d未来，并伴有心烦易怒，食欲不振，周身不适。查：脉沉弦，舌质暗红。诊为气滞血瘀，乃致经水不得应时而至，证属经迟，然时已久，近属经闭。治以行气活血通经为主，乃取合谷、三阴交、曲泉、地机，均取双侧穴位，每日1针。首次施针，合谷先针右侧，后针左侧，针下得气后，左右两穴之针感均令循经向肘部传导之后始将针起出；三阴交针下得气后均令针感逆经而行即针感向趾端方向传导，此后随即起针；再刺曲泉、地机二穴。次日，第3天针刺同前法，顺序、针感方向均与首次相同。第4天上午，患者告之，月经已来潮，无不适感，惟血量比以往稍多。

按：此例经闭，乃由气滞血瘀壅塞胞脉，致使月经不潮，治疗以行气活血以通经闭，今取合谷意在清热调气，三阴交以滋阴



养肝，疏通肝、脾、肾三脏之瘀滞，能起行气血，通胞宫，尤加曲泉疏泄肝气，地机行血去瘀，气行瘀去则经通月水自行。

《现代针灸医案选》

朱汝功

陈某，女，21岁，初诊，1965年11月10日。停经5个月。患者于65年6月因劳动汗出口渴，多饮冷水，适值经期，以后即月经闭阻，8月份曾到卫生院治疗。注射黄体酮后月经虽来，但量极少。停用黄体酮，月经即未潮，要求针灸治疗。诊得精神抑郁，面色萎黄，少腹胀痛，胃纳不香，大便溏薄，舌苔薄白根腻，脉来沉紧。证系临经饮冷，寒入胞宫，冲任失调，脾阳受损而致，拟健脾益气，调经通络为治。处方①取穴：三阴交（双）、足三里（双）、血海（双）、归来（双）、气海、关元。②手法：平针法，得气后留针15min。二诊，11月16日。针治以来，胃纳较增，大便正常，少腹胀痛减轻，似有来经之意，守上方投治。处方①取穴：三阴交（双）、足三里（双）、血海（双）、关元、气海、归来（双）。②手法：同前。四诊：11月18日。昨天月经已行，少腹胀痛好转，患者精神愉快，嘱其下月至期未潮，再来针治。处方①取穴：三阴交（双）、足三里（双）。②手法：同前。3月后偶遇病者，询知月经已正期来潮。

按：因适值经期，多饮冷水后月经闭阻，为寒滞经脉，但从辨证来看患者精神抑郁，面色萎黄，少腹胀痛，胃纳不香，大便溏薄，舌苔薄白根腻，这些症状是脾虚的表现，所以本病例为虚实夹杂。虚为脾虚，实为寒滞经脉。治疗时采用通补结合的方法。取足三阴经之会三阴交，足阳明之合穴足三里以健脾益气；血海为足太阴脉气所发，意在引血归海（冲脉）；取归来以行气通经；关元为三阴经与任脉的交会穴，配合气海以益气调经，通补结合，经治月经来潮。

《陆瘦燕朱汝功针灸学术经验选》



郑魁山

解某，女，25岁，未婚。因6个月未来月经，1961年3月9日初诊。患者15岁月经初潮，一向规律，28d 1次，每次持续5d，量中等，色红有块，1959年冬开始不规则，20~45d 1次，量少，超前或错后不定。1960年8月30日末次月经后，即未回潮，至今已6个多月，最近1个月来头晕、腰酸、疲倦无力，胸闷气短，有少量白带。一般检查：苔薄白，脉沉细涩，体温36~36.5℃，营养中等，体重43.5kg，血压18.7/15.7kPa，其他未见异常。妇科检查：宫体后倾偏左，激素中度低落，其他正常。化验：白细胞 $8 \times 10^9/L$ ，中性70%，淋巴29%，单核1%，红细胞 $4.35 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白12.5g/dl。中医辨证系饮食失调，损及脾胃，冲任失养，无血以行；采用健脾益胃、培补冲任之法治之。取气海、关元、气穴、三阴交、关元俞，用热补法，留针20min，每日针治1次，针治4次，患者感肠鸣腰酸、白带增多，又按上穴针治1次，月经于4月14日即回潮，因只来2d而量少，又按上穴继续针治5次，至4月23日，月经回潮即持续了5d，并且血量和颜色正常，舌苔薄白，脉缓稍细，因症状均已消失而停诊观察，经5~11月份复查、随访，月经正常，未发现症状。

朱某，女，25岁，未婚。因7个月未来月经，1961年3月9日初诊。患者12岁来月经，有时冬季不来，无其它症状。于1960年8月月经来潮后，至今已7个月，始终未回潮，9月份出现全身酸困，近2个月来经常出汗，每夜盗汗，全身疲乏无力。检查：两颧红，发育良，营养中等，舌净无苔，舌尖稍红，唇干，爪甲枯，脉沉细无力，两侧地机和三阴交穴处有明显压痛，其他未见异常。妇科检查：子宫发育不良，后倾，其他正常。中医辨证系先天不足，饮食失调，脾肾两虚，血海空虚。采用健脾补肾、培源养血之法治之。取中脘、天枢、关元、三阴交、肾俞，用热补法，每日1次，针治4次，盗汗、疲乏等症减轻，即改用肾俞、



关元俞、气海、关元、三阴交，治疗到12次，出现了烦躁腹痛，治疗到4月15日，针达14次时，月经回潮而停诊。经过5月复查和11月随访月经基本正常。

按：本病多因气血瘀滞，或血源枯竭所致。临床可分为虚、实两类，虚证又有脾胃虚弱和肝肾不足之别，实证主要为肝郁气滞。取穴以关元、气穴、三阴交为主，脾胃虚弱者加配中脘、天枢、章门用热补法以健脾养血，肝肾不足者配肝俞、肾俞、关元俞、膀胱俞、气海用热补法以补益肝肾。肝郁气滞者配肝俞、膈俞用平补平泻法以理气活血。郑氏运用本方法治疗闭经一般3~8次月经来潮。在治疗期间发现多数闭经患者三阴交、膀胱俞、气海、地机等穴处出现压痛点，常随月经的来潮而消失。所治病例辨证为脾肾两虚，血海空虚型闭经。采用健脾补肾、培源养血之法，取中脘、天枢、关元、三阴交、肾俞、关元俞、气海等穴用热补法治愈。

《郑氏针灸全集》

钟梅泉

周某，22岁，未婚，1961年9月13日初诊，患者5个月前正当月经来潮时，参加翻地劳动，随后月经一直未来。近月来自感腰酸痛、少腹隐痛不适，神倦乏力，心烦性急。胃纳尚可，大便干，小便如常。14岁初潮，周期30~35/3~5d干净，量中等。脸色苍白欠华。检查脊柱两侧，胸椎_{5~10}两侧可摸到条索及压痛，腰、骶部有泡状软性物。脉细稍弦，舌苔薄。证属寒凝胞宫，阻滞冲任。拟以温经散寒，调理冲任，化瘀通经为治。根据病证，选取胸椎_{5~12}两侧、腰、骶部、下腹部、带脉区、中脘、期门、阳性物处进治。采用梅花针治疗2次后，腰痛、少腹痛均减轻，白带增多，治疗6次后，月经来潮，量中等，色稍暗。随后改为脊柱两侧，重点叩打腰、骶部、下腹部、带脉区、大椎、足三里调治，继续巩固治疗1个疗程（15次），精神好转，其他无不适。



感而停诊。随访观察 3 个月经周期，每次均按期来潮，色量正常，疗效巩固。

按：梅花针是古代“毛刺”“扬刺”和“半刺”的发展，从梅花针的检查诊断和叩打部位上来看与经络皮部密切相关，治疗妇科疾病取腰部、骶部、尾部、腹股沟、下腹部、髂嵴部、带脉区、阳性物处。重点叩打腰部、骶部、下腹部、带脉区、阳性物。主要在膀胱经、任脉、肾经、脾经、带脉等经脉皮部分三个层次寻找与治疗妇科病症密切相关阳性物，包括结节物、条索状物、泡状软性物和障碍阻力。先轻推，寻找浅层阳性物，再加力推动，寻找较深层阳性物，最后用力重推，寻找深部阳性物。一般泌尿生殖系疾病在腰椎和骶椎_{3~4}两侧的阳性物和阳性反应最为多见和明显，尾椎两侧、腹股沟处也可触摸到阳性物或阳性反应。所治闭经病例为寒滞胞宫，充任失调型。治疗原则是以温经散寒，调理冲任，化瘀通经。钟氏采用梅花针治疗，选取胸椎_{5~12}两侧、腰骶部、下腹部、带脉区，中脘，期门，阳性物处进行治疗。采用中脘、期门健运中焦，补益气血，以达到攻补结合的目的，疾病痊愈。

《中国梅花针》

二、针灸疗法

针灸治疗闭经

【穴位选择】中极、十七椎下、公孙、次髎。加减：1 型：冲、任、督三脉不足，气血虚亏，脉络失养加关元、气穴、百会、命门、肝俞、志室、育俞、复溜、气门穴；2 型：素体虚亏，邪侵冲任，气血瘀阻，脉络失宣加中脘、大赫、子宫、腰俞、肝俞、脾俞、蠡沟、三阴交。

【治疗方法】每次选取 6~8 穴，辨证应用捻转、提插、疾徐补泻法，骶部次髎穴得气后行雀啄法。1 型腰部关元、气穴进



针得气后缓慢由浅入深，行针 1~3d，待有温热感，或加用温灸 1~3 壮；2 型背部腧穴浅刺捻转补法。隔日治疗 1 次，3 个月为 1 个疗程，月经来潮时停止治疗，待经净后继续针刺。一般治疗 1 个疗程，个别病例治疗 1 个疗程以上。

【功效主治】 补益脾肾，通调气血，活血化瘀。

【经验心得】 运用奇经辨证，处方配穴，选择恰当的针刺手法，是治疗本病取得良好效果的重要环节。清·叶天士医案谓：“奇经为病，通因一法为古圣贤之定律。”说明了通法之重要性，后世医家循此法则者众多。病必辨虚实，本文辨证分型中见素体虚亏，邪侵冲任致气血瘀阻，脉络失宣的 2 型为多，临床可见虚实夹杂证候，其本为虚，然虚中挟实。针刺时宜以补法为主，通法佐以，如背部督脉及相关腧穴均浅刺，捻转补法，骶部次髎穴则在得气后用雀啄法，待其酸麻感得以扩散，其余诸穴，用捻转、提插、疾徐泻法。如此通补并用的手法使之补益脾肾，通调气血，活血化瘀，则冲任脉通，经血可自调也。

【方剂出处】 浦蕴星. 针灸治疗闭经疗效分析. 上海针灸杂志, 1994; 13 (6): 257

针刺三阴交治疗闭经

【穴位选择】 三阴交。加减：虚证配以关元、气海、足三里等穴；实证配以丰隆、太冲、血海等穴。

【操作方法】 每日 1 次，10d 为 1 疗程。虚证针用平补平泻；实证针用泻法。

【功效主治】 活血调经，祛痰除湿。

【经验心得】 闭经是指女子超过 18 周岁而尚未来潮，或已形成月经周期复停止 3 个月以上（妊娠和哺乳期除外）。闭经最早记载于内经，称为“女子不月”《景岳全书·妇人规》以“血枯、血隔”分为虚、实两证，实证多因邪气阻隔，脉道不通，经血不得下行；虚证多由气血虚弱，肝肾不足，阴虚血燥而致。气



为阳，血为阴，三阴交为足三阴之交会穴，可调血，行血。实证配以血海、丰隆可起活血调经，祛痰除湿之功；虚证配以任脉、背俞穴、足三里以调理脾胃，补益肝肾。

治验：顾某，女，32岁，生1子，形体肥胖。每次月经周期间隔3个月以上，小腹作胀，大便燥结，口干，B超提示子宫附件均未见异常，遂来诊治，予以三阴交加血海、丰隆穴，针用泻法，7d后即出现月经，在下次正常月经周期前10d坚持治疗，连续3个月，至今月经周期正常。

【方剂出处】 陆萍. 针刺三阴交为主治疗闭经 32 例. 针灸临床杂志, 2000; 16 (6): 44

针刺艾灸治疗继发性闭经

【穴位选择】 归来，关元，三阴交（双），血海（双）。加减：肾虚型加太溪；气滞血瘀型加太冲、气海；气血亏虚型加足三里。寒凝血瘀型重用艾条。以上除气海、关元，其余穴位均取双侧。

【操作方法】 首先针刺上述穴位 20min。关元、血海、足三里、太溪用补法，气海，三阴交平补平泻，太冲用泻法。然后温针灸关元，气海，足三里，太溪 10min。寒凝血瘀型嘱患者回家悬灸 30~60min，每日 1 次，10 次 1 疗程，共针治 3 个疗程统计结果。为巩固疗效，下次月经来潮前 1 周，再以上法针灸 5~7 次巩固疗效。

【功效主治】 补肾益气，活血化瘀，温经散寒。

【经验心得】 针刺采用局部近取加循经远取的针灸方法，各型病例均于针刺后采用温针灸。艾灸不仅能温经散寒，活血化瘀，还有回阳补虚的功效。人工流产直接损伤胞宫，所以针刺后结合温针灸或艾灸。妇女以血为本，取血海为主穴能补血调经。归来穴为卵巢分泌功能，气海为任脉之穴，系任脉之气所发，有强壮作用。能补肾培元，益气和血，固冲任。关元为足三阴经与任



脉交会穴，刺灸，可使肝、脾、肾及任脉气血调和。闭经与肝、脾、肾功能失常较密切，而三阴交为三经交会穴，能调理诸脏腑，疏通三经之气血，配太冲穴疏肝，太溪补肾，足三里能健脾和胃诸穴合用，可使化源足，肾气充沛，血海满盈经水自通。

【方剂出处】 娄玉方. 针刺结合艾灸治疗人工流产后继发性闭经 30 例. 针灸临床杂志, 1999; 15 (9): 17

针灸配合中药治疗闭经

【穴位选择】 风池、关元、归来、合谷、血海、足三里、三阴交、太冲。加减：肝肾不足加肝俞、肾俞；气血虚弱加脾俞、气海俞；肝郁气滞血瘀加阳陵泉、地机；寒湿凝滞加中脘、阴陵泉、丰隆等。

【药物组成】 柴胡、黄芩、桂枝、当归、白芍、地黄、枸杞、黄芪、杜仲、白术、茯苓、甘草。肝肾不足者加肉桂、牛膝、山药；气血虚弱者加山药、莲肉、鸡血藤；肝郁气滞血瘀加川芎、桃仁、红花；寒湿凝滞加吴茱萸、丹参、半夏。

【操作方法】 患者取仰卧位，选取主穴 5~7 个及配穴 1~2 个，常规消毒，然后选用 1.5 寸毫针，以双手进针法刺入皮肤，然后调整进针深度。其中刺风池时，针尖向风府方向横向刺入 1.2 寸左右，关元、归来、足三里直刺 1.2~1.5 寸，合谷、血海、三阴交、太冲直刺 1 寸左右。得气后，行平补平泻手法并留针 45~60min，且可间歇运针，还可根据患者病情，在足三里加温针灸 2~3 壮。每周治疗 3 次，12 次为 1 疗程，疗程间隔 1 周。配合中药治疗，每日 1 剂，水煎服，连服 5d，休息 2d，共服 20 剂为 1 疗程。疗程间隔 1 周。

【功效主治】 疏肝理气，活血化瘀。

【经验心得】 闭经属内分泌系统疾病，发病原因复杂，常与全身性疾病、精神等方面因素有关。中医认为，该病与肾虚、脾虚、血虚、气滞、寒凝、血瘀、痰湿等有关。但作者认为：本病



主要与肝有关，治疗以疏肝理气为主，辅以活血化瘀。针灸取穴中，风池疏肝理气，配合谷与太冲“开四关”，对精神活动的调节效果甚佳；关元益肾气、利下焦，配归来与血海活血化瘀；足三里扶正培元，配合三阴交疏下焦、调血室。中药逍遥散合四物汤疏肝健脾，活血调经。处方中，柴胡、黄芩疏肝清热；当归、白芍养血柔肝，配地黄等活血化瘀；枸杞滋补肝肾；杜仲补肾；桂枝通阳；黄芪益气，配合白术、茯苓、甘草健脾，以资生气血。诸药合用，使肝气得舒，气血得行，新血得生。针药结合，疏肝活血，故使经水能按时而下。

治验：钱某，女，46岁。患者既往月经基本正常。约7个月前，因工作问题与人发生口角，郁闷不乐，随后月经未能再行。曾服中西药物，未能奏效。刻下胸闷胁胀，小腹胀满，时有疼痛，纳呆，眠差，便秘，舌质紫暗，脉沉细弦。证属肝郁气滞，血瘀经闭。治宜疏肝理气，活血通经。采用针药结合的方法，先予针灸治疗，取风池、归来、合谷、血海、足三里、三阴交、阳陵泉、太冲等穴，以前述方法进行针刺。其中足三里穴施温针灸3壮。留针50min后出针。并辅予中药，处方：柴胡10g，黄芩15g，桂枝9g，当归15g，白芍30g，生地15g，枸杞15g，黄芪15g，白术10g，茯苓12g，甘草5g，川芎10g，桃仁9g，红花9g，陈皮9g。每日1剂，水煎服。每周针治3次，服药5剂。治疗6次后，月经来潮，遂暂停治疗1周。经净后改为每周针灸1次，服汤药2剂（每剂服2d），连治3周，月经复至，停止治疗后，月经仍如期而至，临床治愈。8个月后随访，月经已如病前，恢复正常。

【方剂出处】管建红，等．针灸配合中药治疗继发性闭经35例．江苏中医，2000；21（5）：31

中药配合耳穴电针治疗肾虚闭经

【穴位选择】耳穴：卵巢、子宫、内分泌、肝穴、肾穴、生



殖器、神门。

【药物组成】 熟地黄 15g，川芎、白芍、车前子、牛膝、五味子、仙茅各 9g，当归、淫羊藿、枸杞子、覆盆子、菟丝子各 15g。

【操作方法】 用 30 号 1 寸毫针刺入上穴，得气后接通电针仪，留针 30~60min，用疏密波，强弱适度，每日 1 次，两耳交替进行，10d 为 1 个疗程。配合中药，每日 1 剂，水煎，早、晚分服。

【功效主治】 益气养血，补肾填精。

【经验心得】 闭经一证虚实兼有，但临床中以虚证为多。气血不足，肾气不充，冲任脉不通盛，导致血海空虚，无源可下。作者借用刘奉五《四二五合方》，拟成基本方，随证加减施治。方中四物汤有养血调血之功；二仙汤益肾助阳，使阳生而阴长；五子衍宗丸滋阴益肾，平补肾中之阴阳，使阳盛精足，经水有源；牛膝补肾通经。诸药合用，冲任通调，血海按时满盈，月经自调。现代医学认为：功能性闭经为下丘脑-垂体-卵巢-子宫轴功能失调的表现，耳针可对上述生理机能起调整作用，从而诱导黄体生成激素高峰出现，促进卵巢功能，以达到内分泌与代谢的相对平衡。

治验：郭某，女，29 岁。患者于 1981 年足月顺产一男婴，产后第 9 天因胎盘残留大出血致休克，此后闭经 14 个月。曾用西药人工周期治疗 3 个月，仅周期性见内裤上少许暗黑色血迹，尔后闭经 3 年，诊断为“席汉综合征”。刻诊：精神倦怠，肢软乏力，腰酸疼痛，性欲减退，毛发及腋毛轻度脱落，怕冷，脉沉细，舌质淡，舌尖有瘀点，着薄边有齿印。妇科检查：外阴已产型，阴毛稀疏，阴道通畅光滑有少许乳白色黏液，宫颈：质中光滑。宫体前屈质中略小于正常。双侧附件未见异常。证属气血两虚，肾气亏损。治则：益气养血，补肾填精。药用基本方化裁：当归、党参各 15g，川芎、白芍、牛膝、覆盆子、车前子、菟丝



子、仙茅、淫羊藿、五味子各 9g，熟地黄、黄芪各 18g，枸杞子 12g，肉桂 6g。配以电针耳穴卵巢、子宫、内分泌、肾、肝、神门、生殖器等，每日 1 次，共治疗 75d，月经来潮，随后月经按期而至。

【方剂出处】 宫建英. 中药配合耳穴电针治疗肾虚闭经 21 例. 湖北中医杂志, 1997; 19 (2): 46

针灸按摩治疗继发性闭经

【穴位选择】 肾俞、阴交、三阴交。加减：虚闭加关元，足三里；实闭加中极、地机、血海；腰腹痛加肾俞或少腹部拔火罐。

【操作方法】 先行针刺治疗，针刺以迎随补泻法，虚闭用补法，实闭用泻法，每次留针 20min，然后行按摩治疗，手法以按、揉、点、疏、抖为主，让患者先取俯卧位，医者用两拇指按揉膈俞、肝俞、脾俞、肾俞及八髎穴 3~4min，再让患者仰卧，点按气海、关元穴，常规揉腹数遍后再将腹部肌肉抖动数次，最后按足三里、地机、三阴交穴，每次按摩时间 7~8min。治疗 7 次为 1 个疗程，每日 1 次。

【功效主治】 理气活血，调理冲任。

【经验心得】 针刺肾俞能益肾培元；阴交为冲、任和足少阴肾脉的交会穴，有调理冲任之功；三阴交能通调三阴以行血气。血虚加刺足三里、关元有益元健脾、补益气血之效；血滞加刺中极、地机、血海可以疏调下焦，行血祛滞止痛。并根据病情的虚实，分别予以迎随补泻手法。按摩背俞和腹部穴位，有理气和血，温暖胞宫。

【方剂出处】 田文华, 等. 针灸按摩治疗继发性闭经 16 例. 山东医药, 2002; 42 (33): 90

针刺治疗肥胖妇女闭经

【穴位选择】 脐周八穴和肾俞、关元俞、气海俞等 2 组穴位



交替使用。加減：足三里、三陰交、血海、丰隆。

【操作方法】用 1.5~3 寸毫针快速刺入，根据患者的虚实情况，施以提插捻转补泻手法，偏于肾虚冲任不足者用补法，偏于痰湿内盛者用泻法。留针 40min，隔日 1 次，15 次为 1 疗程。一般治疗 2~3 疗程。

【功效主治】祛湿化痰，疏通经络。

【经验心得】中医学认为闭经的形成与肾气、天癸、冲任的盛衰及胞宫的营养发育情况直接相关，并与脏腑功能的失调有密切关系。肥胖多因脏腑功能失调而使水谷精微聚而成痰、浊、脂，故有“肥人多痰湿”之说。现代医学认为功能性闭经是由于下丘脑-垂体-卵巢轴系统功能失调所致。肥胖妇女闭经，是由于素体湿盛，痰湿阻于胞络，或经期受寒，胞络瘀阻，或过食肥甘厚腻之品，痰湿不化，冲任受阻，经隧不通，以致经血不得下行而闭塞不通。正如古人所云：“肥人闭经，必是痰湿与脂膜壅塞之故”，朱丹溪云：“经不行者，非无血化，为痰碍而不化也。”可见女性肥胖与闭经关系密切，治宜祛湿化痰、疏通经络，即化湿调冲法。脐周八穴可调补冲任、理气和血、通调二焦，为减肥调经之要穴；肾俞、气海俞、关元俞可补肾气；足三里、三阴交可健脾胃；丰隆、血海可化湿祛痰，活血通经。诸穴合用，可使肾充脾运，痰湿得化，经水自行。实验研究证实，针灸对下丘脑-垂体-卵巢轴系统的功能有良好的调整作用，为针刺治疗单纯性肥胖而致闭经提供了科学依据。

【方剂出处】王玲，等．针刺治疗肥胖妇女闭经 31 例疗效观察．新中医，2001；33（6）：44

耳贴治疗功能性闭经

【穴位选择】主穴：子宫、卵巢、内分泌、垂体前叶、下丘脑；配穴：肾、肝、皮质下、交感。

【操作方法】每次取 5~6 个穴，双耳同时贴或一侧耳轮流



交换贴均可。贴法：治疗时先用耳穴探测仪或用圆珠笔尖按压找出敏感点，然后用备好的王不留行胶布对准敏感点贴于耳穴，患者每日自行按压耳穴 3~5 次，每次时限 3min 左右，自觉耳部有重胀，烧灼温热感，隔 3d 换 1 次，5 次为 1 个疗程，根据病情再决定下一疗程。有的痛经、闭经 2~3 次即可奏效。对于习惯性痛经可嘱患者每次月经来潮前 3d 来贴耳穴。

【功效主治】 调经行气，活血化瘀。

【经验心得】 《灵枢·口问第二十八》“耳为宗脉之所聚”。足少阴、足阳明、足厥阴经均经下腹入盆腔，有的直接与生殖器相连，又合于耳中，故月经不调时，刺激耳穴，可调和气血。现代医学则认为规律月经受神经系统、大脑皮质、内分泌等影响，与下丘脑、垂体前叶、卵巢密切相关，刺激耳穴可通过末梢神经传到大脑皮质相应区，从而调节垂体前叶及丘脑下部功能，使月经正常来潮。同时垂体内储有内啡肽，内啡肽又有很强镇痛作用，故痛经取垂体前叶可有镇痛作用。采用王不留行子，此药性味苦平，入肝、胃经，有行气通经，下乳消肿之力，专走血分，性善通利。

【方剂出处】 王遐云. 耳贴治疗痛经和功能性闭经的尝试. 甘肃中医, 1997; 10 (3): 33

三、简方疗法

方 1

晚蚕沙 30g，加酒，炒热，用布包裹，贴敷腹部。每日 1~2 次。直至来经。一般 3~4 次即可。

方 2

益母草 120g，晚蚕沙 30g。先将益母草加水煎煮，滤汁，倒入盆中，温洗少腹。然后将晚蚕沙入锅炒热，用布包裹，熨敷。



每日1次。连用3~4次即可来潮。

方3

益母草 120g，月季花 60g，加水煎煮，滤汁，倒入盆中，用两条毛巾浸于汁内，拧干后敷于少腹部。毛巾轮流使用。每日1次。1剂可用2次。一般3~4d即来潮。

方4

香附 2g，桃仁 1g，水蛭 1条，共捣糊，敷脐，外贴伤湿膏固定。每3d更换1次。直至经来。

方5

益母草 30g，柴胡 15g，当归 20g，川芎 15g，红花 20g，丹参 25g。益母草加水煎煮，滤汁。其他药共研粉，用药汁调成糊状。取5g捏成饼状，贴敷脐部，胶布固定。每3d更换1次。直至经行。

方6

患者取仰卧位。术者用右手拇指腹从石门至中极穴，自上到下推按5~10遍，用力由小到大，逐渐加力；再在石门、关元、中极穴各按、揉1min；然后掐压双侧合谷穴1min；再强力点按双侧三阴交穴3~5min。每日或隔日1次，10次为1个疗程。

第 3 章 功能性子宫出血

第1 节概述

功能失调性子宫出血简称功血，是指非器质性疾病（全身或局部）而出现的异常子宫出血。临床上以阴道不规则流血，甚至出现贫血为其特征。其基本病理生理改变是下丘脑-垂体-卵巢轴的神经内分泌调控异常，或卵巢局部调控机制异常或子宫内膜或肌层局部调控功能的异常。功血一般分为无排卵型和有排卵型两类。前者占 70%~80%，多见于青春期及绝经过渡期妇女；后者占 20~30%，多见于中年妇女。

本病属于中医崩漏范畴，即经血非其时暴下不止或淋漓不尽，前者称为崩中或经崩，后者称为漏下或经漏。由于两者出血情况虽不相同，但常交替出现，故合称崩漏。

一、病因病机

（一）中医认识

中医学认为，本病多因肾虚、脾虚、血热、血瘀所致，发病机理主要是冲任损伤，不能约制经血，胞宫藏泄失常，经血非时妄行。



1. 肾虚 先天禀赋不足，肾气稚弱，天癸未充，冲任未盛；年届七七，肾气渐虚，天癸欲绝；房劳产众多，或手术不当，损伤胞宫冲任以致肾虚。肾阳虚则封藏失职，冲任失固，不能约制经血，乃成崩漏；肾阴虚则虚火内动，迫血妄行，亦成崩漏。

2. 脾虚 忧思过度，饮食劳倦，损伤脾气，脾虚则统摄无权，冲任失固，不能约制经血，故成崩漏。

3. 血热 热盛则血妄行，但有虚热、实热之分：素体阴虚，相火偏旺，或久病、失血以致阴伤，水亏火旺，扰动血海，经血非时妄行，此为虚热之证。而素体阳盛，肝火内动，侵扰血海，迫经妄行，此为实热之证，正如《傅青主女科》说：“冲脉太热而血即沸，血崩之为病，正冲脉之太热也。”

4. 血瘀 内伤七情，气血不畅，冲任郁滞；经期、产后余血未尽，气血郁遏，瘀阻冲任，血不循经，发为崩漏。

崩漏为病，虽概括为虚、热、瘀等不同机制，但其发病常非单一原因，在发病过程中常是因果相干，气血同病，多脏受累，虚实相间，阴阳互转，其势反复。如阴虚阳搏成崩，病起于肾，而肾水阴虚不能济心涵木，以致“心火亢盛，肝肾之相火挟心火之势亦从而相煽”，导致“血脉泛溢，错经妄行”（《女科正宗·崩漏门》）成为心、肝、肾同病的崩漏。而无论何因所致的崩漏，由于失血耗气，均存在不同程度的统摄失司、冲任失养的病变，日久均可转化为气血俱虚或气阴两虚，或阴阳俱虚。故崩漏病本在肾，位在冲任，变化在气血，表现为阴道非时下血，或为崩，或为漏，或崩漏互见。

（二）西医认识

功能性子宫出血分为无排卵型功能失调性子宫出血和有排卵型功能失调性子宫出血。

1. 无排卵型功能失调性子宫出血

（1）青春期：青春期功血多由于下丘脑-垂体-卵巢轴发育成熟不全或延迟，在下丘脑垂体与卵巢之间尚未建立完善的正反馈



调节机制所致。精神紧张、恐惧、劳累、环境和气候的改变等是常见的青春期功血发病的重要诱因。

(2) 绝经过渡期：此类功血主要是由于卵巢功能自然衰退、卵泡数量减少且不能发育成熟，或下丘脑-垂体对性激素正反馈调节的反应性降低而引起。

(3) 育龄期：可因劳累、流产、手术、肥胖或多囊卵巢综合征、高催乳素血症等疾病的内外环境因素，导致短期排卵功能失常或停止。

无排卵型功血卵巢内虽有卵泡发育，但无优势卵泡形成，故卵泡不能成熟而周期性排卵。然而卵巢中处于不同发育阶段的卵泡仍在分泌雌激素，累积雌激素持续作用于子宫内膜，可使之增生过长，当体内雌激素水平有波动时，子宫内膜发生局部剥脱，因而发生出血。

2. 有排卵型功能失调性子宫出血 有排卵型功血的产生多与黄体生成素分泌不足或黄体生成素持续分泌有关。该型功血卵巢中卵泡周期性成熟而排卵，但排卵后形成的黄体缺乏足量的黄体生成素支持，故黄体发育不健全、过早萎缩，导致孕激素分泌量不足，使子宫内膜提前剥落；或黄体生成素持续分泌导致黄体萎缩不全，使激素量撤退不迅速，子宫内膜剥脱不完全、剥脱期延长，则修复亦延长。

二、临床表现

(一) 无排卵型功血

青春期功血表现为：初潮后最初2年内，月经周期紊乱，或流血时间过长，或子宫大量出血，出现贫血，妇科检查内外生殖器均属正常范围。更年期功血表现为：在停经数月甚至1年后又发生出血，量或多或少，持续时间长短不一，且无痛经。

(二) 有排卵型功血

黄体发育不健全功血表现为：月经周期缩短，少于21d，即



月经过频，但仍保持一定的规律性，或经前有点滴出血，或阴道排出血性分泌物，多数患者有不孕或早期流产史。黄体萎缩不全功血表现为：月经周期正常，经期延长持续不止，经血量不一，多数患者于流产或足月产后发病。

三、诊断与鉴别诊断

（一）诊断要点

询问病史，包括年龄、月经史、婚育史及避孕措施，全身有无慢性病史等，以排除非生殖道及生殖道其他部位的出血。

体格检查，包括全身检查、妇科检查等，以排除全身性疾病、生殖道器质性病变。

根据病史、症状体征和以下辅助检查结果，可对功能性子宫出血作出诊断。

1. 无排卵型功血 ①基础体温曲线呈单相型。②月经周期中阴道脱落细胞涂片检查，无正常周期性的变化。③月经前检查宫颈黏液仍呈现不同的羊齿状结晶，而缺少在黄体期应有的椭圆体。④经前或经行1周活检子宫内膜，呈增殖期或各种类型的增生，而无分泌期变化。⑤尿中孕二醇降低，雌激素可处于较高水平。

2. 有排卵型功血 ①基础体温曲线呈双相型，但高相期小于11d。②阴道脱落细胞涂片及宫颈黏液结晶，均有周期性变化。③子宫内膜活检显示分泌功能不足。

（二）鉴别诊断

功能性子宫出血需与下列疾病作鉴别：

1. 全身性疾病出血 包括血液病、肝脏疾病、高血压病、甲状腺病等均可引起阴道出血，需结合其他检查加以区别。

2. 妊娠并发症出血 引起阴道出血的常见妊娠并发症有流产、异位妊娠、葡萄胎等，可通过相关的妊娠检查予以排除。

3. 生殖器肿瘤出血 子宫肌瘤、宫内膜癌、绒癌、卵巢肿瘤等，可通过妇科检查、超声检查、病理学检查予以排除。



4. 生殖器炎症出血 严重的阴道炎、宫颈炎、子宫内膜炎等引起的阴道出血多无周期性，且多伴有炎症表现，如白带增多、白细胞总数增高等，容易区别。

5. 医源性出血 由于宫内放置避孕器具或使用性激素类避孕而引起的阴道出血，可通过询问病史而获知。

第2节 辨证论治

一、名家医案、医论

王松荣

翟某，女，38岁，1978年7月31日初诊。主诉：每值经期下血不止5年余。病史：患者5年前自产第2胎后，每值月经提前，时间持续20余天，前10d经过多，其势如崩，后10d经过减少，淋漓不尽，色紫或鲜红。先后经湖南医学院一附院、省妇幼保健院等确诊为功能性子宫出血。留住院及门诊服中西药物、刮宫、磁疗、针灸等方治疗未愈。此次经潮半月，服中西药物、针灸治疗血仍未止，且逐渐增多，色淡红，时有紫块，淋漓不断，少腹隐痛，喜按，腰痠，夜卧不安，气短懒言，胃纳差，大便初结后溏，小便多。检查：神疲倦怠，形体消瘦、面色晄白，舌质淡，舌根紫，苔薄白，右脉沉细，左脉小弦，诊断：崩漏（功能性子宫出血），气虚血瘀型。治疗：益气固摄，活血化瘀，取穴：1组百会、气海、三阴交。2组中极、太溪、行间。3组肾俞、阴陵泉。操作：以上3组穴，每日选1组穴，交替使用，10次为1个疗程。1个疗程结束后，休息5d再做下1疗程。行间穴采用泻法，其他穴均用提插与徐疾手法补之。百会、气海、中极加灸，气海、中极穴的针感要达到阴部。依上法经2个疗程后，自觉症状减轻，神疲腰酸，夜卧不安等症消失，经潮持续时间20d左右



减至 14d，但头几天仍暴下如注，后几天淋漓不净。脉细，左小弦，舌质淡红、苔薄白。按上法治疗 5 个疗程后，诸症状减轻，告知月经周期及出血量均正常，但尚感形寒乏力，诊其脉细，舌质淡红，苔薄白，仍按原方加膈俞，再针 1 疗程。嗣后几次好如常人。诸症尽愈，随访已月余情况良好。

按：崩漏在发病过程中，常互相转化，如崩血渐少，可能致漏，漏势发展，可能致崩。该例患者乃崩漏之证俱兼，其因系由素体脾虚，中气不足，统摄无权，冲任不固，气虚日久，渐至血运不畅，导致血瘀，故可见时崩、时漏，血下色淡有块。治宜益气固摄、活血化瘀为主。取百会以固下元，取气海、三阴交以健脾补气统摄血运。取肾俞、中极、太溪以培本固元，收摄经血，取行间以活血化瘀，约束经血妄行。诸穴合用，共收佳效。

《中国当代针灸名家医案》

叶心清

固摄冲任是治疗崩漏的首要大法，必用杜仲、天冬固冲任。然后应分清冲任失固的原因，一般有两种：一是气虚不摄所致，此时应补气摄血；二是肝肾不足所致，此时应滋阴清血。在止血药的选用中，善用肉桂炭、丹皮炭、荆芥炭、地榆炭以及花蕊石、梔子、茜草和三七粉等。如无炭品则可以用量增倍自炒成炭。另外需善后巩固以防复发，善后之治从脾、肾着手，上午服补中益气丸，下午服六味地黄丸。止崩漏配以针刺也有必要，取穴之道，也是以脾肾为主并调冲任带脉，常用足三里、三阴交、关元、肾俞、带脉等。

《中医临床家叶心清》

黎文献

张某，女，20 岁，未婚，1963 年 7 月 6 日初诊。主诉：月经持续量多 10d。病史：身体素虚，16 岁月经初潮后，每次持续



7~8d, 本次月经已持续 10d 不止, 并伴有四肢乏力, 气短, 心慌, 食欲不振, 头晕眼花等症状。检查: 面色苍白, 精神萎靡, 舌淡苔少, 脉细数。诊断: 崩漏 (功能性子宫出血), 脾气亏虚型。治疗: 健脾止血。取穴: 隐白 (双)。操作: 直接艾灸 7 壮, 灸 2 次而痊愈。

按: 崩漏是脾气亏虚, 清阳下陷, 统摄无权, 冲任不固所致。所治病例身体素虚, 中气不足。故采用隐白穴治疗, 隐白乃脾经井穴, 井为经气发源之地。以艾灸之则可温通经络, 补中益气, 使脾的血职能得以恢复, 从而达到固崩止漏的目的。

《中国当代针灸名家医案》

张善忱

李某, 女, 31 岁。自诉平亲身体尚健, 17 岁月经初期后, 经量常偏多, 每次持续 7~8d。今月经已持续半月, 开始月量偏多, 以后乃淋漓不断, 并伴有倦怠无力, 少气懒言, 食欲不振, 头晕眼花。查: 面色微黄, 心烦不安, 多梦, 二便调, 舌淡苔少, 脉细数。经妇科诊断为功能性子宫出血, 经服药疗效不显, 随即来诊治, 观其脉证皆居虚象。因肝不藏血, 而脾又失统摄, 故经水淋漓不断, 所属漏症。

治以清热健脾而止血。乃针刺合谷以清热调气, 刺阴陵泉以健脾调中, 刺三阴交以滋阴养肝健脾而止血, 每日 1 针。合谷针刺得气后令针感顺经传至膝腘部。首次针后症状如故, 血量未减, 惟觉体力稍增, 再次针后血量即见显著减少而血色变成淡黄, 3 针之后经血即止, 他症亦除。

按: 此例经漏, 乃由脾不统血, 肝不藏血, 致使月水淋漓不断, 持续 15d。由于日久, 脾虚则面淡黄, 肢倦怠, 肝郁则心烦夜寐不宁。治取三阴交调健脾气使统血有权以止漏, 刺脾之合穴阴陵泉以健脾气。

《张善忱医案》



郑魁山

1951年12月，去北京广安门外关厢出诊，遇刘某，女，34岁，小学教师。子宫出血，血量少但淋漓不止，内有血块，色淡红，每日50~80ml，头昏，腰痛，疲乏无力，已持续5个月。检查：腹软无压痛，舌质淡，苔薄白，脉沉细。证系素体脾虚，中气不足，统摄无权，冲任不固。采用健脾益气，固摄经血，培本固元，温补冲任之法治之。先针血海、隐白，配气海、关元用热补法，使热感传到小腹和足趾，留针30min，针后出血停止。每日1次，连续治疗6次未再出血，半年后随访未复发。

按：本例辨证为脾虚不摄，冲任不固型崩漏。其症见：子宫出血量少但淋漓不止，内有血块，色淡红，头昏，腰痛，疲乏无力，舌质淡，苔薄白，脉沉细。所选血海以健脾调经止血，隐白系脾经之井穴，脾为统血之脏，脾失健运，统摄无权，则血不归经，经水过期不止，甚或崩漏，常以隐白为主穴，配气海、关元以益气固本，调补冲任，固摄经血，并用热补法，使热感传到小腹和足趾，治疗6次后愈。

《郑氏针灸全集》

李世珍

王某，女，40岁，1985年9月初诊。主诉：经血淋漓不断4个月。病史：4个月前在行经期建房屋，操心劳倦过度，出现经血淋漓不断，血色淡而质稀。在当地医院经妇产科检查，无明显器质性病变，服中药20余剂无明显疗效而来针灸科诊治。检查：面色苍白，气短懒言，神疲肢倦，面浮肢肿，纳呆，经血淋漓不断，经色淡而稀。舌质淡，苔白，脉细弱。诊断：崩漏，脾虚气陷，气血亏虚型。治疗：健脾益气，补血摄血。取穴：合谷（双）、三阴交（双）。操作：毫针刺法，补法。隔1~2d针治1次。二诊后漏下量减少，气短神疲症状减轻；三诊后出血已止，



精神好，饮食增加，面浮肢肿明显减轻；五诊后痊愈。随访 2 年未发。

按：辨证为脾虚气陷，统摄无权，造成漏下。漏下日久，更损气血，则脾虚益重。妇女以血为本，月经、胎孕、产育、哺育，都是以血为用，而在经、孕、产、乳期间又易于耗血，致使机体常处于血分不足、气分失助的状态。所以，调理气血在妇科病的治疗中具有重要意义。而针补合谷、三阴交，可收补气摄血，养血调经之效。不仅漏下治愈，伴见的气血亏虚症状，亦随之治愈。

《中国当代针灸名家医案》

钟梅泉

李某，18 岁，1979 年 7 月初诊。主诉：经期紊乱、量多半年。病史：患者 13 岁初潮。初期经期尚准。1976 年 1 月开始月经不正常，每月来 2 次，每次历时 6~7d，量多，有血块，有时少腹痛。曾在北京某医院妇科检查，诊断为功能性子宫出血。服中药及单验方治疗 3 个月未收效。平素胃脘隐痛不适，纳谷欠佳，大便干，小便如常，性情急躁，口干发苦。此次因 7 月 6 日来经 1 次，历时 6d，7 月 19 日再次来月经，至 26 日血止，前来就诊。检查：脸色黄白欠华，倦怠乏力。脊柱两侧检查：腰、骶部两侧触摸到条索、泡状软性物，髂嵴部有条索和压痛，三阴交有压痛。舌淡嫩胖，苔薄，脉细稍弦。诊断：崩漏（功能性子宫出血），冲任失调型。治疗：调摄冲任，健脾疏肝。取穴：腰部、骶部、带脉区、腹股沟。配穴：中脘、三阴交、肝俞。操作：梅花针叩打。治疗 12 次。历时 28d 月经来潮，量中等，无腹痛，6d 干净。随后又调经治疗 15 次，追踪观察 3 年 5 个月，月经正常，疗效巩固。

按：崩漏主要是任冲受损、脾不摄血，肝不藏血，肾失封藏所致，该病在脊柱两侧及体表有特殊反应，在胸椎_{9~11}两侧、腰、骶部两侧可摸到条索、结节和泡状软性物、髂嵴部有条索及压痛、



小腿内侧（三阴交）有明显压痛。钟氏应用梅花针治疗崩漏常分期按步骤论治，均收到较好疗效。其方法下①出血期：不论是崩还是漏，治疗均以养血止血，调理冲任，兼治肝脾为原则。治疗选用腰部、骶部及该部位小的阳性物处、带脉区、下颌三角区、小腿内侧、百会、三阴交、足三里（此期不叩刺腹股沟和下腹部）。②调理期：出血停止后以调理任冲，滋肾平肝，补中益气健脾和胃为主。治疗部位选用脊柱两侧、下腹部、腹股沟、带脉区、小腿内侧、中脘、期门、肝俞、胆俞、脾俞、胃俞。重点叩打胸椎_{7~12}两侧，腰部、骶部以及该部位小的阳性物处，带脉区。③随症加减：症见腰部、少腹痛者重点叩打腰部、下腹部、三阴交；胃纳差，便溏腹胀者重点叩打胸椎_{5~12}两侧、腰部、上腹部、中脘、足三里；头晕、头痛、目眩者重点叩打腰部、头部、太阳、风池、内关、三阴交；气虚，脸色苍白不华，神倦乏力者重点叩打腰部、骶部、大椎、中脘、足三里。所治病例采用调摄冲任，健脾疏肝法，取腰骶部、带脉区、腹股沟。配穴，中脘、三阴交、肝俞梅花针叩打治愈。

《中国当代针灸名家医案》

黄宗勗

吴某，女，32岁，1964年7月10日初诊。主诉：月经量多10余年。病史：自15岁月经初潮后，经量素常偏多，每次持续8~9d。最近数年来每次均持续半个多月，开始经量如崩，并有血块，1周后则淋漓不断。伴有神疲乏力，食欲不振，头晕目眩，屡治未效，前来诊治。检查：面色萎黄，倦怠无力，少气懒言，现月经已来期2d，小腹隐痛，舌淡，苔薄，脉细。妇科检查无异常病变。诊断：崩漏（功能性子宫出血）。治法：滋阴养肝，健脾止血。取穴：关元、三阴交、隐白、断红。操作：每日针灸1次，用补法，留针30min。针后加艾条灸10min。隐白单灸不针，断红单针不灸。经初诊针灸后20min，血量即减少，仍守前法针



灸3次，经血停止。如此治疗20次，下次月经来潮时经量基本正常。

按：功能性子宫出血属于中医崩漏范畴，崩和漏可互相转化。主要由于冲任损伤，不能固摄经血所致。治疗取关元，调补冲脉、任脉之气，以加强固摄，约制经血妄行，三阴交滋阴养肝，补脾统血，为治疗妇科疾病的要穴，隐白用治崩漏效果良好；断红是黄氏治崩漏的经验穴，位在第二、三掌骨之间，掌指关节前下1寸处，有减少出血的作用。

《中国当代针灸名家医案》

二、针灸疗法

针刺隐白、复溜、关元治疗崩漏

【穴位选择】主穴：隐白、复溜、关元。加减：配穴为偏热者加血海；脾气虚者加足三里，阴虚加内关。

【操作方法】选用2.5~3寸不锈钢毫针，用弹针进针法进针，得气后留针30min，每隔10min大幅度刮针1次，针感传导至大腿内侧者为佳。偏虚者用捻转补法（手大拇指向前示指向后），实热者用捻转泻法（手示指向前大拇指向后）。每日针1次，10次1疗程。主穴交叉使用，如左刺复溜穴，则右刺隐白穴；反之亦然。配穴则辨证选取。

【功效主治】调补脾肾，清热止血。

【经验心得】历代医家治疗崩漏证多采用中药治疗。多年来，在临床实践中以针刺为主，配合中药治疗崩漏证，疗效较显著。针刺调补脾肾和冲任之气为主，佐以清热。复溜为足少阴经经穴，为调理肝肾治疗崩漏之效穴；隐白穴为足太阴经井穴，为治疗崩漏常用效穴；关元穴为足三阴、冲任之会，可以调补冲脉、任脉之气，以加强固摄制约经血妄行。

治验：朴某，女，19岁，未婚。主诉：经血量多5年余，加



重 4d。14 岁月经初潮，经期超前，量多如冲。自 1987 年起，每年有大出血 1 次。今年 10 月症状加重，经用中西药及内分泌周期治疗均未控制。患者面色萎黄，经量极多如小便状，少腹胀痛，口干唇燥，精神不振，脉细数，苔薄黄，质红，唇色亦红。诊断：崩漏。给予针刺疗法，补泻兼施，针刺 3 次血已止，腰酸、腹胀痛等症状消失。随访 6 个月未复发。

【方剂出处】 于善堂，等．针刺为主治疗崩漏 38 例．中国针灸，1999；（1）：37

针灸隐白治疗崩漏

【穴位选择】 主穴：隐白。配穴：实证取太冲、中极；虚证取气海、三阴交。

【操作方法】 选 1 寸针，常规消毒后，在双隐白穴呈 45° 角斜向上快速刺入 0.1~0.15 寸，施轻捻转，有胀痛针感后，留针 25~30min，点燃艾条对准穴位灸 20min，隔日针灸 1 次。10d 为 1 个疗程，疗程期间休息 5d。治疗时间为 3 个月。

【功效主治】 健脾疏肝。

【经验心得】 隐白穴为足太阴脾经之井穴，《灵枢·九针十二原》“所出为井”，意指经气所出，如水之源头。针灸隐白穴，为治水之源，健脾疏肝，加强统血功能。实证配太冲、中极。太冲为肝经原穴有疏肝解郁，藏血止崩作用，中极属任脉和足三阴经的交会穴，可调理气机，泻邪实，清热利湿活血调经；虚证配气海、三阴交。气海为任脉之穴，任主胞胎，气海为气之大海，补肾益气调冲任；三阴交为肝、脾、肾交会穴，可益肾之封藏，脾之统血，肝之藏血，以补冲任，故崩漏可愈。

治验：李某，32 岁，已婚。4 个月以来月经过频，无周期性，有时 10~20d 1 次，每次出血半个月余，经妇科检查：子宫附件均正常，排除全身性疾病。西医诊断：功能性子宫出血。平日心烦急躁，生气或劳累后即有不规则出血，此次已有 20 余天未止，



血色红，时或挟有血块，症见：小腹胀痛，口干不欲饮，舌红苔黄，脉弦滑。辨证：肝郁血热，血不循经，属实证崩漏，治疗按上述针灸隐白，针太冲（泻法）、中极（泻法），隔日1次，4次血止，为巩固疗效，又针3次，病告痊愈，6个月随访，无复发。

【方剂出处】 王芳. 针灸治疗崩漏 40 例临床观察. 北京中医, 1999; (2): 44~45

针灸治疗脾肾阳虚型崩漏

【穴位选择】 隐白（双）、三阴交、气海、关元、次髎、肾俞、肝俞、脾俞。

【药物组成】 党参 50g，黄芪 30g，白术 15g，川断（炒）20g，阿胶 15g，白芍 15g，茜草 15g，地榆炭 15g，血余炭 10g，海螵蛸 20g，乌贼骨 15g，甘草 10g，山药 15g

【操作方法】 将上述穴位用酒精棉球常规消毒后，用 2 寸、1.5 寸针，针刺后有柔和酸胀感、温热感为宜用。肝俞、肾俞、脾俞行热补手法隔日针 1 次，为求针后有温热感觉。三阴交针 1.5 寸，针下得气后，行针使针感向上至膝或向下至足跟，同时兼用捻转补法留针 15min，气海、关元捻转补法留针 20min。同时重用灸法，出针后用艾条灸气海、关元、三阴交次髎穴针刺 2 寸左右行针使针感向前放散至前阴部为好。对双侧隐白穴用艾条雀啄灸 3~5min，每日 1 次直至经净，以上均 10 次为 1 疗程。配合中药，每日 1 剂，水煎，早晚分服。

【功效主治】 温补脾肾，益气摄血。

【经验心得】 针对崩漏的病因病机，属脾肾阳虚者则首先采用针灸治疗，重用灸法佐以药物辅助治疗。独取肝俞、脾俞、肾俞行针以热补手法，意使气足血旺。隐白穴是足太阴脾经之井穴，用于止血则有较好疗效；关元为肝、脾、肾与任脉之合穴，配关元可培肾固本，补益元气而达健脾补肾之功；三阴交是肝、脾、



肾三经之会穴有健脾益肾养肝之作用，用之调补三阴留针 15min 同时起针后重用灸疗，共奏温脾肾之阳，益气摄血之功，次髎为治妇科之要穴。四穴同用具有健脾补肾养肝统血止血之功用，故对崩漏有较好效果。

方中党参、黄芪、山药、川断补气培元，固冲摄血；阿胶、白芍养血止血，且白芍酸平增强固涩之力；茜草、地榆清热凉血、止血；血余炭化瘀止血；海螵蛸收敛止血；乌贼骨涩血固冲；白术、甘草健脾益气。全方塞流、澄源，标本兼顾，共奏益气兼止血调经之功，针药并举，异曲同工，融“塞流、澄源、复旧”之法为一体，临床应用屡效。

【方剂出处】孙国宇，等．针灸配合加减固本止崩汤治疗脾肾阳虚型崩漏 27 例．中医外治杂志，1995；（6）：15

针刺治疗崩漏

【穴位选择】中极（双侧）、三阴交、隐白穴。

【操作方法】患者取仰卧位，穴位常规消毒后，用 3.5 毫针刺。根据病情采用补法或泻法。留针 30min，每日 1 次，10d 为 1 疗程。

【功效主治】调气止血，补肾调经。

【经验心得】中医学认为崩漏是由于冲任损伤，不能制约经血所致。其临床表现以经期出血时间延长、月经周期紊乱、出血量的变化等为主。与肝、脾、肾三脏有密切关系。肾主精，肝藏血，脾统血，肾与脾又先后天之本，三者功能失调影响冲任、胞宫、胞脉的正常功能而致不规则性出血。中极穴为任脉之经穴，是三阴经之交会穴，三阴交为足三阴经的交会穴，隐白为脾经之井穴。三穴合用，可以调补肝脾肾三脏功能，使冲任气血调和，达到固摄止血而止崩的目的。

【方剂出处】焦英霞．针刺治疗崩漏 27 例的临床观察．针灸临床杂志，2003；19（5）：31



三、简方疗法

方1

大蒜 15g 捣泥，贴敷两侧涌泉穴（足掌心，第 2 跖骨间隙的中点凹陷处），包扎固定。间隔 3h 再敷 1 次。直至血止。

方2

诃子 20g 加适量米醋与水煎煮，滤汁，倒入盆中，熏洗下阴部。每日 2 次。直至血止。

方3

蓖麻子 30g，蓖麻叶 2 张共捣烂，贴敷百会穴（头顶部正中线上，距前发际 5 寸）、脐部，纱布覆盖，胶布固定。每日 1 次。直至血止。大麻子即。

方4

党参 15g，白术 15g，炮姜 15g，海螵蛸 15g 共研细。取适量用醋调成糊状，敷脐，胶布固定。每日 1 次。一般 2~3d 即净。

方5

生地 12g，地骨皮 12g，丹皮 10g，黄柏 10g，青蒿 10g 共研细。取适量用醋调成糊状，敷脐，胶布固定。每日 1 次，直至经净。

方6

吴茱萸 50g，杜仲 50g，蛇床子 50g，五味子 50g，秦皮 50g，丁香 25g，木香 25g 共研细。取 25g 用生绢袋包裹，加水煎煮，滤汁，倒入盆中，乘热熏洗阴部。每日早、晚各 1 次。直至经净。



方7

灸断红穴：常规消毒，沿掌骨水平方向刺 1.5~2 寸，留针 20min 起针，再灸之。用艾卷行雀啄灸法 10~15min，对脾虚型崩漏疗效较好。

方8

按摩治疗：小腹部顺时针摩法摩腹 2min；点按气海、关元 2min；按揉血海、三阴交 2min；掐按隐白、断红（第 2、3 指缝间赤白肉际处）1min；血热加按揉曲池、水泉 1min；血瘀加按揉地机、气冲、冲门、足三里、膏肓、脾俞 1min；阳虚加按揉命门、肾俞 1min。阴虚加按揉太溪、交信穴 1min。

第4章 盆腔炎

第1节概述

盆腔炎是指女性内生殖器官、宫旁结缔组织及盆腔腹膜炎性病变的总称。主要包括子宫内膜炎、输卵管炎、输卵管卵巢脓肿、盆腔腹膜炎，炎症可局限于一个部位，也可同时累及多个器官，故临床表现繁多。此病有急、慢性之分，急性盆腔炎治疗不彻底或失治，常可转化为慢性病变，也有因发病初期，症状较轻，未引起注意，而成慢性炎症；在一定条件下，慢性炎症又可呈急性或亚急性发作，因此本病具有反复发作、病程冗长、缠绵难愈的特点，成为妇科疑难病症之一。

中医学没有盆腔炎的名称，根据它的主要临床表现归属于带下、痛经、癥瘕等范畴。《素问·骨空论》指出瘕聚的发生与冲任二脉关系密切：“冲脉为病，逆气里急…任脉为病，女子带下瘕聚。”东汉张仲景在《金匮要略·妇人杂病脉证并治》篇中论述了妇人腹痛的具体治疗方法：“妇人六十二种风，及腹中血气刺痛，红蓝花酒主之”，“妇人腹中诸疾病，当归芍药散主之。”隋代巢元方《诸病源候论·八瘕候》指出了其病机在于恶血成积：“若经水未尽而合阴阳，即令妇人血脉挛急，小腹重急支满，……



结牢恶血不除，月事不时，因生积聚。”宋代陈自明《妇人大全良方》则认为本病疼痛是由于邪搏气血而成：“夫妇人小腹疼痛者，此由胞络之间夙有风冷，搏于血气，停结小腹，因风虚发动，与血相击，故痛也”，并对本病进行分型论治：“前症（指妇人血气小腹痛）若气寒血结，用威灵仙散；气滞血凝，用当归散，肝经血虚，用四物汤，加参、术、柴胡；肝经湿热，用龙胆泻肝汤；肝脾气虚，用六君子汤加柴胡、芍药；肝脾虚寒，用六君子汤加柴胡、肉桂；若兼呕吐，加木香；四肢逆冷，再加炮姜。”

一、病因病机

（一）中医认识

急性盆腔炎多因分娩、流产、经期房事、宫腔手术等后，胞脉空虚，气血耗伤而余血未尽，湿热、热毒、或湿毒之邪毒乘机侵袭，稽留于冲任及胞宫脉络，与气血相搏结，邪正交争而发病。慢性盆腔炎亦多在经行产后，胞门未闭之际，风寒湿热之邪，或虫毒乘虚内侵，与冲任气血相搏结，蕴积于胞宫血海，或由急性盆腔炎失治误治、治疗不彻底而成，反复进退，耗伤气血，虚实错杂，缠绵难愈。

具体而言，其病理机制括有以下六个方面。

1. 热毒炽盛 经行、产后、流产、手术创伤，体弱胞虚，气血不足之时，若房事不节，邪毒内侵，客于胞宫，滞于血海，化热酿毒，致高热腹痛不宁，急性发作。
2. 痰湿瘀结 素体虚弱，脾运失司，湿浊内停，聚而为痰，痰湿之邪，其性胶结，下注冲任、胞脉，阻碍气机，气血运行不畅，日久痰血互结，故发为本病。
3. 气虚血瘀 素体虚弱，经期、产后胞脉、冲任空虚，湿毒内侵，或病久不愈，正气内伤，气虚不能帅血以行，血行迟滞而为瘀，瘀阻胞脉、冲任而为病。
4. 气滞血瘀 七情内伤，肝气郁结，或外感湿热之邪，余毒



未清，滞留于冲任胞宫，气机不畅，瘀血内停，脉络不通而为本病。

5. 湿热瘀结 湿热之邪，乘虚客于胞宫、胞脉，与血搏结，久而成瘀成癥，复又阻痹胞脉、冲任而致本病。

6. 寒湿凝滞 素体阳虚，下焦失于温煦，水湿不化，寒湿内聚，凝结不去，或寒湿之邪乘虚侵袭，与胞宫内余血浊液相结，凝结瘀滞，则本病生矣。

（二）西医认识

女性生殖道在解剖生理上的特点，具有比较完善的自然防御功能，增强了对感染的防御能力。但当机体免疫功能下降、内分泌发生变化或外源性致病菌侵入，则可导致炎症的发生。引起盆腔炎的病原体，有来自原寄居于阴道内的菌群，包括需氧菌及厌氧菌，和来自外界的病原体如淋病奈氏菌、沙眼衣原体、支原体、结核杆菌、绿脓杆菌等。

盆腔炎的感染途径主要为经生殖系统淋巴、生殖器黏膜上行及邻近组织器官炎症直接蔓延，或经血循环传播。多见于产后或流产后感染、宫腔内手术操作后感染、经期卫生不良，以及感染性传播疾病，邻近器官炎症直接蔓延，慢性盆腔炎急性发作，宫内节育器等。

急性盆腔炎病理改变包括急性子宫内膜炎，急性子宫肌炎，急性输卵管炎，输卵管积脓，输卵管卵巢脓肿，急性盆腔结缔组织炎，急性盆腔腹膜炎，甚至发展为败血症及脓毒血症。慢性盆腔炎病理改变有慢性输卵管炎与输卵管积水，输卵管卵巢炎及输卵管卵巢囊肿，慢性盆腔结缔组织炎。

二、临床表现

1. 急性盆腔炎 往往突然发病，症见发热，恶寒或寒战，头重痛，食欲不振，下腹胀痛、压痛、反跳痛，压痛点多在耻骨联合上缘两侧，疼痛可向大腿两侧放射，肠鸣音减弱或消失，腰



部酸胀坠痛，带下量增多，色黄质稠并有臭秽气，月经先期、量多，色深红或黯红，质稠浓。妇科检查见阴道充血、后穹窿触痛明显，宫体略增大，有压痛，活动受限，两侧附件有压痛，可触及肿块或索状增厚。有子宫旁结缔组织炎时，可扪及下腹一侧域两侧有片状增厚，严重时呈冰冻样骨盆；有盆腔脓肿形成时，则可在子宫直肠窝触到有波动的包块。

2. 慢性盆腔炎 由于病程时间较长，部分患者可出现神经衰弱症状，当患者抵抗力差时，易有急性或亚急性发作，炎症形成的瘢痕粘连以及盆腔充血，常引起下腹部坠胀、疼痛及腰骶部酸痛，常在劳累、性交后及月经前后加剧；若炎症导致盆腔瘀血，常见经量增多；卵巢功能损害时可致月经失调；输卵管粘连阻塞时可致不孕。妇科检查见阴道分泌物增多，子宫多后倾或偏向一侧，可能活动受限或固定。如为附件炎，则可在一侧或双侧附件处扪及条索状物或片状块物，并伴有压痛；如有输卵管积水或输卵管卵巢囊肿，则可扪及活动受限的囊性包块；有盆腔结缔组织炎时，子宫的一侧或两侧有片状增厚，子宫骶骨韧带增粗、变硬，有不同程度压痛。

三、辅助检查

（一）急性盆腔炎

1. 血常规检查见白细胞升高，粒细胞更明显。
2. 阴道、宫腔分泌物涂片或培养可见致病菌。
3. 后穹窿穿刺可吸出脓液。
4. B超可见盆腔内有积液或包块。
5. 腹腔镜检查能提高确诊率。

（二）慢性盆腔炎

1. 血象一般不高，红细胞沉降率不快。
2. 腹腔镜镜活检可见明显炎症病变。
3. B超检查两侧附件增宽、增厚，或有炎性肿物。



4. 子宫输卵管碘油造影显示输卵管部分或完全阻塞。
5. 盆腔血流图、血液流变学及微循环测定均有不同程度的异常。

四、诊断与鉴别诊断

（一）诊断要点

1. 急性盆腔炎 根据病史、症状和体征，可作出初步诊断。此外，还需做必要的化验，如血常规，尿常规，宫颈分泌物及后穹窿穿刺物检查。

临床诊断需同时具备以下三项：下腹部压痛伴有或不伴有反跳痛；宫颈或宫体举痛；附件区压痛。

2. 慢性盆腔炎 多有急性病史，结合症状和体征，必要时可行腹腔镜检查以确诊。

（二）鉴别诊断

盆腔炎需与下列疾病相鉴别：

1. 急性阑尾炎 与急性盆腔炎都有腹痛、身热、白细胞升高。盆腔炎痛在下腹部两侧，病位较低，常伴有月经异常、带下量多，甚至腰骶部疼痛；急性阑尾炎多局限于右下腹部，有麦氏点压痛、反跳痛。

2. 异位妊娠 输卵管妊娠流产、破裂者，腹腔内出血，临床表现为腹痛、阴道流血，甚至晕厥，与急性盆腔炎相似。盆腔炎者高热、白细胞升高。异位妊娠者血及尿 HCG（+）。后穹窿穿刺，异位妊娠者可抽吸出不凝固的积血，盆腔炎者则为脓液，可资鉴别。

3. 卵巢囊肿蒂扭转 常表现为突然腹痛，渐加重，甚至伴有恶心呕吐，一般体温不甚高，妇科盆腔检查或 B 型超声检查可资鉴别。

4. 子宫内膜异位症 其主要的临床特点为进行性加重的痛经，病程长，与慢性盆腔炎相似。后者的特点是长期慢性疼痛，



可有反复急性发作、低热，经行、性交、劳累后疼痛加重。子宫内膜异位症平时不痛，或仅有轻度疼痛不适，经期则疼痛难忍，并呈进行性加重腹腔镜检、B 型超声及抗子宫内膜抗体等检验有助于确诊。

5. 盆腔瘀血症 无炎症病史，有下腹痛及低位性疼痛史。与慢性盆腔炎相鉴别。妇科检查无明显阳性体征可借助盆腔血流图确诊。

6. 盆腔结核 可有下腹痛、低热、月经异常、不孕等症状，或有全身结核病史。体检腹部有揉面感，甚至可查到腹水或包裹性积液，腹部平片、子宫输卵管造影、血沉、腹水查嗜酸杆菌、PCR 等有助于诊断。

第2节 辨证论治

一、名家医案、医论

郑魁山

1948 年 4 月，在北平门诊，遇一王某，女，38 岁。2 年前生育满月后，阴道出现白带，开始时量少，后来量逐渐增多，连绵不绝，色白，饮食减少，大便溏泄，精神疲倦，四肢无力。检查：腰骶部关元俞、上髎、次髎穴处有压痛，手足皮温低，舌质淡、苔薄白，脉缓。证系脾虚不运，水湿内停，胞脉不固，任带失约。采用健脾益气，调理任带，固摄胞脉，利湿止带之法治之。先针带脉、三阴交，配气海、关元、上髎、阴陵泉用热补法，使热感传到腰骶、小腹和足趾，留针 20min，每日 1 次，针治 3 次，白带减少，改为隔日 1 次，针治 34 次，症状消失。1 年后随访未复发。

《郑氏针灸全集》



钟梅泉

凌某，女，38岁，1959年5月25日初诊，少腹胀痛、腰酸痛已5年。白带多，味臭，头昏，神倦乏力，梦多，纳谷欠佳，形瘦。经北京某医院妇科检查：宫颈Ⅱ级糜烂，右侧下腹部可触及指头粗肿物，压痛（++++）。诊断为慢性盆腔炎。曾用中西医多法治疗均未收效。在胸椎_{5~10}两侧有条索和压痛，腰、骶有结节和泡状软性物，腰骶部叩诊呈空音。脉细弱，苔薄。证属病久正虚，脏腑虚损，冲任失调。拟以益气养血，调理冲任为治。根据病证，选取胸、腰部、下腹部、重点叩打腰、骶部、腹股沟、带脉区、中脘、大椎、足三里、三阴交、关元、阳性物处进治，采用梅花针治疗3次后，少腹痛和腰痛均减轻，白带减少；治疗7次后，上症消失，精神好转；治疗25次后，患者回某医院妇科复查：“子宫颈无糜烂，右下腹粗大肿物已消失，无压痛”。共治疗36次，诸症消失，无不适感而停诊。随访26个月疗效巩固，未复发。

《中国梅花针》

邱茂良

验案1：汪某，女，32岁。因结婚后10年不孕，腹痛，白带量多而来诊。患者经妇科检查，诊断为两侧附件炎，临床症状为两少腹部疼痛拒按，腰骶部酸痛。白带增多，有时色黄、质黏、有秽臭。小便频数，色黄，月经超前量多色红，常感五心躁热，夜寐不安，舌质红，苔黄腻，根部尤甚，脉滑数。脉症合参，证属湿热郁结下焦，阻于任带二脉，故多带下，气血壅滞，故见癥瘕腹痛。拟先治理下焦湿热，调理任带奇经为法。取穴：①气海、中极、带脉、水道、阴陵泉、太冲；②三焦俞、次髎、蠡沟、三阴交、行间等。旨在清利湿热，调理奇经。每日1次，连治1疗程（10次），带下减少，小便较畅，腹痛亦减，唯仍五心烦热，



夜间多梦，口干，湿热久留，伤及肝肾之阴所致，原法中应参调肝理肾，扶正祛邪。取穴：肝俞、肾俞、关元、三阴交等以补肝肾；大赫、阴陵泉、足三里以清下焦湿热，神门，太溪以安心神而治烦热。连续治疗，带下减少，腹痛渐除，诸症均见好转，共计治疗3个月。5个月后，已经怀孕。

按：辨证为湿热郁结，任带失约型带下，邱氏先拟治理下焦湿热，调理任带奇经为法，取①气海、中极、带脉、水道、阴陵泉、太冲；②三焦俞、次髎、蠡沟、三阴交、行间等，旨在清利湿热，调理奇经。后以肝俞、肾俞、关元、三阴交等以补肝肾；大赫、阴陵泉、足三里以清下焦湿热，神门、太溪以安心神而治烦热。经治带下减少，腹痛渐除，患者怀孕。

验案2：张某，女，34岁。患者于22岁结婚翌年即生一子，以后9年不孕，要求治疗。询得患者，知多年带下不断，质清稀而无腥臭，小便多而色清，小腹有冷感，并腹胀不适，得热较舒，形寒畏冷，月经多后期而来，大便易溏。妇科检查诊断为两侧附件炎。舌淡苔白腻，脉细弦。证属寒湿久留，伤及脾肾之阳所致。治先温经散寒，化湿止带。取穴：①关元、归来、大赫。针后加灸，温化下焦寒湿，化湿止带；②地机、中膻俞、三阴交等，扶脾止带。用平补平泻法，每日1次。连续治疗10次，白带减少，畏寒已少，腹痛不甚。前方有效，不宜更法。原法中加肾俞、脾俞、足三里、阴谷等穴，针外加灸。以调补脾肾，此方加减出入，连治3个月，诸症悉愈。

按：患者辨证为寒湿停滞，脾肾阳虚型带下，西医诊断为两侧附件炎，邱氏治先温经散寒，化湿止带，取①关元、归来、大赫针后加灸，温化下焦寒湿，化湿止带；②地机、中膻俞、三阴交扶脾止带。后以原法中加肾俞、脾俞、足三里、阴谷针后加灸，调补脾肾后诸症悉愈。

验案3：陈某，女，32岁，1974年11月24日来诊。带下10年。带下量较多。初起白色无味。近2年来逐渐加重，色黄如



脓，味腥臭，伴阴部瘙痒，腰背酸痛，口干纳呆，神疲乏力，手足心热，大便干，小便赤，每行经前，诸症加重，经行腹痛，色黑有块。舌苔薄黄，脉沉数。证属肝热脾湿之带下，治拟疏肝健脾，清热利湿。取穴：阴陵泉、带脉、白环俞、蠡沟、太冲。上穴均以毫针刺，行提插捻转泻法，每次留针 30min，每 5min 行针 1 次。连续施术治疗 5 次后，带下及臭味减少，腰酸减轻。依上法继续治疗 5 次后，诸症悉除，停止治疗而告愈。

按：辨证为肝热脾湿之带下，治拟疏肝健脾，清热利湿。取阴陵泉、带脉、白环俞、蠡沟、太冲提插捻转泻法。邱氏认为带下之病，多因下焦肾气虚损，或喜怒忧思，产育房劳，致伤及任脉而成，或因郁怒伤肝，肝乘脾土，土伤生湿，下注而渗入下焦所致。治疗应以平肝健脾除湿治其本，清化湿热止带治其标。取阴陵泉、带脉、白环俞、蠡沟、太冲等穴起效。

验案 4：缪某，女，30 岁，1980 年 10 月 27 日来诊。带下 3 年余，色白清稀，连绵不断，量多，口淡，食少腹胀，便溏，体倦乏力，易怒。近半年来，诸症加重。来门诊求治。观其面色萎黄，形容猥琐，气短而语促。舌质淡，苔薄白，脉沉缓。证属脾虚肝郁，湿盛带下。治当健脾止带，佐以疏肝。取穴：阴陵泉、带脉。上穴均施以提插捻转补法。每次留针 30min，每 5min 行针 1 次。经连续治疗 10 次后，诸症悉愈。

按：辨证为脾虚肝郁型带下，取带脉穴其调节带脉，助其固摄诸脉之功，加阴陵泉，乃求其利湿之用。一般长年不愈之带下，多兼湿盛，湿邪重浊黏滞，使证情胶着，难以痊愈。带脉与阴陵泉合用，可化湿固带。

验案 5：沙某，女，31 岁，1988 年 3 月 11 日来诊。带下 2 年余，加重 4 个月。带下色黄，或黄白相间，量多，已 2 年余。近 4 个月来，诸症加重，下身常湿，观之如涕如唾，连绵不断，稍有腥臭，时时阴痒难耐，腰坠腹胀。时有隐痛，脘闷纳呆，多方求医，均疗效不显。患者形体消瘦，面色不华，精神疲惫，苔



黄略赋，脉沉数。西医诊断：慢性盆腔炎。中医诊断：带下。证属脾虚失运，带失固约。拟从健脾益气，利湿止带论治。取穴：阴陵泉、带脉、白环俞、血海。上穴均用提插捻转补法，每次留针 30min，每 5min 行针 1 次。其中白环俞应深刺，针尖朝向前阴部，使产生放射至下腹的针感，然后连续行针 10min。以上方连续治疗 5 次后症状基本消失，遂停止治疗而告愈。

按：属脾虚带下，乃“完带汤”证，针灸亦当以补益收摄为法。取阴陵泉、白环俞健脾止带，配带脉、血海之固摄，而共奏健脾止带之效。

验案 6：仇某，女，40 岁，1972 年 12 月 9 日来诊。带下 10 余年。近 1 年来加重。带下黄白或赤白相兼，小腹坠胀疼痛，按之痛处固定不移。脐正下方偏左可触及包块，质地坚硬，腰骶酸痛，月经愆期，经前腹痛。B 超检查见双侧卵巢各有一个 $5.5\text{cm} \times 4.8\text{cm}$ 大小的包块，属囊性肿物。诊断为“双侧卵巢囊肿”。面色不华，色暗尘垢，肌肤粗糙不润。舌紫暗，有瘀斑，脉沉细涩。中医诊断：癥瘕。证属气滞血瘀，冲任不通，带脉失约，聚而成积。治拟活血散结，破瘀消癥。取穴：中极、次髂、胞育、气冲、阿是、地机。各穴均用提插捻转泻法，阿是穴为触摸小腹癥之所在。用长针刺入小腹硬结中，使之产生较强的胀痛感，然后行温针灸。隔日治疗 1 次，针灸治疗 30 次后，白带减少，少腹痛和腰痛均有明显减轻。继续针灸，并配合少腹逐瘀汤合四君子汤方投之。半年后症状基本消失，月经恢复正常。

按：为气虚血瘀，气虚则推动血行无力，血瘀下焦。冲任失调，带脉不约，则见带下、癥瘕。取中极、次髂前后相配，攻逐少腹之瘀积；针刺带脉可产生放射向病所的较强针感，可通经行气，以促瘀滞之消散；阿是穴乃破积之验穴，攻伐之首将。诸穴共用，可奏活血散结，破瘀消积之效。但由于患病日久，其气必虚，峻攻易伤气血，故破积针方若合补益气血药物，针灸治其外，中药补其内，针药合用，标本兼顾，攻补兼施，



积乃可除。

《中国百年百名中医临床家丛书·邱茂良》

田从豁

白某，女性，34岁，初诊日期1996年7月。主因带下6年，加重1年前来就诊。患者6年前生产后带下不止，1年前带下症状加重，并出现两少腹隐痛。就诊时诉带下较多，月经前后每日需用卫生护垫，带下色黄，有腥臭味，伴两乳胀痛经前加重，平日常少腹隐痛，口苦。就诊前妇科检查：阴道分泌物较多，宫颈Ⅱ度糜烂。诊断：中医带下证（肝胆湿热兼有肝郁），西医：盆腔炎。治则：运脾、利湿、止带。治疗：毫针刺中极、水道、带脉、三阴交、丰隆、阳陵泉、外关。隔日针刺，每周3次。疗效：二诊后少腹隐痛症状缓解。六诊后带下症状改善，经前乳胀基本缓解。十二诊后带下如常，腹痛、乳胀症状完全消失。两年后随访，病情平稳未再反复。

按：带下伴少腹隐痛，两乳胀痛，带下色黄有臭味并伴口苦。表现出一派热象、实象，病在少阳胆经，肝胆互为表里，取中极、水道清利膀胱；外关清利三焦水道；三阴交、丰隆健脾化湿；带脉利胆固带；阳陵泉清利肝胆，具有引经作用。患者虽病已久，但仍以实象为主，所以遵循运脾利湿之法，即可取效。

《当代中医名家丛书·田从豁临床经验》

二、中药外治疗法

妇炎散外敷治疗慢性盆腔炎

【药物组成】延胡索10g，血竭8g，三七2g，香附、连翘、蒲公英、土茯苓、红藤各15g。

【治疗方法】将上药混合后研末，搅匀，装于纱布袋内，每袋100g。系于小腹正中或脐部，3d更换1次，2周为1个疗程。



【功效主治】 清热利湿，活血化瘀，调理冲任。

【经验体会】 本病多系湿热内侵，气血瘀滞或身体虚弱，无御外邪，湿邪乘虚侵袭湿瘀胶结，壅塞胞宫，迁延失治而成。根据病情，辨证施治，妇炎散清热利湿，活血化瘀，调理冲任，且药理研究证明，可改善盆腔血液循环，促进炎症吸收。尤其是本法敷于脐中或小腹，是以中医经络学说和脏腑学说为基础的外治法，因脐在胚胎发育过程中为最后闭合处，表皮角质层薄，药物易于通过，可直接激发经脉之气，促进气血运行。采用妇炎散外敷，其中延胡索辛散温通，既能行气，又能散瘀止痛，行气中血滞；香附辛散理气，行气止痛；血竭、三七活血理血，生肌，可促进炎症消散；蒲公英、红藤、土茯苓清热解毒，祛湿除浊，直除外邪，药物相伍，药效增强。而且脐部系任脉之要地，与胞宫之尤通，药物可直达病所，故效果良好。

治验：女，32岁。患者自述3年前因做人流术后，出现月经后期，量时多时少，伴有血块，痛经。且白带量多，色黄稠，有臭味，小腹时痛，腰骶部坠痛。近3年未孕。曾经输注青霉素、先锋、氨苄、甲硝唑等效不显，来诊。经妇查见：阴道有大量黄稠分泌物，宫颈糜烂，活动受限，压痛(+)。B超示：子宫大小正常，左卵巢可见3.2cm×2.1cm之无声暗区，包膜完整，边界清楚。提示：诊为慢性盆腔炎并卵巢囊肿。尿检有大量脓细胞。舌质暗、苔厚腻微黄，脉滑数。采用妇炎散20d后，病情明显好转，继用40d后症状消失，B超检查未见异常。

【方剂来源】 王优芳，等。妇炎散外敷治疗慢性盆腔炎 78例。陕西中医，2005；26(10)：1000

肠安散外敷治疗慢性盆腔炎

【药物组成】 黄芪 15g，肉桂 3g，白术 10g，白及 10g，白头翁 30g，丁香 5g，黄连 3g，白芷 10g，小茴香 6g，冰片 5g。

【治疗方法】 上药研细末制成散剂备用，每次 5~6g，用米



醋调成稠膏状敷于神阙穴，伤湿解痛膏覆盖固定。3d 换药 1 次，15d 为 1 个疗程，可连续治疗 2 个疗程。

【功效主治】 消肿毒、透肌肉、通经络。

【经验体会】 慢性盆腔炎以下腹坠胀隐痛、累及腰骶酸痛、带下量多、经量增多或经期延长、劳累或月经前后加剧等为主要症状，属中医学痛经、带下、癥瘕等范畴，由湿毒瘀血阻络，脾肾阳气亏虚而成，寒热并见，虚实错杂，病程缠绵，易于反复，故采用健脾补肾、解毒活血为法治疗。肠安散方中丁香、白及理气活血，散结止痛；白头翁、黄连清热燥湿以祛余邪；黄芪、白术、肉桂健脾气，温肾阳；白芷、小茴香、冰片辛香走窜，具有消肿毒、透肌肉、通经络之效，引药入内直达病所。全方温清并用，攻补兼施。扶正化瘀中药可提高机体免疫功能，改善局部血液循环，增强吞噬细胞功能，促进炎症的吸收、粘连的松解和包块的消散。

【方剂来源】 陈芳，等．肠安散外敷治疗慢性盆腔炎 62 例．河北中医，2006；28（1）：30

丹香合剂治疗慢性盆腔炎

【药物组成】 丹参、昆布各 20g，葛根、薏苡仁、泽兰、红藤、续断各 30g，山药、赤芍、归尾、败酱草各 15g，香附子、延胡索、桂枝各 9g。

【治疗方法】 水煎过滤浓缩为 50ml，保留灌肠，每日 1 次，连用 10d，原药渣加艾叶 240g，透骨草 120g，酒拌后打包隔水蒸热腹部热敷 10d。共治疗 3 个月为 1 个疗程。

【功效主治】 清热解毒，活血化瘀。

【经验体会】 慢性盆腔炎是余邪未尽，瘀积胞中，以致脏腑功能失常，气血失调，冲任受损，从而引起月经不调、崩漏、痛经、带下、癥瘕等。丹香合剂中的丹参活血化瘀，改善微循环，促进组织修复与再生。桂枝扩张血管，促进血液循环。当归尾改



善血液循环，促进体液吸收，山药、续断以壮腰健肾，以防脏气受损太过。桃仁活血化瘀且对炎症的渗出有作用。葛根解肌缓痛，清热凉血，对妇科炎症有良好的效果。佐以其余诸药辅助主药以达祛邪不伤正，补虚不恋邪之意。本方配伍严谨，用药恰当补泄互使，相得益彰，是治盆腔炎有效的良方。

【方剂来源】张雪梅. 丹香合剂治疗慢性盆腔炎 70 例临床观察. 陕西中医学院学报, 2003; 26 (5): 31

复方仙鹤草膏治疗慢性盆腔炎

【药物组成】仙鹤草 500g，瞿麦 100g，篇蓄 100g，败酱草 300g，香附 100g，五灵脂 200g，桃仁 100g，蒲公英 200g，生薏苡仁 300g，土鳖虫 100g，红花 50g。

【治疗方法】药材粉碎后，加水适量，煎煮 2 次，每次 2h，合并煎液滤过，滤液浓缩成清膏。每次 7g，每日 3 次，10d 为 1 个疗程。

【功效主治】活血化瘀，清热解毒。

【经验体会】本病属中医“寒湿”“湿热下注”“热入血室”“带下”“癥瘕”等范畴，祖国传统医学认为该病多因湿热、寒湿侵袭而诱发以致湿热内蕴、寒湿内生、气滞血瘀、冲任受阻热毒蕴结于下焦，与气血相搏，正邪交争，营卫不和所致。方中仙鹤草补虚固涩、扶正祛邪，五灵脂、土鳖虫、香附、桃仁、红花行气化瘀止痛，瞿麦、篇蓄、薏苡仁清热利湿，蒲公英、败酱草清热解毒散结，诸药合用配伍机制合理，制成膏剂既矫正了口味又方便服用。

【方剂来源】马俊杰, 等. 复方仙鹤草膏治疗盆腔炎 48 例. 现代中西医结合杂志, 2003; 12 (7): 717

归芍延桃饮灌肠治疗慢性盆腔炎

【药物组成】当归、川芎各 10g，延胡索、桃仁各 15g，肉



桂 6g, 败酱草、白花蛇舌草各 20g。加減: 有包块加三棱、莪术各 15g, 带下多加薏苡仁、土茯苓各 15g。

【治疗方法】 上药水煎取汁 150ml, 每晚 1 剂, 睡前保留灌肠。方法: 患者排空大便, 取侧卧位, 将药液放入灌肠袋中, 挂在输液架上, 药温 39℃ 左右, 另一端塑料肛管插入肛门直肠内约 15cm, 药液约在 5min 内滴完。

【功效主治】 活血行气、化瘀止痛。

【经验体会】 慢性盆腔炎应用抗生素治疗效果差, 其疗程长、用药久、缠绵难愈。本病病因病机为外邪侵袭, 瘀积日久, 使脏腑功能失常, 气血失和, 瘀血内生, 瘀阻经脉所致。治宜活血行气、化瘀止痛。方中当归、川芎养血行气、活血止痛; 桃仁破瘀行血止痛; 延胡索行气活血止痛; 肉桂能入阴通阳、通经脉; 败酱草、白花蛇舌草清热解毒、抗菌消炎。诸药合用, 共奏活血化瘀、解毒消炎之功。临床观察发现, 用此类中药保留灌肠, 保留时间与作用呈正比, 经直肠吸收的药物可以很快在盆腔弥散, 目的是直肠黏膜吸收药液后, 促进血液循环, 改善组织营养, 降低毛细血管通透性, 减少炎症渗出, 有利于抑制结缔组织增生, 促进炎性包块吸收。

【方剂来源】 康义华, 等. 归芎延桃饮灌肠为主治疗慢性盆腔炎 60 例. 山东中医杂志, 2005; 24 (4): 223

红酱解毒汤灌肠治疗慢性盆腔炎

【药物组成】 红藤 30g, 败酱草 30g, 蒲公英 30g, 延胡索 30g, 制乳香 15g, 三棱 10g, 莪术 10g, 丹参 15g。

【治疗方法】 每日 1 剂水煎取汁 200ml, 药温 39~41℃。患者侧卧位, 用 5 号导尿管插入肛门 14cm 以上, 将药物用静脉输液器 30min 滴入, 药液注完后卧床休息 30min。每日 1 次, 15d 为 1 个疗程, 经期停用, 连用 1~2 个疗程。

【功效主治】 消肿散结、活血化瘀软坚。



【经验体会】慢性盆腔炎多为余邪未尽、气血瘀积胞中，以至脏腑功能失调，冲任受损，当以活血化瘀法治之。本方中红藤、败酱草、蒲公英能清热解毒；三棱、莪术活血化瘀软坚散结；丹参可活血化瘀疏通微循环；乳香、延胡索理气止痛。诸药配伍可消肿散结、活血化瘀软坚，使盆腔纤维组织变软而康复。选用保留灌肠法，可自肠黏膜吸收直接进入盆腔病灶，更好发挥治疗作用。可避免患者长时间口服中药伤胃之虑。

【方剂来源】王晓玲，等．红酱解毒汤灌肠治疗慢性盆腔炎185例．中国乡村医药杂志，2004；11（10）：43

慢盆汤内服灌肠治疗慢性盆腔炎

【药物组成】白花蛇舌草、红藤、蒲公英、败酱草、苦参、苍术各30g，丹参、当归各15g，赤芍、桃仁、延胡索各12g，黄柏10g。加减：下腹冷痛加小茴香、肉桂；腰酸痛者加续断、菟丝子；气血虚弱者加太子参、黄芪；气滞者加香附、木香。

【治疗方法】将上述药物煎两汁，头汁200ml分2次早、晚口服，二汁浓煎成100ml，保持在38℃左右，患者取侧卧位，将8号导尿管插入直肠约15cm，收药液缓慢注入直肠内，注完以后休息1~2h以上，最好晚上临睡前排便后灌肠，一般可保留至次日晨，每晚1次，经期停用，1个月经周期为1个疗程。

【功效主治】清热解毒，活血化瘀，消痈止痛。

【经验体会】本病的发生多是由于经行、产后等致胞脉空虚之时，邪热入于胞宫，与血互结阻滞胞脉，致胞脉气血不畅壅于下焦，蕴而化热；或邪热炽盛，蕴积于内，损坏血脉，化成脓毒。本方中白花蛇舌草、红藤、败酱草、蒲公英长于清热解毒，消痈排脓，去瘀止痛；当归活血止痛；丹参、桃仁活血化瘀，凉血消痈止痛；苦参、苍术清利湿热。全方配伍能清热解毒，活血化瘀，消痈止痛。采用内外合治，使药力直达病所，利气机，通血脉，清湿热，消癥瘕，且毒副作用小、痛苦少。



【方剂来源】 宋美娥，等．慢盆汤内服灌肠治疗慢性盆腔炎 88 例．陕西中医，2004；20（10）：852

如意金黄散治疗慢性盆腔炎

【药物组成】 天花粉、黄柏、姜黄、白芷、大黄、厚朴、陈皮、甘草、苍术、胆南星。

【治疗方法】 上药各等份烘干，用粉碎机粉碎，过 100 目筛后备用。每次取约 20g 用 120ml 开水浸泡，冷却后滤去药渣，每晚睡前保留灌肠。灌肠方法：左侧卧位，装药水的输液瓶挂在床边，输液管上端接瓶，下端的接头剪去后塞入肛门约 15~20cm。另用约 30g 以米醋调湿，敷下腹部，并用热水袋装热水后敷盖，水冷即可撤药。7d 为 1 个疗程，共治疗 2~3 个疗程。

【功效主治】 活血止痛、温通血脉。

【经验心得】 盆腔炎包括子宫内膜炎、子宫肌炎、输卵管炎、盆腔结缔组织炎，是经、产、不洁妇检时感染致病菌所致。慢性盆腔炎由于病程长，反复使用多种抗生素，容易造成耐药，因此采用中医药治疗有一定优势。如意金黄散出于《外科正宗》，由天花粉、黄柏、姜黄、白芷、大黄、厚朴、陈皮、甘草、苍术、胆南星组成，具有清热解毒、消肿排脓、燥湿化痰、活血化瘀功效。主治外科一切顽恶肿毒，原为治疗外科疮疡而设。疮疡为感染因素（特别是感染湿毒、热毒）作用于肌体，肌肤气滞血瘀、郁而化热、热盛肉腐、酝酿成脓所致。盆腔炎在中医学里没有相应病名，分散见于“带下病、痛经”等证，由感染湿毒、热毒而成，病机主要为“湿、热、瘀”，日久可转为“寒、湿、瘀”。

作者认为此病应属内痈范畴，与外科疮疡的致病原因、致病机制基本一致，因此用如意金黄散治疗效果良好。现代药理证实黄柏具有广谱抗菌作用，大黄、白芷、姜黄具有抗菌、抗炎作用，厚朴对革兰阳性菌、革兰阴性菌均有较强的抗菌作用，天花粉能调节免疫和抗菌。用米醋调如意金黄散外敷以及热敷治疗，目的



是要加强活血止痛、温通血脉作用。为延长药液在肠内停留时间，宜选用制大黄。

治验：患者，女，32岁，1997年8月15日初诊。因反复下腹胀痛6年，再发半个月来诊。症见下腹隐痛，伴腰骶酸痛，肛门坠胀，时欲大便，月经失调，痛经等。B超检查提示：两侧输卵管增粗，子宫直肠凹积液。患者曾经多次来我院门诊妇科就诊，予氨苄青霉素、第三代头孢类抗生素、甲硝唑、喹诺酮类等抗生素治疗，病情反复未愈。半月前下腹胀痛，经用如意金黄散灌肠、外敷治疗（方法同前），7d为1个疗程。2个疗程后症状体征全部消失。B超复查提示：两侧输卵管未见异常，子宫直肠凹无积液。随访1年未见复发。

【方剂出处】许靖．如意金黄散治疗慢性盆腔炎32例．广西中医药，2003；26（2）：30

三、简方疗法

方1

生大黄300g，丹皮200g，桃仁150g，冬瓜子100g，芒硝120g，前4味共研细末，分3份。取1份用米醋调成糊状，然后拌入芒硝40g，装入布袋，放锅中蒸至透热，乘热敷于小腹40min，外加热水袋。每日早、晚各1次。每袋可用2~3d。直至痊愈。

方2

黄芩15g，黄柏15g，黄连15g，虎杖30g，加水煎煮，滤汁，约100ml，保留灌肠，保留时间为18~24h。每日1次。一般15~30次可愈。如选择在经净后3d灌肠，则效更佳。

第 5 章 不孕症

第 1 节 概述

育龄妇女婚后有正常性生活，未避孕，同居两年而未能受孕者称为不孕症。据统计未避孕的夫妇，60%在婚后6个月内怀孕，80%在9个月内，85~90%在1年内怀孕，约有4%在婚后第2年怀孕。如婚后2年未孕，可称不孕症。

不孕症又分原发性不孕和继发性不孕。原发性不孕指从未妊娠过，《山海经》称：“无子”，《千金要方》称：“全不产。”继发性不孕指曾有过妊娠，以后1年以上未避孕而未再妊娠，《千金要方》称：“断绪”，《素问·骨空论》有“不孕”之名。

一、病因病机

不孕的原因十分复杂，夫妇双方任何一方生育能力的下降，都会影响其配偶的生育能力。女方的原因主要是脏腑功能失常，气血不调，寒、热、痰、湿、瘀、郁、虚互相影响与转化，影响冲任、子宫的摄精成孕及育胎的功能，导致不孕症。

（一）中医认识

1. 肾虚 肾为先天之本，元气之根，受五脏六腑之精而藏



之，且肾为天癸产生之源，主宰天癸的至与竭，主导月经的产生。先天禀赋不足，肾气亏损，或房事不节，久病伤肾，肾气暗耗，冲任脉虚，胞脉失养，不能摄精成孕；肾阳虚不足，命门火衰，不能温煦冲任、子宫，宫寒不孕；肾阴不足，精血亏损，胞脉失养，或阴虚火旺，血海蕴热，冲任失调，亦不能成孕。

2. 肝郁 女子以血为本，肝主藏血，体阴而用阳，性喜条达而忍抑郁，冲脉隶属于肝，司血海，为机体调节气血的枢纽。肝血不足，冲任失养，或情志抑郁，暴怒伤肝，疏泄失常，气血不和，冲任不能相资，以致不孕；或肝郁化火，郁热内蕴，伏于冲任，胞宫不能摄精成孕。因为情绪变化可以影响盆腔内脏含有的丰富的自律神经对卵巢血供、卵巢收缩、卵泡生长与排卵及输卵管蠕动功能的调节。

3. 痰湿 寒湿外侵，困扰脾胃，劳倦内伤，脾虚气弱，水湿内聚，蕴而化痰，或体质肥胖，恣食膏粱厚味，脾虚不运，痰湿内生，或肾虚气化失司，痰湿内生，流注下焦，滞于冲任，壅阻胞宫，气机不畅，不能摄精成孕。

4. 血瘀 七情所伤，情志抑郁，气机不畅，气滞血瘀；或经期产后余血未净，外邪入侵，宿血停滞成瘀；或感受寒邪，寒凝血瘀，或邪热灼津，血凝成瘀。更有气弱运血无力，血停成瘀。瘀血瘀滞胞脉，壅阻胞宫，两精不能结合，以致不孕。

5. 血虚 气血是月经的物质基础，素体虚弱，或久病大病，失血伤精，或脾运失职，生化乏源，气血亏损，冲任空虚，胞脉失养，不能摄精成孕。

6. 湿热 湿热可因脾虚生湿，遏而化热酿成；或因肝脾不和，土壅木郁而成；或恣食肥甘酿生；或淋雨涉水，久居湿地，或受湿邪熏蒸，蕴而化热，流注下焦，阻滞胞脉胞络，壅塞胞宫，而致不孕。或手术、产后、经期将养失宜，湿热之邪直接侵犯胞脉、胞络、子肠、阴户，壅塞胞宫，阻碍冲任以致不孕。



（二）西医认识

1. 排卵功能障碍 各种因素引起下丘脑-垂体-卵巢性腺轴功能或器质性异常都可影响排卵。主要表现为无排卵和黄体功能不全。

（1）无排卵：卵巢局部因素导致的无排卵有先天性卵巢发育不全，多囊卵巢综合征、卵巢功能早衰，功能性卵巢肿瘤如颗粒—卵泡膜细胞瘤等直接影响卵巢中卵子的发育、成熟和排出；卵巢子宫内膜异位症不但破坏卵巢组织，且可造成严重粘连而致不孕；席汉综合征、闭经溢乳综合征、高催乳素血症及一些全身性疾病如重度营养不良、过度肥胖或饮食中缺乏某些维生素特别是E、A和B，内分泌代谢疾病如甲状腺功能亢进或低下，肾上腺皮质功能失调，重症糖尿病等也能影响卵巢功能导致不排卵。

（2）黄体功能不全：黄体不全是由于促黄体生成激素分泌受到干扰，影响黄体的合成和孕酮的分泌，导致黄体分泌孕酮不足或黄体过早萎缩、受精卵发育异常，子宫内膜分泌反应不良影响受精卵着床。多见于经前期综合征、月经失调，即使妊娠也极易流产，因而导致不孕。

2. 输卵管因素 输卵管具有摄拾卵子、贮存卵子、并在此精卵结合、运送受精卵到宫腔植入子宫内膜的功能。输卵管阻塞是女性不孕的重要因素，有时输卵管的管腔虽然通畅但内膜被炎症破坏，管壁变僵硬，使内膜的纤毛运动及管壁的蠕动功能丧失，亦可影响精子与卵子的相遇及运送而致不孕；子宫内膜异位症引起输卵管粘连扭曲或瘢痕挛缩，使其挪动受到限制，影响伞端拣拾卵子造成不孕。输卵管发育不良、过长、过细或输卵管缺如等都可导致不孕。

3. 子宫因素 子宫发育异常、宫腔粘连、内膜急慢性炎症、子宫肌瘤、子宫内膜息肉、内膜分泌不良或手术创伤再生障碍、内膜结核等因素，或影响精子移行或影响精卵结合或影响受精卵着床而引起不孕。



4. 子宫颈因素 急、慢性宫颈炎时，宫颈黏液变黏稠，含有大量白细胞，影响精子的存活、活动和通过；宫颈息肉、宫颈肌瘤能堵塞子宫颈管，或宫颈口狭窄，可影响精子穿过导致不孕；子宫后倾，宫颈口朝上，也会减少精子进入宫颈口的机会，而降低受孕几率。

5. 外阴、阴道因素 处女膜闭锁，阴道横膈，先天性无阴道等畸形妨碍性生活；严重阴道炎症时，影响精子活力，缩短生存时间而影响受孕。

6. 免疫因素 主要有两种免疫情况影响受孕：一是同种免疫，精子、精浆、或受精卵，作为抗原物质，被阴道及子宫内膜吸收后，通过免疫反应产生抗体物质，使精子与卵子不能结合或受精卵不能着床。二是自身免疫，男性精子、精浆或女性卵子、生殖道分泌物、子宫内膜组织、激素等溢出自身生殖道而进入周围组织，造成自身的免疫反应，影响精子活力、卵泡成熟和排卵以及子宫内膜的正常周期，或阻止精卵结合和孕卵着床，而造成不孕。

7. 精神因素 如过度紧张、焦虑对丘脑下部-垂体-卵巢轴可产生影响，抑制排卵。其他如男女双方因素有缺乏性生活的知识；夫妇双方过分焦虑不孕而造成精神紧张等。

上述因素可单一，也可复合呈多元性地作用而产生不孕。

二、临床表现

（一）症状

1. 婚后2年以上不孕。

2. 不孕症病因的伴随症状

（1）排卵功能障碍引起的不孕：常伴有月经紊乱、闭经。

（2）多囊卵巢综合征引起的不孕：常伴有多毛痤疮、肥胖、月经稀发、闭经、色素沉着等。

（3）生殖器炎症引起的不孕：可有白带多、腹痛。



(4) 子宫肌瘤、子宫内膜异位、宫腔粘连引起的不孕常伴有痛经、月经失调、月经过多或过少、经期延长等。

(5) 高泌乳素血症或闭经溢乳综合症引起的不孕可见闭经、乳胀或溢乳等。

(二) 体征

随着不孕病因的不同，体征也表现各异。

(1) 多囊卵巢综合征者：有多毛痤疮、肥胖，妇检或腹腔镜检发现卵巢增大。

(2) 闭经溢乳综合症患者：可见单侧或双侧乳房溢乳。

(3) 盆腔炎者：可有下腹部压痛，妇检子宫活动受限或固定；输卵管炎者可有下腹部两侧压痛，在有输卵管增粗时，妇检在子宫的一侧或两侧可触及条索状物。盆腔结缔组织炎者，宫旁可扪及片状增厚、压痛，子宫骶韧带变硬增粗，或触及炎症包块，伴有盆腔静脉瘀血者可见宫颈呈淡蓝色。

(4) 子宫肌瘤、子宫腺肌瘤者：腹部触诊可触及下腹部包块，妇检可发现子宫增大、或子宫表面凹凸不平。

(5) 盆腔子宫内膜异位症典型者在妇检时：可发现子宫多后倾固定，直肠子宫陷凹、宫骶韧带或子宫后壁下段等部位扪及触痛性结节，在子宫的一侧或双侧附件处扪到与子宫相连的囊性偏实不活动包块，往往有轻压痛。

(6) 其他全身内分泌性疾病则见相应的疾病体征，如甲亢可见突眼、甲状腺肿等。

三、诊断与鉴别诊断

(一) 诊断要点

1. 病史

(1) 年龄和不孕时间、原发或继发：结婚年龄，男方年龄，健康状况，夫妇是否两地分居，性生活情况，婚后采用过何种避孕方法及其时间。



(2) 月经史：要注意初潮年龄，月经周期，经色、经量、经质，有无闭经、痛经、经少、或月经紊乱及其他不适。

(3) 过去史：了解有无生殖道感染性疾病、流产史、手术史、结核病尤其腹腔结核，幼年腮腺炎，是否有其他内分泌疾病，以及精神过度刺激、体重改变、严重不良嗜好如吸毒、酗酒等；对继发不孕应了解以往流产或分娩的经过，有无感染等。对工作性质及环境也应有所了解，以排除有毒物质及放射性物质的影响。

2. 症状 无避孕措施，同居 2 年以上而未怀孕。以及其他伴随症状。

3. 检查

(1) 全身检查：注意第二性征发育情况，甲状腺有无肿大，以及其他内分泌失调所引起的体征。

(2) 妇科检查：注意内、外生殖器的发育，有无畸形、炎症或包块等。

根据病史、症状体征、全身检查、妇科检查和辅助检查等，可对各种原因的不孕症作出诊断。

(二) 鉴别诊断

在不孕症的治疗过程中，应注意与暗产相鉴别。暗产是指早孕而流产，因孕早期妊娠反应不明显，孕妇已孕而不自知，当做一般月经，易被误诊为不孕症。可通过基础体温、早孕试验及其他检查发现暗产，与不孕症鉴别。

第 2 节 辨证论治

一、名家医案、医论

朱汝功

施某，女，34 岁，初诊 1977 年 11 月 29 日。结婚 10 年未孕。



1968 年结婚后有正常性生活，配偶健康，但一直未孕。于 1977 年 3 月 17 日赴上海市某妇产科医院检查：宫体中位，大小正常，宫颈、阴道均光滑，右侧骶骨韧带增粗。作诊断性刮宫，病理报告示：“分泌期子宫内膜”。施行“通液术”，发现双侧输卵管阻塞，诊为“原发性不孕症”。患者生育之望迫切，经人介绍来我院针灸治疗。诊得平素每月经前双乳作胀，乳头触痛，少腹胀滞难忍，经来颜色暗紫，量少，伴有两膝腿酸软，神疲乏力，胃纳不振，脉细弦，苔薄。证系肝郁气滞，冲任之脉失调，拟疏肝理气，通调冲任以观之。处方：①取穴：关元、气海、水道（双）、归来（双）、足三里（双）、内关（双）、太冲（双）。②手法：平针法，得气后加电，留针 20min，隔日 1 次。三诊：12 月 1 日。针治 2 次后，少腹胀痛减，但出现右肩关节沉重痠痛，守上方续治。处方：取穴、手法同前。七诊：12 月 15 日。经来少腹胀痛大减，经量较前增多，经色转鲜，双侧乳房胀痛亦瘥。两腿较前有力，舌脉同上，再守前意出入。处方：①取穴：气海、关元、水道（双）、归来（双）、三阴交（双）②手法：同前。十七诊：1978 年 1 月 17 日。本月临经，两乳房胀滞，乳头触痛较前减，少腹痛亦瘥，唯胃纳欠馨，右肩关节酸痛感尚存，舌脉同上，嘱其去妇产科复查，仍守上方投治。处方：取穴、手法同前。十八诊：1 月 21 日。1 月 19 日赴妇产科医院检查，再次作双侧输卵管通气术，当气体进入两侧输卵管，加压至 200 毫米汞柱时，腹部两侧均闻及水泡音，伴有胸闷、肩酸感觉，证实双侧输卵管通气良好。再守原方投治后，嘱停针观察。十九诊：5 月 25 日。自 1 月下旬作通气术诊断双侧输卵管已通畅后，每月经前经后带下如注，经前少腹胀痛更甚，双侧乳房仍有胀痛，胃纳不佳，脉弦苔薄。并称上次月经净为 4 月 13 日，至今经水未潮，伴有胸闷，胁胀，两乳胀滞疼痛，不思饮食。仍以调益冲任续治。处方：①取穴：关元、气冲（双）、足三里（双）、三阴交（双）、公孙（双）、太冲（双）、内关（双）。②手法：平针法，留针时间



同前。二十六诊：6月13日。月经迄今未潮，少腹胀痛尚存，胸院痞闷，泛恶，腰膝酸软，神疲纳差，脉弦带滑，苔薄。疑为有孕之象，嘱赴妇产科作妊娠试验，以和胃理气观之。处方：①取穴：内关（双）、公孙（双）、三阴交（双），②手法：平针法。二十七诊：6月20日。尿妊娠试验阳性，嘱停针随访观察。

《陆瘦燕朱汝功针灸学术经验选》

郑魁山

1952年3月20日在北京治一朱某，女，28岁。结婚5年未生育，丈夫健康。患者14岁月经初潮，1946年秋天游泳后小腹冷痛，腰腿酸痛，经期加剧，月经量少色暗，舌质淡、苔薄白，检查小腹凉，关元处有压痛。辨证系寒邪侵袭，客于胞宫，采用暖宫散寒、养血助孕之法，针关元俞、次髎用烧山火法，使热感传到小腹，不留针，天枢、气海、三阴交用热补法，使热感传到小腹和足趾，留针20min，每周3次，治疗到4月19日，针达12次时，月经来潮，血量血色正常，小腹冷痛明显好转。休息1周，继续按上述方法治疗到5月20日，月经未见来潮，亦无小腹冷痛、腰腿酸痛等症而停诊观察。7月1日其丈夫告之，经化验已怀孕，1953年6月寄来一男孩照片留念。

按：郑氏在治疗不孕症和不育症突出的特色是针刺手法。认为针灸治疗疾病应在选穴配方的基础上灵活应用手法，才能达到心手合一，手到病除。病例辨证为寒邪侵袭，客于胞宫不孕，采用热补法起到了温阳散寒的目的，疾病痊愈。热补法在操作时术者左手手指或拇指紧按针穴，右手将针刺入穴内，候其气至，左手加重压力，右手拇指向前连续捻按3~5次，候针下沉紧、针尖拉着有感觉的部位，连续急（重）插慢（轻）提3~5次；拇指再向前连续捻按3~5次；针尖顶着产生感觉的部位守气，使针下继续沉紧、产生热感。根据病情留针后，缓慢将针拔出，急扞针穴。实验证明，不但能使患者产生热感，而且能使皮肤温度



升高。

《郑氏针灸全集》

二、中药外治疗法

中药外敷微波并用治疗慢性附件炎并发不孕症

【药物组成】 丹参、透骨草、三棱、穿山甲、皂角刺、桂枝、刘寄奴、海藻、白芥子、红花各 30g。

【治疗方法】 上药用水充分浸润，数层纱布包好，放在盛有一定水量的盘中（水量的多少以取出药包时，无水滴下为宜），同放锅中蒸 20min，取出药包，凉至合适的温度后放于病变部位，用厚毛巾盖住药包，凉后再蒸，可反复数次。10d 为 1 个疗程。月经期间停做。配合微波治疗：采取天津产 LY—II 型多功能微波治疗机，最大输出功率 50W，圆形电极板置于病变输卵管部位，中间有隔热层，患者感觉温热为宜，每个部位治疗 20min，每日治疗 1~2 次，10d 为 1 个疗程。月经期间停做。

【功效主治】 活血化瘀，温经通脉，软坚散结。

【经验心得】 慢性附件炎大多是流产或宫外孕术后引起急性炎症未能彻底治疗转变成慢性，但更多的是由于起病缓慢，病情较轻未引起注意，故而治疗不及时，迁延成慢性，导致孕龄妇女不孕。慢性附件炎是输卵管、卵巢的炎症，输卵管是精卵结合的惟一场所，其功能正常是自然受孕的必要条件之一。慢性输卵管均存在着不同程度的粘连、变性和功能损伤，故易导致不孕症。目前现代医学缺乏治疗此病的理想治疗方法，因此，寻找一种无副作用和易于接受的方法尤为重要。中医认为本病主要是气滞血瘀所致。气机不畅，经络阻滞，气血运行不畅，胞络受阻，冲任失养，影响冲任及脏腑功能，不能摄精，妨碍精卵结合，故难受孕。

选用活血化瘀、温经通脉、软坚散结的药物外敷而治之。而



且中药外敷可通过局部皮肤相关穴位直接渗透和吸收,可循经入络,改善盆腔内的血液循环,抑制组织的增生,促进炎症的消散,这种方法方便实用,避免了口服药对胃肠道的刺激,易于病人接受;微波的热作用可以使机体组织血管扩张,细胞膜渗透性升高,改善局部组织营养代谢,促进组织再生,具有解痉、止痛、消炎的作用。两者结合更能提高治疗效果。

治验: 患者,女,29岁。主诉结婚已3年未孕。3年前行人工流产后出现下腹及腰骶疼痛下坠,白带增多,痛经,运动劳累后加重,未系统治疗。妇科检查:子宫前倾,活动尚可,双侧输卵管呈条索状,有压痛。白带常规检查正常,尿HCG检查阴性。B型超声检查提示:双侧附件增厚、增粗;输卵管通液试验显示:双侧不通。诊断为:慢性附件炎并不孕症。经采用上述方法治疗1个疗程后,症状明显减轻,继续完成3个疗程治疗,症状消失。休息1月后,作输卵管通液试验:双侧输卵管通畅。10月初来诊已怀孕。

【方剂出处】 高汉义,等. 中药外敷微波并用治疗慢性附件炎并发不孕症40例. 实用中医内科杂志,2005;19(5):479

中药灌肠辅助输卵管通液治疗继发性不孕

【药物组成】 皂角刺、川厚朴各15g,蒲公英、夜交藤各30g,生大黄10g。

【治疗方法】 患者于月经干净2~3d后,用地塞米松5mg,生理盐水40ml,庆大霉素1.2g,在20kPa的压力下,以每分钟1ml的速度缓慢注入,边注入边询问患者是否有感觉,若推注阻力大,液体外溢,患者疼痛难耐,则显示输卵管不通,嘱患者隔日再行手术,每周2次,直至排卵期前,可连用2~3周,同时用灌肠方,每晚1剂50~100ml保留灌肠,4周为1个疗程。

【功效主治】 清热活血。

【经验心得】 输卵管通液术为妇科常用手术,治疗因输卵管



炎性粘连、堵塞不通畅导致不孕，用地塞米松、庆大霉素有消炎、减轻局部充血、水肿，抑制纤维组织形成、溶解或软化的目的，而灌肠方的作用是活血破滞调冲止痛，二者合用，起到事半功倍的疗效。

【方剂出处】 王爱华. 中药灌肠辅助输卵管通液治疗继发性不孕 45 例. 医学理论与实践, 2005; 18 (6): 691-692

中药外敷法治疗输卵管阻塞不孕症

【药物组成】 鱼腥草 30g, 连翘 30g, 红藤 20g, 益母草 20g, 丹参 20g, 皂角刺 15g, 路路通 15g, 生甘草 10g。

【治疗方法】 上述中药 1 剂装入白色布袋中，并喷适量水在布袋上，隔水煮沸 30min，待适温后外敷在患侧腹部及腰骶部，每晚 1 次，约 1~3h，期间用热水袋加温。月经干净 3~5d 后即开始敷药，连续外敷 10~15 次。

【功效主治】 清热散结，活血化瘀，软坚通络。

【经验心得】 中药外敷法是中医妇科常用的外治法。本处方由鱼腥草、连翘、红藤、益母草、丹参、路路通、皂角刺等 8 味中药组成，具有清热散结、活血化瘀、软坚通络的功能。其外敷能促进局部静脉丛扩张，改善血液循环，促进粘连的组织软化并吸收，使管道疏通的目的，从而恢复输卵管“拾卵”及输送受精卵至宫腔的功能。

【方剂出处】 孙淑芳，等. 中药外敷法治疗输卵管阻塞不孕症的临床观察. 中华中医药杂志, 2005; 20 (2): 126

中药外熨加通液术治疗慢性输卵管炎不孕

【药物组成】 外熨药：黄柏 30g, 龙胆草 20g, 三棱 15g, 莪术 15g, 桂枝 15g, 牡蛎 30g。

通液药：庆大霉素针剂 8 万 U，地塞米松针剂 10mg，糜蛋白酶 4 000U，加生理盐水 15ml 混合后使用。



【随症加减】 输卵管炎性粘连者加败酱草 30g，蒲公英 30g；输卵管积水加滑石 30g，茯苓 30g；输卵管峡部结节加海藻 30g，昆布 30g。

【治疗方法】 ①外熨：取食盐 500g 置锅内炒热，根据不同证型选用该组药，加入盐中炒至药物焦黄为止（叶类药后下），用三层布包裹成袋。患者仰卧，把药袋放置病侧患处热熨 30min，若双侧病变者，将药袋加热，双侧各熨 30min（注意防止烫伤）。隔 4d 1 次，每个月经周期 6 次，经期停止。②通液术：月经净后 3d，术前 30min 肌注阿托品 0.5mg，在常规消毒下把上述混合液注入宫腔，隔日 1 次，每个月经周期 3 次，术后禁性生活及盆浴 2 周。

【功效主治】 清热解毒，活血化瘀，软坚散结。

【经验心得】 慢性输卵管炎是输卵管及周围组织水肿、粘连，导致输卵管阻塞而引起不孕。应用庆大霉素、地塞米松、糜蛋白酶宫腔注药，可以直接消除局部病灶，分解粘连组织，有一定疗效；而注药前 30min 肌注阿托品可以防止输卵管痉挛，保持较好的疗效。但由于宫腔注药易引起出血而影响疗效，故加用中药炒盐局部热熨，既保持中药清热解毒、活血化瘀、软坚散结的疗效；又借热力透达腹肌直达病所，加强局部血液循环的改善，使炎症水肿吸收，从而缩短疗程，取得了较好疗效。

治验：任某，女，26 岁。婚后 3 年未孕，月经及夫妻生活正常，诊时下腹坠痛，黄白带增多，舌稍红、苔薄黄腻，脉滑数。妇检：外阴（-），阴道通畅，黄带，宫颈滑，子宫后位，正常大小，双少腹压痛，可扪及增粗的输卵管。碘油造影提示：双侧输卵管粘连。诊断为：慢性输卵管炎性粘连阻塞、原发性不孕。遂于该次月经净后用清热燥湿、活血散结等中药外熨加通液术，起初患者反映较为疼痛，第 1 个疗程后疼痛逐渐减轻，3 个疗程后碘油造影示双侧输卵管通畅，次年顺产一女婴。

【方剂出处】 谢爱春，等. 中药外熨加通液术治疗慢性输卵



管炎不孕 68 例. 中医外治杂志, 1999; 8 (1): 5

三、针灸疗法

育肾汤配合针灸治疗不孕症

【药物组成】 当归 15g, 白术 12g, 茯苓 10g, 熟地黄 10g, 菟丝子 15g, 淫羊藿 12g, 赤芍 12g, 皂角刺 10g, 穿山甲 9g, 鸡血藤 20g, 香附 12g, 丹参 25g。

【穴位选择】 中极、关元、子宫、三阴交。

【随症加减】 有寒象者加天南星 5g, 细辛 3g, 徐长卿 12g; 有湿热者去淫羊藿加红藤 20g, 败酱草 25g, 薏苡仁 15g, 苍术 10g; 肾阳不足者加巴戟天 10g, 熟附片 6g, 肉桂 6g; 肾阴亏损者加女贞子 12g, 墨旱莲 18g, 龟甲胶 15g, 枸杞子 12g。

【治疗方法】 每日 1 剂, 水煎分 2 次服。20d 为 1 个疗程。经期停服。配合针灸疗法。在月经周期第 14d 开始行电针, 每日 1 次, 共 3 次。进针得气后通电, 用脉冲波, 频率 3Hz, 电流强度 $< 5\text{mA}$, 通电 30min。在针中极、子宫穴时, 应使针感放射至下腹部两侧和外阴部; 针三阴交时应使产生针感麻至足。

【功效主治】 温肾、补气、养血。

【经验心得】 方中当归、熟地黄、茯苓、白术益气养血; 丹参、香附、赤芍、鸡血藤理气和血调经; 菟丝子、淫羊藿温养肝肾、助阳益精; 穿山甲、皂角刺性善走窜, 通络搜风, 为疏通要药。现代医学研究证实补肾活血中药当归、白芍、熟地黄、皂角刺等能降低雄激素水平, 改善卵巢微循环, 调节纠正下丘脑-垂体-卵巢轴的功能失调。针灸取中极、关元穴调补冲任; 三阴交穴是足三阴经的会穴, 有培补肾气, 调理三阴经气的作用; 子宫穴为经外奇穴, 为治疗女性生殖系统病的经验穴。据报道, 针刺上述穴位可传至中枢大脑皮质、间脑而促进垂体分泌和释放黄体激素, 从而达到人工排卵的目的。



治验：徐某，女，26岁，已婚。诉结婚3年，夫妻同居，未避孕。月经14岁初潮，周期28~30/3~5d，月经量少、色红、无血块，经期小腹坠痛。平素带下量时多时少，色白或黄，外阴无瘙痒。曾做B超显示子宫、附件未见异常，做输卵管通液术示通畅，曾服中西药治疗未获受孕。舌质偏红，苔少，脉细数。妇科检查外阴、阴道、子宫颈未见异常，子宫体前位，正常大小，双侧附件区未触及异常。男方查精液常规未见异常。诊断为原发性不孕。即给育肾汤基本方加女贞子15g，墨旱莲15g，牡丹皮10g水煎服，每日1剂，共服40剂。同时配合针刺疗法，取穴三阴交、中极、关元、子宫穴。治疗后带下明显减少，原方继续服1个疗程后，经期、白带均转正常。停药药物及针刺2个月经周期后怀孕，足月分娩一健康男婴。

【方剂出处】陈大春. 育肾汤配合针灸治疗不孕症18例. 中国民间疗法, 2004; 12(2): 20-21

针刺推拿法治疗痛经伴不孕

【穴位选择】头针：尿殖区双侧，精神情感区双侧；耳针：卵巢、过敏点、神门；体针：关元、三阴交。

【治疗方法】患者仰卧，用强刺激间歇运针，留针20min。配合推拿手法：患者俯卧①用轻柔的滚法放松腰部，继而寻找痛点或痛结，用深沉的一指禅或用指拨法推消揉散痛点或结点；②按摩背部俞穴，先用双手拇指按揉法，自上而下，重点以膈俞、肝俞、脾俞、胃俞、三焦俞、肾俞、气海俞、关元俞、八髋处，穴位要准，按压要稳，由浅入深，由轻至重，缓缓加力，静中有动，多用轻微快速的震颤，以求刚柔相济；③术者位于患者左侧，双手掌放于患者腰部两侧，边推边揉直至尾椎，再用拇指指腹顺腰椎横突方向推揉至髂腰部，二者往返24次。并同时弹拨腰筋（腹内斜肌）、背筋（骶棘肌）、腘腿筋（股内收肌）及腘窝部肌；④捏拿腰骶，术者双手拇示指作钳状，自第7胸椎至尾椎，



沿正中线交替捏拿其皮肤 8 遍；⑤直擦背部督脉及横擦腰骶部八髎穴，斜擦小腹两侧均以透热为度

【功效主治】 疏通气血。

【经验心得】 五步推拿加（头、耳、体）针刺，头针、耳针、体针是在中医学基础上表示一种特定部位治疗多种病症的方法，使作用区、点通过神经体液调解而引起生物物理和生物化学变化，从而产生一系列病理生理过程的改变，疏通气血调整冲任，达到治疗效果。在推拿中医者要心静，手法由轻到重，做到轻而不浮，重而不滞，每穴操作不少于 2min。治疗最佳期为月经来潮前 1 周，治疗 4 次经净后治疗 5 次，每月按期医治，连续 4 个月，做到诊断明确，手法稳妥，力度适当，配穴精要，取穴准确。

治验：尹某，女，28 岁，主诉：经前及经期腹痛 9 年，每于行经前 2~3d 即小腹胀痛，至行经期剧痛，并向肛门及大腿内侧放射，伴恶心呕吐，汗出，乳房胀痛，精神郁闷，经量少，色暗红，有块质稠，当血块及膜样物排出后痛减。曾在市一院诊为原发性膜样痛经。已婚 3 年未孕，就诊时正值痛经，脉弦紧，舌质绛有瘀点。经上法治疗，2 次后痛减，4 次后痛除，7 次后诸证消而月经来潮。此后仍按前法继续治疗 3 个月经周期，治疗期及行经期末再腹痛，亦无膜样物排出。6 个月后患者痛经未再复发，受孕已 4 个月。

【方剂出处】 董飞，等. 针刺推拿法治疗痛经伴不孕 8 例. 中医药信息，1998；（1）：49

针刺卵巢穴治疗卵子滞留症

【穴位选择】 卵巢穴。定位在耻骨联合中点上 3 横指旁开 4 横指处（即子宫穴上 1.5 寸）。

【治疗方法】 每位患者从月经周期的第 11 天开始 B 超监测卵泡，每日 1 次，当卵泡发育成熟（卵泡直径在 20mm 以上）时，开始进行治疗。针刺前令患者小便，排空膀胱，取卵泡成熟侧（或



双侧)“卵巢穴”。局部严格皮肤消毒,选用长 10cm 直径 0.45mm,消毒后的毫针(针灸针)垂直刺入,深度可根据病人的体型适当调整,一般可刺 5~8cm,并反复提插捻转,至局部出现酸胀麻重,针感向外生殖器放射,留针 30min。35h 后 B 超复查,根据卵泡是否消失,决定是否治疗,卵泡不消失者,按上法继续治疗,针刺最多不超过 3 次。

【功效主治】 滋阴活血。

【经验心得】 目前认为成熟卵泡不破裂其主要原因是 LH/FSH 峰值偏低,使上述 1~3 个环节发生障碍,卵子不能从卵泡中逸出,造成了女性不孕。现代医学对该症的治疗,多采用人工造成 LH/FSH 峰,但在用药时间和药物剂量上有时难以准确掌握,长期应用或剂量过大可造成卵巢增大及滤泡囊肿,严重者可并发卵巢过度刺激综合征(OHSS)和内分泌失调疾病。

针刺有整体调节和局部刺激两大作用。现代的实验研究已证实针刺对体内性腺激素有双向调节作用,针刺通过兴奋下丘脑—垂体系统使性腺激素分泌增加,使 LH/FSH 恢复正常,从而激发卵泡破裂的一系列内分泌变化,引起卵泡破裂而排卵。另一方面针刺卵巢穴,使卵巢平滑肌收缩,促进了卵泡壁的破裂而排卵。其详尽的作用机理,有待于今后深入研究。

【方剂出处】 魏虹,等. 针刺卵巢穴治疗卵子滞留症 38 例临床观察. 潍坊医学院学报, 1998; 20 (4): 289

针灸配合耳穴贴压治疗不孕症

【穴位选择】 体针:主穴取关元、气海、中极、四满、子宫、神阙、三阴交、次髎、命门。耳穴:取肝、肾、神门、内生殖器(子宫)、卵巢、肾上腺、皮质下,内分泌。加减:体穴:肾虚加太溪、肾俞;肝郁加合谷;气血亏虚加血海、膈俞。

【治疗方法】 每次选体穴 6~8 个。手法均用补法,其中神阙穴只灸不针,针刺关元、中极、子宫穴时,针尖斜向内下方,



进针 1~2 寸左右，要求使针感下传至会阴部，每日 1 次，留针 1h，10d 为 1 个疗程。用王不留行进行耳穴贴压，每日按压 3~5 次，每次 5~10min，双耳交替，3d 换贴 1 次或隔日换 1 次。

【功效主治】 调和肝脾，补肾活血。

【经验心得】 中医学认为不孕与肝、肾关系密切，并与冲任两经病变或脏腑气血不和影响胞脉功能有关，故体针多选以下腹部和骶骨部接近盆腔脏器穴位为主，采用疏通经脉，调理冲任为治疗原则，并配合调和肝脾、补肾活血的三阴交、肾俞等穴。另外，耳为宗脉之所聚，与五脏六腑关系密切，贴敷肝、肾、内分泌、皮质下等耳穴，与现代医学可以调节下丘脑-垂体-卵巢性腺轴密切相关，可见体针与耳穴贴敷合用可以调节垂体功能，提高雌激素水平，促进排卵而受孕。

治验：王某，29 岁。主诉：结婚 3 年未孕，月经周期正常，量中等。经妇科确诊为原发性不孕。治疗：体针取穴 1 组：关元、神阙、中极、三阴交、合谷；2 组：命门、子宫、气海、膈俞，二组交替使用，同时配合耳穴贴压子宫、皮质下、肾上腺、内分泌、肝、肾。按上法治疗 3 个月，该患受孕，随访足月产一女婴。

【方剂出处】 李晓宁，等. 针灸配合耳穴贴压治疗不孕症 28 例. 针灸临床杂志，1999；15（2）：10

针灸治疗卵巢早衰不孕症

【穴位选择】 关元、中极、大赫、子宫、肾俞及胸 5~腰 4 夹脊穴。加减：肝肾阴虚者加三阴交、阴陵泉、肝俞、阴郄、复溜。脾肾阳虚者加脾俞、命门、次髎、地机。

【治疗方法】 用补法，先用指弹进针，得气后留针 20min，脾肾阳虚者加温针灸，出针后背俞及夹脊穴拔火罐 5~10min。20 次为 1 个疗程、休息 5~7d 进行下 1 个疗程，6 个疗程为限。

【功效主治】 补益脾肾，通调气血。

【经验心得】 卵巢功能早衰是生殖功能降低或停止的一种表



现,与生理性绝经十分相似,故由称之为早期绝经或早发更年期。随着体内性激素水平的降低,人体会出现一系列自主神经功能代谢失调症状。卵巢功能早衰导致的卵巢组织学退变和生理功能的改变也为继发其他疾病提供了条件。本病的治疗尚缺乏理想的方法,病人多数因出现闭经症状或要求生育而就诊。

针灸治疗对人体垂体促性腺激素的作用比较持久,停止治疗后较长时间内效应明显,而西药激素治疗虽然近期也有较明显作用,但停药后效应不够持久。通过一系列临床和动物实验研究证实,针灸对垂体分泌功能及生殖内分泌功能的影响主要是针灸能激活脑内多巴胺系统,调整下丘脑-垂体-卵巢的自身功能,使自身功能恢复,生殖内分泌恢复正常,生理的动态平衡,因而作用持久疗效好。

【方剂出处】 沙桂娥,等. 针灸治疗卵巢早衰不孕症 84 例的临床研究. 针灸临床杂志, 1998; 14 (6): 16

针灸治疗输卵管炎性不孕

【穴位选择】 关元、归来、中极、子宫、大赫、足三里、三阴交、肾俞。加减: 气滞血瘀者配血海、肝俞; 下焦湿热者配曲骨、次髎。

【治疗方法】 选用 28 号不锈钢毫针, 虚证用补法, 紧按慢提(力向下), 同时搓针; 实证用泻法, 先紧提慢按(力向上), 同时用飞针之法。得气后, 控制针感使气至病所, 下腹部腧穴针感要达会阴部, 下肢穴位针感达到少腹部。留针 20min, 同时用艾条灸腹部穴位 20~30min, 每日 1 次, 10 次为 1 个疗程。

【功效主治】 活血化瘀, 消癥散结。

【经验心得】 输卵管炎性不孕是由输卵管炎性阻塞而导致的, 其病因病机无非邪气内侵, 湿热蕴积, 轻则影响胞宫生理功能, 重则毒邪内聚客居不去则生癥瘕; 或气滞血瘀, 经脉不畅, 影响气血循环而阻塞输卵管, 妨碍正常妊娠。而针灸的活血化瘀



作用解除了微循环障碍，改善微循环功能和血液流变学的性质，从而促进炎性、坏死组织的吸收和消退，加快组织的修复和再生，有利于输卵管的畅通。因此，活血化瘀、消癥散结是治疗输卵管炎性不孕的关键。

【方剂出处】沙桂娥，等。针灸治疗输卵管炎性不孕 78 例临床观察。河北中医，2000；24（12）：960

针灸治疗女性不孕症 1

【穴位选择】关元、气海、中极、四满、大赫、神阙、肾俞（双）、命门、次髎（双）、太溪。加减：肝气郁结者加合谷、太冲；寒凝血瘀者加膈俞穴，并增加艾灸时间 20~30min；气血不足者加血海、膈俞；肾气亏虚者加太溪，并对腰 5 穴加灸时间 20~30min。

【治疗方法】手法均用补法，神阙穴只灸不针，腹部穴位均用温盒灸，针关元穴时须使针尖向下进针 2 寸左右，要求针感向会阴扩散。针刺须在患者排空膀胱后进行。腰部 5 穴也用针上加温盒灸。针次髎穴使针感传至骶尾部，最好传至会阴。每次留针 1h。10~15d 为 1 个疗程，疗程间可休息 3~10d。治疗于每月经后 12d 左右进行。注重精神调护，树立患者信心，使其对医生有高度的信任。

【功效主治】疏肝理气，活血化瘀。

【经验心得】不孕症多与肝、脾、肾关系密切，与冲任失和有关。取穴则以任、冲两脉为主。故穴取关元、气海、中极、四满、大赫。虽然把临床各症皆归于冲任失和。但临床又常分肾虚、肝郁、血瘀、痰湿，治疗时不仅要理冲任，而且要针对肾虚则补肾，肝郁则疏肝，血瘀则活血，痰湿则燥湿化痰。针灸到时到位，到时是指针灸留针时间及艾灸时间须给足。到位是指穴位针感必须到位，尤指关元、次髎两穴针感须达到预期的部位。临床配合温盒灸，不仅简便易行，患者易接受，而且热力透达，疗效好。



临床体会热力以透达至少腹为佳，灸时不少于 30min。针灸治疗于每次经后 12d 左右进行，因为排卵大多发生于 2 次月经中间。只有抓住适当的针灸时机，促进排卵，增加受孕机会，才能使疗效更著。

【方剂出处】 常静玲. 针灸治疗女性不孕症 32 例. 上海针灸杂志, 1998; 17 (1): 26

针灸治疗女性不孕症 2

【穴位选择】 至阴、足三里、关元、子宫。

【治疗方法】 用普通艾条灸上穴，灸至局部皮肤起红晕为度，每次灸需 30~40min，从月经干净后开始灸至下次月经来潮为止，每日 1~2 次。配合针刺，在每次月经来潮的第 10 天开始采用毫针刺，针足三里、关元、子宫穴。行以补法，以得气（酸、胀等感觉）为准，每次留针 30min。隔日 1 次，至患者基础体温升高（黄体期）后即停针刺，一般每个周期针刺 3 次。以上针灸并用，3 个月为 1 个疗程。

【功效主治】 温肾益气，调补冲任。

【经验心得】 在针灸处方时，根据肾与膀胱相表里及五输穴的子母补泻原理，用膀胱经的至阴穴为主以补金生水，益肾生精。配合使用足阳明胃经之足三里温补气血，使气血生化有源，以后天助先天。选用的关元穴为任脉与足三阴经之交会穴，具有培补元气，温肾暖宫之效。子宫穴为治该病之经验穴。诸穴合用，加之艾条本身具有温阳，调理气血的作用共奏温肾益气，调补冲任之功。在针刺时间上，根据妇女生理上周期性的特点，以基础体温监测排卵，并在排卵前给予针刺以促进排卵。针法与灸法并用，提高了疗效。

治验：周某，女，33 岁。结婚 5 年未孕，曾于 1984 年在上海、南京等有关医院检查诊治，未能获效。月经 17 岁初潮，周期为 28~32/4~6d，量少色淡或紫，无块，无痛经史。刻下面色



萎黄，头晕耳鸣，腰酸乏力，素体怕冷，性欲淡漠，两便正常，苔薄白，脉细。妇科检查无异常，输卵管通水通畅，1986年以来测得的基础体温显示黄体功能不良（基础体温呈阶梯式上升，且不稳，黄体期少于11d）。四诊合参，此乃肾虚不足，冲任空虚，胞宫失养。治拟温肾益气，调补冲任。经上法治疗2个月后肾虚症状明显改善，且其基础体温显示黄体期增至14d，升高后的体温曲线较为平稳。经治3个月以后未再来治疗。后经随访获知，该妇女于第3个月治疗后即受孕妊娠。

【方剂出处】 施振东，等。针灸治疗女性不孕症30例。上海针灸杂志，1994；13（1）：15

针药结合治疗输卵管梗阻性不孕

【穴位选择】 关元、中极、子宫穴、三阴交、地机、内关。

【治疗方法】 每次月经过后3d治疗，平补平泻，留针20min，每日1次，10次为1个疗程。针刺的同时开始内服汤剂，川芎9g，当归12g，生地黄9g，赤芍9g，黄芪15g，王不留行9g，党参12g，连翘15g，每日1剂，10剂为1个疗程。

【功效主治】 活血化瘀。

【经验心得】 不孕症患者中有20%~30%是由于输卵管因素所致，其中输卵管梗阻是最常见的原因。人工流产、药物流产后发生的感染是输卵管梗阻的主要原因之一。针刺疗法可以直接作用病所，改善局部的血液循环，与中草药配合能明显缩短治疗时间，妊娠率高。

治验：李某，女，33岁。主诉：人流术后5年未孕。现病史：1997年妊娠50d在医院做人工流产，术后未出现明显不适。之后3年未孕，经子宫输卵管碘油造影示右侧输卵管伞端粘连，双侧输卵管不通。行通液术6次，腹腔镜手术1次，2月前再次行子宫输卵管造影示双侧输卵管不通。查：外阴未产型，阴道（-）、宫颈（-）、子宫前位、双侧附件轻度压痛。诊断为继发性不孕



(双侧输卵管梗阻)。经上述治疗 6 个疗程后妊娠, 顺产 1 子。

【方剂出处】赵荣. 针药结合治疗输卵管梗阻性不孕 20 例. 针灸临床杂志, 2004; 20 (1): 22

针药并举治疗输卵管阻塞性不孕

【药物组成】三棱、莪术、穿山甲(先煎)各 10g, 海藻、昆布、蒲公英、败酱草各 15g, 黄芪 30g。加减: 伴肾虚加仙茅、淫羊藿; 伴肾阴虚加女贞子、墨旱莲; 肝郁气滞加香附; 伴痰湿加苍术、半夏; 伴湿热加茵陈、黄柏。

【穴位选择】石门、关元、水道、三阴交、太溪。

【治疗方法】于月经干净后开始连服 15 剂为 1 个疗程。针灸平补平泻手法, 留针 30min, 每日 1 次, 10 次为 1 个疗程。中药针灸各治疗 3 个疗程。

【功效主治】活血化瘀, 软坚散结, 清热解毒。

【经验心得】输卵管阻塞性不孕, 多因经期、流产、产褥期摄生不慎或日常生活不知慎戒, 感受邪毒, 入侵胞脉, 胞脉阻滞, 不能摄精成孕。治以活血化瘀通络、软坚散结、清热解毒。故以三棱、莪术、穿山甲活血化瘀通络; 海藻、昆布软坚散结; 蒲公英、败酱草清热解毒; 黄芪益气扶正。中医学认为“肾主生殖”“胞络者, 系于肾”“任主胞胎”, 脾胃为后天之本, 气血生化之源, 气血和调, 方能摄精成孕, 故针灸取肾经之太溪、石关, 任脉之关元, 脾经之三阴交, 胃经之水道。

活血化瘀药物能改善局部血液微循环, 促进巨噬细胞增多, 并活跃其功能, 有效地使粘连组织松解, 有利于输卵管复通。中药药理学研究证实, 三棱、莪术、穿山甲, 具有减小血管阻力、增加血流量、改善微循环的作用; 海藻、昆布, 含有多量碘, 碘化物进入组织及血液后, 能促进炎症渗出物的吸出, 并能使病态的组织崩溃和溶解。

【方剂出处】梁燕, 等. 针药并举治疗输卵管阻塞性不孕 36



例. 辽宁中医杂志, 2001; 28 (5): 294

温针灸治疗痛经不孕

【穴位选择】 气海, 关元, 子宫穴 (双侧)。

【操作方法】 嘱患者排空小便, 腹部常规消毒后, 术者用 1.5~3 寸的毫针针刺患者气海、关元、双侧子宫穴, 深度因患者胖瘦而定。待出现酸胀感后, 取四段 1 寸长的艾条, 用牙签扎孔后, 套在针柄上, 针孔处垫 4 块纸板, 以防烫伤。从艾条下端点燃艾条, 至艾条灰烬完全熄灭后起针, 每次持续大约 30min。月经前 1~2d 或行经疼痛时针刺均可, 针刺后疼痛不减者, 次日再针, 直至完全止痛。每个月行经前或行经期疼痛者继续下 1 个疗程。患者行经期间注意情志愉悦, 避免受凉, 不吃生冷饮食, 多吃蔬菜, 保持大便通畅。

【功效主治】 温经散寒, 调气行血。

【经验心得】 选取气海、关元、双侧子宫穴, 乃因气海, 关元为任脉经穴, 通于胞宫。针刺气海, 能补气调气行血, 调理冲任; 针刺关元, 有益精血、补肝肾、养冲任之功。双侧子宫穴为经外奇穴, 为女子蓄血之处, 针刺子宫穴, 能活血调经。加之艾灸能温经散寒、活血通络, 故而针灸并用, 双重刺激穴位, 可达温经散寒、调气行血、补养冲任的目的, 使胞中经血得以畅通, 痛经因而缓解。

治验: 张某, 女, 25 岁, 已婚未孕。自诉每次月经来潮前 1d 开始小腹疼痛, 痛连腰骶部, 得热痛减, 按之痛甚, 经血量少色黯有血块。诊为痛经。此次痛经症状如前, 舌淡胖有瘀点, 脉沉涩。辨为寒凝血瘀。经上法治疗后, 疼痛有所缓解, 续治 3d 后, 疼痛消失。但此后月经来潮前 1~2d, 腹部仍然疼痛。续以温针灸治疗 5 个月经周期, 疼痛缓解。随访半年未见复发, 后怀孕生子。

【方剂出处】 严桂芳. 温针灸治疗痛经 160 例. 湖北中医杂志, 2002; 24 (10): 51



耳压配合中药治疗子宫内膜异位症痛经

【穴位选择】 皮质下、内分泌、交感、神门、肝、肾、内生殖器、庭中。

【药物组成】 丹参、赤芍、三棱、莪术、枳壳、香附、生黄芪、柴胡、白术、山药。

【操作方法】 行经前 5d 开始，耳郭常规消毒后，以中药王不留行子埋压，每日按压 3~5 次，每次 30min 左右，每 2d 换埋药 1 次，两耳交替治疗共 5 次，每 2 个月经周期为 1 个疗程。中药煎剂以活血化瘀、疏肝理气、补脾益肾辨证组方，行经前 5d 煎服，每 2d 1 剂，共服 5 剂，每 2 个月经周期为 1 个疗程。

【功效主治】 活血化瘀，疏通经络。

【经验心得】 子宫内膜异位症的发病机制是下焦寒凝气滞，血瘀。病因多由忧怒伤肝，七情抑郁，气机不畅，引起气滞血瘀；忧思伤脾，脾失健运，劳伤气血，气虚血滞。离经之血流注经络脏腑，凝聚壅塞胞宫，积聚日久，形成节结、肿块。痛经是本病的主要症状，通则不痛，不通则痛，故治疗原则以活血祛瘀，疏肝理气健脾胃，益气补肾，消肿散结，进行个体辨证治疗。“耳者，肾之官”。女子以肾为本，耳与冲、任脉，肾脏关系密切，同时耳穴有自身的特异性，与全身脏腑经络有密切关系，选用耳穴内分泌、皮质下、肾、肝、内生殖器、庭中等穴治疗，调节脏腑经络、冲任脉功能，改善全身血液循环，达到活血化瘀，疏通经络，同时调节内分泌及神经体液等方面代谢。对子宫内膜异位症引起的痛经这一特征性症状起到较理想的治疗作用。

治验：张某，女，24 岁。以月经不调、行经腹痛，经妇科检查、B 超检查，在盆腔内子宫右侧探及 2.5cm×2.3cm×2.0cm 包块，提示子宫内膜异位症（巧克力囊肿），在当地予中西医结合治疗，痛经未见好转来诊，自诉 1999 年 5 月结婚，月经周期正常，婚后第 1 次行经痛经加剧，月经量多，色暗红，有血块。面色无华，



形体适中，舌质淡黯，舌边瘀点，苔薄白，脉细弦。妇检子宫中位，大小正常，质稍硬，活动欠佳，子宫右侧可触及约鸽蛋大肿块，表面光滑，活动尚可，压痛明显，B超检查提示右侧可探及 $2.3\text{cm} \times 2.8\text{cm} \times 2.2\text{cm}$ 巧克力囊肿。诊断为子宫内膜异位症。中医诊断为痛经、癥瘕，辨证属虚邪实证，气血凝滞，肾精不足。治以活血化瘀通络，舒肝健脾，补气益肾。耳穴埋药按压，取穴：皮质下、交感、内生殖器、庭中、内分泌、肾、肝，在行经前5d中药煎剂口服同时治疗。治疗第1个疗程，痛经明显减轻，月经量稍减，血块减少，连续治疗3个疗程，痛经消失，妇科检查子宫活动正常，双侧附件阴性，B超提示，子宫双侧附件正常。2001年2月来诊，自诉停经60余天，有早孕反应，B超提示：早孕单胎存活，符合停经天数。

【方剂出处】李媛枫，等．耳压配合中药治疗子宫内膜异位症痛经8例．辽宁中医杂志，2002；29（3）：144

腹丛刺为主治疗慢性附件炎并发不孕症

【治疗方法】以腹丛刺为主，配穴取足三里、三阴交。腹丛刺取穴法：以中极穴为 midpoint，向左右两侧各找一点，即髂前上棘向内侧旁开2寸，连成1条弧线，左右共分成4等分，共9个刺激点。用25~40mm毫针直刺约15~25mm，以不刺破腹膜为度，只行提插手手法，不作捻转，似滞针状即可；其他穴位用40~50mm毫针直刺，平补平泻。

【功效主治】理气血、化瘀滞、调冲任、理胞络。

【经验心得】本病定位在肝、脾、冲、任，还兼及带脉和肾。笔者拟定了慢性附件炎并发不孕症的腹丛刺疗法，本法基于解剖学、经络学及症状局部多针刺法等，遵照中医辨证论治的理论，结合病人实际的证候，分析病变的部位、原因和性质，依据“急则治其标，缓则治其本”，重点针刺解决患者慢性附件炎的各种临床症状，以创造妊娠的条件。慢性附件炎并发不孕症大多病程长，故祛



邪行气活血通络佐以扶正为其治疗大法。腹丛刺连成的弧线，与肝、脾、肾、冲、任、带脉相交，既是疾病疼痛的部位，又是子宫附件体表投影所在，因此腹丛刺具有理气血、化瘀滞、调冲任、理胞络、补下元、健脾胃的功能；配足三里、三阴交既激发脾经之气，又助活血化瘀行滞之功，瘀去血行，经脉调和，冲为血海，任主胞胎，二脉与孕育关系密切，冲任已调，月经按时已下，故能有子。

治验：唐某，27岁，已婚。2001年8月3日就诊。主诉：下腹及腰骶疼痛下坠3年。3年前行“人工流产”后出现下腹及腰骶疼痛，性交时痛甚，未引起注意。因2年多未孕，赴广州南方医院就诊，经尿HCG检查、B型超声检查及输卵管造影检查，诊断为“继发性不孕症（慢性附件炎，双侧输卵管不通）”。患者被告知无特殊治疗方法，要求她做试管婴儿，患者拒绝。遂返回茂名市人民医院妇科求治，妇科医生介绍她来我科针灸门诊治疗。症见：不孕，下腹及腰骶疼痛下坠，月经量少，淋漓不尽，白带增多，神疲乏力，舌淡苔薄白，脉弦细。妇科检查：子宫前倾，活动尚可，双侧输卵管呈条索状有压痛。白带常规检查正常，尿HCG检查阴性。B型超声检查示：双侧附件增厚、增粗。诊断：慢性附件炎并不孕症（气滞血瘀型）。经采用腹丛刺方法治疗1疗程，B超检查示：左侧附件基本正常。患者信心倍增，继续完成3个疗程治疗，休息1个月后，做输卵管通水试验：双侧输卵管通畅。12月初来告知已有身孕。

【方剂出处】洪建云，等．腹丛刺为主治疗慢性附件炎并发不孕症疗效观察．中国针灸，2004；24（9）：593

四、简方疗法

方1

黄丹 6g，白胡椒 50g，小茴香 100g，共研细，装入纱布袋中，贴敷脐部，腰带固定。每10d更换1次。一般1次即孕。本方宜



于寒性不孕者。黄丹即铅丹、广丹，系铅加工制成的四氧化三铅粉末，其辛咸，有毒，功专拔毒生肌，治痈疽疔疮。操作时慎防入口。

方2

柴胡 20g，当归 20g，小茴香 20g，川芎 20g，牛膝 30g，茯苓 30g，白芍 30g，香附 25g，附子 10g，郁金 15g，青皮 15g，益母草 15g，熟地 35g，共研细粉，用麻油调成膏状。取 5g 填脐，胶布固定。每 3d 更换 1 次。一般连用 30 次即可受孕。本方宜于无器质性疾病而仅因月经不调等引起的不孕者。

方3

按揉生殖腺穴 3min；按揉双侧肝俞、脾俞、肾俞穴各 2min；按揉三阴交穴 3min。适用于女性不孕症。

第6章 乳腺增生

第1节概述

乳腺增生病也称慢性乳腺病（简称乳腺病，mastopathy）和乳腺结构不良综合征。是指腺管周围增生并伴有大小不等的囊肿形成；或腺管内表现为不同程度的乳头状增生，伴乳管囊性扩张。也有发生于小叶实质者，主要为乳管及腺泡上皮增生。本病属中医的“乳癖”“乳粟”“奶癖”“乳痞”。

一、病因病机

1. 情志内伤，肝郁气滞 情志不畅，肝气郁结，横逆犯胃，致肝胃不和，气机不畅，气滞血瘀，阻于乳络而发癖。

2. 脾失健运、痰气凝结 脾胃素虚，或饮食不节，忧思伤脾，或郁怒伤肝，肝木克脾土，致脾不健运，水湿不运，聚而为痰，痰阻于乳络而发癖。

3. 肝郁肾虚、冲任失调 肾为五脏之本，肾气激发冲任通盛，冲任下起胞宫，上连乳房。先天肾气不足，或后天劳损伤肾，可致冲任不调。肝失涵养，木气不舒，气血瘀滞，结于乳络而发癖。

现代研究表明“乳腺增生病又称乳腺结构不良，是乳腺主质



和间质不同程度地增生及复旧不全所致的乳腺结构在数量和形态上的异常，常形成可触及的肿块，既非炎症，也非肿瘤。乳腺增生病出现周期性的激素分泌失调是发病的主要原因。具体表现在黄体期雌二醇水平显著高于正常妇女，而孕酮水平偏低，这种雌孕激素平衡的失调，使雌激素长期刺激乳腺组织，而无孕激素的节制和保护作用从而导致乳腺增生。

二、临床表现

1. 好发年龄为 30~45 岁左右的中年妇女

2. 乳房疼痛 大多表现为排卵期到经前期的胀痛，一侧或双侧，痛可牵涉到腋下、背部，这种与月经周期相关的疼痛称为周期性疼痛。也有表现为持续性疼痛或无规律性疼痛，或无明显疼痛。

3. 乳房肿块 乳腺增生病不属肿瘤，临床表现的非肿瘤性质的肿块有以下特点：质地不一，大小不一，形态不一，边界不清，无粘连，活动度好。肿块的出现是由于乳腺结构数量和形态的变化形成了多形性，临床触诊时多见结节状、片状、颗粒状、条索状、混合状。肿块形态多变，但无确切的边界。质地随乳腺增生的早期（小叶增生期）可以较软，中期（纤维腺病期）较韧，晚期（纤维化期）较硬。并在早、中期的增生结块可随月经周期的变化增大或缩小，晚期则变化不大。

4. 伴随症状 有部分的患者可出现乳头溢液，单侧或双侧，单孔或多孔，色淡清或淡黄，量不多；有的可出现周期性乳头、乳晕处瘙痒；有的可出现月经不规律，色、量的变化等。

三、诊断与鉴别诊断

1. 诊断要点

(1) 病史：经前紧张征明显，多次人流史，有乳腺疾病史或家族乳病史。



(2) 临床表现如上所述

①体检，外观乳房皮色不变，肿块各象限均可扪及，以外上象限较多，单侧或双侧，肿块活动度好，表皮及基底均可活动，无粘连。腋下触诊一般无肿大的淋巴结。

②辅助检查，B超病变区回声根据分型的不同可稍低于或高于周围乳腺组织，形态和轮廓不规则，境界不清，无包膜回声。近红外线扫描出现不同灰阶影及血管的变化，可见血管的增粗、增多，但走向清晰、弯曲自然。X线钼靶不同年龄段腺体增生及分型的不同所见X线征有差异，但以增生部位密度增高，形态不一，边缘模糊不清，不规则的X线征为主。

2. 鉴别诊断

乳癖应与乳核、乳岩鉴别

项 目	乳 癖	乳 核	乳 岩
概念	乳腺良性增生	乳腺良性肿瘤	乳腺恶性肿瘤
病发年龄	中年妇女	青年妇女	中老年妇女
临床特点	乳房肿块，	乳房肿块，	乳房肿块，
肿块特点	随月经周期变化，边界不清，质地不硬，大小不一，形态不一，有疼痛，不活动	与月经周期无关，边界清，质地硬，大小不一，形态规则推之活动	与月经周期无关，边界不清，质地硬，早期单发，无痛，不活动
药物治疗	有效	无效	无效

第2节 辨证论治

一、名家医案、医论

郭诚杰

验案 1：患者，女，25岁。1999年3月17日初诊。双乳胀



痛 8 个月。因生气而双乳疼痛作胀，以后反复不已，每于经前加重，双乳发现有块。近 3 个月来，兼见月经后期，腹部胀痛。检查见右乳外上象限扪及 $3.5\text{cm} \times 3.5\text{cm}$ 片状肿块，左乳外上象限肿块为 $2.5\text{cm} \times 2.5\text{cm}$ ，触痛明显，质地中等，活动度可，表面光滑，腋下淋巴未及。舌质淡红，脉弦。红外线扫描示乳腺增生。证属肝气郁结，治取疏肝理气，消坚散结之法。电针双侧屋翳、乳根、合谷、阳陵泉，留针 30min。第 1 次针后，就感双乳胀痛减轻，心情为之喜悦，三诊肿块明显缩小变软，六诊诸症消失痊愈，次月随访未见复发。

验案 2：患者，女，40 岁。1980 年 5 月 6 日初诊。双乳疼痛发现肿块 6 年。始于 6 年前人流后，出现月经后期，双乳逐渐增大，伴有疼痛，经西安某院就诊，拟“乳腺增生病”予中药治疗后，疼痛有所缓解，但停药后疼痛又作。近 3 年来，每次经前 15d 起，自感舌尖发麻，舌根强硬，两颌下淋巴结肿大，经期第 2~3d 夜间，口中有咸味兼见心烦约 1h，吐出血液汁 10ml。平素性急易怒，现月经延期，经量少色淡，每于经前、生气、劳累后双乳疼痛加重，伴前额痛，不易入睡，多梦，目眩耳鸣，腰膝酸软，胸胁胀痛，口苦咽干。检查见形体消瘦，面色少华，双乳外观无异常，乳头无溢液，左右乳外上象限均扪及 $4.5\text{cm} \times 3.5\text{cm}$ 的片状包块，质地中等，边界清，压痛明显，活动度大，表面光滑，颈腋下淋巴结增大。舌质红而少津，苔薄白，脉弦细。辨证为肝肾阴虚，冲任失调。治拟滋补肝肾，调摄冲任。取天宗、肩井、肝俞、肾俞和屋翳、膻中、三阴交、太溪，予补虚泻实手法，两组穴交替使用，每日 1 次，10 次为 1 个疗程，休息 4d 后继续下 1 个疗程。连针 5 个疗程后，经前乳痛消失，肿块缩小至 $0.5\text{cm} \times 0.5\text{cm}$ ，无压痛，经期口中无异味，不再心烦吐血，但尚有咽干，入睡困难，腰酸等症，故再针刺 2 个疗程后，悉症均瘥，2~3 年后随访，未再发病。

验案 3：患者，女，45 岁。1982 年 3 月 2 日初诊。右乳头溢



液3个月，逐渐加重，但无痛感，伴有月经量少，周期紊乱。1个月前经西安某院检查确诊为：乳管内乳头状瘤，准备手术，因见病友术后痛苦状态，拒绝手术，为此情绪颓丧，悲伤不已，性情更见急躁，心烦易怒，夜间难以入寐。检查见双乳对称，外观未见异常，右乳头有清晰粉红色液体自溢，量多，挤压时溢液呈喷射状，但未触及肿块。症属肝气郁结，脾失统血，治以疏肝理气，健脾统血。针刺屋翳、乳根、合谷、足三里和肝俞、膈俞、脾俞。轮流选用，日针1次，除膈俞、脾俞、足三里用补法，余穴均为泻法。经10次针治后，右乳溢液量未减，但颜色变浅，质较前清晰，再针10次，溢液减少，挤压时方见溢出，无喷射状，液呈清亮色，故继续针治。为巩固疗效，又配服加味逍遥散加减。经过30次针治，兼配服中药8剂后，右乳溢液挤压时未见溢出，近期治愈，以后随访，未见复发。

《上海针灸杂志》

贺普仁

章某，女，41岁。主诉左乳内侧生一硬结，已数年之久。开始如枣大，近年来因恚怒，情志抑郁逐渐增大如胡桃。下方亦生小结数枚，有压痛，推之可移动。恐生恶性肿瘤，即去某医院检查，否认恶性肿物，诊为“乳腺增生”。辨证：肝郁气滞、气血凝聚所致。治以疏泄肝胆，温通经络，调和气血。取穴：照海、足临泣。局部火针点刺，每核点刺3~5针。疗效：1次后压痛消失，8次后则核消而愈。

按：乳癖、乳岩均以乳房局部结块为主要临床表现，或兼有其他全身或局部症状，因其病灶局限，故临症可从局部病灶入手，用火针点刺，以达行气活血，散瘀消结之目的。对若乳癖肿块较多，可每次选取2~3个肿块，分别依次施治，对乳岩早期患者，治疗较好，而中晚期毒邪外溢，或侵袭其他组织，则单纯火针只能缓解局部症状，必须采用其他疗法共同治疗，



但多预后不良。

《针灸治痛》

田从豁

宁某，女性，33岁，初诊日期1997年5月。患者主因“发作性鼻塞、鼻痒、流涕3年”前来就诊，经一疗程的治疗，鼻炎症状基本缓解，因针灸在她身上产生了满意的疗效，因此患者提出要求治疗其原已患有的乳腺增生病。患者诉2年前开始无明显诱因出现两乳胀痛，发病初表现为经前及经期疼痛，以后逐渐发展至整个月经周期均痛，经前加重，并且逐渐出现两乳肿块，曾间断服用中药“百消丹”及汤药1年，未获得明显疗效。就诊所见：两乳丰满，两乳外侧均可触及核桃大块状肿物，压痛以右乳为甚，肿块质地中等，推之可移动，压痛明显。月经经期基本正常，经血中常带有血块，平常性格较急躁，舌质偏暗，脉弦。诊断：中医，乳癖（肝气郁结）；西医，乳腺增生。治则：疏肝理气、散结化郁。治疗：毫针患处围刺，膻中、天井、期门、三阴交，每周3次，针刺以泻法为主，留针30min。疗效：一诊后胀痛即消失，肿块变软，患者自扪之甚感诧异；三诊后症状体征均消失。为巩固疗效令患者继针数次。此后患者间断来诊2~3次。1年后随访，病情未见复发。

按：以两乳肿块胀痛为主，伴随月经有血块，性格急躁等症状，辨证当属肝气郁结。气郁日久则与体内实邪互结形成肿块。采用局部取穴可调理气血，疏通乳络，天井为手少阳三焦经穴，具有理气消痰，散结化郁的作用，是田氏治疗本病的经验取穴。膻中、期门分为气之会穴和肝之募穴，针而泻之可疏肝解郁，疏通乳络。育俞为冲脉与足少阴之会，肾脉由此深入育膜，取之既可补肾，又可调理冲脉之气。三阴交为足三阴之交会穴，用以调补肝肾，经治而愈。

《当代中医名家丛书·田从豁临床经验》



焦顺发

杨某，女，41岁。主因：双乳房肿块及腰痛1年余。病史：1977年4月某日发现右乳晕直上有一肿块，逐渐增长约鸡蛋大，伴有局部胀、难受。先后多处诊断为乳腺肿瘤，因不能完全排除恶性肿瘤，多次劝其手术切除。患者思想压力大，不愿手术治疗。后于1978年3月又发现左乳晕上方又有一肿块，大小及位置基本和右侧相同。查体：双乳晕直上3cm处有6cm×6cm×4cm之肿物。用手捏之，肿块明显，质中等硬度，肿块高低不平，但和基底部无粘连。用手平摸或按压，肿块则不明显，边缘摸不清。表面不红肿，无压痛。弯腰时腰痛明显。选区：双感觉区上2/5、足运感区，每日1次。疗效：因腰痛选双感觉区上2/5及足运感区，针2次后，同时双侧乳房的肿块也明显缩小。针3次后，查体：双乳房的肿块仅为1cm×1cm×2cm。

《头针》

二、中药外治疗法

消癖散结膏治疗乳腺增生

【药物组成】 松香、血竭、冰片、轻粉、木鳖子、麝香、银珠、乳香、没药、马钱子。

【治疗方法】 诸药混合均匀后用膏药糊加热熬成膏，摊于小方牛皮纸或方布上，每贴10g左右。用时稍加温后贴敷于患处，48h换药1次，4次为1个疗程。同时配合服用逍遥丸或乳癖消。

【功效主治】 活血散结，通络止痛。

【经验心得】 中医认为乳癖多为七情内伤，肝郁不疏，脾失健运，冲任不调以致气血凝滞，痰湿内结，凝聚为核，阻于乳络而成。故治则应以破瘀行气、温经散寒、化痰散结、开窍定痛为主。方中松香生肌定痛、去腐逐瘀；血竭、乳香、没药活血化瘀、



消肿生肌、散结止痛；冰片芳香走窜，能通诸窍、散郁止痛；轻粉、银珠均能破积散结；麝香少入既能活血消肿散结，又能通经达络；马钱子有剧毒，能通络止痛，散结消肿。用以上几味药味厚并具有毒性的药物为外用膏剂作为贴敷，既能治疗疾病而又安全有效。

治验：患者，女性，38岁。诉1991年因左侧乳腺增生并纤维瘤而行手术治疗，其后一直服用乳癖消、乳核散结片、天冬素片、谷维素等药物。近3个月来，每到月经前期乳房胀痛较甚，自触双乳均有大小不等的硬结，诊见双侧乳房外上方有数个大小不等的硬结，质柔韧，压痛明显，推之移动，无波动感。经乳腺近红外线检查提示为双侧乳腺小叶增生。予消癖散结膏外敷及口服逍遥丸，每日2次，配合精神、饮食等方面的调整。用药4个疗程后双侧乳房硬结均有不同程度的消退或减轻。继续4个疗程治疗，右侧乳房硬结消失，左侧乳房仅有花生米大小的一处，无压痛。嘱间断外敷，随访至今未复发。

【方剂出处】化玉梅，等. 消癖散结膏治疗乳腺增生36例. 中国民间疗法，2000；8（4）：33

消核散阴膏治疗乳腺增生

【药物组成】桃仁18g，羌活18g，白芷18g，白附子18g，制川乌12g，丹参30g，麻黄9g，白芥子24g，王不留行30g，土鳖虫12g，三棱12g，莪术12g，蛇床子24g，桂枝12g，当归15g，赤芍15g，蜈蚣3条，马钱子6g，穿山甲9g，清油6斤，黄丹2斤，黄蜡500g。

【治疗方法】制备方法：将方中的桃仁、羌活、白附子、制川乌、丹参、麻黄、白芥子、王不留行、三棱、莪术、蛇床子、桂枝、当归、赤芍放入清油6斤。浸泡7d后，用文火煎炸，至药物变枯黑为度。过滤，去渣，再入黄丹2斤，蜡500g，熬至滴水成珠。待油温降至100℃以下后，再入制备好的白芷、土鳖虫、



蜈蚣、马钱子、穿山甲细末搅匀成膏，备用。载体采用厚实均匀，消毒无菌的牛皮纸，剪成 9cm 大小的正方形，将制备好的膏药，按每贴 10g，直径约 5cm，平摊在牛皮纸的中央。使用方法：将消散膏略加温后贴于患处固定，范围大者可增加消散膏数量，要求将有肿块处全部覆盖，每 24h 或 48h 更换 1 次，连用 20d 为 1 个疗程。

【功效主治】 消核散结，行气止痛。

【经验心得】 据《疡科心得集》所论述：乳中结核，形如丸卵，不疼痛，不发寒热，皮色不变，其核随喜怒而消胀，此名“乳癖”，亦即现代医学之“乳腺小叶增生”。乳腺增生病多由于郁怒伤肝，或思虑伤脾，或肝肾不足，冲任失调等原因所致。乳腺增生病的治疗：肝郁痰凝型治以疏肝解郁、化痰散结；冲任失调型治以调理冲任、温阳化痰。因此病范围比较局限，临床治疗时故以局部外敷消散膏为主。

消散膏方剂中的桃仁、羌活、丹参、白芷等可活血散寒；麻黄、白芷、穿山甲、王不留行可化痰祛瘀消肿；土鳖虫、蜈蚣、马钱子等可破瘀通脉，引药直达病灶。诸药合用，标本兼治，共奏消核散结、行气止痛之功。

【方剂出处】 何俊安. 消核散阴膏治疗乳腺增生 90 例. 中医外治杂志, 2003; 12 (1): 31

八味狼毒散治疗乳腺增生

【药物组成】 瑞香狼毒 15g，酸膜 15g，多叶棘豆 15g，黄精 15g，天冬 15g，菖蒲 15g，姜黄 100g，草乌 100g。

【治疗方法】 取上述 8 味药配研，过 80~100 目筛混合均匀药用。用温水洗净患侧乳房，取 20g 该药，用蛋清调成糊状，均匀涂在纱布上，厚度约 0.5cm 敷在患处，上盖纱布固定。

【功效主治】 活血化瘀，消肿止痛。

【经验心得】 蒙药八味狼毒散具有活血、化瘀、消肿、通络、



散结、止痛及组织修复等功效。其中狼毒、酸膜、菖蒲有消肿、化瘀、散结作用；黄精、多叶棘豆、天冬有止痛、散结、组织修复作用。临床观察中发现该药对囊性增生型的疗效不如其他类型，有待进一步研究，尽快找出最佳配方、剂型和剂量，获得最佳效果。临床应用中偶有局部过敏者值得注意。

【方剂出处】何毕力格，等．应用八味狼毒散外敷治疗乳腺增生症的临床观察．现代中西医结合杂志，1997；10（5）：470

自制乳消散外敷治疗乳腺增生

【药物组成】香附、柴胡、郁金、橘核、浙贝母、生牡蛎、半夏、当归、红花、乳香、没药、穿山甲、鹿角霜、王不留行，按 1.5：1：1.5：1：1.5：1.5：1：1：1：0.9：0.9：1：1：比例，共研细末，包装备用。

【治疗方法】取乳消散 60g，用白棉布制成药包，外滴红花油 5～6 滴，将有红花油一面的药包敷于乳房肿块处，外敷湿毛巾，毛巾上放热水袋，温度以患者能耐受为宜，每次 30min，每晚 1 次，10d 为 1 个疗程。肿块未消可继敷第 2 个疗程。

【功效主治】理气化痰，活血散结。

【经验心得】乳腺增生是由于内分泌失调，黄体素分泌减少，雌激素分泌相对增多所致，多发生于 20～40 岁妇女，以乳腺出现肿块、疼痛为主。本病属于中医学乳癖范畴，多由思虑过度，情志不遂，肝郁气滞，冲任不调，损伤脾胃，聚而生痰，痰瘀互结，上阻乳络而致。本病多责于气滞痰凝、血瘀。故治疗多以理气化痰、活血散结为主。乳消散方中柴胡、香附、郁金疏肝理气；橘核行气散结；半夏、浙贝母、生牡蛎、鹿角霜化痰散结；当归、红花、乳香、没药、穿山甲、王不留行活血通络；红花油加热敷可使乳腺局部皮温上升，血管扩张，改善局部血液循环，可使局部细胞活动旺盛，再生和修复加快。

【方剂出处】连爱玲，等．自制乳消散外敷治疗乳腺增生 98



例. 河北中医, 2004; 26 (8): 587

自制乳癖贴治疗乳腺增生

【药物组成】红花 15g, 川芎 30g, 乳香 20g, 没药 20g, 生南星 30g, 生半夏 30g, 穿山甲 20g, 生大黄 20g, 三棱 30g, 阿魏 20g, 冰片 15g, 血竭 15g, 松香 250g, 广丹 500g, 芝麻油 2kg 熬制而成。

【治疗方法】以上诸药清洗晾干, 用芝麻油将上药混合, 浸泡 7d 后, 文火煎熬, 待诸药渣发褐色时, 留液弃渣, 继续煎熬, 待药液滴水中不散头为度, 把血竭、阿魏、冰片末与药液充分混合后, 将广丹、松香末与药液均匀搅拌, 文火煎熬, 待滴水中成膏为度, 熄火收膏, 分切压平。每张 5g, 切成直径为 3cm, 厚为 0.2cm 的圆形。

贴敷方法: 将制成的药贴放在麝香壮骨膏上, 贴敷增生局部及相关穴位(屋翳穴、膻中、神阙), 5d 换药 1 次, 2 次为 1 疗程。

【功效主治】活血化瘀, 祛腐消炎, 生肌长皮。

【经验心得】本症在中医学中属于“乳癖”“乳痞”等范畴。多由情志内伤、肝郁气滞、痰气互结而成; 或因肝肾不足, 冲任失调, 气滞痰凝所致, 运用“乳癖贴”穴位外贴可起到活血祛瘀、消痞散结、软坚消滞、行气止痛的作用, 屡获良效。正如清代著名外治大师吴师机所说: “外治之法亦内治之法, 外治之理亦内治之理。”穴位贴敷, 药物可通过经脉的传导直达病灶, 有药精力宏之效, 且无不良反应, 对“不肯服药之人或服药无效之症”, 更具有“殊途同归, 异曲同工”之妙。

治验: 朱某, 女, 27 岁, 2001 年 5 月 24 日来就诊。自诉两乳房肿块已 2 年多, 开始较小, 后逐渐增大, 月经来潮前胀痛更明显, 肿块变硬, 经净则痛减, 肿块亦软, 且伴有腹痛, 时有胸闷胁痛。检查: 两乳房均有包块, 有鸡蛋大小, 边缘清楚, 质地坚硬, 尚光滑, 无结节, 与周围组织不粘连, 推之可以活动。找



准穴位，局部用酒精棉球消毒后，贴敷“乳癖贴”。贴敷1次后，触及包块明显缩小、变软，仅有枣粒大小，胸闷胁痛基本消失。为了巩固治疗，仅在乳房局部和乳腺反射区贴敷2次后，包块完全消失，随访2年未复发。

【方剂出处】曹群宗，等．自制乳癖贴治疗乳腺增生215例临床观察．中医外治杂志，2004；13（4）：43

中药垫外敷治疗乳腺增生

【药物组成】山慈菇 60g，皂刺 50g，穿山甲 60g，郁金 60g，莪术 60g，香附子 60g，夏枯草 60g，桔梗 60g，青皮 60g，黄药子 60g，三棱 50g，辣蓼草 50g，三七粉 30g，川楝子 40g，王不留行 60g，牡蛎 60g，海蛤壳 60g，白花蛇舌草 60g，当归 50g，海藻 60g，冰片 30g。

【治疗方法】将上述中药研成粉状，装入自制的药袋内，每个药袋可装30g，将药袋口封死、摊平，用缝纫机将药袋中间来回等距离圈行，制成直径10cm，厚1cm的药垫。使用时将药垫放在乳房包块部位的胸罩内，有效期1个月。另外注意，此药垫不能用水清洗。不用时应放在塑料袋中，以防药物有效成分挥发。

【功效主治】活血化瘀，理气止痛。

【经验心得】气滞、血瘀、痰凝是发生本病的直接原因。在组方时既考虑中医学的辨证论治，又结合现代医学的理论根据，而且还参考了一些药物的药理研究。方中皂刺、穿山甲、郁金、三棱、莪术等药，有血中气药之称，既能活血化瘀，又能理气止痛。香附、青皮、当归、川楝子等药舒肝解郁，从而起到抑肝扶脾之功。牡蛎、海藻、夏枯草等药，可化痰软坚，消解包块。白花蛇舌草、辣蓼草、黄药子等据药理研究，对一些非感染性炎症有特殊疗效。据临床观察，该方对一些囊性增生患者效果差，应引起注意。

【方剂出处】刘清林．中药垫外敷治疗乳腺增生120例．河



南中医, 1999; 19 (3): 47

痛消散外敷治疗乳腺增生症

【药物组成】 穿山甲、血竭、桂枝、赤芍、当归、红藤、败酱草、制大黄、没药、乳香、水蛭等各 15g。

【治疗方法】 共研细末加医用凡士林, 外敷患处, 每日 1 次, 连敷 5d, 休息 1d, 连用 30d 为 1 疗程。

【功效主治】 活血散瘀, 理气温经。

【经验心得】 乳腺增生症是常见病、多发病, 有缠绵难愈、易于复发的特点。西医认为本病与卵巢功能失调有关, 可能是黄体功能相对不足而雌激素水平相对过高所致, 内分泌失调引起雌激素相对或绝对增高, 作用于靶器官乳房而形成乳房肥厚或各种形状结节。为非炎症、非肿瘤性疾病, 究其实质是乳腺本身生理增生与复旧不全的情况下产生的结构紊乱。而中医认为本病多因情志不遂, 导致肝郁痰凝, 久则血瘀。根据几十年的临床经验, 以“怪病多瘀”的理论为依据, 提出乳腺增生症应抓住瘀为侧重点, 以气滞血瘀论治为辨证思路, 总结以活血散瘀、理气温经为主的痛消散治疗本病, 取得了良好效果。痛消散集活血化瘀、理气止痛、温经通络于一方, 以穿山甲、血竭、没药、乳香活血、通络、散瘀为君药, 配桂枝、赤芍、当归温经养血活血, 促进血液循环, 有助于包块的吸收, 加红藤、制大黄解毒祛瘀, 消除致病原, 全方选药精当, 从临床观察看, 既能减轻临床症状及体征, 同时亦促进增生性病变的软化和吸收, 充分发挥中医药外治的特色, 真正起到祛瘀逐邪之作用。

【方剂出处】 张海燕, 等. 痛消散外敷治疗乳腺增生症临床观察. 河南中医学院学报, 2004; 19 (113): 37

乳癖消膏外敷治疗乳腺增生

【药物组成】 珍珠 50g, 冰片 100g, 琥珀、牡蛎、贝母各 50g,



将珍珠、琥珀、牡蛎、贝母研末，红丹 1 600g，炕干，上药过 120 目筛，优质香油 3 000g 备用。

【治疗方法】 将香油放入铁锅内加热至 100℃ 以上，持续熬油 0.5h，然后缓慢放入红丹，并不停搅拌，防止红丹沉淀，使其在油中充分化合。待熬至泡沫消退、滴水成珠、色如浓墨、光亮如镜、软硬适宜时方可停熬（2~3h）。继而，将上述 5 味中药放入锅中搅拌均匀，趁热将锅中药膏缓慢倒入盛有冷水的瓷盆内去除火毒，待药膏冷却后放掉冷水，放置 15d 即可使用。用时将药膏摊在直径 10~15cm 的圆形白布上，每张重 8~10g。

敷药前清洗患部，把药膏适度加热熔化，准确敷于乳房肿块表面，5~7d 换药 1 次。

【功效主治】 活血化瘀，化痰散结，消肿止痛。

【经验心得】 乳腺增生中医认为与肝郁气滞、血瘀痰聚有关。作者选用活血化瘀，化痰散结和消肿止痛的中草药制成外用膏，经过 241 例的临床观察，发现对乳腺增生引起的胀痛、刺痛和触痛缓解作用显著，大多病人在敷后 1~3 周疼痛消失或明显缓解，且疗程短于口服组；对增生的肿块自第 3 周以后逐渐缩小或变软，随用药时间延长而消失或明显缩小，与口服法无显著性差异。总之，乳癖消膏外敷可取得理想的治疗效果，且无明显副作用，可作为治疗乳腺增生症的一种行之有效的方。

【方剂出处】 路西明，等．乳癖消膏外敷治疗乳腺增生 241 例临床研究．中医外治杂志，1998；7（3）：8

乳癖散外敷治疗乳腺增生

【药物组成】 肉桂、丁香、延胡索、石见穿、穿山甲、白僵蚕、山慈菇、八月札。将上述药按比例混匀加工成极细末，每 4g 为 1 份，装入约 3cm×4.5cm 的药棉纸袋内封口，然后密封于塑料袋内备用。

【治疗方法】 治疗时根据乳房肿块的大小、部位，将除去塑



料袋的数枚药袋置于胸罩内外敷乳房，3d后换新药，3个月为1疗程。

【功效主治】 理气活血，温经化痰，散结止痛。

【经验心得】 乳腺增生症属中医学“乳癖”范畴，绝大多数病人由于长期情志不舒，导致肝气郁结，肝郁则气血运行不畅，瘀血内滞；郁久伤脾，脾虚则运化失常，聚湿生痰。痰瘀内结，阻滞络道，故乳房胀痛频作，尤以经前为重，甚者不能触衣。针对临床辨证，采用理气活血、温经化痰、散结止痛的中药，制成乳癖散外敷乳房。

方中肉桂、丁香温经通络，散寒活血止痛；石见穿、穿山甲、山慈姑活血消肿散结；白僵蚕化痰散结；八月札疏肝理气；延胡索活血理气止痛。诸药混合外敷，通过肌肤的吸收，疏通气血，条达乳络，从而达到壅者通之、郁者达之、结者散之、坚者软之目的。

【方剂出处】 徐爱娣，等. 乳癖散外敷治疗乳腺增生 38 例. 河北中医，2000；22（2）：104

乳结消膏贴敷治疗乳腺增生病

【药物组成】 青核桃枝 80g，七叶一枝花 30g，黄药子 30g，公丁香 10g，皂角刺 60g，青皮 60g，马戟天 30g，泽漆 60g，仙茅 30g，淫羊藿 30g，山慈姑 30g，天葵子 30g，白蔹 30g，制香附 30g，制马钱子 30g，白芥子 30g，雷公藤 60g，制乳香 30g，制没药 30g，急性子 30g，蟾皮 10g，薄荷脑适量，樟脑适量等。

【治疗方法】 20 余种中草药。采用乙醇提取后，回收乙醇，浓缩成膏的工艺，然后加入蟾皮，蟾皮加入前须粉碎，过 100 目筛。成膏后再兑入薄荷脑、樟脑和总重量 1% 的氮酮搅匀，经真空干燥后打为细粉，然后按比例加入应用高分子聚合物所研制的新型无铅膏药基质内，通过制膏工艺，摊涂于大小适宜的无纺布上，药膜呈青黄色，质地粘着柔软、粘着力强。取本膏药撕去衬



纸，贴敷于乳房疼痛处或病变部位，4d 更换 1 次，20d 为 1 个疗程。休息 5d 再用下 1 个疗程。

【功效主治】 疏肝解郁、消肿止痛、利气豁痰。

【经验心得】 中医学认为肾虚及冲任失调是本病发病的基础，肝郁失疏是其诱因，痰瘀互结是为结果。方中仙茅、淫羊藿、巴戟天、补肾助阳、调养冲任；青皮味苦辛温，有疏肝健脾、行气散结之功，凡肝气郁结、胸胁胀痛者首选之要药；白蒺藜、白芥子有较强的疏肝解郁、消肿止痛、利气豁痰，并具有使皮肤局部充血、改善血液循环，从而起到化瘀止痛作用。本方的目的是镇痛散结，所以选雷公藤、泽漆、马钱子、黄药子、天葵子、七叶一枝花、山慈菇、急性子、蟾酥等有毒之品、均有较强的利尿消肿、清热解毒、舒筋通络、消积软坚、行瘀止痛和抗肿瘤作用；青核桃枝，系民间验方，外用主治各种肿块，有较好疗效。公丁香、薄荷脑、樟脑等有辛香走窜，外用透皮力极强，再选 1% 氮酮更加起到组织带入作用，本疗法机制是通过角质层的流通性，使角质层中的类脂质产生不规则排列，从而使细胞中脂质包层裂开，有利于药物透过角质层而吸收。

【方剂出处】 董守义，等．乳结消膏贴敷治疗乳腺增生病 108 例．中国中西医结合外科杂志，1998；4（3）：141

三、针灸疗法

背俞穴拔罐治疗乳腺增生

【穴位组成】 肝俞、脾俞。

【治疗方法】 用大号真空拔罐器，取肝俞（双侧）、脾俞（双侧）拔罐，抽罐真空至患者能耐受为度，留罐 40~50min，4 穴多发泡（尤其在治疗初期），注意别弄破，令其自行吸收，待结痂消除后，行下 1 次治疗。不发泡者。3d 1 次，10 次为 1 个疗程，疗程间不间隔。



【功效主治】疏肝健脾、理气活血、祛湿化痰、消积祛瘀。

【经验心得】背俞穴为五脏六腑之气输注于背部的腧穴。《素问·长刺节论》：“迫藏刺背，背俞也。”说明背俞穴接近内脏，对相关脏腑具有相对特异性。肝俞、脾俞分别为足厥阴肝经，足太阴脾经的背俞穴，两穴合用，具有疏肝健脾、理气活血、祛湿化痰，消积祛瘀的功能。拔罐能促进局部血液循环、增强血管通透性，增强白细胞吞噬能力，而且取罐后仍持续发挥作用，兼之发泡疗法的双重作用，使疗效显著且更持久。鉴于本病的病因病机，治疗过程中，嘱患者调节好心态，使心情舒畅，同时注意饮食，少食辛辣之物，使疗效更佳，本疗法可在医者指导下，病人家属自己操作，更宜推广。

【方剂出处】王瑜. 背俞穴拔罐治疗乳腺小叶增生症 92 例. 中国中医药科技, 2004; 11 (4): 250

耳穴贴压治疗乳腺腺病

【穴位组成】神门、肝、胸、内分泌、乳腺点 1、乳腺点 2。

【治疗方法】治疗前先用探棒找准穴位敏感点，耳郭常规消毒后将王不留行子放在胶布上，对准穴位贴紧，嘱患者每天按压 3~5 次，每次 2~5min，强度以胀痛感为宜，至耳郭出现热感为止，5d 后去掉。随月经周期性疼痛者每月贴压 1 次，月经前 5d 开始；持续性疼痛者 5d 1 次，两耳轮换贴压，每个月经周期贴压 6 次，3 个月后观察疗效。

【功效主治】舒肝宽胸，行气活血。

【经验心得】乳腺腺病西医认为是由于内分泌失调引起，中医认为是肝气不舒、情志失调引起气血瘀滞所致。神门、肝、胸能疏肝行气宽胸，调情志；内分泌穴能调节人体内分泌；乳腺点 1、乳腺点 2 是解剖部位取穴法，能直接作用于乳腺部位，改善乳腺部位的血液循环，诸穴合用共奏疏肝、宽胸、行气活血之功，使乳房部位气血畅通，从而使包块消失，疼痛症状



消除。

【方剂出处】 刘传祥. 耳穴贴压治疗乳腺腺病 38 例. 中国针灸, 1999; (10): 630

膏药外贴配合手法治疗乳腺增生

【药物组成】 膏药制备: 白芷 20g, 蜈蚣 20 条, 赤芍 50g, 生甲片 30g, 川黄连 30g, 生地 30g, 子芩 30g, 川黄柏 30g, 蝉蜕 10g, 乳香 30g, 没药 30g, 大黄 30g, 全虫 20g 组成。将乳香、没药研极细末备用, 其他药物放入麻油锅内浸泡, 冬七夏五。按黑膏药的熬制方法, 滴水成珠, 下广丹稍冷后再加入乳没粉末搅匀成膏备用。

取生川乌 120g, 生草乌 60g, 郁金 30g, 枳壳 30g, 丁香 60g, 蟾酥 60g, 消石 60g。干燥后研细末装瓶备用。

【治疗方法】 先将患部用 75%酒精清洗消毒, 然后根据病变部位的大小摊涂比增生肿块略大 1cm 的膏药。可选用牛皮纸或较厚的棉布, 膏药厚度应在 0.5cm 左右, 再将药粉撒在膏药中间, 与增生肿块一般大小, 即可外贴患部。

手法治疗: 贴膏药后或平时患者自己均可用手轻捏乳头, 上下左右摇动乳房, 每次约 15min, 每天坚持 1~2 次。连用 1 个月左右, 特别是疼痛时更应坚持。

注意事项: 膏药贴后 4h 左右, 患部会出现火辣辣的刺痛及剧痒感, 患者可用手轻轻拍打以缓解, 以能耐受 1d 及时间稍长, 再将膏药除去为好; 因药物对皮肤的刺激较大, 部分患者会引起小水疮, 不能搔抓, 可顺其自然结痂或用针挑破, 外涂紫药水; 对一次外贴未愈者可间隔 1~2 周再贴, 但其间手法治疗应坚持; 连用本法治疗 4 次无效者改用他法; 保持心情舒畅, 治疗月经不调, 是预防本病再发生的关键。

【功效主治】 理血行气, 消瘀散结。

【经验心得】 乳腺增生病属中医“乳癖”范围, 好发于 30~



40 岁的妇女。患乳可见于一侧或双侧，可局限于乳房的部分或分散于全乳房，轻者不易注意，重者可影响日常工作和生活。触诊多呈结节状，大小不一，边缘不清，无粘连，可被推动，同侧腋窝淋巴结不肿大，患乳肿块呈不同程度的胀痛，可随月经周期而变化，月经前期胀痛甚，有时可从乳头溢出少量黄绿色、棕色或血性分泌物，月经后期即可减轻，少数病人则无明显的周期性变化。自制膏药中的白芷、黄连、黄芩清热止痛；生川乌、生草乌温经止痛。两组药寒热相配互用，相得益彰。方中消石，又名芒硝，其主要成分为硝酸钾，可以化七十二种石，故能破积散坚，同时加入穿山甲、乳香、没药以增强理血行气、消瘀散结之功。配合手法有利于患部血液循环，加速瘀消结散。

治验：冯某，女，28 岁，2002 年 6 月 22 日就诊，自诉双侧乳房胀痛，能扪到包块，约有半年左右。患有“慢性肾病综合征”“肾动脉硬化”“高血压”，无结核及其他传染病。因害怕服用药物对其有影响，故来本所求膏药外治。诊见：双侧乳房不红，乳头下方可扪及核桃大小的肿块，明显触痛，可推动，与皮肤及周围组织无粘连，每于月经来潮之前胀痛、肿块加重。随即应用本法治疗，贴药 2 次后疼痛、肿块等临床症状及体征明显消失，下次月经来潮均未任何反应，嘱其应保持心情舒畅，随访至今未见复发。

【方剂出处】 魏述炎，等．膏药外贴配合手法治疗乳腺增生 18 例．中医外治杂志，2004；13（1）：27

刮痧拔罐治疗乳腺增生

【穴位组成】 取穴采用对应取穴法，取患者背部乳房对应部位。

【治疗方法】 ①刮痧：嘱患者反坐靠背椅上，暴露背部，局部涂以刮痧活血剂，手持刮痧板，与皮肤呈 45°角顺次、均匀刮拭，刮拭至局部出痧（斑点或斑块）为止。②拔罐：刮痧结束后，



对出痧部位进行常规消毒，然后进行拔罐。留罐时间一般为 15~45min，发疱后将罐取下，再用消毒毫针刺破水疱，并以消毒棉球轻轻按压渗液，最后以消毒纱布包扎固定。治疗结束后，嘱患者饮 200~300ml 热开水，以助血液循环，加速新陈代谢。每周 1 次，5 次为 1 疗程。

治疗期间避免过度疲劳及精神刺激，并忌食辛辣及有刺激的食物。

【功效主治】 祛瘀生新，化结消积。

【经验心得】 近代研究者发现，本病的发生主要与内分泌失调有关。刮痧能调血行气，疏通经络，不仅能调整各种分泌腺的功能，并能将阻滞经络的病源呈现于体表。而拔罐不仅能将呈现于体表的病原拔出体外，还能祛瘀生新，化结消积。二者合用，通过背部乳房对应部位调整了紊乱了的下丘脑-垂体-卵巢轴内分泌功能，抑制了增生细胞 DNA 的复制，从而促进了增生的乳腺组织恢复正常。

治验：曾某，女，42 岁，1994 年 4 月 13 日初诊。双侧乳房出现肿块、胀痛 7 年，经某妇幼保健院检查确诊为乳腺增生，多方治疗罔效。近因恚怒，肿块明显增大，疼痛加剧，恐生恶物，遂来就诊。经各项检测手段检查，排除恶性肿物，遂以上法治之，1 疗程显效，2 疗程痊愈，随访 6 个月未复发。

【方剂出处】 孟宪凯，等．刮痧拔罐治疗乳腺增生病．针灸临床杂志，1997；13（45）：33

火针围刺治疗乳腺增生

【穴位组成】 以乳头为中点，在乳周对称性选取 4~8 穴，以后以结节为穴点逐个从外向内围刺。

【治疗方法】 患者取仰卧位，穴位常规消毒后，用碘酊作标记，取中粗火针烧至需要进针的深度，待通红时快速刺入肿块，深度约 0.5~1.2cm，围刺时无肿块区可浅刺，每次取 4~8 穴，



交替进行，隔日1次，5次为1个疗程，治疗期间忌洗浴。

【功效主治】 开门祛邪，散结消肿。

【经验心得】 现代医学认为，乳腺增生症与卵巢功能失调有关，多数患者出现周期性乳房肿痛、月经不调、情绪不稳定等现象。中医学认为，本病与肝气不疏、脾虚湿盛、冲任失调有密切联系。肝经、脾经、胃经、冲任脉通于乳房，肝气郁结而气滞血瘀，肝气犯胃伤脾而致痰湿凝结，冲任不固，气血失调是致病的主要因素。火针能开门祛邪，散结消肿，《外科正宗》称：“火针之法独称雄，破核消痰立大功，灯草桐油相协力，当头一点破樊笼。”笔者采取以乳头为中心围刺，是取八卦九宫穴之意，从而达到调节机体阴阳平衡，截断其病根的目的。

【方剂出处】 王祖林. 火针围刺治疗乳腺增生症 36 例. 山东中医杂志, 2004; 23 (12): 730

温针灸鱼际穴治疗乳腺增生

【穴位组成】 在双侧鱼际穴周围轻轻按压，有乳腺增生者均有压痛点或有结节，进针点就选在此处。肝气郁结、痰凝气滞加太冲，肝肾阴虚、冲任失调加三阴交。

【治疗方法】 用迎随补泻，针尖朝向上肢方向进针，进针深度 3~5 分，再用捻转强刺激手法行针，使患者自觉乳房部胀，行气后在针上加温灸器，留针 30~40min，每日 1 次，10 次为 1 疗程。

【功效主治】 疏肝理气，活血化瘀，化痰通络。

【经验心得】 乳腺增生属于中医学“乳癖”的范畴。病因病机为忧思郁怒，肝脾失调，气血运行失常，而致气滞血瘀，痰浊内生，阻滞乳络而成；或因肝肾不足，冲任失调，阳虚痰湿内结所致。因此治疗大法应从疏肝理气，活血化瘀，化痰通络或调补冲任，温阳化痰散结等方面论治。

鱼际穴为手太阴肺经经穴，肺主一身之气，调节全身气机的



升降出入，而足厥阴肝经之气又通过支脉回流入肺中，这样十二经脉气血往复循环，周而复始，故鱼际穴理气通络的作用很强。“气为血之帅，血为气之母”，气行则血行，鱼际穴通过理气又可达到活血化瘀，化痰通络的作用。而鱼际穴又为肺经的荥火穴，因肝属木，木为火之母，荥属火，根据补母泻子法，实则泻其子，故肝木实，泻其荥，所以针刺鱼际穴又具有疏肝解郁兼清肝火的作用。另外灸法可起到“气血不足可补之，经络不通者可通之”的功效，故鱼际穴针上加灸可以理气散结，活血通络，温阳化痰。太冲穴为肝经之原穴，有疏肝理气，健脾化湿的功能；三阴交为足三阴经脉之交会穴，具有健脾利湿，调补冲任，活血通络之效。故鱼际穴针上加灸并配以太冲、三阴交辅之，在治疗乳腺增生病中能够取得较为满意的疗效。

【方剂出处】 吴雪梅，等．温针灸鱼际穴治疗乳腺增生 68 例．辽宁中医杂志，2000；27（6）：274

针刺治疗乳腺增生 1

【穴位组成】 主穴取合谷、内关、太冲、膻中、天宗、屋翳。配穴：肩井、风池。局部围刺（每个肿块直、斜或横 2~4 针）。肝火盛加太冲、肝俞、期门、后溪。肾虚：太溪、肾俞、京门。脾虚或气血双虚：足三里、三脘、脾俞、章门、三阴交。月经紊乱：血海、三阴交、关元、中极、肝俞。

【治疗方法】 每次取主穴 2~3 个，配穴 1~2 个，必要时围刺肿块。10 次为一疗程，疗程间休息 3d。膻中穴向下平刺 1.5 寸，天宗穴向外下斜刺 1 寸，屋翳呈 15° 向外斜刺 1.5 寸。围刺时直、斜或横刺硬块，得气后留针 20~30min。

【功效主治】 活血化瘀，清热散结，疏肝健脾

【经验心得】 乳腺增生，祖国医学称为“乳癖”。“气为百病之长”该病多因思虑过度，恼怒伤肝，内伤肝脾，气滞血瘀，痰瘀成癖。又认为“通则不痛，痛则不通”。治宜活血化瘀，疏



肝理气，涤痰软坚。调和气血，疏通经络。膻中穴属任脉，八会之一，气会于此，功能宽中理气、宁心化痰，通乳理肺。合谷为手阳明经，足三里为足阳明胃经合穴，二穴互为表里，是调理胃肠功能主穴，清泻阳明经气，疏风镇痛，通经开窍。太冲是肝经原空，肝俞为肝脏本俞，二穴疏肝理气，清泻肝胆。屋翳穴属足阳明胃经，宣理肺气，安神定志，活络通乳。天宗疏筋利节。三阴交、血海、关元、气海、中极等补宜肝、脾、肾、滋阴调经。上述诸穴配伍轮番应用，共奏活血化瘀，清热散结，疏肝健脾理气，安神化痰，通络镇痛之功。

治验：张某，女，32岁，延寿县寿山乡人，性急易怒，左乳房有肿块3个，2年。月经紊乱，脉弦数。经期或生气后肿块疼痛加剧而增大，经哈尔滨医大确诊为乳腺小叶增生。取合谷、太冲、肝俞、膻中、乳根、天宗、屋翳、三阴交、关元、血海、中极，各穴轮番使用，针刺3个疗程痊愈。随访1年疗效巩固。

【方剂出处】 嵇怀珠，等．针刺治疗乳腺增生50例．针灸临床杂志，1997；13（9）：20

针刺治疗乳腺增生病2

【穴位组成】 针刺取穴分为两组：胸穴组屋翳、膻中、足三里（双侧）；背穴组肩井、天宗、肝俞均双侧。肝火型去足三里，加泻太冲（双侧）；肝肾阴虚兼补肾，月经不调加三阴交（双侧），胸闷加合谷（双侧），肩困加外关（双），气血亏损补足三里（双侧）、气海。

【治疗方法】 针刺治疗时，两组交替使用，每日1次，补虚泻实，留针20~30min，行针2~3次，10次为1疗程，每疗程结束后休息3~4d。

【功效主治】 疏肝解郁，消肿散结。

【经验心得】 本病病因为因冲任不调，或因忧郁思虑以致肝郁气滞，肝脾失调，气滞血瘀，痰凝聚结成核。故宜疏肝解郁，



调理冲任。冲脉隶属阳明而附于肝，冲、任同出一源，乳房属胃，故取胃经屋翳及下合穴足三里，通调阳明胃经之气，并调脾胃；膻中为人会之气穴，属任脉，为宽胸理气，行气解郁之要穴；肩井、天宗为治乳病之验穴，配以肝俞共奏疏肝解郁，消肿散结之功。以上穴位，通过针刺激发其相应脏腑进行功能调节，使气血通，肿块消散，其病自愈。

【方剂出处】 黄传萍，等．针刺治疗乳腺增生病 100 例．山东医药，2000；40（14）：67

针刺配合耳压法治疗乳腺增生症

【治疗方法】 采用体针配合耳压法治疗。①体针取穴：A 组膻中、患侧乳旁四穴（即乳头正中向上、下、内、外侧旁开 2 寸）、双侧阳陵泉、太冲、合谷。B 组双侧肩井、天宗、肝俞、足三里，伴月经不调加三阴交，伴腰痛，加肾俞、太溪。A 组、B 组穴位隔日交替取用，1 个月为 1 个周期，第 1 个周期每日针刺 1 次，第 2 个周期隔日针刺 1 次，第 3 个周期隔 2d 针刺 1 次。3 个周期（3 个月）统计疗效。②耳压取穴：神门、皮质下、内分泌、脑点、肝、胃、胸、乳腺。每次用王不留行子贴压一侧耳穴，3d 后换贴另一侧，1 个月为 1 个周期，疗程同上。

【功效主治】 疏肝活血，软坚散结，祛瘀止痛。

【经验心得】 本病中医称之为“乳癖”，多由忧郁思虑以致肝气郁结，肝失条达，气血失调，痰湿阻滞乳络而成。针刺阳陵泉、太冲、肝俞可疏肝解郁；足三里、合谷可梳理上下阳明经气，健脾化痰；乳旁 4 穴（该 4 穴历经 3 条经络，即内侧足少阴肾经，乳头正中上下为足阳明胃经，外侧为足太阴脾经）可疏通乳部经气；肩井、天宗通经活络，以上穴位具有调节机体内分泌功能，疏肝活血，软坚散结，祛瘀止痛的作用；耳穴可理气解郁，疏通阳明经气而调整内分泌，抑制乳腺小叶增生，加速消肿散结作用。

【方剂出处】 程玉荣．针刺配合耳压法治疗乳腺增生症 60



例. 中国中西医结合杂志, 1998; 18 (5): 284

针挑治疗乳腺增生

【穴位组成】主穴：期门、章门、日月、辄筋、气户、库房、屋翳、乳根、不容、膻中、中庭、玉堂、紫宫、华盖；备用穴：大包、食窦、天池穴，必要时选太阳膀胱经有关之背俞穴。另外，胸部部“皮肤异点”（病理阳性反应点），也可作针挑部位。

【治疗方法】取穴法：以乳房为基准，从乳房近端开始，按近乳房穴位分布而顺序由近而远，上、下、左、右各取1穴，每次先挑3~4穴（双侧）；若一侧乳腺增生者，只挑患侧，每次2~3穴；若胀痛牵扯腋下方者，可选加乳房外上方穴，挑完1次一般需30~45min。

患者仰卧位，充分暴露治疗部位。①选好穴位，指甲切印或以龙胆紫或红药水作标记。②针挑部位皮肤以稀碘酊或75%酒精作常规消毒，用1~2%普鲁卡因在针挑处作局麻（形成皮丘为度），对此药过敏者，可不作局麻。③用普通外科手术刀或“双面刀片”横切开皮层，约0.7cm左右，取“大号缝衣针”或特制不锈钢圆利针，于切口处挑治，分次由浅而深渐渐挑断皮下纤维组织，针挑时以针尖用力向外作摇摆、牵拉，震颤等手法，直到切口内皮下纤维组织全部挑断为止，然后切断（一般体质肥胖者要用较强手法，反之用较弱手法）。④压平挑口处皮肤，涂上碘酊或酒精棉球，复盖消毒纱布，用胶布固定。

【功效主治】疏肝理气。

【经验心得】乳腺增生为中年妇女常见多发病，以30~45岁为多，从病因认识，因乳房部位与肝经和胃经有关，肝脉布胸胁，主疏泄气机，属木，若肝气不疏，胸胁脉络不通，乳部气机不畅，故胀痛。乳房为胃脉所过，阳阴为多气多血之腑，属土，又为气血，乳汁流过的器官，易于气滞血瘀痰凝，若肝气横逆，克伐脾胃，脾失健运，痰浊内生，痰浊气血滞结于乳房而成块。



中医辨证，为肝气不疏，胃经经气不畅，痰气郁结为主，其诊断根据乳房疼痛的性质和触诊时乳房内可扪及肿块，常随情志不畅或劳累而加重为特点。

针挑治疗宜取肝胆经、脾肾经及任脉经腧穴，以疏肝理气为主，辅以顺畅胃经及冲任之气，故近、远期均有显著疗效。针挑疗法是针灸学的组成部分，属中医外治法之一，都属于物理刺激疗法，实践证明针挑为治疗本病开辟了一条新的有效途径，具有止痛快、肿胀消退快、疗程短，又有简、便、验、廉、无副作用，能使多数患者肝脾调和，食欲增加，睡眠良好之优点。在治疗过程中，辨证取穴，注意手法，坚持针挑原则（每次不得少于 40min），要求患者保持乐观，防止精神刺激，是提高疗效的重要因素。

【方剂出处】 苏慧敏，等．针挑治疗乳腺增生 240 例．中国中医药科技，2004；11（4）

针刺背俞穴治疗乳腺囊性增生病

【穴位组成】 选穴：肺俞、厥阴俞、心俞。双乳病变者取双侧；病单侧者取病变侧。

【治疗方法】 患者端坐，暴露后背，取两侧或单侧肺俞、厥阴俞、心俞。用 28 号 2 寸长不锈钢针，斜刺向背柱 1~1.5 寸深，作强刺激，间隔 5min 捻针 1 次，留针 15min，每日针 1 次，5 次 1 疗程。

【功效主治】 调脏腑，通乳络，祛瘀散结。

【经验心得】 乳腺囊性增生病发病率，在妇女乳腺疾病中占首位，目前已列为乳癌前期病变。近代研究者认为，本病的病因主要与内分泌失调有关，乳腺是垂体-卵巢轴激素的靶器官，可能是由于垂体-卵巢轴分泌失调所致，雌二醇和孕酮主要来自卵巢分泌雌二醇可促进腺基质和导管系统生长，孕酮在雌激素作用的基础上，促进乳腺小叶及腺泡增生。据报道，乳腺增生病人卵



泡期血清雌二醇水平比对照组高,差异显著,针刺可降低雌二醇浓度及至正常水平。选取3个背俞穴是考虑到背神经胸第2~5外侧皮支,分布于胸部外侧的皮肤,并分出乳房外侧支至乳房。称为乳房内侧支,3个背俞穴是背神经胸3、4、5后支及伴行的动静脉分布区。此法中医“前病后治”法的具体体现,针刺3穴可起到“调脏腑,通乳络,祛瘀散结”的作用。

【方剂出处】 王玉慧,等. 针刺背俞穴治疗乳腺囊性增生病36例. 针灸临床杂志,1996;12(9):40

循经推拿手法治疗乳腺增生病

【穴位组成】 足三阴及足阳明胃经均取胫部经脉,以一指禅推法循经按压。配合足三里、涌泉、水泉、太冲、三阴交点按。

任脉取胸段璇玑至中庭,督脉取大椎至命门,以一指禅推法循经按压。配合膻中、命门、厥阴俞、肝俞、脾俞、肾俞点按。

乳房部位以乳头为中心,放射方向至乳房边缘,由周围向等中心以指揉法按摩。

【治疗方法】 患者先取仰卧位,同时行双侧胫部足三阴经和足阳明胃经按摩3min,点按足三里、涌泉、水泉、太冲、三阴交共3min。再取俯卧位,循督脉按摩3min,点按厥阴俞、肝俞、脾俞、肾俞共3min。最后取仰卧位,先按摩任脉3min。乳房部位双侧同时按摩5min。一指禅推法,触面积较小,但深透度大,可适用于全身各部穴位。具有行气散结,舒筋活络,祛瘀消积,健脾和胃的功能。指揉法轻柔缓和,刺激量小,具有宽胸理气,活血祛瘀,消肿止痛等作用。点按法取穴准确,力度易于掌握,以得气为度,具有较明显的通经止痛作用。每日按摩1次,10d为1疗程,间隔5d可行第2疗程。

【功效主治】 化痰、解瘀、散结。

【经验心得】 乳房位居胸胁,与多条经脉相络属。经络,内属脏腑,外络肢节,具有“行气血而营阴阳,濡筋骨利关节”(《灵



枢·本藏》)的作用。在乳癖患者中病者多有性情抑郁,忧思多虑,尚伴见经血虚少,经行不畅的证候,乳房肿块大小及疼痛的变化和情志及月经周期都相关连。根据经络学说,乳头乳房是足厥阴肝经循行之处,由于肝失调达,肝郁气滞,肝气结于乳络则结块胀痛;肝失疏泄,气机横逆则胸闷胁痛;气逆于下则小腹胀满;肝气失于调达任脉失畅;任主胞胎,胞胎受累则不孕,所以上述见证都归于肝木失调。肝郁气滞,脾虚生痰,肝脾二伤,痰瘀互结留阻经络而成。

乳癖之症虽发于外而实根于内,肾气不足,冲任失调病之本。乳癖如发于青年女子者,常伴月经提前,月经量少色淡,这是先天肾气不足,天癸未充,胞宫、乳房同时受累的缘故。更多中年妇女的乳癖结块胀痛不甚,但每多伴有经期紊乱,月行2次,腰膝酸软,耳鸣目眩等,这是由于后天肾气虚衰,下不能充实胞宫,上不能濡养乳房,肾气冲任俱衰,肾虚不能温煦冲任,冲为血海,藏血失司,所以会出现月经淋漓不尽,任脉虚损不能滋养乳房则结块胀痛。推拿手法作用于上述经络腧穴,使肝经疏通,调达顺畅,气郁得解,气行则血行,脾肾得以补益,冲任得以充实,气机升降有序,气血通行和顺,故化痰、解瘀、散结,“通则不痛”。本法治标以乳房局部指揉,治本以足三阴佐任督二脉点按推拿,手法上刚柔相济,治则上表里相顾,标本兼治,取得良好疗效。

【方剂出处】郭宇飞.循经推拿手法治疗乳腺增生病120例报告.中华实用中西医杂志,2004;4(17):590

第7章 前阴疾病

前阴是女性生殖系统的一部分，它通过经络与脏腑相联系。厥阴之脉“入毛中，过阴器，抵少腹；足少阳之经”“入毛际，合于厥阴”。《素问·厥论》说：“前阴者，宗筋之所聚。”足厥阴、足少阴之筋，皆“结于阴器”；足太阴，足阳明之筋，皆“聚于阴器”。冲脉“与阳明合于宗筋”；任脉出于会阴，过阴器，“以上毛际”；督脉“女子入系廷孔”；“其络循阴器”。上述表明前阴连通经络、经脉和奇经八脉中冲、任、督三脉以及肝、脾、肾等脏腑有直接或间接的联系。因此，前阴病的发病机制有直接和间接两个方面。间接机制是脏腑功能失常累及前阴发生病变，如肝肾亏损，阴部筋脉或肌肤失养，可致阴痛、阴痒；脾肾阳虚，湿浊下注，日久化热，湿势浸淫，可致阴痒、阴疮、阴痛；谷道不利，腑气下泄，可致阴吹；脾气虚弱中气下陷，则见阴挺；肾司二阴，肾气不固，可致阴挺；脏阴亏虚，阴部失于濡养可致外阴白色病变；肝热脾湿，阴部为湿热阻遏，可致外阴白色病变。直接机制是前阴局部感染邪毒、病虫，或外伤，可致阴痒、阴痛、阴疮等。

前阴疾病的治疗，一般是内服药调理脏腑以治其本，配合局部外治法以治其标。同时，前阴之病重在防护，注意前阴的清洁卫生，防止邪毒、病虫感染，对避免和减少前阴病有重要意义。



第1节 概述

一、阴道炎

阴道自然防御功能受到破坏时，病原体易于侵入阴道，导致发生阴道黏膜炎症，白带出现量、色、质、气味的异常，称为阴道炎。属中医“带下病”“阴痒”范畴。本病可发生于各个年龄段的女性，且易复发。本病按发病年龄分类可分为老年性阴道炎、幼女性阴道炎。按侵入阴道的病原体种类分类可分为细菌性阴道炎、滴虫阴道炎、念珠菌性阴道炎。

二、外阴瘙痒

外阴瘙痒症是外阴各种不同病变而引起的一种症状。中医称本病为“阴痒”“阴门瘙痒”等名称。外阴瘙痒病常由局部因素而引起，其中念珠菌性阴道炎和滴虫阴道炎及糖尿病是外阴瘙痒最常见的原因，虱子、疥疮亦可导致外阴发痒。慢性外阴营养不良，以奇痒为主要症状，同时伴有外阴皮肤变白。常见于大阴唇、小阴唇、阴蒂及阴道口，严重者可波及会阴部及肛门。阴唇部常有皮肤变厚及浸渍，色素减退，呈灰白色苔藓样。阴蒂阴道皮肤黏膜可有红肿糜烂，渗出及继发感染。

三、外阴白斑

外阴白斑是指外阴黏膜的增生性、白色角化性皮损，并有特定的组织病理变化。中医称本病为“阴痒”“阴蚀”“口疮”等。外阴白斑是由于外阴局部环境，如潮湿、热等物理性因素的刺激，亦可导致女阴白斑的发生，其真正的病因迄今未明。皮损表现在处阴黏膜部位，初发常在小阴唇内侧，逐渐扩展到小阴唇的外侧、阴蒂、大阴唇内侧黏膜处，亦可发生于前庭、阴道及尿道口。但



不波及大阴唇外侧、肛周及外阴皮肤。

患者的症状可轻可重，程度不一，病程经过也不一样，病变范围小，症状轻，短期治疗后，即可完全恢复如初。若病变范围大，症状重，经久不愈，并反复发作，持续数年甚至十几年者。长期不愈的患者，要经常复查，要排除癌变的可能性。好发于40岁左右妇女，尤其是绝经期后的妇女。本病在早期仅有轻度瘙痒。晚期剧烈瘙痒，由于搔抓可发生继发性皮损，如黏膜红肿，皲裂、苔藓样变或继发性感染等。

第2节 辨证论治

一、中药外治疗法

黄柏油外用治疗阴道炎

【药物组成】 取黄柏 100g 烘干研成细末，蛇床子 100g，加入 500g 麻油浸泡 1 周，去渣留油装入净瓶备用。

【治疗方法】 用药前先用温开水将外阴冲洗干净，拭干，再用消毒棉签蘸黄柏油擦于外阴及阴道，每日 2~3 次。

【功效主治】 清热燥湿，止痒杀虫。

【经验体会】 黄柏对致病性皮肤真菌、阴道滴虫及多种革兰阳性杆菌和阳性球菌有较强的抑制作用；蛇床子具有性激素样作用及抗阴道滴虫、抗真菌等作用，并能减少炎症分泌或渗出物。二药水煎外用，研粉外涂均能治疗多种阴道炎，用麻油与黄柏、蛇床子制成油剂外擦，意在取其麻油生肌润肤之效，不仅避免或减轻因粉剂外涂以及炎症所致外阴干涩不适的症状，而且增强了清热燥湿、杀虫止痒的作用，加之蛇床子的性激素样作用，对老年性阴道炎尤为适用。

【方剂来源】 杨金珊. 黄柏油外用治疗阴道炎. 中国民族民



间医药杂志, 2004; (70): 308

二黄子洗液治疗阴道炎

【药物组成】 黄柏 30g, 黄连 20g, 蛇床子 30g, 苦参 30g, 土茯苓 30g, 土槿皮 30g, 山豆根 30g, 五倍子 25g, 冰片 1.5g (后下)。

【治疗方法】 上药加水 800ml 浸泡 1h, 煎煮 30min 后取汁, 两料加水 300ml 煎煮 20min 取汁, 两汁相混, 加入冰片, 等分为 4 份, 每次 1 份, 熏洗外阴、阴道 15min, 每日 2 次, 每剂药用 2d, 8d 为 1 个疗程。

【功效主治】 清热解毒, 燥湿杀虫, 消肿止痒。

【经验体会】 二黄子洗液为纯中药制剂, 方中黄柏、黄连功专清热燥湿解毒为主药; 蛇床子、苦参、白鲜皮解毒燥湿, 杀虫止痒为辅药; 土茯苓、土槿皮、山豆根、冰片燥湿消肿为佐药; 五倍子“味酸咸, 其气寒, 能散热毒疮肿”“外以治肤熏洗, 则能祛风除湿杀虫”, 增加君臣功效为使药。全方共用, 可使热得清, 毒得解, 湿得除, 虫得杀, 诸病自愈。

【方剂来源】 王磊, 等. 二黄子洗液治疗阴道炎 167 例临床观察. 中国中医基础医学杂志, 2002; 8 (2): 62

复方百部洗剂治疗阴道炎

【药物组成】 百部 30~50g, 艾叶 15~30g, 苍耳子 15~30g, 仙鹤草 15~30g, 花椒 15~30g, 苍术 20g, 黄柏 20g, 苦参 30g, 蚤休 30g, 功劳木 30g, 蛇床子 30g, 地肤子 30g, 败酱草 20g。

【治疗方法】 煎煮 30min, 浓缩 500~800ml 药液, 取 400~600ml 坐浴 20min, 100~160ml 药液用阴道冲洗器做阴道冲洗, 7~10d 为 1 个疗程。

【功效主治】 清热解毒, 杀虫止痒, 祛湿止带。

【经验体会】 妇科阴道炎为外感湿热、湿毒所致, 故在治疗



上应采用清热解毒，杀虫止痒，祛湿止带的方法。复方百部洗剂方中百部、苦参片、艾叶、花椒杀虫止痒，有抗菌、抗皮肤真菌作用；苦参片体外试验有抗滴虫作用；败酱、黄柏、功劳木清热解毒燥湿，现代中药药理研究证明，黄柏具有一定抗真菌、滴虫作用；仙鹤草清热解毒，抗菌消炎，对阴道滴虫有直接杀灭作用。地肤子、蛇床子、蚤休能清热利湿，祛风杀虫止痒，地肤子对皮肤真菌有较强的抑制作用，蚤休有抗衣原体作用，苍耳抗菌抗病毒，并有一定抗真菌作用。以上诸药合用具有抗菌消炎，清热解毒，抗真菌、抗滴虫，杀虫止痒，祛湿止带的协同作用。

【方剂来源】吕志红，等. 复方百部洗剂治疗阴道炎 102 例. 福建中医药，1998；29（5）：27

复方苦参散治疗阴道炎

【药物组成】苦参、蛇床子、川连、黄柏各 60g，枯矾、硼砂各 120g，冰片 2g。

【治疗方法】先将苦参、蛇床子、川连、黄柏烘干研粉，过 120 目筛；其次将枯矾研末过筛；再将硼砂置于铁锅内烤干去水后过筛；然后将各种粉末混匀过筛，装瓶密封备用。用法：先排空小便，用窥阴器扩开阴道，以 0.1% 高锰酸钾水冲洗阴道、外阴。擦干阴道、外阴，用药匙取复方苦参散 2g 散布阴道内，再用棉签蘸取药粉散布在阴道口、小阴唇皱褶及大小阴唇沟，每日治疗 1 次，7d 为 1 个疗程。

【功效主治】抗菌消炎，杀虫止痒。

【经验体会】方中川连、黄柏性味苦寒，功能清热燥湿，抗菌消炎；苦参、蛇床子燥湿杀虫止痒；硼砂对皮肤黏膜有收敛保护、消炎作用，能抑制细菌生长；枯矾渗湿生肌作用较好。诸药配合，有相得益彰之效，对治疗真菌性和滴虫阴道炎疗效显著。

【方剂来源】仲伟保，等. 复方苦参散治疗阴道炎 100 例. 实用中医药杂志，2002；18（11）：40



自拟止痒汤外洗治疗阴道炎

【药物组成】 蛇床子、苦参、百部、花椒、黄柏、白鲜皮、地肤子、败酱草、冰片。

【治疗方法】 诸药入包煎汤，先熏，待水温后坐浴，每日2次，每次20min，10次为1疗程。如外阴破溃，则减去花椒。月经期停止用药，防止上行性感染。

【功效主治】 清热燥湿，杀虫止痒。

【经验心得】 本病属中医“阴痒”“带下”病范畴，中医认为本病的发生由肝经湿热下注，损伤任带二脉，带下浸渍阴部，或湿热生虫，虫蚀阴部所致。故治疗上以清热燥湿，杀虫止痒为主。本方中苦参清热燥湿、祛风杀虫；白鲜皮、地肤子清热解毒，除湿止痒；蛇床子有很好的祛风燥湿杀虫作用，现代药理研究证明蛇床子对阴道滴虫、致病性皮肤真菌有抑制作用，能减少炎性分泌物；百部灭虱杀虫，黄柏清热燥湿，泻火解毒；败酱草清热解毒；花椒杀虫止痒；冰片消肿止痒，散邪外出。全方组合有清热解毒，杀虫止痒之功效，并以外用药直达病所。此方法治疗外阴、阴道瘙痒具有疗程短，疗效可靠，无毒副作用，费用低，易被患者接受。

【方剂出处】 阎平．自拟止痒汤外治外阴阴道炎．天津中医，2001；18（5）：

复方硝矾洗剂治疗阴道炎

【药物组成】 五倍子 15g，白鲜皮 15g，明矾 15g，黄柏 12g，苍术 12g，荆芥 15g，防风 15g，苦参 12g，金银花 15g，花椒 10g，蛇床子 12g，地肤子 15g，百部 12g，鱼腥草 12g。

【治疗方法】 上方煎煮分装成 200ml 药液，备用。加水 400ml 先熏后洗，每日2次，每次15~30min，每次1袋。

【功效主治】 清热利湿，杀虫止痒，抗菌。



【经验体会】方中黄柏、苦参、蛇床子、地肤子、白鲜皮、苍术清热燥湿、止痒；百部杀虫止痒；鱼腥草、金银花清热解毒；明矾解毒消肿、收敛止湿；五倍子收湿敛疮、止带下。现代药理研究表明，荆芥、防风、苦参、白鲜皮有抗白色念珠菌等多种真菌和阴道滴虫的作用。鱼腥草、金银花尚有增强机体免疫功能的作用。明矾、花椒、五倍子亦有抑菌作用。全方具有清热利湿、杀虫止痒、抗菌之功效。

治验：王某，32岁。白带增多、外阴瘙痒，时有奇痒难忍，尤以经期过后为甚，症状加重3月余。在家多次用制霉菌素、甲硝唑外用（外洗药不详）治疗后症状减轻，但疗效不巩固，停药1周后又感外阴灼痛不适，白带增多，如此反复3月余，来院就诊。妇科检查：外阴皮肤潮红，阴道黏膜充血水肿，表面覆有大量豆渣样白带，拭去后有针尖大小出血点，取阴道分泌物镜检可找到真菌孢子。诊断为真菌性阴道炎，采用复方硝矾洗剂配以达克宁栓连续治疗2个疗程，诸症消失，白带正常。

【方剂来源】刘洪伟，等．复方硝矾洗剂治疗阴道炎317例．中国民间疗法，2005；13（4）：39

苦参蛇冰汤熏洗治疗阴道炎

【药物组成】苦参30g，花椒15g，黄柏15g，蛇床子30g，地肤子15g，白鲜皮15g，土槿皮15g，五倍子9g，百部12g，白花蛇舌草30g，冰片2g。

【治疗方法】取上药1剂，加水适量水煎滤出药液，溶入冰片2g，趁热熏洗，水温后坐浴20min，每日2次。10d为1个疗程。

【功效主治】清热燥湿，杀虫止痒。

【经验体会】阴痒是由于湿热不洁，虫蚀所致，用外治法，可使药液直达病所，取效速捷。苦参蛇冰汤是根据中医清热解毒，燥湿，杀虫止痒的治疗原则，针对阴道炎出现的带下量多，灼热



瘙痒，皮肤有出血点，及各类阴道炎的临床症状、病因病理拟定的。方中：苦参、花椒、黄柏、百部清热燥湿、杀虫止痒；蛇床子、地肤子、土槿皮清湿热，收涩止痒，药理研究认为其对细菌及皮肤真菌有抑制和杀灭作用；白鲜皮治湿热疮毒，黄水淋漓；白花蛇舌草甘寒清利湿热，治头火毒疮疗，尿赤涩疼；冰片清热消肿止痛，具有抑菌镇疼作用。综上所述，全方清热燥湿，杀虫止痒，适用于各种阴道炎。

治验：李某，女，40岁。带下量多，黄色稀泡沫状，有腥味2周，伴有外阴、阴道瘙痒，灼热疼痛、尿频、尿痛、坐卧不安，心烦失眠，舌质红，苔薄腻、脉细数。妇科检查：阴道黏膜有散在的红色斑点，后穹窿有多量泡沫状分泌物。镜检：滴虫满视野。诊为：滴虫阴道炎。属中医“阴痒”证。即用苦参蛇冰汤以清热解毒、燥湿、杀虫止痒。按方每日1剂，水煎后滤去药渣。溶入冰片，趁热熏洗，水温后坐浴20min，每日2次。用上方5d后，带下量明显减少，灼热疼痛，瘙痒减轻，继用10d后，诸证消失，镜检无异常发现。

【方剂来源】刘杏枝. 苦参蛇冰汤熏洗治疗阴道炎48例. 中医外治杂志, 1997; (4): 32

苦柏液外洗治疗老年性阴道炎

【药物组成】苦参、黄柏、蛇床子、地肤子、白鲜皮各30g，龙胆草、川花椒、苍术、苦矾各10g等。

【治疗方法】加水2000~2500ml，煎煮10~15min后，泌出药汁，再取核桃大小消毒棉球缚以长线，饱吸药液，温度适宜，于睡前塞入阴道，待次日晨起时取出（治疗期间禁止性生活），如法连续10次为2个疗程即可。

【功效主治】抗菌消炎。用于治疗老年性阴道炎。

【经验体会】苦柏液的作用为增强防御功能、抑菌、消炎、杀虫、收敛止血、保护黏膜、修复组织。



【方剂来源】 于才英. 苦柏液棉球阴道塞入法治疗老年性阴道炎. 现代中西医结合杂志, 2001; 10 (9): 864

清热解毒汤外洗治疗细菌性阴道炎

【药物组成】 野菊花 60g, 忍冬藤 100g, 龙胆草 40g, 川黄连 20g。

【治疗方法】 将上方四味中药加水 2 000ml, 文火煎至 1 500ml, 去渣, 待微温后, 先洗后坐浴 30min。根据病情, 每日 1~2 次, 重者可作阴道冲洗, 药效直达病所。若痒甚者 (查白带、真菌、滴虫阳性) 上方加百部、苦参、白鲜皮、蛇床子等杀虫止痛药。中医辨证, 患者脉弦数, 舌苔黄腻, 白带色黄或呈黄水样, 本病为湿热下注, 可清肝胆湿热, 可给龙胆泻肝汤 1~2 剂口服, 效果更佳。

【功效主治】 清热燥湿, 杀虫止痒。用于细菌性阴道炎。

【经验体会】 《医宗金鉴》指出“妇人阴痒多因湿热生虫”。本病与雌激素的分泌、糖原分解、阴道 pH 值等生理因素有关, 这些生理功能失调, 阴道的自净作用就会失去防御能力, 这时病原体就乘虚侵袭而发病。中医学的“虫”和现代医学的“病原体”是一致的, 这是发病的主要原因。野菊花、忍冬藤清热解毒, 龙胆草、川黄连清热燥湿, 杀虫止痒, 四药合用有较强的抗菌消炎作用。上述药物对葡萄球菌、链球菌、大肠杆菌、绿脓杆菌和某些真菌均有抑制作用, 黄连对真菌和滴虫有双重治疗作用。

【方剂来源】 陈勋. 清热解毒汤外洗治疗细菌性阴道炎 210 例. 中医外治杂志, 1997; (1): 14

自拟六味汤熏洗坐浴治疗真菌性阴道炎

【药物组成】 苦参、黄柏、蛇床子、白鲜皮、土茯苓、龙胆草各 50g。

【治疗方法】 上药加水 3000ml, 文火煎 30min, 去渣, 温药



液熏洗坐浴，每次 20min，每日 2 次，5d 为 1 疗程。

【功效主治】 解毒燥湿。

【经验体会】 真菌性阴道炎中医属于“阴痒、带下病”范畴。是湿浊与邪毒相兼为病。现代医学认为该病病原菌以白色念珠菌多见，念珠菌与正常内生性阴道菌群同时存在，与身体虚弱或阴道内菌群失调，如大量使用广谱抗生素阴道冲洗诱发二重感染，月经期使用不洁卫生巾引起阴道念珠菌大量繁殖而发病。笔者以中医学理论为指导，自拟六味汤熏洗治疗，根据湿浊与邪毒相兼为患的病因病机，选药组方，苦参、龙胆草、黄柏、土茯苓具有解毒燥湿之功，蛇床子、白鲜皮有杀虫止痒之效。同时药物通过熏洗坐浴，既可直达患处，又可稀释阴道内分泌物，促进阴道内分泌物的排出，有助疾患痊愈，故疗效较佳。

治验：李某，女 34 岁，1994 年 3 月 14 日就诊，自诉反复外阴搔痒 1 年余，曾多次检查为真菌性阴道炎，经用西药治疗症状无明显改善，妇检：小阴唇高度水肿充血，阴道内大量灰色豆渣样白带，阴道壁充血触痛，实验室涂片检查发现真菌，经用六味汤熏洗坐浴治疗 5d 后复诊，自述熏洗 1 次后外阴瘙痒明显减轻，继续用药症状日渐消失。白带涂片真菌检查阴性，随访 3 个月均正常。

【方剂来源】 周华英，等．自拟六味汤熏洗坐浴治疗霉菌性阴道炎的临床观察．中医外治杂志，1997；（1）：47

解毒止痒汤治疗滴虫阴道炎

【药物组成】 大黄 30g，蛇床子 30g，地肤子 30g，苦参 30g，龙胆草 30g，苍术 30g，黄柏 30g，苦楝根皮 30g，百部 30g，花椒 30g。

【随症加减】 浓煎后加食用醋 250ml，冲洗外阴、阴道，然后阴道放入灭滴灵栓 1 粒，将一带线棉球浸透药液后塞入阴道，6h 后取出，每日 1 次，共 7d。



【治疗方法】 利湿解毒，杀虫止痒，消炎止带。

【功效主治】 用于滴虫阴道炎。

【经验体会】 本病属中医妇科“带下”“阴痒”的范畴，多由湿热下注，虫蚀阴中所致，其中以湿毒居多，解毒止痒汤以清热解毒，燥湿杀虫药物组成，具有清利湿热毒邪，杀虫止痒，消炎止带作用，以杜绝滋生滴虫之源。药理研究亦证明黄柏、大黄、花椒、苦参局部具有杀滴虫，抗菌消炎之功；地肤子止痒杀虫；龙胆草、苦楝根皮、苍术利湿清热杀虫；食用醋使药物呈酸性，不利滴虫的生长，配伍灭滴灵增加杀灭滴虫之功，故收到较好疗效。

【方剂来源】 黄亚黎. 解毒止痒汤治疗滴虫性阴道炎 69 例. 河南中医, 2004; 24 (89): 40

蛇凤汤外洗治疗滴虫阴道炎

【药物组成】 蛇床子 10g, 苦参 10g, 凤眼草 6g, 山豆根 10g, 黄柏 6g, 明矾 5g。

【治疗方法】 将上药加水 1 000ml, 煎开 10min, 待温后洗浴。病位较深者, 洗浴后用消毒纱布浸药液加线置阴道, 2h 后取出。中医辨证属肝经湿热下注内服龙胆泻肝丸; 肝郁脾虚内服丹栀逍遥丸。均每日 2 次, 每次 9g, 连服 15~30d。

【功效主治】 清热、燥湿、止痒。用于治疗滴虫阴道炎。

【经验体会】 滴虫阴道炎属中医学“淋证、带下病、阴痒”等范畴。多由肝经湿热、脾虚湿盛、湿热下注或感染虫毒所致。蛇凤汤方中蛇床子燥湿杀虫；苦参清热燥湿，杀虫止痒；山豆根清热解毒；凤眼草清热、燥湿、止带；黄柏泻火、燥湿、解毒；明矾燥湿、杀虫、止痒。诸药合用，有清热、燥湿、止痒的功效。滴虫阴道炎由阴道毛滴虫引起，滴虫属厌氧桑寄生原虫，对不同环境的适应力很强，不仅易生于阴道内，并可侵入尿道及阴道旁腺，甚至上至膀胱、输尿管及肾盂。滴虫阴道炎为临床较顽固的



妇科常见病之一，患者痛痒难忍，夜间加重，痛苦较大，易反复发作。因此，患者要坚持治疗，巩固疗效，愈后做定期检查，保持清洁卫生和心情舒畅，禁食辛辣，避免复发和交叉感染，以求彻底痊愈。

【方剂来源】 方敬，等．蛇凤汤外洗治疗滴虫性阴道炎 31 例．河北中医，2002；24（12）：905

蛇床苦参煎外洗治疗滴虫阴道炎

【药物组成】 蛇床子、苦参、白鲜皮、黄柏各 20g，萆薢 15g，荆芥、防风、花椒各 12g，蝉蜕 10g。

【治疗方法】 将上方水煎至 1 500~2 000ml，去渣，高温时熏洗外阴，待温度降至适宜时坐浴，浸泡外阴及阴道 25min，或将温度适宜的药液放入阴道冲洗器内自行冲洗阴道，使分泌物排出体外。每日坐浴或冲洗 1 次，每日 1 剂，7d 为 1 个疗程，经期禁用。使用本方治疗，滴虫检查转阴后仍应继续治疗 1 个疗程，以巩固疗效，同时配偶也接受治疗更好。

【功效主治】 燥湿杀虫止痒。用于治疗滴虫阴道炎。

【经验体会】 本病多因脏腑功能减弱，湿热、湿毒（细菌、滴虫）内侵，湿郁化热，湿热下注则成湿热带下。方中蛇床子、苦参、白鲜皮、萆薢、荆芥、防风利湿热，化湿浊；花椒、黄柏、蝉蜕清热解毒，燥湿杀虫止痒。

【方剂来源】 姚玉荣，等．蛇床苦参煎外洗治疗滴虫性阴道炎 68 例．江苏中医药，2000；9（2）：40

蛇白汤熏洗治疗女性阴部瘙痒

【药物组成】 蛇床子、白鲜皮、黄柏各 50g，荆芥、防风、苦参、龙胆草、白芷各 15g，薄荷（后下）3g。

【随症加减】 带下多而黄者黄柏加倍；有滴虫者苦参加倍；真菌感染者龙胆草加倍，再加用枯矾 3g 研极细末撒于局部。对



各种有原发性疾病引起的并发症可加其他药物治疗。

【治疗方法】 上方水煎，外用熏洗，每日3次。如阴道内部瘙痒可用10ml注射器冲洗阴道。15d为1个疗程。

【功效主治】 清热燥湿，祛风散热，解毒杀虫。

【经验心得】 外阴瘙痒症属中医学“阴痒”范畴，亦称阴门瘙痒，患者常伴有不同程度的带下。对于湿热型采用蛇白汤局部熏洗，方中蛇床子、白鲜皮、苦参、龙胆草、黄柏清热燥湿、泻火解毒、杀虫止痒；白芷、荆芥、防风、薄荷祛风散热、止痛、止带、止血。枯矾末外撒局部具有收敛、燥湿止痒功效。诸药合用，具有清热燥湿、祛风散热、解毒杀虫、止带止痒之功效。外用熏洗，药效直达病灶收到良好效果。

【方剂出处】 路文臣. 蛇白汤熏洗治疗女性阴部瘙痒症 100例. 河北中医, 2002; 24 (7): 525

熏洗方治疗女性阴部瘙痒

【药物组成】 蛇床子、地肤子、苍术各30g，丹皮、黄柏、苦参、生地、当归、刺蒺藜各25g，制首乌、薏苡仁、土茯苓各35g。

【治疗方法】 将诸药加水浸泡20min后武火煎沸20min，滤取药液3000ml左右倒入盆中，凉至温度适宜时用以熏洗外阴，先熏15min，后洗10min。每日2次，10d为1个疗程。每剂药可用2d。

【功效主治】 清热利湿止痒，滋阴降火，调补肝肾。

【经验心得】 糖尿病外阴瘙痒在中医学中虽无确切病名，但从其临床症状看，与阴痒之证颇合。本病的发生多因湿热下注或肝肾阴虚致血虚生风所致。脾虚生湿，肝经郁热，湿热下注则阴痒灼痛，痒痛难忍则心烦少寐，坐卧不安；肝肾阴虚，精血两亏，血虚生风化燥，则阴部干涩，灼热瘙痒。

本组所用熏洗方中苦参、蛇床子、地肤子、土茯苓有清热燥



湿止痒之功；苍术、薏苡仁有健脾燥湿之效；丹皮、生地、黄柏能滋阴清热凉血；首乌、当归、刺蒺藜能调补肝肾，养血祛风。全方配伍具有清热利湿止痒、滋阴降火、调补肝肾之功用。运用中药熏洗法主要是治疗糖尿病的外阴瘙痒只是治标，而控制血糖则是治疗的根本。临床观察到外阴瘙痒症状治愈或好转后因患者未能有效地控制血糖，则瘙痒可再次复发。瘙痒程度与血糖的水平成正比，所以必须积极治疗糖尿病，方能从根本上解决问题。

【方剂出处】 丁丽芳，等．中药熏洗治疗糖尿病外阴瘙痒症46例．河北中医，2002；24（7）：525

自拟土茯苓苦参汤治疗女性阴部瘙痒

【药物组成】 茯苓 50g，苦参 50g，黄柏 50g，地肤子 50g，蛇床子 50g，白鲜皮 50g，川椒 5g，枯矾 5g，百部 30g。

【治疗方法】 上药加入 3 000～5 000ml 水中煮沸 30min 后去渣熏洗外阴并坐浴，每日 1 剂，早、晚各 1 次，每次 30min，坐浴后用一洗康 7ml 加温开水配制到 100ml 装入自带冲洗器中冲洗阴道，早、晚各 1 次，7d 为 1 个疗程。

【功效主治】 清热解毒，燥湿杀虫，除痒。

【经验心得】 女阴瘙痒症，中医认为是湿热下注所引起，西医认为是阴道感染细菌、真菌、滴虫、病毒所引起。治疗中以土茯苓、苦参、黄柏清热解毒、燥湿，蛇床子燥湿杀虫，川椒、枯矾、百部共凑杀虫之功，白鲜皮除湿止痒，众药合用具有清热解毒，燥湿杀虫，除痒之功效。一洗康为碘与聚维酮络合而成的外阴用消毒防腐液，具有高效广谱杀菌作用，对阴道中常见的细菌、真菌、病毒、滴虫具有较强杀灭作用。中西药合用疗效满意值得推广。

【方剂出处】 姚心凌．自拟土茯苓苦参汤联合一洗康治疗女阴瘙痒．河南医药信息，2003；24（1）：50



龙蛇苦参汤治疗女性阴部瘙痒

【药物组成】 龙胆草、蛇床子、苦参、地肤子、百部各 30g，土茯苓、白鲜皮各 20g，黄柏、紫花地丁各 15g，花椒、白矾各 10g。

【治疗方法】 将药用凉水浸泡 1h 后用文火煎 20min。第 1 次煎药液 800ml，用纱布滤过放温装入妇用卫生器中冲洗阴道，药液保留 10~15min。第 2 次煎药 1 500ml，先熏洗后坐浴 15~20min，每日用药 1 剂，早、晚各 1 次。7d 为 1 个疗程，一般用药 1~3 个疗程。

【功效主治】 清热解毒，燥热止带，杀虫止痒。

【经验心得】 本病的病因病机多因忽视卫生，不洁房事外感邪毒虫蚀，或久居阴湿之地而致湿邪壅积化热内蕴，流注下焦，客于阴户。或因素体肝肾阴虚，或年老体衰，精血亏损，血虚生风化燥而致阴痒。肝之经脉“循股阴、入毛中、过阴器、抵少腹”，按《女科证治准绳》中“治之当外以熏洗坐导药之乃可”，尊其肝经郁热、湿毒下注客于阴户而致阴痒的病机，故采用龙蛇苦参汤煎液冲洗阴道。方中龙胆草、黄柏、紫花地丁泻肝胆郁热、清下焦湿热，蛇床子、苦参、白鲜皮、土茯苓清热解毒、燥湿止带，百部、花椒、白矾杀虫止痒，诸药合用具有清热解毒，燥热止带，杀虫止痒之功效。药物直接通过熏洗、冲洗外阴、可直达病所，直接起到治疗作用。

【方剂出处】 杨烈文，等．龙蛇苦参汤治疗外阴瘙痒症 75 例．中医药学刊，2005；23（4）：745

止痒消白液治疗女性阴部瘙痒

【药物组成】 苦参 150g，白鲜皮 150g，蛇床子 150g，地肤子 150g，百部 150g，蒲公英 100g，防风 100g。

【治疗方法】 ①取处方量苦参加水浸泡 30min 煎煮 15min；



②将其他处方药加水浸泡 30min 后加入①中，共煎 30min 过滤，收集滤液；③将过滤药渣加温水浸泡后立即煎 20min，过滤收集滤液与第 1 次滤液混合成 1 000ml 即可。每次取 200ml 本液加水 1 000ml，加热坐浴，温度越高疗效越好，凉后可再加热（注意不用铁器皿），每次 20min，每日 2~5 次，15d 为 1 个疗程。

【功效主治】 解毒燥湿，杀虫止痒。

【经验心得】 外阴瘙痒往往需全身用药加局部用药，患者大多需到医院诊治，且疗效不满意。中医学中苦参、白鲜皮、蛇床子、地肤子等，治疗不明原因外阴瘙痒经过多年的临床观察，止痒效果好、药效持久。地肤子治疗皮肤湿疹，百部杀灭多种人体桑寄生虫，蒲公英抑制金黄色葡萄球菌，对伤寒杆菌、痢疾杆菌、大肠杆菌均有抑制作用；防风抑制多种痢疾杆菌及枯草杆菌；这些成分的作用使止痒消白液具有止痒、同时兼有抑制人体桑寄生虫，金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌、大肠杆菌作用。

【方剂出处】 曹丽波，等．止痒消白液治疗外阴瘙痒症疗效观察．中国实用妇科与产科杂志，2003；19（5）：279

蛇黄苦参汤治疗女性阴部瘙痒

【药物组成】 蛇床子 30g，黄柏 30g，苦参 30g，虎杖 30g，百部 20g，白鲜皮 20g，花椒 20g，明矾 10g，掉毛草 20g。

【治疗方法】 上药加水 30kg 煮沸 30min，取汁倒入清洁容器中，先熏，待皮肤适应水温时反复洗患处或坐浴，每日早、晚各 1 次，10d 为 1 个疗程。

【功效主治】 清热解毒，利湿杀虫。

【经验心得】 本方治宜清热解暑，利湿杀虫止痒。方中黄柏、苦参、虎杖苦寒清热解暑，利湿杀虫，且三药均具有不同程度的广谱抗菌作用，对绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、疥癣、真菌均具有抑制作用；蛇床子、百部、白鲜皮、花椒、明矾祛风燥湿，杀虫止痒，生肌敛疮，有不同程度的抗真菌作用；掉



毛草祛风除湿，活血化瘀，可促进血液循环，增加皮肤抗病能力，有利于炎症的吸收。用全方煎后热熏洗外阴，药疗、理疗相结合，针对病因给予西药治疗，可抑制、杀灭病原体，消除炎症水肿。

治验：患者，45岁，自诉外阴瘙痒7个月余。舌红苔黄腻，脉细弱。妇科检查：外阴部红肿，有抓痕，部分破溃，有污秽分泌物；窥阴器检查：阴道有较多分泌物，呈豆腐渣样。西医诊断为白色念珠菌性阴道炎，外阴炎。中医诊断为外阴瘙痒。在西医处理的同时，予蛇黄苦参汤加蒲公英20g，金银花20g，2剂煎水外熏洗，每日2次。7d后外阴红肿明显好转，瘙痒症状消失。为了巩固疗效，继续用药7d，随访3个月无复发。

【方剂出处】李秀娟，等。蛇黄苦参汤外洗治疗外阴瘙痒40例疗效观察。现代中西医结合杂志，2004；13（24）：3304

外阴瘙痒洗剂治疗女性阴部瘙痒

【药物组成】苦参20g，黄柏、蛇床子、地肤子、白鲜皮、百部、黄芩、栀子、豨莶草、花椒、青盐各10g，生白矾6g，苍术15g，黄连5g。

【治疗方法】水浸30min，煮沸30min后不过滤，倾入盆内，以可耐受之温度，先熏后洗30min，1剂药液通过加温可连用3次。另根据病情和症状可内服中药，常以龙胆泻肝汤为基本方，药用龙胆草15g，柴胡、生地黄、黄芩、栀子、白芍、当归、金银花、蒲公英、黄柏、茯苓、泽泻各10g，生甘草8g。每日1剂，水煎分2次服。

【功效主治】清热燥湿，杀虫止痒。

【经验心得】外阴瘙痒多由湿热下注或感受湿邪热毒所致。熏洗方中苦参、黄柏、黄连、黄芩等清热燥湿，地肤子、白鲜皮、蛇床子、百部、枯矾、花椒杀虫止痒，生甘草、青盐清热消炎。诸药熏洗局部能直达病所，故疗效显著。



治验：患者李某，女，30岁。外阴瘙痒3年余，近日较甚，痒痛剧烈，大腿根内侧及会阴部皮肤潮红，微肿，局部表皮破溃流滋浸淫，污浊秽气难闻，身热面赤，舌红苔黄，脉弦数。采用内服外洗之法，以清热解毒祛湿为主。内服以龙胆泻肝汤加减；外用熏洗剂，1剂药连用3次。痒痛渐轻，流滋浸淫减少，继内服2剂和熏洗第6次后症状明显改善，大腿根及会阴、外阴部潮红变浅，肿痒消减，已无浸淫。内服药停用，熏洗至第6剂后，症状基本消除，熏洗8剂后肿消痒止，症状消失。

【方剂出处】张兰芝. 中药治疗外阴瘙痒20例. 实用中医药杂志, 2003; 19(10): 524

苦参汤治疗女性阴部瘙痒1

【药物组成】苦参、金银花、菊花各30g，蛇床子、白芷、地肤子各15g，黄柏20g，大石菖蒲9g。加减：滴虫或蛲虫性阴道炎加百部20g；真菌性阴道炎增加地肤子15g；外阴潮湿重加炉甘石20g。

【治疗方法】每日1剂，煎药滤药液2000ml先熏至水温下降30~40℃时坐浴20min，待自然风干。5d1个疗程。

【功效主治】祛风除湿，杀虫止痒。

【经验心得】方中苦参，蛇床子清热燥湿，杀虫止痒；白芷燥湿止痒；黄柏清热燥湿；地肤子清热利湿，祛风止痒；金银花、菊花清热解毒；大石菖蒲化湿。另加百部杀虫止痒，炉甘石收湿生肌。诸药合用共奏祛风杀虫除湿止痒。经现代药理研究，苦参中含有黄酮，对多种皮肤真菌有抑制作用，且具有明显的止痒作用；蛇床子对癣菌抑制作用，对一些皮肤病有收敛，抑制渗出的作用；地肤子对多种皮肤真菌有抑制作用。所以苦参汤方熏洗对于治疗外阴瘙痒的病理机制有十分明确的针对性。

【方剂出处】史月侠. 苦参汤治疗外阴瘙痒158例. 陕西中医, 2003; 24(12): 1113



苦参汤治疗女性阴部瘙痒 2

【药物组成】 苦参 30g，荆芥 15g，防风 15g，黄柏 30g，透骨草 20g，川楝子 30g，白鲜皮 20g，土茯苓 20g，蛇床子 30g，川椒 6g。

【治疗方法】 上药加水煎开后先熏后洗，每日 1~2 次。连续熏洗半年（月经期停用）。

【功效主治】 清热燥湿，祛风止痒。

【经验心得】 外阴白斑属中医“阴痒”的范围，系肝经风热或脾湿蕴热引起，治疗应是清热解毒，祛风除湿，养血活血。方中以苦参清热燥湿，祛风止痒，消炎止痛利小便；黄柏清下焦湿热，泻火解毒；川楝子清热利湿杀虫；蛇床子燥湿杀虫止痒；土茯苓清热利湿；荆芥、防风祛风止痒，促进病变组织愈合；透骨草活血止痛，祛风除湿；白鲜皮养血祛风，清热解毒；川椒温中祛寒，理气杀虫。用煎汤熏洗，可以使病变区血管扩张，血循环加快，增加营养，有利于病变组织修复。

【方剂出处】 秦真娥，等．苦参汤治疗外阴白斑 30 例．中国民间疗法，2001；9（10）：34

中药止痒液治疗女性阴部瘙痒

【药物组成】 苦参 150g，白鲜皮 150g，蛇床子 150g，地肤子 150g，百部 150g，蒲公英 100g，防风 100g。

【治疗方法】 取苦参加水浸泡 30min，煎煮 15min。将其他药加水浸泡 30min 后加入苦参药液中，共煎 30min 过滤，收集滤液。将过滤药渣加温水浸泡后煎 20min，过滤收集滤液与第 1 次滤液混合成 1 000ml 左右即可。每次取 200ml 本液加水 1 000ml，加热坐浴，温度越高，疗效越好（以不烫伤，患者能忍耐为度），凉后可再加热（注意不能用铁器皿），每次 20min，每日 2~5 次，15d 为 1 个疗程。



【功效主治】 清热解毒，杀虫止痒。

【经验心得】 方中苦参、白鲜皮、蛇床子、地肤子等治疗不明原因外阴瘙痒经临床观察，止痒效果好、药效持久。地肤子治疗皮肤湿疹；百部杀灭多种人体桑寄生虫；蒲公英具有杀灭金黄色葡萄球菌作用，对伤寒杆菌、痢疾杆菌、大肠杆菌也有抑制作用；防风可杀灭痢疾杆菌及枯草杆菌。这些药物的共同作用使中药止痒液具有止痒的同时兼有杀灭人体桑寄生虫、金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌、大肠杆菌的作用。

【方剂出处】 李金枝，等．中药止痒液治疗外阴瘙痒症 100 例．中国民间疗法，2005；13（1）：22

中药外洗治疗外阴瘙痒

【药物组成】 苦参 25g，蛇床子、艾叶各 30g，黄柏、白鲜皮各 12g，皂角 20g。

【治疗方法】 将药物置较大容器内，加水 2 000ml，浸泡 2h，煮沸后文火持续 20min 后，倒入干净盆中先熏 5min，然后坐浴冲洗，擦干即可。每晚 1 剂。7d 为 1 个疗程。

【功效主治】 健脾渗湿。

【经验心得】 外阴瘙痒多由脾胃湿热及肺经风毒发于肌肤之间，兼以六淫之邪乘虚袭入肌肤所致。采用自制中药洗剂熏洗治疗外阴瘙痒。外洗剂中苦参、艾叶清热燥湿，凉血止血；蛇床子祛风燥湿；黄柏清热解毒；白鲜皮、皂角杀虫止痛。上述药物多具有除湿杀虫止痒、消炎止痛的作用，故治疗外阴瘙痒疗效较佳。

熏洗疗法是以温热之药液熏洗肌肤的方法，来借其温暖氤氲之气，温通经络，畅达气血，疏启汗孔，使药力适于渗透深入，从而药物作用借助热力作用，刺激神经，促进血液循环，增加皮肤代谢，改进皮肤的营养状况，而达到治愈疾病的目的。

熏洗疗法的本身是一个清洁方法，尤其是对脓痂性及鳞屑性病变，可除去脓痂及屑皮，以利于皮肤疾病的早日痊愈。



【方剂出处】 王静，等．中药外洗治疗外阴瘙痒 120 例．河北中医，2002；24（11）：878

荆防洗剂治疗外阴白斑

【药物组成】 荆芥 30g，防风 30g，菊花 30g，透骨草 30g，淫羊藿 20g，苦参 20g。

【治疗方法】 以上药水煎外用，每日 1 剂，每剂水煎 2 次，第 1 次水煎 400ml，坐浴熏洗，第 2 次浓煎 100ml，用无菌纱布湿热外敷患处皮肤，每 3～5min 更换 1 次，5d 为 1 个疗程。

【功效主治】 清热解毒，杀虫止痒。

【经验心得】 本病属中医“阴疮”范畴，其成因在《外科正宗》中曰：“妇人阴疮，乃湿热下注为患，其病因不一，总由邪火热毒所化也”。其治疗在《疡科心得集》中曰：“在皮肤腠理间者，可从表而散。若怫郁气血在肌肉之分，外达皮肤，皆宜解内热，外以杀虫润燥。”自拟方中荆芥、防风能祛风杀虫止痒；淫羊藿清热利湿；菊花清热解毒；苦参清热燥湿、杀虫止痒；透骨草清热解毒、腐蚀赘疣。诸药合用既能清热解毒、杀虫止痒，又能散结消肿、收敛止痛，故临床疗效较好。

【方剂出处】 赵大勤．荆防洗剂治疗外阴白斑．中医外治杂志，2003；12（2）：45

坤痒宁治疗外阴白斑

【药物组成】 丹参、蛇床子、白鲜皮、补骨脂、淫羊藿各 15g。

【治疗方法】 上药研末制成药垫，每张药垫用 24h 后，再将药垫中药粉倒入开水盆中熏洗。1 个月为 1 个疗程。

【功效主治】 养血补肾，祛瘀止痒。

【经验心得】 本病属血虚肾亏，血虚不能滋养皮肤，皮肤变白，干裂、弹性消失，血虚生燥故瘙痒，血虚日久而致血瘀故皮肤增厚粗糙，肾司二阴，阴亏生殖器萎缩，拟以养血补肾，祛瘀



止痒法，取得较好效果。

【方剂出处】甄棣．坤痒宁治外阴白斑 285 例．陕西中医，2001；22（11）：656

苦参汤治疗外阴白斑

【药物组成】苦参 30g，荆芥 15g，防风 15g，黄柏 30g，透骨草 20g，川楝子 30g，白鲜皮 20g，土茯苓 20g，蛇床子 30g，川椒 6g。

【治疗方法】上药加水煎开后先熏后洗，每日 1~2 次。连续熏洗半年（月经期停用）。

【功效主治】清热解毒，祛风除湿，养血活血。

【经验心得】外阴白斑属中医“阴痒”的范围，系肝经风热或脾湿蕴热引起，治疗应是清热解毒，祛风除湿，养血活血。

方中以苦参清热燥湿，祛风止痒，消炎止痛利小便；黄柏清下焦湿热，泻火解毒；川楝子清热利湿杀虫；蛇床子燥湿杀虫止痒；土茯苓清热利湿；荆芥、防风祛风止痒，促进病变组织愈合；透骨草活血止痛，祛风除湿；白鲜皮养血祛风，清热解毒；川椒温中祛寒，理气杀虫。用煎汤熏洗，可以使病变区血管扩张，血循环加快，增加营养，有利于病变组织修复。

【方剂出处】秦真娥，等．苦参汤治疗外阴白斑 30 例．中国民间疗法，2001；9（10）：34

二、针灸疗法

芒针疗法治疗外阴瘙痒症

【穴位组成】双侧秩边、肾俞、大肠俞、带脉、三阴交、归来、八髎、气海、石门、关元、鸠尾。

【治疗方法】患者取俯卧姿势，①先用长度 150mm、直径 0.35mm 针灸针针刺秩边穴，透向同侧水道穴，要求患者前下腹



出现酸麻胀痛的针感，并向前阴部放射，留针 1min，留针期间应保持上述针感；②再用长度 40mm、直径 0.30mm 针灸针针刺双侧肾俞、大肠俞、八髎穴，要求局部有酸麻胀的针感，留针 20min，留针期间以 TDP 距离皮肤 30cm 照射，以患者能耐受为度，20min 后出针；③患者再仰卧，用长度 40mm、直径 0.30mm 针灸针针刺双侧带脉、三阴交、归来、气海、石门、关元、鸠尾穴，要求局部有酸麻胀的针感，留针 20min，留针期间以 TDP 距离皮肤 30cm 照射，以患者能耐受为宜。隔日治疗 1 次，3 次为 1 个疗程。共治疗 2 个疗程。

【功效主治】 通经行气，调整阴阳。

【经验心得】 外阴瘙痒易反复发作。芒针可深刺透穴，1 针透 2 穴，选穴配方上少而精，能使良好的针刺感应随着针体上下移动，有的放矢地到达相关部位，激发该处经气，畅通血脉，从而发挥针刺通经行气、调整阴阳的作用，达到以通求效之目的。研究表明，针刺秩边透水道，当针尖正好到达盆丛前下部时，可使患者盆腔出现热、胀、松快等感觉，而由此处发出的次级丛主要分布到膀胱、前列腺和外生殖器等部。从而直接刺激盆丛内的交感或副交感神经感受器，调整了其紊乱的功能，引起一系列生理、生化的改变，从而使外阴瘙痒得以痊愈。

【方剂出处】 栗漩，等. 芒针为主治疗外阴瘙痒症 34 例. 中国针灸，2004；24（11）：755

耳穴贴压法治疗外阴瘙痒症

【治疗方法】 耳穴贴压取外生殖器、肝、肾、肺、脾、神门、内分泌、皮质下等穴位。用耳穴探测仪或针灸针柄找准穴位，用 2% 碘酒消毒，再用 75% 的乙醇脱碘，用小胶布将王不留行子固定在穴位上，嘱患者用手指每天每穴按压 4~8 次，每次每穴按压 5min，要求有胀、痛、热等感觉，隔日再调换至对侧耳穴，治疗 10 次为 1 个疗程。可配合体针治疗：在上述耳穴贴压治疗的



基础上，对于病程迁延，病情顽固者配以体针。取穴：血海、中极、蠡沟。强刺激，反复快速捻转，不留针。

【功效主治】 养血润燥，活血祛风。

【经验心得】 中医认为外阴瘙痒症是天癸将绝，肝肾阴虚，血虚生风化燥，女阴失于濡养所致。因此在治疗上着重于调理肝肾，以补为主。耳郭与十四经脉有着直接或间接的联系，耳穴贴压治疗外阴瘙痒症主要是通过王不留行子贴压刺激，按摩耳穴，通过气血经络的循环作用，调整体内的阴阳平衡，调节脏腑的功能。肺主皮毛，脾主肌肉。肺、脾、肝、肾四穴同用，配以外生殖器穴，起到补益肝、肾，养血润燥，血行风灭而痒止的作用。现代医学研究发现贴压耳穴对于人体内分泌平衡系统具有双向调节作用，能激活患者的自身免疫功能，从而达到治疗目的。

治验：陈某，女，51岁。外阴瘙痒3月余，坐卧不宁，痒痛难忍，经外用药膏及中药熏洗、坐浴治疗均无明显好转。白带显微镜下检查未见真菌、滴虫，尿常规正常。妇产科确诊为外阴瘙痒症。用耳穴贴压法治疗5次后，痒痛症状明显减轻，继续巩固治疗5次，同时配合体针，取穴血海、蠡沟，强刺激手法。瘙痒症状完全消失，随访3月未见复发。

【方剂出处】 孙深. 耳穴贴压为主治疗外阴瘙痒症 54例. 河南中医, 2002; 22(1): 56

毫针针刺加火针点刺治疗外阴白斑

【穴位组成】 蠡沟。

【治疗方法】 ①取蠡沟穴：常规消毒，以4cm毫针平刺蠡沟穴，行九六补法，留针30min起针，隔日1次，5次为1个疗程。②用1:1000新洁尔灭溶液患部消毒，以贺氏粗火针快速点刺局部肤色变白处。每5d 1次。每次点刺局部7~8针。4次为1个疗程。观察3个疗程。如恐惧针者可用0.5%盐酸利多卡因溶液



在白色病变处施浸润麻醉。月经期停止治疗。

【功效主治】 激发经气，扶正祛邪。

【经验心得】 中医学认为前阴为肾所司，肝经循行所过之处，肝为风木之脏，赖精血柔养、才能疏泄畅达，若肾脏虚弱、精血不足，肝气失畅不能达于前阴，以致局部气血不足，血不润肤。如肝经虚风内动，则瘙痒疼痛，固属阴不足，故夜间为甚。足厥阴肝经之脉入毛中，过阴器是与外阴联系最密切的经脉，所以治疗上应以肝经为主。

【方剂出处】 王卫红，等. 毫针针刺加火针点刺治疗外阴白斑. 中国临床医生，2002；30（5）：62

针刺配合火针治疗外阴白斑

【穴位组成】 中极、关元、三阴交、阴陵泉。

【治疗方法】 ①针刺：患者仰卧位，穴位常规消毒后，用 30 号 40mm 毫针快速刺入皮下至得气，行平补平泻手法，留针 30min，留针期间每隔 10min 行针 1 次。每日治疗 1 次，10 次为 1 疗程。②火针治疗：外阴皮肤常规消毒后，选择中粗火针在酒精灯上将针烧红至白亮，快速点刺局部皮肤变白处，深度约 0.1cm，以刺穿表皮为度，点刺时沿患处由外向内逐步点刺，两针之间相距约为 1cm，每次点刺 7~8 针，如病变面积较大，可分次点刺，5d 点刺 1 次，2 次为 1 个疗程。月经期停止治疗。

【功效主治】 补肝益肾，调理冲任，疏通气血。

【经验心得】 外阴白斑属中医学“阴蚀”“阴疮”范畴。其病因为肝肾亏损，冲任气虚，阴部失于濡养加上湿热长期浸渍而致。中极、关元为足三阴经与任脉之交会穴，任脉起于胞中，司二阴，针之可通调冲任经脉气血，补肾助阳，散寒祛湿；中极为膀胱之募穴，可疏调膀胱之气而利湿热；三阴交为足三阴经之交会穴，可补肾养肝，调理气血，健脾渗湿；阴陵泉可清脾经湿热；火针集针刺及温灸于一体，能温助人体阳气，继而激发经气，促



进气血运行。针刺配合火针相辅相成，补肝益肾，调理冲任，疏通气血，清利湿热。肝肾强健，气血充足，胞脉得养，冲任脉气自调，外阴得以濡养则诸症自除。从临床观察可以看出针刺配合火针治疗外阴白斑，方法简单，疗效确切，无副作用，值得临床推广应用。

治验：王某，女，43岁。于1998年4月9日初诊。主诉：外阴瘙痒1年余，夜间尤甚，加重1月余。检查：大阴唇内侧上段及阴蒂部呈白色，弹性减弱。实验室检查：白带清洁度Ⅱ，无真菌及滴虫，空腹血糖5.1mmol/L，局部活体组织病理检查：外阴白斑。给予针刺治疗5次配合火针局部点刺1次后，瘙痒明显减轻，局部皮肤白斑变为粉红色。经2个疗程治疗后，外阴瘙痒消失，外阴皮肤色素恢复正常，大阴唇及阴蒂弹性也恢复。随访1年余未复发。

【方剂出处】 杨晋红，等．毫针针刺加火针点刺治疗外阴白斑．中国针灸按摩，2003；23（11）：646

电针治疗外阴白斑

【穴位组成】 阿是穴、曲泉、血海、三阴交、太溪、太冲。

【治疗方法】 局部平刺加用电针，曲泉、血海、太冲用泻法。三阴交、太溪用补法，每日1次，10次为1疗程。

【功效主治】 疏肝解郁，清利湿热。

【经验心得】 前阴为足厥阴肝经循行之处，肝为风木之脏，赖精血柔养，才能疏泄畅达。患者平素性急，肝郁久之化热，湿热循经下注于阴部，致局部经气阻滞，精血不足故见诸症。方中阿是穴意在疏通局部气血。血海具有调经理血，散风祛湿之功效。曲泉为肝经合穴具有清利湿热，调理下焦之功。太冲为肝经原穴能疏肝解郁。三阴交为肝、脾、肾三经交会穴，有健脾、益肾、疏肝之功，太溪能滋肾阴以柔肝。诸穴合用故收其效。



治验：患者张某，女，51岁。2000年10月16日初诊主述外阴瘙痒疼痛2年余，经多方治疗无效。经介绍前来就诊。患者平素性急，查：外阴红肿，触之有5处豆粒大小斑块，色白。舌红，苔薄黄稍腻，脉弦细。证属肝郁气滞，湿热下注。治则疏肝解郁，清利湿热，疏通气血。取穴：阿是穴、曲泉、血海、三阴交、太溪、太冲。刺法：局部平刺加用电针，曲泉、血海、太冲用泻法。三阴交、太溪用补法，每日1次，10次为1疗程。共治疗1个疗程诸症消失。为巩固疗效又治疗5次而告终。

【方剂出处】肖梅玲，等．电针治疗外阴白斑2例．针灸临床杂志，2001；17（8）：37

三、简方疗法

方1

鲜桃树叶 150g 加水煎煮，滤汁，倒入盆中，坐浴或冲洗。每日早晚各1次。一般3~5d可愈。适于滴虫阴道炎，外阴瘙痒甚者。

方2

虎杖根 100g，加水煎煮，滤汁，浓缩 1000ml，倒入盆中，待温坐浴 15min。每日1次。一般3周即愈。适于真菌性阴道炎。

方3

马鞭草 30g，紫花地丁 30g 加水煎煮，滤汁，倒入盆中，先熏后洗，然后坐浴 15min。每日2次。一般3d即愈。适于真菌性阴道炎。

方4

明矾 30g，大黄 30g，地肤子 15g，茵陈 10g，加水煎煮，滤



汁，倒入盆中，先熏后洗，待温坐浴 15min。每早、晚各 1 次。每日 1 剂。一般 10d 左右愈。适于真菌性阴道炎。

方 5

徐长卿 50g 加水煎煮，滤汁，倒入盆中，先熏后洗。每日 2 次。一般 10~15d 可愈。适于阴道炎。

方 6

椿树根皮 200g 加水煎煮，滤汁，倒入盆中，坐浴 15min。每日 2 次。直至治愈。适于阴道炎。

方 7

龙胆草 250g，每次用 25g，加水煎煮，滤汁，倒入盆中，每早、晚各洗 1 次。一般 15d 可愈。适于各种原因引起的阴道炎外阴瘙痒。

方 8

狼毒 50g 加水煎煮，滤汁，倒入盆中，洗浴局部。每日 2 次。并用消毒棉球浸取药液，塞入阴中，每日更换 4 次。一般 1 周可愈。适于各种原因引起的阴道炎致顽固性阴痒。

方 9

六神丸 15 粒，先用洁净开水清洗外阴，然后将六神丸全部塞入阴道。每晚 1 次。经期停用。一般 10d 即愈。适于滴虫阴道炎。

方 10

苦参 250g，陈醋 500ml 加水煎煮，滤汁，倒入盆中，待温熏洗局部。每日 1 次。一般 1 周即愈。适于滴虫阴道炎。



方 11

苦参 45g, 小蓟 60g, 大蒜 30g, 加水煎煮, 滤汁, 倒入盆中, 先熏后洗。每日 1 次。连用 5d 即愈。本方适于滴虫阴道炎。

方 12

蛇床子 60g, 苦参 15g 加水煎煮, 滤汁, 倒入盆中, 先熏后洗, 然后坐浴 15min。每日 1 剂, 分 2 次熏洗。一般当日止痒。1 周痊愈。本方适于滴虫阴道炎。

方 13

虎杖 100g, 苦参 50g, 木槿皮 50g 加水煎煮, 滤汁, 倒入盆中, 先熏后洗, 待温坐浴 15min。每日 2 次。一般 10d 即愈。适用于阴道炎。

方 14

荆芥 15g, 防风 15g, 地肤子 15g, 蛇床子 15g, 加水煎煮, 滤汁, 倒入盆中, 先熏后洗。每日 2 次。每日 1 剂。一般 3d 愈。对外阴湿疹、滴虫阴道炎、真菌性阴道炎等所致的阴痒均效。

方 15

蛇床子 30g, 苦参 30g, 艾叶 30g, 明矾 20g, 上药共研粗末。取 30g 用纱布袋或绵纸袋装入, 用沸水冲泡, 倒入盆中, 先熏后洗 15min。每日 1 次。同时更换内裤, 月经期停用。若外阴有白色病损者, 加鲜桃叶 50g 同时熏洗。一般 3~5d 即愈。

方 16

地肤子 20g, 紫花地丁 30g, 白矾 10g, 黄柏 20g, 白鲜皮 30g, 加水煎煮, 滤汁, 倒入盆中, 用药液擦洗患处, 以不破皮肤为度。



每日早、晚各 1 次。一般 1 周愈。适用于外阴瘙痒。

方 17

黄柏 15g，苦参 30g，苍术 15g，荆芥 12g，蛇床子 30g，丹参 6g 上药加水煎煮，滤汁，倒入盆中，坐浴 30min。每日 2 次。一般半个月即愈。治疗期间忌食辛辣食物。适用于外阴白斑。

方 18

淫羊藿 100g 研粉。用鱼肝油软膏调匀。取少许涂于患处。每日 2 次。直至痊愈。适用于外阴白斑。